PROVAS INTERNATO CLINICA MÉDICA

PROVAS:

- **2022.1.1**
- **2023.1.1**
- **2023.1.2**
- **2023.2.1**
- **2023.2.2**
- **2024.1.1**
- **2024.1.2**
- **2024.2.1**
- **2024.2.2**
- **2025.1.1**
- **2025.1.2**
- **2025.2.1**

PROVA C.M. – 2022.1.1

1) Paciente de 55 anos, com sobrepeso, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica controlada com enapril, comparece à consulta referindo que, após início de um remédio para o diabetes, há dois meses, vem tendo diarréria diariamente. O hipoglicerniante oral que mais provavelmente pode ter sido prescrito foi:

a) Gliclazida

b) Acarbose

c) Metformina

d) Pioglitazona

2) Homem 78 anos foi levado pela filha para consulta no Geriatra. Refere que há, aproximadamente 6 anos, seu pai começou a ficar repetitivo, esquecia onde guardava objetos, nomes de pessoas e que os sintomas foram piorando, mas que achavam normal para a idade. Nesse período se perdeu algumas vezes em lugares muito conhecidos para ele. Parou de cuidar das finanças e de sair de casa sozinho. Está sempre alegre, gosta de conversar, mas não consegue memorizar nada do que lhe é falado. Escolaridade de 4 anos, sempre trabalhou na lavoura, e atualmente gosta de estar exercendo algum trabalho na sua chácara, mas já não se lembra de como realizar as tarefas que antes fazia muito bem. Avaliação funcional: Atividades Básicas de Vida Diárias (ABVDs) e Atividades Instrumentais Vida Diárias (AIVDS) - precisa de ajuda para todas as atividades. Avaliação cognitiva: MEEM 13/30 → perdeu 8 pontos na orientação, 3 memória recordação→ 3 do comando, 1 desenho dos pentágonos e 1 na frase. Fluência Verbal categórica: 6 animais. O exame de imagem cerebral mostrou atrofia mesial temporal bilateral = 3. Com esses dados assinale a alternativa que sugere o diagnóstico desse paciente.

a) Transtorno Depressivo Grave.

b) Esquecimento benigno, próprio do envelhecimento.

c) Demência na Doença de Alzheimer, provável.

d) Demência Vascular.

3) Irineide, idosa com 80 anos refere que está com dificuldade para lembrar nomes de pessoas e quando está dirigindo seu veículo refere que precisa ficar mais atenta e que ela não era assim. Sempre foi muito ativa, aposentada como professora de universidade, tem três filhos, é viúva e mora sozinha, totalmente independente para atividades instrumentais e não faz uso de medicamentos de uso contínuo. No exame cognitivo com Mini Exame do Estado Mental (MEEM): 28/30 perdeu dois pontos em cálculos. Fluência Verbal categoria animais: 14, GDS-15 = 3. Como você orientaria essa paciente?

a) Explicaria para ela que essas queixas podem ocorrer no envelhecimento cerebral normal com pessoas de sua faixa etária. Solicitaria exames de rotina (tireoide, vitamina B12) para afastar causas secundárias de queixas cognitivas.

b) Você afirmaria que as queixas são consequências da doença de Alzheimer e prescreveria anticolinesterásico.

c) Você daria o diagnóstico de transtorno cognitivo leve e solicitaria ressonância cerebral.

d) Você já solicitaria tomografia cerebral e chamaria os filhos para assumirem as tarefas da paciente.

4) Agricultor de 25 anos iniciou quadro de febre alta, dor nas panturrilhas e grandes grupos musculares, queda do estado geral, seguido por icterícia rubínica. Negou tosse e diminuição do volume urinário. Referiu que sempre teve boa saúde. Os exames de entrada mostram: 19.000 leucócitos com 18% de bastões, hemoglobina = 11g/dL, ureia =

120, creatinina = 4,0mg/dL, sódio = 130mEq/L, potássio = 3,0mEq/L, bilirrubina total = 10mg/dL com 8,0mg/dL de direta, CK total = 550U/L, AST = 180U/L e ALT = 200U/L. Não usava medicamentos antes de chegar ao hospital. O quadro admite alguns diagnósticos diferenciais, porém, os dados disponíveis até o momento fazem com que a primeira hipótese diagnóstica seja:

A) leptospirose

B) colangite aguda

C) hepatite viral aguda

D) colecistite aguda supurada

5) Mulher de 25 anos procura médico por cansaço. Está hipocorada com hemoglobina = 9,9g/dL, VGM = 72fl, HGM = 23pg, RDW = 16,5 e ferritina = 6,0µg/L. Cerca de dez dias após iniciar o tratamento correto, é possível acompanhar a sua eficácia, solicitando:

A) ferritina

B) ferro sérico

C) reticulócitos

D) hemoglobina

6) Homem de 68 anos vem progressivamente apresentando cansaço, fraqueza e dor no corpo. Foi à emergência com dor lombar forte e realizou tomografia de abdômen e pelve com contraste venoso, que mostrou colapso da primeira vértebra lombar. O hemograma mostrou anemia normocrômica e normocítica, Hb = 10,0g/dL, plaquetas = 100.000 e função renal normal. Dias depois, evoluiu com oligúria. Está hipocorado e com fácies de dor, tem linfonodos de menos de 1cm, cervicais, elásticos, móveis e indolores, sem visceromegalias. Novos exames mostram: Hb = 9,6g/dL, normocromia e mormocitose, com formação de fenômeno de Roleaux, plaquetas = 99.000, VHS = 110mm/h, sódio = 136mEq/L, potássio = 3,8mEq/L, creatinina = 3,6mg/dL, cálcio total = 13,2mg/dL, proteínas totais = 9,2g/dL, sendo 3,4g/dL de albumina e ácido úrico = 10mg/dL. Antes de solicitar outros exames, esse quadro levanta a suspeita principal de:

A) púrpura trombocitopênica trombótica

B) linfoma de células do manto

C) leucemia mieloide crônica

D) mieloma múltiplo

7) Mulher de 30 anos com diagnóstico de migrânea crônica sem aura, obesa em tratamento para ovário policístico, passado de nefrolitíase e tremor essencial. Também em investigação para glaucoma de ângulo fechado. O tratamento preventivo deve ser feito com:

a) Amitriptilina

b) Topiramato

c) Propranolol

d) Valproato de sódio

8) Homem de 45 anos, fumante, com quadro de dor torácica, tosse com hemoptoicos, associado a infiltrados pulmonares e história de atopia e rinite alérgica, evoluiu com diminuição do volume urinário. Os exames mostraram glicemia = 90mg/dL, ureia = 90mg/dL, creatinina = 3,0mg/dL, sódio = 140mEq/L e potássio = 5,5mEq/L. A ultrassonografia revelou rins de tamanho normal com dissociação córtico-medular preservada. A biópsia renal identificou 20 glomérulos, tendo crescentes em 70% deles. A imunofluorescência indicou depósitos granulares subepiteliais e subendoteliais. O próximo passo na investigação e o diagnóstico mais provável, respectivamente, são:

A) dosagem do complemento / lúpus eritematoso sistêmico

B) dosagem do complemento / síndrome de Churg-Strauss

C) dosagem do ANCA / poliangeite com granulomatose

D) dosagem do ANCA / síndrome de Goodpasture

9) Homem de 70 anos, tabagista, relata alguns episódios de hematúria macroscópica há algumas semanas, mas sem dor lombar. O exame físico é normal e os exames de urina mostram pesquisa de sangue positivo, proteína negativa, piócitos 1 a 2 por campo, hemácias 50 a 60 por campo, sem dismorfismo e raros cilindros hialinos. A urinocultura foi negativa. Os exames mais adequados para a elucidação desse caso são toque retal, PSA, bem como:

A) Ultrassom das vias urinárias e sedimento urinário no microscópio de fase.

B) TC das vias urinárias, citologia urinária e cintilografia óssea.

C) TC das vias urinárias, citologia urinária e cistoscopia.

D) Ultrassom das vias urinárias e cistoscopia.

10) Diante de um nódulo solitário de tireoide, o exame que deve ser feito inicialmente é a dosagem sérica de:

A) tireoglobulina

B) calcitonina

C) TSH

D) TRH

11) Homem de 40 anos, apresenta cefaleia pulsátil holocraniana com náuseas e vômitos, de forte intensidade, há 20 anos com as mesmas características. A duração do episódio costuma durar 24 horas. Pouca ou sem melhora com dipirona. Nega uso prévio ou atual de outros medicamentos. Apresenta fotofobia, e piora da dor com atividade física ou esforços. Com média de 1 crise/mês. Exame físico e neurológico sem alterações. A conduta frente ao caso:

a) Iniciar Topiramato

b) Realizar punção lombar

c) Prescrever Sumatriptano

d) Solicitar uma tomografia de crânio

12) Uma mulher com 72 anos de idade é levada à Unidade Básica de Saúde por familiares, que declaram que ela "está diferente". Segundo eles, a paciente, que sempre foi muito calma, tem estado muito ansiosa. Na entrevista, a paciente mostra-se agitada, apresenta leve tremor de extremidades e reclama de palpitações, muito calor e sudorese. Diz achar isso estranho porque já "passou da menopausa e não estamos no verão". Tem o olhar fixo e assustado e refere estar muito preocupada com a possível explicação dos seus sintomas.

Nessa situação, são sinais esperados ao exame físico:

a) taquicardia; exoftalmia; pele úmida e quente.

b) exoftalmia; macroglossia; pele fria e pastosa.

c) bradicardia; hipertensão diastólica; macroglossia.

d) taquicardia; macroglossia; hipertensão diastólica.

13) A azia e a regurgitação são os sintomas mais comuns da doença do refluxo gastroesofágico, contudo, se a regurgitação for de alimentos não digeridos deve-se pensar em:

A) Acalasia.

B) Pancreatite.

C) Divertículo gástrico.

D) Doença de Menetrier.

14) Artrite, espondilite anquilosante, eritema nodoso, pioderma gangrenoso e a colangite esclerosante primária são manifestações extraintestinais de:

A) Divertículo de Meckel.

B) Retocolite ulcerativa.

C) Doença de Behçet.

D) Tumor carcinoide.

15) A hemorragia digestiva alta pode acontecer em pacientes cirróticos e não cirróticos. A endoscopia digestiva deve ser realizada preferencialmente nas primeiras 24 horas após a hemorragia, a fim de reduzir o tempo de internação, a quantidade de transfusões de sangue e a necessidade de cirurgia. A causa mais comum de hemorragia digestiva alta em não cirróticos é:

A) Síndrome de Mallory-Weiss.

B) Gastrite de estresse.

C) Lesão de Dieulafoy.

D) Úlcera péptica.

16) Seu José, 70 anos, cardiopata, dislipidêmico, hipertenso e diabético de longa data. Além disso, com hiperplasia prostática. Em tratamento irregular para as comorbidades, se queixa de parestesia e dor em queimação em ambos os

pés, pior a noite e que não melhora com analgésicos. Refere os sintomas há pelo menos 2 anos, com piora do quadro nos últimos meses. Nega etilismo e tabagismo. No exame neurológico: Marcha escavante, força grau 4 distal nos MMIIs, hipoestesia em bota e reflexo aquileu abolidos bilateralmente. O exame complementar a ser solicitado para confirmação clínica:

a) Eletroencefalograma

b) Tomografia de crânio

c) Eletroneuromiografia

d) Ressonância magnética de coluna lombar

17) Seguindo o caso do seu José, o exame complementar confirma a principal hipótese diagnóstica. O tratamento para amenizar a dor, além do controle das doenças de base, é:

a) Donepezila

b) Amitriptilina

c) Gabapentina

d) Fenobarbital

18) Paciente idoso portador de insuficiência cardíaca (IC) com história de asma na infância. Decide-se então por indicar um beta-bloqueador com menor possibilidade de causar broncoespasmo. Dos quatro betabloqueadores que podem ser indicados na IC, qual deles tem maior probabilidade de causar broncoespasmo?

A) Metoprolol

B) Carvedilol

C) Bisoprolol

D) Nebivolol

19) Após a imunização completa para a hepatite B, o perfil sorológico que deve ser observado é:

A) anti-HBc positivo e anti-HBs positivo

B) anti-HBc positivo e anti-HBe positivo

C) anti-HBc negativo e anti-HBs positivo

D) anti-HBc negativo e anti-HBe positivo

20) Paciente de 63 anos vem em investigação de quadro de anemia macrocítica persistente com piora progressiva. Os exames de sangue solicitados inicialmente para investigação foram inconclusivos. Pensando em síndrome mielodisplásica, qual a melhor forma de diagnóstico?

a) Pesquisa de BCR/ABL

b) Hematoscopia de sangue periférico

c) Biópsia de medula

d) Painel de mutações para mielodisplasias

21) Dos critérios abaixo, quais deles sugerem o diagnóstico de Doença de Crohn:

A) acometimento principalmente do reto e raramente do íleo terminal

B) acometimento contínuo da mucosa e presença de ulcerações extensas

C) presença de fístulas e acomentimento principalmente de íleo terminal

D) sintoma principal é a diarréia com presença de sangue e muco nas fezes

22) Ao avaliar exames de sangue de um paciente com doença hepática, o dado que indicaria que a doença é crônica é o(a):

A) albumina baixa

B) gamaglutamil transferase normal

C) tempo de atividade de protrombina alargado

D) transaminase glutâmico pirúvica muito elevada

23) Paciente de 21 anos, sem comorbidades, apresenta febre alta de início súbito há 2 dias, mialgia, 01 episódio de vômito, cefaleia, hepatomegalia maior que 3cm do rebordo costal. Não apresenta sangramentos, sinais de choque e sinais de comprometimento grave de órgãos. Tratando-se de Dengue, qual seria a conduta correta para este caso?

a) Hidratação oral e acompanhamento ambulatorial

b) Hidratação venosa e internação em enfermaria

c) Hidratação venosa e internação em leito de terapia intensiva

d) Hidratação oral e observação em leito-dia.

24) Paciente de 30 anos apresenta quadro de dor nas articulações interfalangeanas proximais, rigidez matutina com mais de uma hora de duração e títulos altos de anti-CCP. Uma das drogas conhecidas como “modificadoras da doença” e que não retarda sua progressão radiológica é:

A) leflunomida

B) metotrexate

C) sulfassalazina

D) hidroxicloroquina

25) Uma paciente de 20 anos, pertencente a grupo de risco (múltiplos parceiros sexuais sem uso de preservativo), procura o médico com exame de sorologia para o HIV positivo (anti-HIV ELISA) repetido e confirmado com Western-

blot. O médico pede exame de carga viral, imunotipagem linfocitária e genotipagem para o HIV. Em relação ao tratamento nos dias atuais, deve-se recomendar que a paciente inicie o tratamento em caso de:

A) CD4 menor que 350 células

B) CD4 menor que 250 células

C) presença de doença definidora

D) qualquer contagem de CD4

26) Mulher de 22 anos procura assistência médica em função de cefaleia crônica e recorrente de forte intensidade. Informa cefaleia unilateral e pulsátil que inicia de forma mais leve e acentua-se com o passar das horas, durando mais de 4h na ausência de tratamento adequado. Às vezes, o quadro é precedido por escotomas, caracterizados como falhas periféricas no campo visual. A avaliação sugere migrânea, pois, além dos dados apresentados, há:

A) fonofobia e fotofobia durante as crises

B) anorexia isolada, sem náuseas ou vômitos

C) hiperemia conjuntival e miose ipsilateral à dor

D) alívio da dor ao subir escadas ou fazer atividade física similar

27) Mulher de 32 anos apresenta quadro de disúria, polaciúria e estrangúria, temperatura de 37,8°C e dor suprapúbica, descrito como primeiro episódio. O exame de urina mostra 20 a 30 hemácias por campo e 40 piócitos por campo. A melhor conduta, nesse caso, é:

A) iniciar antibiótico e realizar TC abdominal

B) solicitar cultura de urina e USG abdominal

C) iniciar o antibiótico e avaliar a evolução clínica

D) solicitar cultura de urina e aguardar resultado para iniciar antibiótico

28) Paciente masculino, 30 anos, apresentando episódios recorrentes de hematúria macroscópica precedidos por um quadro de infecção do trato respiratório superior. Nega outras queixas. Das opções abaixo qual o diagnóstico mais provável?

A) Glomerulonefrite pós-estreptocóccica

B) Nefropatia por IgA

C) Síndrome de Goodpasture

D) Púrpura de Henoch-Schonlein

29) Leia o caso a seguir e selecione a opção correta em que devem ser preenchidas as causas de óbito na Parte I da Declaração de Óbito, sendo que a primeira da lista deve ser a causa imediata e a última a causa básica: Homem de 65 anos de idade, aposentada, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi levado a serviço de emergência após ter sofrido queda de escada em casa. Foi diagnosticado com fratura exposta da tíbia, sendo submetido a cirurgia. Devido a dificuldade para deambular, evoluiu no pós-operatório com pneumonia, seguido de septicemia, indo a óbito:

A) Hipertensão - Fratura exposta de tíbia - Pneumonia- Septicemia

B) Septicemia - Pneumonia - Fratura exposta de tíbia - Queda de escada

C) Queda de escada - Fratura exposta de tíbia - Septicemia- Pneumonia

D) Pneumonia - Septicemia - Queda de escada - Diabetes

30) Seu paciente está tratamento para tuberculose. Assinale abaixo o sintoma adverso que, caso ele apresente, você deverá suspender o tratamento.

a) neurite óptica.

b) neuropatia periférica.

c) hiperuricemia com artralgia.

d) náusea, vômito e dor abdominal.

31) A avaliação de um paciente com privação alimentar importante mostrou anemia com elevação do volume corpuscular médio. Um exame realizado cerca de 6 meses antes mostrava valores normais. Ao exame físico, além de emagrecimento e mucosas hipocoradas, mostrava a pressão arterial normal. A proposta terapêutica deverá priorizar o seguinte item:

A) Ferro.

B) Transfusão sanguínea.

C) Ácido fólico.

D) Eritropoetina.

32) A partir do caso a seguir, selecione a opção com a sequência CORRETA de causas de óbito, para preenchimento da Parte I da Declaração de Óbito, considerando que a primeira causa da lista deve ser a causa imediata e a última será a causa básica. Paciente masculino, 65 anos, sabia ser portadora de hipertensão arterial sistêmica desde há 20, sem tratamento. Há cerca de 2 anos iniciou quadro de dispneia aos esforços, quando foi diagnosticada cardiopatia hipertensiva, tendo iniciado tratamento. Desde há 2 meses, evoluiu com insuficiência cardíaca congestiva. Hoje, foi internado com edema agudo de pulmão, indo a óbito após 2 horas.

A) Edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatia hipertensiva, hipertensão arterial sistêmica.

B) Hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatia hipertensiva, edema agudo de pulmão.

C) Edema agudo de pulmão, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatia hipertensiva.

D) Cardiopatia hipertensiva, hipertensão arterial sistêmica, edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva.

33) Um jovem procura atendimento devido ao aparecimento, há 3 semanas, de manchas claras na pele localizadas na região cervical e nos braços, bilateralmente. Enquanto espera o atendimento, preocupa-se ao observar um cartaz afixado com os seguintes dizeres: “Que mancha é essa? Você pode estar com hanseníase”. Nesse caso, a principal informação a ser utilizada pelo médico para diferenciar a hanseníase de outras dermatoses que cursam com lesões semelhantes é:

a) O tempo de aparecimento das lesões.

b) A ausência de alterações de sensibilidade.

c) O fato de as manchas serem hipocrômicas.

d) A faixa etária em que se encontra o paciente.

34) Um homem de 67 anos de idade é admitido na emergência por desnutrição grave e apresentando Glasgow 8. O paciente apresenta diagnóstico de câncer de pulmão há 2 anos. A cirurgia para extração do tumor foi realizada há 1 ano e meio, não sendo possível, na ocasião, a retirada completa da lesão. Submetido a quimioterapia e radioterapia, evoluiu o quadro com metástases cerebrais e de coluna lombar. Atualmente, o paciente não está lúcido e apresentando desconforto respiratório. A família solicita a sua transferência para a UTI para suporte ventilatório. As diretivas antecipadas de vontade do paciente incluíam o desejo expresso de não ir para a UTI e não ser intubado, mas os familiares mostram-se muito angustiados, afirmando que "não querem ver o paciente sofrer". Considerando o estabelecido no Código de Ética Médica e na Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) n. 1995/2012: Diretivas antecipadas de vontade e autonomia do paciente, avalie as afirmações a seguir.

I. Dada a gravidade do caso, o médico deve encaminhar o paciente à UTI para adequado suporte ventilatório.

II. A adoção de medidas que deliberadamente diminuam o tempo de sobrevida não são eticamente justificáveis.

III. O desejo da família deve ser respeitado, uma vez que o paciente não se encontra lúcido.

IV. Constitui conduta adequada não intubar o paciente, manter seu conforto, dignidade, controlando a dor e outros sintomas.

É correto apenas o que se afirma em:

a) I e III.

b) I e IV.

c) II e IV.

d) II, III e IV.

35) Em casos de pielonefrite aguda, o esquema antibiótico empírico mais adequado para pacientes estáveis e ambulatoriais é:

A) ertapenem 1g IM 1x/dia durante 7 dias

B) cefuroxima 500mg VO 12/12h durante 14 dias

C) ciprofloxacina 500mg VO 12/12h, durante 7 dias

D) sulfametoxazol+trimetropim (800/160mg) 12/12h durante 7 dias

36) São causas de microcitose e hipocromia no exame de esfregaço sanguíneo:

A) deficiência de ferro, mieloma múltiplo, uso de fenitoína

B) hemólise intravascular, mielodisplasia, hipertireoidismo

C) anemia da inflamação, talassemia, anemia sideroblástica

D) insuficiência renal, leucemia mieloide crônica, hepatite crônica

37) Paciente feminina, de 62 anos de idade, vai à consulta médica, referindo tosse produtiva com expectoração clara de aspecto mucoide. Refere história de dispneia aos médios esforços nos últimos 5 anos, com piora nos últimos 30 dias. Nega febre ou alteração característica da tosse habitual. Tabagista 1 maço/ dia há 40 anos. Nega hipertensão arterial sistêmica e diabetes melito. A radiografia de tórax mostra hiperinsuflação pulmonar, hipertransparência e retificação do diafragma. A hipótese diagnóstica provável é:

A) DPOC

B) bronquiectasia

C) asma agravada por infecção

D) DPOC agravada por pneumonia

38) Uma mulher branca de 35 anos de idade procura atendimento ambulatorial por ter notado "caroço" no pescoço. A paciente nega dor local, disfonia ou disfagia. Relata discreto cansaço, intolerância ao calor, palpitações e nervosismo, atribuindo esses sintomas à descoberta do "caroço". A mulher nega febre e alteração de peso. Relata ciclos menstruais regulares e uso de anticoncepcional oral. Ao exame físico, nota-se tireoide palpável, indolor, móvel, de consistência fibroelástica com presença de nódulo em terço distal do lobo esquerdo, com cerca de 2 cm de diâmetro, móvel à deglutição e de consistência endurecida.

Considerando o caso descrito, avalie as afirmações a seguir acerca da conduta médica adequada.

I. Indica-se a dosagem da tireoglobulina devido ao risco de malignidade.

II. Indica-se a cintilografia de tireoide em razão do quadro clínico sugestivo de hipertireoidismo.

III. Indica-se a ultrassonografia de tireoide para a caracterização do nódulo.

IV. Indica-se a punção aspirativa do nódulo após 6 meses de tratamento com levotiroxina.

É correto apenas o que se afirma em:

a) I.

b) III.

c) IV.

d) I, II e III.

39) Um militar de 22 anos de idade apresenta meningite por N. meningitides do tipo B. Ele divide o dormitório com outros cinco militares. Qual a conduta indicada em relação aos colegas de dormitórios?

A) Profilaxia apenas para aqueles cuja cultura de líquor for positiva.

B) Ceftriaxone para todos eles.

C) Profilaxia apenas para aqueles cuja cultura de swab nasal for positiva.

D) Vacinação com vacina conjugada.

40) Mulher branca de 30 anos de idade queixa-se de dor e edema em articulações de mãos e punhos há 2 meses, acompanhados de rigidez matinal de aproximadamente 30 minutos. A paciente informa uso frequente de anti-Inflamatório não hormonal, com alívio parcial dos sintomas. Refere ainda que os dedos das mãos ficam roxos com o frio. Ela nega história de febre recente ou prévia ao início do quadro. No interrogatório complementar, a paciente diz que sempre que se expõe ao sol, mesmo que por pouco tempo e fica com o rosto bastante vermelho. A mulher relata aborto espontâneo ocorrido há 1 ano (G1P0A1). Ao exame físico: PA = 140 x 90 mmHg, FC = 89 bpm, mucosas hipocoradas +/4+, ausculta cardiopulmonar e abdome sem alterações; presença de sinovite em articulações interfalangeanas proximais, metacarpofalangeanas e punhos, além de edema de membros inferiores+/4+.

Considerando os princípios de custo-efetividade, assinale a opção que apresenta os exames iniciais indicados para esclarecimento do diagnóstico dessa paciente.

a) Hemograma completo, exame de urina, C3, C4 e CH50, FAN, anti-DNA.

b) Hemograma completo, VHS, creatinina, exame de urina, FAN, fator reumatoide.

c) Hemograma completo, VHS, fator reumatoide, radiografia de mãos e punhos.

d) Hemograma completo, FAN, anti-Sm, anti-DNA, creatinina, proteinúria de 24 horas.

GABARITO:

1. C

2. C

3. A

4. A

5. C

6. D

7. C

8. A

9. C

10. C

11. C

12. A

13. A

14. B

15. D
16. C
17. C
18. B
19. C
20. C
21. C
22. A
23. B
24. D
25. D
26. A
27. C
28. B
29. B
30. A
31. C
32. A
33. B
34. C
35. C
36. C
37. A
38. B
39. B
40. B

PROVA C.M. 2022.1.2

1. Mulher de 28 anos apresenta hipertensão arterial de difícil controle. Foi diagnosticada aos 26 anos e desde então tem feito uso crescente de medicamentos. Sua pressão arterial atual é de 170/100mmHg e a frequência cardíaca é de 84bpm. A ausculta cardíaca apresenta quarta bulha, sem outros achados. No exame físico não há edemas, hirsutismo, má distribuição da gordura corpórea ou estrias. Os exames laboratoriais séricos apresentam: glicemia em jejum = 98mg/dl; ureia = 36mg/dl; creatinina = 0,9mg/dl; Na = 136mmol/l; K = 2,8mmol/l. A hipótese diagnóstica mais provável para esta paciente é:

A) Feocromocitoma

B) Síndrome de Conn (hiperaldosteronismo primário)

C) Síndrome de Cushing

D) Displasia fibromuscular da artéria renal.

2. Homem de 68 anos com história prévia de infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca se sente confortável quando em repouso. Entretanto, desenvolve fadiga, dispneia e, às vezes, palpitações quando caminha para seu carro. Então, ele tem de descansar por vários minutos até que seus sintomas regridam. Em qual classe funcional este paciente se enquadra segundo os critérios da New York Heart Association?

A) I

B) II

C) III

D) IV

3. Paciente masculino de 65 anos está internado há cinco dias em uma enfermaria de emergência devido à desidratação. Sua creatinina sérica na admissão era de 3,6mg/dl, mas no momento encontra-se em 1,9mg/dl. Ao se queixar de dor lombar de moderada intensidade, o médico plantonista prescreveu anti-inflamatório não esteroide em doses intermitentes. Qual o mecanismo pelo qual este medicamento pode prejudicar a função renal do paciente?

A) obstrução ureteral

B) toxicidade tubular proximal.

C) vasodilatação da arteríola eferente.

D) vasoconstrição da arteríola aferente.

4. Mulher de 63 anos com história prévia de câncer do colo uterino tratado com histerectomia total e radioterapia pélvica complementar apresenta evidências de lesão renal aguda anúrica (diurese de 50ml em 24h). No exame físico a PA encontra-se normal e o restante do exame cardiovascular está normal. O exame de urina mostrou densidade de 1.010 e não há células nem cilindros à microscopia do sedimento. Qual a medida mais adequada a ser tomada pelo médico nesta etapa da investigação?

A) Realizar TC de abdome e pelve com contraste.

B) Solicitar ultrassonografia dos rins e vias urinárias.

C) Prescrever furosemida para aumentar o débito urinário.

D) Administrar líquidos por via intravenosa e monitorar a diurese.

5. Homem de 58 anos, com história de diabetes mellitus e hipertensão arterial há mais de dez anos e em uso irregular da medicação é atendido em unidade de pronto atendimento devido a náuseas, vômitos e dispneia. No exame físico apresenta: PA = 210/110mmHg, FC = 118bpm, FR = 26rpm; temperatura axilar = 36,7°C; mucosas hipocoradas (++/4+); aparelho respiratório com crepitações nas bases pulmonares; ritmo cardíaco regular com B4 e atrito pericárdico; edema periorbitário e de membros inferiores. Exames complementares iniciais: Hematócrito = 28%; Hb = 8,5 g/dl; glicose = 165mg/dl; ureia = 146mg/dl; creatinina = 8,4mg/dl; Na = 135mmol/l; K = 6,9mmol/l; HCO3 = 12,5mmol/l; Ca = 6,8mg/dl e P = 6,4; PTH = 98pg/ml (normal = 12 a 6).

A alteração óssea passível de estar presente neste paciente deve ser:

A) osteomielite

B) osteomalácia

C) osteíte fibrosa

D) doença óssea adinâmica.

6. Homem de 57 anos é avaliado com endoscopia digestiva alta devido a um episódio de hematêmese. É tabagista e usa medicação para hipercolesterolemia; há um mês apresentou episódio de lombalgia, tendo feito uso intermitente de paracetamol para alívio da dor. O exame mostrou a presença de úlcera duodenal de 3cm. Qual dos itens abaixo se encontra correto em relação a este achado?

A) O uso de paracetamol é o provável agente causador do quadro.

B) Pelo achado endoscópico, a probabilidade de ser devida ao H.pylori é mínima.

C) A lesão deve ser submetida à biopsia, pois tem alto risco de ser devida a um câncer.

D) Baixo nível socioeconômico é um fator de risco para o desenvolvimento desta condição.

7. Mulher, 44 anos, é acompanhada pelo clínico devido ser portadora de infecção crônica pelo vírus C. Encontra-se bem controlada e assintomática. Qual dos achados abaixo, quando encontrado, sugere o desenvolvimento de hipertensão portal?

A) Trombocitopenia

B) Leucocitose no hemograma

C) Elevação da gama-GT sérica.

D) Dilatação do átrio esquerdo no exame ecocardiográfico.

8. Mulher de 28 anos é encaminhada ao clínico geral para avaliação de anemia encontrada em exame de rotina solicitado por sua ginecologista. Ela refere fadiga aos esforços nos últimos seis meses, não faz uso de medicamentos, a não ser um complexo multivitamínico às refeições e apresenta ciclos menstruais regulares, de três a quatro dias, que não têm se modificado há anos. É tabagista de um maço de cigarros por dia desde os 17 anos e nega uso de drogas ilícitas. O hemograma completo que trouxe consigo apresenta: leucócitos = 4.000/mm³; plaquetas = 235.000/mm³; hemoglobina = 8g/dl; VCM = 112fl. O diagnóstico mais provável para esta paciente é:

A) Anemia perniciosa

B) Anemia ferropriva

C) Esferocitose hereditária

D) Leucemia mieloblástica aguda.

9. Homem de 64 anos, com história de dor óssea há seis meses, é atendido no setor de emergência com febre e tosse com expectoração amarelada. Sua única medicação é losartana potássica para tratamento de hipertensão arterial. A radiografia do tórax mostrou infiltrado alveolar no lobo inferior direito e lesões osteolíticas múltiplas na coluna dorsal. Exames complementares: ureia = 106mg/dl; creatinina = 2,8mg/dl; cálcio = 12,3mg/dl (valor de referência = 8,5 a 10,5); proteínas totais = 9g/dl (valor de referência = 5,5 a 8,0). Qual dos seguintes exames irá confirmar a condição subjacente que predispôs o paciente a apresentar o quadro de pneumonia?

A) Anti-HIV

B) cintilografia óssea

C) biopsia da medula óssea

D) TC de tórax, abdômen e pelve com contraste.

10. Paciente de 78 anos, sexo masculino, foi diagnosticado com deficiência cognitiva leve após apresentar queixas quanto à memória. Ele solicita ao médico para que prescreva algum medicamento que possa reduzir a possibilidade de que evolua para doença de Alzheimer. Qual tratamento você recomenda?

A) memantina

B) donezepil

C) gingko biloba

D) Nenhum tratamento atual demonstrou retardar a progressão do déficit cognitivo leve para doença de Alzheimer.

11. Homem de 37 anos encontra-se em tratamento para tuberculose pulmonar no quarto mês de tratamento. Queixa-se ao médico de atenção primária de que vem apresentado disestesias nos pés e mãos desde há quatro semanas e que dificultam o seu caminhar. Foi tabagista por longo tempo, tendo abandonado o hábito ao início do tratamento. As queixas deste paciente poderão ser revertidas com a administração de:

A) niacina

B) piridoxina

C) vitamina D

D) cobalamina

12. Homem de 36 anos foi admitido no hospital com relato de dispneia aos esforços progressiva há três meses que evoluiu com ortopneia. Não há relato de dor torácica aos esforços ou síncope, hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes e tabagismo. É natural de Tocantins e trabalha na construção civil desde que chegou ao Rio de Janeiro há

quinze anos. Exame físico: afebril, PA = 100/75mmHg; FC = 110bpm; FR = 22rpm; pulmões com crepitações bilaterais; ritmo cardíaco com extrassístoles frequentes; ictus desviado para a linha axilar anterior; presença de sopro sistólico (++/6+) audível no foco mitral; jugulares túrgidas a 45°; edema de membros inferiores, mole, frio, indolor e atingindo os joelhos. Qual dos exames complementares abaixo terá maior possibilidade de esclarecer o diagnóstico do paciente?

A) Troponina sérica

B) Angiografia coronariana

C) Cateterismo do coração direito

D) Reação sorológica para anticorpos contra o T.cruzi.

13. Paciente de 29 anos, sexo feminino, apresenta ansiedade, palpitações e diarreia. A investigação diagnóstica foi conclusiva da doença de Graves. Antes que ela iniciasse o tratamento para esta condição, apresentou episódio de dor torácica aguda, procurando o serviço de emergência. Embora o médico plantonista tenha solicitado a angiografia-TC de tórax, o radiologista o informou que tal procedimento poderia ser potencialmente perigoso para a paciente. Por quê?

A) A exposição ao contraste iodado poderia exacerbar o hipertireoidismo.

B) A embolia pulmonar é extremamente rara da enfermidade de Graves.

C) A exposição à radiação nos pacientes com hipertireoidismo está associada a um maior risco de doença maligna subsequente.

D) A presença de taquicardia na doença de Graves limita a qualidade técnica da imagem na angio-TC, não sendo útil para avaliação de embolia pulmonar.

14. Dentre os itens abaixo, assinale aquele que apresenta a causa mais comum de síndrome de Cushing.

A) adenoma adrenocortical

B) carcinoma adrenocortical

C) secreção ectópica de ACTH

D) adenoma pituitário produtor de ACTH

15. Qual das afirmações abaixo sobre o tromboembolismo pulmonar (TEP) encontra-se correto?

A) A hiperventilação alveolar é alteração fisiológica típica na presença de TEP.

B) A ocorrência hipotensão arterial no episódio de TEP é devida à disfunção do ventrículo esquerdo.

C) Praticamente todos os pacientes com TEP apresentam evidência de trombose venosa profundo no exame físico.

D) O grau de hipoxemia apresentado pelo paciente invariavelmente correlaciona com a dimensão do tromboembolismo.

16. Paciente de 30 anos, sexo masculino, portador de HIV/AIDS apresenta diarreia, febre e perda de peso há quatro semanas. Seu médico suspeita de colite pelo vírus de inclusão citomegálica (CMV). Qual dos seguintes testes poderão confirmar o diagnóstico neste paciente?

A) IgG sérica para CMV

B) coprocultura para CMV.

C) colonoscopia com biopsia

D) pesquisa de antígeno para CMV nas fezes.

17. Homem de 67 anos, engenheiro, decidiu viver em um sítio na Zona da Mata em Pernambuco após sua aposentadoria. Há seis meses surgiu nódulo na região tibial anterior esquerda e que evoluiu para lesão ulcerada com borda elevada e eritematosa. Fez tratamento caseiro com diversas ervas e plantas medicinais, sem sucesso. Ao procurar dermatologista, este realizou pesquisa parasitológica na lesão e identificou a presença de Leishmania (Viannia) brasiliensis. Foi então encaminhado para órgão público de atenção à saúde, onde lhe foi administrado:

A) Antmonial

B) Benzimidazol

C) Arsenico iodado

D) Sulfametoxazol + trimetroprim

18. Dentre os itens abaixo, assinale aquele que apresenta um sinal de alarme, indicativo como antevisão para uma forma clínica mais grave:

A) Febre

B) Mialgia

C) Exantema variado

D) Dor abdominal localizada no andar superior.

19. Sobre a leptospirose iceterohemorrágica, analise as três afirmações abaixo:

I – A febre na fase septicêmica costuma ser elevada.

II –. A insuficiência renal, em geral, se apresenta com hipopotassemia.

III – Os níveis de aminotransferases (AST e ALT) geralmente superam 1.000UI/l.

Estão corretas:

A) I e II

B) I e III

C) II e III

D) I, II e III

20. O Sr. João da Silva, 65 anos, vem se queixando de dor precordial do tipo opressiva, irradiada para o MSE, desencadeada no final de sua caminhada de 3 km, obrigando-lhe a interromper a caminhada para o alívio da dor. Paciente diabético, hipertenso e dislipidêmico. Sinais vitais: FC = 90 bpm PAS= 150/90 mmhg. Com relação aos objetivos terapêuticos desse paciente podemos afirmar:

I- O duplo produto do paciente encontra-se elevado

II- O beta-bloqueador seria droga de escolha tanto com objetivos hemodinâmicos como redução do risco de arritmias ventriculares

III- O papel do nitrato seria no alívio da dor e redução da mortalidade.

A) Somente I está correta

b) Somente III está correta

c) I e II estão corretas

d) I e III estão corretas

21. O Sr. João da Silva, 65 anos, queixa-se de dor precordial tipo opressiva há meses, irradiada para o MSE, desencadeada no final de sua caminhada de 3 km, obrigando-lhe a interromper a caminhada para o alívio da dor. Paciente diabético, hipertenso e dislipidêmico. Sinais vitais: FC = 90 bpm PAS= 150/90 mmhg. Procurou hoje a emergência do hospital por mudança do seu padrão de dor no peito, refere que até ontem era a mesma, ocorrendo ao final dos 3km de caminhada mas hoje, com 100m de caminhada sentiu a a dor, desta vez algo mais forte, suportável porém não desapareceu quando ficou em repouso como de costume. Como estava próximo ao hospital resolveu entrar. Qual a conduta que você tomaria para o caso pensando na segurança do paciente que se encontrava com eletrocardiograma com ondas Ts simétricas e negativas na parede inferior.

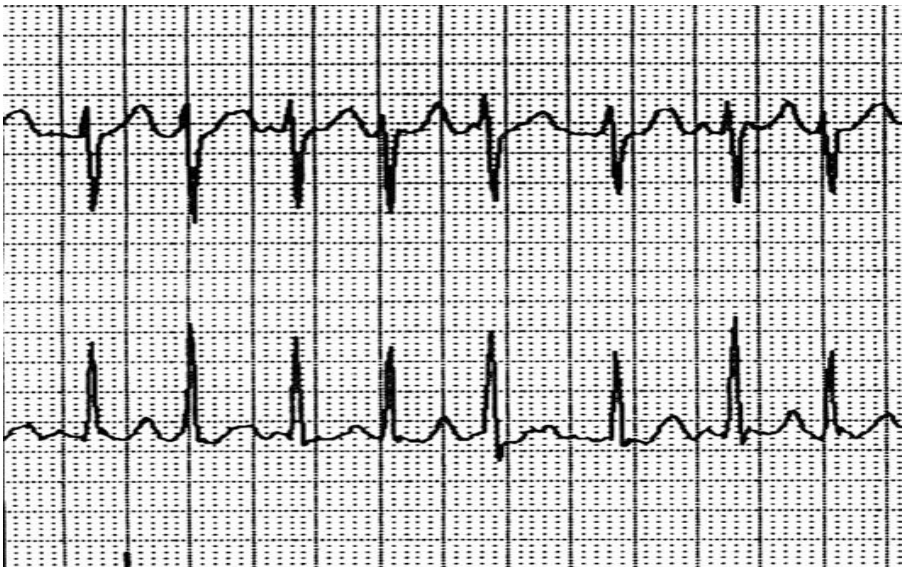
A) Verapamil, Sinvastatina , heparina de baixo peso molecular, AAS e Nitroglicerina venosa + internação em unidade coronariana

B) Carvedilol, AAS, Nitroglicerina oral + internação em enfermaria de cardiologia especializada

c) Metoprolol, Sinvastatina, AAS, Nitroglicerina venosa por 12h se estável, alta hospitalar medicado e orientado

D) Atenolol, Sinvastatina AAS, heparina de baixo peso molecular, Nitroglicerina venosa + transferência para sala de hemodinâmica.

22. Paciente jovem com história de uso de várias latas de Red-bull pela madrugado, foi trazido de uma festa para a emergência com quadro de palpitações chegou na UPA com FC=160 bpm PA= 110/70 mmhg. HPP: sem história de cardiopatia . Qual a melhor conduta terapêutica para o caso?



DII LONGO

A) Amiodarona Venosa + início de heparina venosa plena

B) Amiodarona oral

C) Propafenona oral + início de novos anticoagulantes via oral

D) Propafenona oral somente

23. Uma paciente de 28 anos com história prévia de febre reumática procurou a emergência do hospital e foi internada com quadro de edema agudo de pulmão, sabendo que a paciente é portadora de estenose mitral isolada, qual das informações abaixo pertencem ao contexto da doença da paciente:

I- O ecocardiograma lhe dará a informação que se trata de uma IC com FE <40%

II- Arritmias com perca da contração atrial pode ser causa da piora clínica paciente

III- Metoprolol associado a Furosemida seria uma boa combinação de drogas para estabilizar a descompensação nesse caso.

A) II e III estão corretas

B) I e II estão corretas

C) Apenas II está correta

D) Apenas I está corretar

24. Sra. Maria Antônia, 60 anos, procurou o ESF do Madruga por conta de hipertensão arterial, trouxe consigo cerca de 20 medidas realizadas no período de 30 dias com médias em torno de PAS = 160-170 mmhg e PAD= 100 mmhg. Queixa-se de dor retro esternal opressiva quando realiza esforços como subir o morro da técnica cirúrgica que alivia prontamente (5 minutos) ao chegar ao topo do morro. Com relação ao quadro descrito podemos afirmar:

A) O seu risco cardiovascular é alto e o estágio da HAS é II.

B) O seu risco cardiovascular é moderado e o estágio da HAS é III.

C) O risco cardiovascular é alto e o estágio da HAS é III.

D) O risco cardiovascular é moderado e o estágio da HAS é II.

25) Homem de 22 anos apresenta episódios recorrentes de cefaleia forte intensidade, durando 6 horas em média, unilateral, pulsátil, com náuseas e vômitos e que piora com esforços físicos. As crises são limitantes, atrapalhando as atividades cotidianas, ocorrendo 3 a 4 vezes no mês. A opção terapêutica que deve ser considerada é:

A) Sumatriptano diariamente

B) Divalproato de sódio nas crises

C) Amitriptilina diariamente

D) Topiramato nas crises

26) Garota de 16 anos vem ao ambulatório de neurologia trazida pela mãe devido episódios noturnos, durante o sono, de movimentos tônico-clônicos que duram certa de 5 minutos. Após acordar do episódio, fica confusa por alguns minutos e cefaleia holocraniana. Nega liberação esfincteriana. Na HPP, o único fato relatado era que quando criança, apresentava episódios que ficava parada olhando para o horizonte e mexendo a boca. Nessa época, a mae chegou a levar ao médico que solicitou o eletroencefalograma, demonstrando ponta-onda a 3 Hz. Por se muito rápido os episódios, o médico optou por não iniciar nenhum tratamento.

Diante do caso, a conduta deve ser:

A) Iniciar Diazepam

B) Prescrever Valproato de sódio

C) Medicar com Carbamazepina

D) Realizar punção lombar e TC de crânio

27) Dona Marta, 75 anos, arquiteta aposentada, destra, foi a consulta médica acompanhada da filha primogênita, que relata que a mãe iniciou quadro de esquecimento há 2 anos, principalmente para fatos recentes. O quadro tem piorado com o passar dos meses, chegando a ter incapacidade para executar as atividades físicas. É hipertensa, tabagista e diabética, em uso regular da medicação. Passado de transtorno do sono e ansiedade, em uso de Bromazepam há 10 anos.

Considere as afirmativas:

I – A principal hipótese diagnóstica é uma demência vascular, necessitando iniciar imediatamente a Galantamina

II – Confirmando valor abaixo de 24 pontos no exame do estado mental, deve orientar a paciente a retirar gradualmente o benzodiazepínico e reavaliar

III – A história pregressa de transtorno do sono e ansiedade afastam a possibilidade de doença de Alzheimer

IV – Na conduta inicial, deve conter solicitação de exames como TSH, T4 livre, VDRL, dosagem sérica de vitamina B12 e TC de crânio

São corretas:

A) I e II

B) I e III

C) II e IV

D) III e IV

28) Você está acompanhando um paciente masculino que apresentou AVE isquêmico há 3 meses. Após a alta hospitalar, foi solicitado que acompanhasse no ambulatório especializado. Apresenta hemiparesia espástica a direita e afasia motora. Atualmente, em uso de Enalapril, Clopidrogrel e Atorvastatina. PA: 130x88 mmHg, FC: 98 bpm e FR: 17 irpm. Da internação no dia do incidente, trouxe os seguintes exames e resultados: TC de crânio sem contraste = normal. Eletrocardiograma = taquicardia supraventricular. Ecocardiograma transtorácico = FE > 60%, déficit de relaxamento de VE. Doppler de carótidas e vertebrais = carótida direita oclusão de 80% e carótida esquerda 55%. Vertebrais sem obstrução. Pensando em prevenção secundária, a conduta apropriada:

A) Trocar Clopidrogrel por AAS

B) Solicitar endarterectomia carotídea

C) Iniciar Warfarina, objetivando INR de 2-3

D) Manter as medicações e reforçar medias gerais

29) Paciente masculino de 58 anos procura o serviço de emergência devido a tremor no braço direito que se espalhou para o rosto do mesmo lado. Cerca de um minuto depois, perdeu a consciência e houve movimentos tônicos e clônicos por cerca de 5 minutos. Houve confusão mental após o evento. Possui história pregressa de HAS, DM tipo II e AVE isquêmico há 4 anos atrás. Em uso de AAS, Atenolol e Metformina. Realizou TC de crânio que demonstrou encefalomalacia antiga no lobo frontal esquerdo.

O tipo de crise e a conduta frente ao caso:

A) Crise parcial com generalização secundária; iniciar Fenitoína

B) Crise tônico-clônico generalizada; iniciar Topiramato

C) Crise focal discognitiva; iniciar Valproato de sódio

D) Crise atônica focal; iniciar Diazepam

30) Masc, 52 anos, foi atendido a emergência do HUV com quadro agudo de dispneia. Negava tosse, expectoração, hemoptise ou dor torácica HPP: Dislipidemia em uso de atorvastatina, negava internações, neoplasias ou imobilizações, não havia passado de TEP ou TVP. O exame clínico identificou PA 135x80mmHg, FC 98 BPM, FR 26 IRPM, SatO296% (AA) e estava afebril. RCR 2T BNF sem sopros; MV preservado e sem adventícios. MMII indolor e sem edemas. A radiografia de tórax encontrava-se normal. O residente solicitou dosagem de dímero D cujo resultado foi de 730ng/dL. A melhor conduta então seria:

A) Liberar o paciente pois seu risco para TEP é baixo e a avaliação radiológica e laboratorial encontram-se normais.

B) Repetir o dímero D em 2 horas para curva enzimática pois poderá haver incremento considerando-se o quadro agudo.

C) Iniciar tromboprofilaxia secundária para TEP pois o radiograma de tórax é normal em quadro agudo de dispneia.

D) Solicitar angioTC pois o dímero D está alto para a idade do paciente e seu escore clínico é de baixa probabilidade.

31) Uma senhora de 74 anos, previamente hígida, procurou o atendimento de seu clínico pois há 1 dia apresentava odinofagia, astenia e febre recorrente de 38,70. O quadro teve início na segunda feira após ter tido contato com o neto, também febril, no final de semana. Um swab de nasofaringe detectou antígeno para Influenza vírus. Neste contexto a podemos afirmar que:

A) A sensibilidade e especificidade do swab não permitem o diagnóstico de Influenza neste caso.

B) O oseltamivir não tem indicação neste caso pois somente deve ser utilizado em populações com comorbidades cardiopulmonares ou imunossuprimidos.

C) A pneumonia comunitária é uma complicação da Influenza e deve ser suspeitada caso o quadro infeccioso febril persista ou recorra após de 5 dias.

D) Os sintomas da paciente não estão associados ao contato com o neto pois o período de incubação da Influenza é de 5 a 7 dias.

32) Homem, 57 anos, com queixa de dispneia mMRC2 há 3 anos e que, no último ano, houve progressão para mMRC3. A dispneia não tem associação com dor torácica, sibilância ou expectoração. Queixa-se de tosse noturna, com agravamento da dispneia, porém sem expectoração ou sibilância. HPP: HAS há 15 anos - losartana, indapamida e amlodipina; dislipidemia - atorvastatina; DM II - metformina.Nega cirurgias, internações. Tabagista 70 anos/maço, etilista social com CAGE de 1. PA: 150x100mmHg FC: 97 BPM FR: 20 IRPM SatO2: 96% (AA) IMC: 37,8 Corado, acrocianose, ortopneia, RCR 3T (B4 VE), sem sopros, MV universalmente reduzido, sem ruídos adventícios, MMII sem edemas. A investigação diagnóstica revelou – Radiograma de tórax com trama broncovascular preservada, sem consolidações, índice cardiotorácico de 0,7. A espirometria revelava redução da CVF e VEF1 com VEF1/CVF normal. Diante dos achados, o médico assistente deve considerar mais provável o seguinte diagnóstico.

A) Asma de início tardio, pois a espirometria revelava redução da CVF e VEF1 com VEF1/CVF normal e a DPOC somente acomete 15% dos fumantes.

B) DPOC Grupo B pois não há sintomas de atopia de vias aéreas que dê suporte ao diagnóstico de asma e o paciente tem alta carga tabágica.

C) Superposição de Asma-DPOC pois o radiograma torácico é normal e a espirometria revelava redução da CVF e VEF1.

D) Há exposição significativa ao tabagismo com risco para DPOC, porém, a espirometria não apoia o diagnóstico de doenças pulmonares obstrutivas.

33) Paciente de 63 anos procurou o ambulatório para avaliação devido, tosse seca diária e progressiva há 4 meses e, há 3 semanas, apresentando hemoptóicos. Nega febre, porém, relata perda ponderal de 5 Kg nos últimos 6 meses. A radiografia de tórax evidenciava derrame pleural em 2/3 inferior do hemitórax direito. HPP: HAS e DM há 4 anos, contato há 15 anos, com caso de tuberculose. HS: Tabagista 1,5maço/dia há 25 anos. Etilista social. Foi submetido a toracocentese que identificou: derrame linfocitário, proteína pleural de 63% da sérica, ADA abaixo do limite de referência. Neste contexto, a melhor conduta diagnóstica para a principal hipótese diagnóstica do caso será:

A) Realizar broncoscopia com biópsia de provável lesão endobrônquica pois o diagnóstico de câncer de pulmão com sintomas centrais se apresenta.

B) Repetir a toracocentese e biópsia pleural para teste rápido molecular de TB (TRM-TB) e cultura para tuberculose no fragmento pleural.

C) Solicitar escarro induzido para cultura e TRM-TB por ser exame menos invasivo e o diagnóstico de tuberculose pulmonar não foi excluído.

D) Solicitar angioTC de tórax, pois o escore de Wells tem pontuação maior do que 4,5 e revela alta probabilidade clínica.

34) Paciente comparece ao consultório com resultado de espirometria:

	PREDITO	**LIMITE INFERIOR DA NORMALIDADE**	**PRÉ-PBD**	**PÓS-PBD**	**Ganho em % do PRE**
CVF	4,50 L	4,32 L	4,37	4,40	0,6%
VEF1	3,55	3,27 L	3,01	3,43	14%
VEF1/CVF	0,79	0,75	0,69	0,78	13%

Sobre o resultado acima podemos afirmar que:

A) Apresenta distúrbio compatível com o diagnóstico de DPOC.

B) Apresenta distúrbio obstrutivo, porém, sem resposta ao broncodilatador

C) Apresenta distúrbio obstrutivo compatível com o diagnóstico de asma.

D) Apresenta distúrbio restritivo e não sugere diagnóstico de asma.

35) Uma mulher de 43 anos, previamente hígida, procurou a emergência com queixa de tosse frequente há 48h associada a febre recorrente entre 37,8 a 38,90C além de alguma prostração. O quadro se agravou nas últimas 6 horas com o surgimento de expectoração purulenta. Ao exame, a paciente encontrava-se em regular estado, vígil e orientada. PA 110x65mmHg, FC 88 BPM, FR 24 IRPM, Tax 38,2 0C. A ausculta respiratória revelava algumas crepitações grossas em base do hemitórax direito. Neste contexto, qual dentre as condutas abaixo seria tecnicamente correta e justificável:

A) A paciente deve ser internada devido ao quadro de pneumonia ainda que não apresente comorbidades.

B) Uma radiografia de tórax deve ser solicitada para confirmar o diagnóstico de pneumonia pois a especificidade do diagnóstico clínico é baixa.

C) Independentemente de internar ou não a paciente, a coleta de sorologia para o diagnóstico etiológico e escolha de antimicrobianos é um procedimento aconselhável, caso disponível.

D) A paciente deve ter hemoculturas coletadas no momento

36) Homem de 67 anos é trazido em consulta pela esposa que informa história de intensa agitação e que há 2 anos o paciente começou a envolver-se em brigas e discussões, “não media mais as palavras”, “não suportava ser corrigido”. Nessa época foi demitido. Afirmava que era “mais brilhante que todos da empresa e isso despertou inveja”. Tentou novo emprego, mas não conseguia adaptar-se às novas tarefas. Logo, abandonou o emprego (“era um profissional

muito bom para aquilo"). Há 6 meses está com perda de autocuidado e aumento exagerado do consumo de álcool. Frequentemente sai do banheiro e não fecha a calça, mesmo em locais públicos. O paciente relata importante diminuição na quantidade de sono. Durante a consulta levanta-se diversas vezes e caminha pelo consultório. Avaliação cognitiva: apresenta prejuízo na atenção, linguagem, planejamento, organização, resolução de problemas, abstração e memória de trabalho. Outros domínios cognitivos estão preservados. O caso acima ilustra uma situação encontrada em:

A) Demência por corpúsculos de Lewy

B) Delirium de características visuais

C) Transtorno misto ansioso e depressivo

D) Demencia frontotemporal

37) Mulher de 84 anos, busca consulta geriátrica com queixa de tristeza e desmotivação, sua investigação clínica não encontra alterações cognitivas e, ao aplicar o GDS-15, você identifica critérios compatíveis com um quadro depressivo e opta por iniciar tratamento com paroxetina. Além do exposto, a paciente realiza tratamento prévio de hipertensão arterial com hidroclorotiazida 25 mg/dia e não possui outros comemorativos. Após duas semanas, a filha da paciente refere que sua mãe está letárgica e confusa. Assinale a alternativa que apresenta qual distúrbio eletrolítico é o mais comum para esta paciente, no momento:

a) Hipoglicemia

b) Hipocalemia

c) Hipernatremia

d) Hiponatremia

38) Homem 80 anos é admitido em Instituição de Longa Permanência. Ele é portador de demência (filha não sabe a causa) há 14 anos e de diabetes mellitus tipo II. Está restrito ao leito há 6 anos e encontra-se desnutrido e com lesão por pressão em região sacral. Tem hemoglobina glicada de 7,5% (exame de 15 dias atrás). Assinale a alternativa que melhor apresenta como conduzir o caso:

a) Solicitar ressonância magnética de crânio para investigar a etiologia da demência

b) Passar sonda nasogástrica para alimentação adequada

c) Investigar a etiologia do déficit cognitivo nessa fase é desnecessário

d) Aumentar doses da medicação para terapia de diabetes

39) Homem de 72 anos, professor universitário aposentado, é atendido na Unidade Básica de Saúde. Na Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) foram obtidos os seguintes resultados:

Domínio da AGA	RESULTADO
Mini-exame do estado mental	12 pontos

Fluência verbal de 1 minuto	8 animais
Escala de Depressão Geriátrica	9 pontos
Timed get Up & go	8 segundos
Avaliação do Índice de Katz	se levanta sozinho, é continente, faz higiene pessoal; toma banho, se veste e se alimenta sozinho
Avaliação da Escala de Lawton-Brody	não consegue: usar o telefone, ir a lugar distantes, fazer compras, arrumar a casa, tomar seus medicamentos, cuidar de suas finanças.
Índice de Massa Corporal	24 g/m^2

Assinale a alternativa que apresenta, segundo a AGA, o que este paciente apresenta.

a) Screening positivo para déficit cognitivo e para depressão

b) Risco de queda e screening positivo para déficit cognitivo

c) Risco de queda e dependência para atividades instrumentais vida diária

d) Dependência para atividades instrumentais e básicas de vida diária

40) Homem de 75 anos procura o médico geriatra para esclarecer uma dúvida sobre o diagnóstico que recebeu, recentemente, do seu clínico. Ele refere que apresenta tremores nas mãos, desde seus 50 anos, que é tremor persistente, bilateral, que pioram quando fica nervoso. Seu pai e seus tios também apresentavam tremores. Mas o médico disse que é doença de Parkinson e prescreveu Prolopa. Qual é o diagnóstico mais provável desse paciente?

a) Tremor essencial.

b) Tireotoxicose.

c) Doença de Parkinson.

d) Asterixe ou flapping.

GABARITO 2022.1.2

1. B

2. C

3. D

4. B

5. C

6. D

7. A

8. A

9. C

10. D

11. B

12. D

13. A

14. D

15. A

16. C

17. A

18. D

19. A

20. C

21. D

22. D

23. A

24. A

25. C

26. B

27. C

28. D

29. A

30. D

31. C

32. D

33. A

34. C

35. B

36. D

37. D

38. C

39. A

40. A

PROVA C.M. 2022.2.1

1) A respeito do linfoma de Hodgkin, é CORRETO afirmar:

A) Ocorrem mais frequentemente em crianças abaixo de 15 anos, idosos entre 50 e 60 anos, e mulheres.

B) Apenas uma minoria pode ser curada com o tratamento disponível hoje.

C) A doença se espalha desordenadamente, acometendo aleatoriamente grupos de linfonodos.

D) Pessoas com imunossupressão (HIV, uso de imunossupressores para rejeição) tem mais risco de desenvolver a doença.

2) Paciente 20 anos apresenta dor abdominal recorrente em fossa ilíaca direita. Tomografia de abdome sem contraste, realizada no período de crise, não mostrou "borramento" em quadrante inferior direito, nem líquido livre ou coleções. Adicionalmente o paciente relata que há vários períodos com diarreia sanguinolenta e distensão abdominal. O exame físico do doente identifica sinais de artrites, eritema nodoso e uveíte. Diagnóstico mais provável é de:

A) Doença de Whipple.

B) Retocolite ulcerativa.

C) Apendicite aguda.

D) Doença de Crohn.

3) A neuropatia autonômica diabética é uma polineuropatia de fibras finas, cujo mecanismo é multifatorial. Estando ADEQUADAMENTE relacionado com o seguinte item. Assinale-o.

A) A neuropatia mais comumente relacionada com a NAD é a polineuropatia periférica (PNP) clássica (simétrica, distal e com predomínio motor).

B) A neuropatia mais comumente relacionada com a NAD é a polineuropatia periférica (PNP) clássica (simétrica, distal e com não predomínio sensitivo).

C) A neuropatia mais comumente relacionada com a NAD e´ a polineuropatia periférica (PNP) clássica (simétrica, distal e com predomínio sensitivo).

D) A neuropatia mais comumente relacionada com a NAD é a polineuropatia periférica (PNP) clássica (simétrica, proximal e com predomínio sensitivo).

4) Em relação à Declaração de Óbito (DO), documento oficial para a atestação da morte, é CORRETO afirmar:

A) A causa básica a ser citada é definida como a doença ou lesão que causou diretamente a morte

B) Em caso de óbito hospitalar por complicação de um acidente ou qualquer tipo de violência, a DO devera´ ser preenchida pelo médico legista.

C) Em caso de óbito, ocorrido em ambulância durante o processo de transferência, o médico do hospital de origem será o responsável pelo preenchimento.

D) Não será emitida em caso de óbito ocorrido minutos após o nascimento

5) Mulher de 62 anos queixa-se de epigastralgia em queimação há dois meses, associada a náuseas após a alimentação. Nega pirose, regurgitação, vômitos, disfagia, sangramentos, anorexia, perda ponderal ou quaisquer outras queixas. Desconhece doenças prévias ou em familiares de primeiro grau. O exame físico não revela anormalidades. Esofagogastroduodenoscopia: esôfago e duodeno normais; leve hiperemia na mucosa antral; teste da urease positivo. Assinale a conduta MAIS ADEQUADA nesse caso.

A) Prescrever amoxicilina, claritromicina e inibidor de bomba de prótons por sete dias e solicitar teste respiratório de urease após um mês.

B) Prescrever amoxicilina, claritromicina e inibidor de bomba de prótons por 14 dias e repetir a endoscopia após um mês.

C) Prescrever inibidor de bomba de prótons por oito semanas e, se os sintomas persistirem, prescrever antidepressivo tricíclico.

D) Prescrever inibidor de bomba de prótons por oito semanas e repetir a endoscopia se os sintomas persistirem.

6) Uma mulher de 28 anos, previamente hígida, foi à UPA no dia 10 de abril de 2019 queixando-se de disúria, dor no flanco direito e febre (38,4oC). O exame de urina revelou 54 piócitos/campo, 13 hemácias/campo e presença de bastonetes Gram- negativo. Optou-se pelo tratamento ambulatorial com ciprofloxacino. Evoluiu com melhora dos sintomas e da febre após 48h do uso do medicamento. No dia 14 de Abril, retornou à UPA com queixa de prurido generalizado, recidiva da febre e edema de membros inferiores. Ao exame físico, apresentava PA 120/70mmHg, FC 89bpm, FR 17irpm, SpO2 em ar ambiente 97%. Edema maleolar bilateral depressível. O restante do exame físico não apresentava anormalidades. Exames de laboratório: Em 10/04/2019: Hb13,1g/dL; LG 15.800/mm3; NS 11.570/mm3; Linf 2.450/mm3; Eos 360/mm3; Plq 178.000/mm3; Creat 1,1mg/dL; Ureia 23mg/dL. Urocultura: Escherichia coli, 100.00UFC/mL, resistente a ampicilina; sensível a ciprofloxacino, nitrofurantoína, cefalexina, ceftriaxona, sulfametoxazol-trimetoprim e amoxicilina-clavulanato. Em 14/04/2019: Hb 13,5g/dL; LG 11.800/mm3; NS 6.570/mm3; Linf 2.890/mm3; Eos 1.550/mm3; Plṕ 160.000/mm3, Crat 2,5mg/dL; Ureia 32mg/dL; K+ 5,2mEq/L. A injúria renal nesse caso se deve MAIS PROVAVELMENTE à:

A) Glomerulonefrite pós-infecciosa.

B) Necrose tubular aguda.

C) Nefrite intersticial aguda.

D) Pielonefrite aguda.

7) Mulher de 35 anos informa tosse seca presente há três meses. Ela nega ortopneia, dispneia paroxística noturna, febre, perda de peso e dor torácica. É portadora de insuficiência cardíaca idiopática com fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 40%. Nega tabagismo e etilismo. em uso regular de enalapril, carvedilol, espironolactona e furosemida há seis meses. Ao exame físico, apresenta PA 100/70mmHg, FC 55bpm, FR 13irpm e SpO2 em ar ambiente 97%. O exame cardiovascular revela ictus cordis desviado lateral e inferiormente, e o pulso venoso jugular é normal. A ausculta cardíaca não revela alterações. O restante do exame físico é normal. A radiografia do tórax não apresenta anormalidades. Assinale a conduta inicial MAIS ADEQUADA nesse caso.

A) Solicitar dosagem no peptídeo natriurético do tipo B.

B) Solicitar tomografia computadorizada do tórax.

C) Substituir o carvedilol pelo metoprolol.

D) Substituir o enalapril pela losartana.

8) Homem de 22 anos procura atendimento médico com relato de que a parceira sexual foi recentemente diagnosticada com herpes genital. Ele está assintomático. Não apresenta doenças conhecidas e não faz uso regular de medicamentos. Nega cirurgias prévias, transfusões sanguíneas, uso de drogas ilícitas ou medicamentos injetáveis. Relata ter mantido relações sexuais com múltiplas parceiras. Possui estado vacinal adequado para idade. O exame fisíco não revela anormalidades. Exames de laboratório: anti-HIV ; não reagente; anti- HCV reagente; VDRL não reagente; HBsAg não reagente. Assinale a conduta MAIS ADEQUADA nesse caso.

A) Encaminhar o paciente para o início de tratamento antiviral.

B) Realizar o teste rápido para o vírus da hepatite C na mesma consulta.

C) Repetir a sorologia plasmática para o vírus da hepatite C.

D) Solicitar o teste molecular para a pesquisa de HCV-RNA

9) Mulher, 37 anos, com quatro episódios de cistite no último ano, todos tratados com sucesso com norfloxacino por três dias. Última menstruação há dez dias. No momento está assintomática e refere que os episódios da infecção a limitam muito em suas atividades. Para realizar antibioticoprofilaxia para infecção urinária nesta paciente, o fármaco melhor indicado é:

A) rifampicina

B) fosfomicina

C) nitrofurantoina

D) claritromicina

10) Em relação ao Código de Ética Médica e as Resoluções dos Conselhos Federal e Regional de Medicina, é correto afirmar:

A) É vedada ao médico a prática da ortotanásia.

B) É direito do médico se recusar a realizar atos médicos que, embora legais, sejam contrários aos ditames de sua consciência, exceto em situações de emergência.

C) É permitido cobrar honorários de paciente assistido em hospital que se destina à prestação de serviços públicos, desde que o procedimento tenha sido realizado fora de seu horário de trabalho.

D) É permitido revelar sigilo profissional em redes sociais, desde que tais redes sejam de acesso exclusivo a profissionais médicos.

11) Considere uma mulher, 32 anos, atendida no ambulatório de endocrinologia e metabologia por nódulo tireoidiano e hipotireoidismo autoimune. História familiar de carcinoma papilífero. Ultrassonografia de tireoide: nódulo dominante de 3,5 × 2,0 cm em istmo, acentuadamente hipoecogênico, margens irregulares, com microcalcificações no seu interior. Em uso de levotiroxina 100 mcg/dia e TSH: 1,7 mU/L (Valor referência: 0,55 a 4,78 mU/L). Assinale a alternativa correta com base no caso clínico.

A) Caso a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) apresente citologia compatível com categoria Bethesda III, indica-se a repetição da punção para elucidação diagnóstica.

B) História familiar de carcinoma papilífero está associada a alto risco de malignidade de nódulo tireoidiano e indica a tireoidectomia total profilática.

C) A existência de diagnóstico de hipotireoidismo autoimune está associada a menor risco de malignidade do nódulo tireoidiano e descarta-se a necessidade de punção aspirativa neste caso.

D) A dosagem de tireoglobulina sérica apresenta alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de malignidade em nódulos com diâmetro maior que 2 cm.

12) Um paciente de 78 anos apresenta queixas de astenia, perda de memória e parestesias em membros inferiores. É hipertenso leve e há 10 anos foi submetido a gastrectomia sub-total. Os exames revelam hemoglobina de 7,1g/dL, volume corpuscular médio de 119 fL e hipersegmentação de neutrófilos. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a causa mais provável dos sintomas e o tratamento mais apropriado ao quadro.

A) deficiência de ácido fólico; administração enteral de ácido fólico

B) deficiência de cobalamina; administração enteral de vitamina B12

C) deficiência de ferro; administração parenteral de sulfato ferroso

D) deficiência de cobalamina; administração parenteral de vitamina B12

13) Dona Luiza tem 67 anos. Aos 35 anos, iniciou quadro de hipertensão arterial sistêmica, assim como suas irmãs e sua mãe. Há cerca de 3 anos vem apresentando cansaço durante suas atividades habituais, como fazer feira e ir buscar a neta na escola. Contudo, conseguia manter a jardinagem e subir um lance de escada normalmente. Iniciou também fadiga e edema de membros inferiores com cacifo, sendo diagnosticada com insuficiência cardíaca congestiva, confirmada pelo ecocardiograma como insuficiência cardíaca sistólica. Hoje, veio à consulta para renovar suas receitas. Ao exame apresentava-se eupneica, com pressão arterial de 130/80 mmHg, pulso de 72 bpm, rítmico e cheio, frequência respiratória de 16 mrm, sem edema de membros inferiores. As auscultas respiratória e cardíaca encontravam-se normais. O tratamento farmacológico mais adequado seria:

A) diurético e bloqueador de receptor de angiotensina

B) bloqueador de canal de cálcio associado a digitálico

C) inibidor de enzima conversora da angiotensina associado à espironolactona

D) inibidor de enzima conversora da angiotensina associado a betabloqueador

14) O diabetes melitus é uma condição clínica que pode cursar com complicações agudas e crônicas, micro e macrovasculares. No cuidado de rotina de pacientes com diabetes melitus tipo 2, na perspectiva de evitar ou diagnosticar precocemente tais complicações, está correto afirmar que:

A) O exame ampliado dos pés de pacientes diabéticos deve ser realizado em todas as consultas, independente do intervalo desde a consulta anterior, com auxílio de um monofilamento de 10g, diapasão, palpação de pulsos e avaliação visual. Um paciente é considerado com 'pé em risco' quando não possui alterações em pulsos ou normoestesia.

B) A investigação para retinopatia diabética deve ser iniciada depois de 5 anos do diagnóstico de diabetes através do exame de fundoscopia ou retinografia. Já a investigação para glaucoma, catarata ou oftalmoplegia deverá seguir como na população em geral, uma vez que não há aumento da prevalência dessas oftalmopatias nesse grupo de pacientes.

C) O rastreamento para nefropatia diabética deverá ser iniciado assim que for confirmado o diagnóstico e reinvestigado anualmente através da medida de creatininemia - com estimativa de clearence de creatinina - e albuminúria. Todo teste de albuminúria alterado deverá ser confirmado em duas ou três amostras antes do diagnóstico de nefropatia.

D) Estudos vêm demonstrando que controles mais rigorosos de glicemia têm melhor desfecho na redução da mortalidade, independente da população estudada. Dessa forma, as metas de valores tanto de glicemia de jejum, glicemia aleatória e hemoglobina glicosilada devem ser as mínimas possíveis para pacientes em uso de hipoglicemiantes orais ou insulina.

15) Ângelo, de 37 anos, vem para consulta em demanda espontânea com a médica Andreia. Tem queixa de disúria e polaciúria há 3 dias e teve a impressão de ter saído um pouco de sangue durante a micção. Nega secreção uretral ou relação sexual desprotegida. É a primeira vez que tem esse tipo de sintoma. Ao examinar o paciente, Ângelo encontra-se afebril, com Giordano positivo. Sem outros achados no exame físico. Diante do quadro descrito, a conduta mais adequada deve ser:

A) Solicitar urianálise com cultura e antibiograma, ultrassonografia de vias urinárias e radiografia simples de abdômen; iniciar tratamento empírico com antibiótico depois da coleta de urina

B) Iniciar tratamento empírico com antibiótico e, caso haja de falha terapêutica, solicitar urianálise com cultura e antibiograma e também ultrassonografia de vias urinárias

C) Solicitar urianálise com cultura e antibiograma, ultrassonografia de vias urinárias e iniciar tratamento com antibiótico de acordo com o resultado da cultura e do antibiograma

D) Iniciar tratamento com medicamentos sintomáticos para dor, preferencialmente anti- inflamatórios não esteroides, e aguardar a evolução do quadro, reavaliando o paciente em 2 dias

16) Segundo o Ministério da Saúde, paciente HIV+ com LT-CD4+ 46 céls/mm3 e PPD não reator deve fazer uso de quais profilaxias primárias?

A) Nenhuma profilaxia.

B) Cryptococcus sp., com Fluconazol.

C) Pneumocystis jiroveci e Toxoplasma gondii, com SMX-TMP.

D) Pneumocystis jiroveci e Toxoplasma gondii, com SMX-TMP, e Complexo Mycobacterium avium, com Azitromicina.

17) Qual a causa mais comum de meningite bacteriana adquirida na comunidade?

A) Streptococcus pneumoniae.

B) Staphylococcus aureus.

C) Listeria monocytogenes.

D) Neisseria meningitidis.

18) Em relação às anemias hipocrômicas e microcíticas:

A) Devem ser tratadas com sulfato ferroso.

B) Devem ser investigadas com mielograma.

C) Os principais diagnósticos diferenciais são anemia ferropriva, talassemia e anemia de doença crônica.

D) Os reticulócitos geralmente estão aumentados por se tratar de anemia hiperproliferativa.

19) A asma é uma doença respiratória crônica comum. Caracteriza-se por inflamação das vias aéreas manifestada por diversos sintomas. Em relação a essa patologia, é correto afirmar que:

A) A asma deve ser tratada apenas com base nos episódios de exacerbação.

B) O montelucaste sódico está disponível para crianças a partir de 4 meses na dose de 5mg/dia.

C) Os indivíduos com asma alérgica frequentemente respondem mal aos corticoides inalatórios.

D) Paciente com asma de início tardio são relativamente refratários ao tratamento com corticoides.

20) O diagnóstico de doença de Parkinson baseia- se, fundamentalmente,

A) No conjunto de achados clínicos e laboratoriais.

B) Nos achados da ressonância nuclear magnética de crânio.

C) Nos achados de cintilografia funcional do crânio.

D) Na história e exame físico.

21) Anemia sideroblástica será vista com maior probabilidade num paciente com a seguinte história:

A) Tuberculose em tratamento com isoniazida + rifampicina + pirazinamida + etambutol.

B) Submetido a cirugia redutora de estômago por obesidade

C) Alimentação vegana.

D) Passado de ressecção ileal.

22) Você está passando a visita na enfermaria de um hospital referência em doenças infecciosas e examina uma jovem de 28 anos, com SIDA, internada por pneumonia, atualmente sob controle. Ao exame da cavidade oral, você nota na parte lateral direita da língua placa esbranquiçada linear, apresentando na sua superfície vilosidades semelhantes a pelos. Tal lesão não é removível ao toque da espátula. Qual o agente etiológico responsável por tal achado?

A) Herpes vírus tipo 1

B) O próprio HIV

C) Candida albicans

D) Vírus Epstein-Barr

23) Mulher, 38 anos, advogada, casada. Paciente chega ao seu consultório encaminhada pelo otorrinolaringologista, o qual procurou por tosse seca persistente. Diz que os sintomas se iniciaram há alguns meses e são mais intensos após as refeições e em decúbito dorsal. Sem comorbidades e sem medicações. Nega atopias. Nega história familiar de neoplasias gastrointestinais. Traz consigo exames já realizados: laringoscopia que mostra laringite posterior, e endoscopia digestiva alta normal. Qual a hipótese diagnóstica mais provável e que exame deve ser solicitado para confirmação diagnóstica?

A) Asma / Espirometria

B) Sinusite / TC de seios da face

C) Pneumonia / RX de tórax PA

D) Doença do refluxo / pHmetria

24) Mulher, 70 anos, acometida por cefaleia súbita e intensa, seguida de rebaixamento do nível de consciência. Qual o exame de imagem mais indicado para iniciar o processo diagnóstico?

A) Tomografia de crânio

B) Ultrassom de carótidas

C) Ecocardiograma

D) Angiorressonância cerebral

25) O mieloma múltiplo (MM) é uma neoplasia maligna causada pela proliferação clonal de plasmócitos na medula óssea, que produzem e secretam de forma desproporcional imunoglobulinas anômalas e, consequentemente, elevam a concentração desses anticorpos, o que está associado a diversas disfunções orgânicas. A idade média dos pacientes no momento do diagnóstico de MM é de cerca de 65 anos. Dessa maneira, o MM é uma neoplasia típica da pessoa idosa. O quadro clínico característico do MM é:

a) Dor musculoesquelética, lesões ósseas blásticas, anemia megaloblástica, insuficiência adrenal e hipocalcemia

b) Dor óssea com lesões osteolíticas, anemia, insuficiência renal, hipercalcemia e infecções recorrentes.

c) Dor lombar tipo neuropática, ausência de lesões ósseas, insuficiência renal dialítica e infecções recorrentes

d) Ausência de dor e lesões ósseas, com osteoporose avançada, hipercalcemia e hipovitaminose D, além de insuficiência renal

26) Um senhor de 87 anos é levado ao consultório pelos filhos por apresentar alterações de memória, linguagem e orientação temporal e episódios de ‘urina solta’. Apresenta também tonturas com episódios de quedas de início recente. Entre as chamadas “grandes síndromes geriátricas”, quais são as prováveis nesse paciente?

a) Déficit cognitivo, incontinência urinária e instabilidade postural.

b) Déficit cognitivo, afasia de Wernicke e síncopes.

c) Delirium, prostatismo e tremor essencial

d) Demência senil, incontinência e vertigem paroxística

27) A demência frontotemporal apresenta as seguintes características:

a) Delirium de características visuais bem definidas e apatia.

b) Impulsividade e frequentemente apresentam estado depressivo.

c) Hipersexualidade e perda da empatia.

d) Comportamento antissocial e afasia progressiva.

28) Paciente de 72 anos, com hipertensão de longa data e mal controlada, que apresenta ainda, insuficiência renal estágio IIIb, insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada e gastrite atrófica. Queixa-se de muita fadiga e que as pernas estão adormecidas. A avaliação laboratorial revela anemia com macrocitose. Qual a provável causa desta anemia?

a) Presença de hemólise

b) Deficiência de vitamina B12

c) Deficiência de eritropoietina

d) Deficiência de Ferro

29) João Antônio, 67 anos, casado, 3 filhos e médico. Iniciou com queixas de memória há 2 anos, após ter se perdido na vizinhança de sua casa após sair para caminhar. Apresentou evolução do quadro, e há alguns meses teve episódios de alucinações visuais, já apresentados anteriormente, mas não com tamanha relevância, nesta ocasião afirmou ver seu cachorro que havia falecido anos antes. Sua esposa notou tremor de extremidades que motivou procura ao médico Geriatra. Atualmente já não consegue manter o exercício da profissão devido ao quadro apresentado. Ao exame físico apresentava tremor de repouso moderado, assimétrico, com rigidez moderada e também assimétrica, sem outras alterações. Durante avaliação cognitiva com Mini- exame do estado Mental (MEEM) pontuou 20/30 em primeira avaliação e, horas depois, em nova avaliação, pontuou 27/30. Assinale a alternativa correta sobre o diagnóstico mais provável.

a) Doença de Parkinson

b) Delirium

c) Doença de Alzheimer

d) Demência de corpúsculos de Lewy

30) Seu Amaro, 70 anos, possui HAS e DM. Apresentou um quadro de hemiparesia súbita no dimídio esquerdo do corpo em janeiro/22. No hospital, internaram e fizeram uma TC de crânio que veio normal no primeiro dia. O déficit neurológico se manteve. Foi iniciado AAS 100 mg/dia e com 48 horas repetiram a TC de crânio que demonstrou uma hipodensidade frontal a direita. Três meses após a alta, vem ao ambulatório de Neurologia carregando os exames solicitados que são: ecocardiograma transtorácico (hipertrofia grau I das cavidades esquerda), doppler de carótidas e vertebrais (obstrução da carótida direita 55%, placa estável e esquerda 80%, placa estável, vertebrais sem estenose) e eletrocardiograma (ausência de onda p e intervalos irregulares na derivação D2 longo. FC 89 bpm).

Está em uso de Captopril 25 mg (1 cp de 12/12 hr, AAS 100 mg 1 cp/almoço) e Metformina 850 mg (1 cp ao dia e Sinvastatina 40 mg + 1 cp após a janta). Realizando fisioterapia e fonoaudiologia. PA: 135 x 80 mmHg, FC: 92 bpm, FR: 17 irpm, Tax 36c. Exame neurológico: marcha hemiparética espástica a esquerda, força grau 3, espasticidade, hiperreflexia a esquerda. Sinal de Babinski a esquerda.

A conduta a ser adotada:

a) Trocar AAS para Warfarina

b) Manter AAS e iniciar Dabigatrana

c) Solicitar avaliação da neurocirurgia para endarterectomia

d) Manter as medicações e reabiliatação (fisioterapia e fonoaudiologia)

31) Mulher de 70 anos, refere cefaleia de início há 3 meses, de média a forte intensidade, pulsátil, unilateral e frontal a esquerda. Os episódios duram em média 3-4 horas, e melhoram com 40 gotas de dipirona. Ocorrem duas vezes por semana. Com fono e fotofobia. Nega aura, febre, perda de peso ou episódios de perda de consciência. Na HPP, ela é portadora de HAS em uso de enalapril de modo regular. História familiar positiva para migrânea (sobrinha possui). O exame físico e neurológico é normal, sem alterações.

A conduta ideal no momento é:

a) Orientar e manter o analgésico (dipirona)

b) Iniciar tratamento profilático para migrânea crônica com Propranolol

c) Solicitar um exame de neuroimagem e laboratório (VHS)

d) Orientar e trocar o analgésico por um mais forte (codeína)

32) Observe o seguinte relato do acompanhante: “Durou cerca de 2-3 minutos...há contrações musculares tônicas...olhos semiabertos...fica desorientado após o episódio...sem mordedura de língua...com cianose labial...sem liberação esfincteriana...sem pródromos...”. Trata-se de um paciente de 45 anos que perdeu a consciência há 2 dias atrás e vem no ambulatório para revisão. HPP nada digno de nota. Exame físico e neurológico sem alterações. O que fazer?

A) Solicitar ECG e Ecocardiograma trastorácico. Acompanhamento com cardiologia

B) Iniciar Fenitoína 100 mg 1 cp de 12/12 hr

C) Solicitar EEG e RNM de crânio

D) Orientar e dizer se tratar de um evento emocional

33) Seu Jose 70 anos. Ensino médio completo, destro. É portador de HAS e DM tipo II. Precisou realizar cateterismo no último mês. Devido a infecção urinária hospitalar, precisou ficar mais 3 dias internado, fazendo uso de Norfloxacina 400 mg, 1 cp de 12/12h. Durante a internação, familiares notaram insônia, episódios de esquecimento, desorientação, desatenção e agressividade. Foi prescrito Diazepam para insônia. Após a alta, encaminhado para o ambulatório de neurologia com os seguintes exames: TC de crânio (atrofia cortical difusa e aumento dos ventrículos de modo proporcionais) e laboratório (hemograma, eletrólitos e função renal e hepática) ok. Atualmente de AAS 100 mg 1 cp de 12/12 hr, Captopril 25 mg 1 cp de 12/12 hr e Metformina 850 mg 1 cp/dia e Diazepam 5 mg 1 cp a noite. Mini-mental não finalizado por desatenção e não colaboração da paciente. Dormindo muito pela manhã, com insônia pela madrugada e agitação psicomotora (vendo insetos inexistentes pelo corpo). Conduta:

A) Solicitar VDRL, anti-HIV, TSH, T4 livre e vit B12. Iniciar Donepezila 5 mg 1 cp a noite

B) Solicitar ecodoppler de carótidas/vertebrais, ecocardiograma, eletrocardiograma e ressonância magnética de crânio com hipótese de AVC isquêmico não confirmado na internação

C) Orientar a família em relação ao quadro, suspender o Diazepam e iniciar Quetiapina 25 mg 1 cp a noite

D) Reinternar, solicitar Radiografia de tórax e novo EAS com urinocultura/antibiograma. Prescrever Ceftriaxona EV empiricamente

34) Dona Marta, 70 anos, procura o ambulatório devido ao quadro de déficit de memória e desorientação de modo progressivo há 8 meses. Já não consegue mais ser independente e se confunde com os próprios remédios. Possui escolaridade superior a 12 anos, com mini-mental de 20 pontos e no exame físico apenas marcha de pequenos passos. Trouxe exames laboratoriais ok e um exame de neuroimagem. Em se pensando na principal hipótese diagnóstica, o (1) achado da neuroimagem e (2) conduta terapêutica são, respectivamente:

A) Hipersinal em T2 nas amigdalas perimesencefálicas – Donepezila

B) Atrofia dos hipocampos – Rivastigmina

C) Aumento dos ventrículos – Derivação ventrículo- peritoneal

D) Atrofia do cerebelo – Reposição profilática de vitamina B 12

35) Um paciente está em tratamento para hipertensão arterial com uso de um anti-hipertensivo em monoterapia. Apresenta em seu exame laboratorial dosagem de potássio sérico de 6,1 mEq/L (Normal de 3,5 a 5,5 mEq/L). Assinale a alternativa que contenha o provável fármaco em uso por este paciente.

A) Hidroclorotiazida

B) Losartana

C) Amlodipina

D) Hidralazina

36) Sobre os objetivos de otimização do controle neuro-hormonal da IC, qual das afirmativas abaixo é a correta.

A) o bloqueio da aldosterona tem como forte objetivo redução da pré-carga

B) o bloqueio da angiotensina II tem como objetivo a redução da pré-carga

C) o bloqueio do sistema adrenérgico tem como objetivo o aumento da contratilidade

D) o bloqueio a enzima conversora tem como objetivo a redução da pré-carga

37) Paciente de 60 anos, hipertenso, diabético e tabagista. Procura atendimento por apresentar dor precordial em aperto de moderada intensidade, com irradiação para membro superior esquerdo, desencadeado pelo ato de subir morros, que melhora espontaneamente com repouso em 5 minutos. Início do quadro há 6 meses, sem mudança no padrão e sem outros sintomas associados. No momento do atendimento está sem queixas e relata que o último episódio de dor foi há 1 dia.

Sobre o caso clínico analise as afirmativas:

I- O diagnóstico é angina estável e o paciente deve receber AAS como único antiplaquetário.

II- O diagnóstico é angina instável e o paciente deve receber AAS, clopidogrel e estatina.

III- Esse paciente pode ser conduzido ambulatorialmente, tem a indicação de teste ergométrico, deve receber AAS, beta bloqueador e estatina diários e nitrato sublingual se necessário (caso apresente dor torácica).

É correto apenas o que se afirma em:

A) I e II

B) I e III

C) somente em III

D) somente em II

38) Carlos Mendonça, 50 anos, procurou o ambulatório de cardiologia do HUV com queixa de dispneia aos esforços como andar no plano em frente a sua casa, que vem ocorrendo há um ano e que pirou de intensidade há 2 meses. HPP de HAS em tratamento há 20 anos e níveis descontrolados de PA, toma medicamentos irregulares. Apresenta episódios de tosse noturna que apareceu após a piora clínica da dispneia. Ao exame clínico notamos a presença de ictus no sexto espaço intercostal, na linha axilar média com 4 polpas digitais. Ausculta cardíaca com ritmo regular em 3T e presença de B3 de VE e ausculta pulmonar com crepitações nas duas bases pulmonares. Exame de membros com discreto edema bilateral nos tornozelos (perimaleolar), frio, indolor e com sinal de cacifo.

Com relação a um possível diagnóstico de Insuficiência Cardíaca, analise as afirmativas abaixo:

I- Segundo o modelo hemodinâmico temos critérios para insuficiência cardíaca direta e esquerda

II- Em sua avaliação foi detectado a presença três critérios menores de Framingham

III- Em sua avaliação o provável modelo de IC encontrado é com fração de ejeção preservada (ICFEP)

Assinale a alternativa correta:

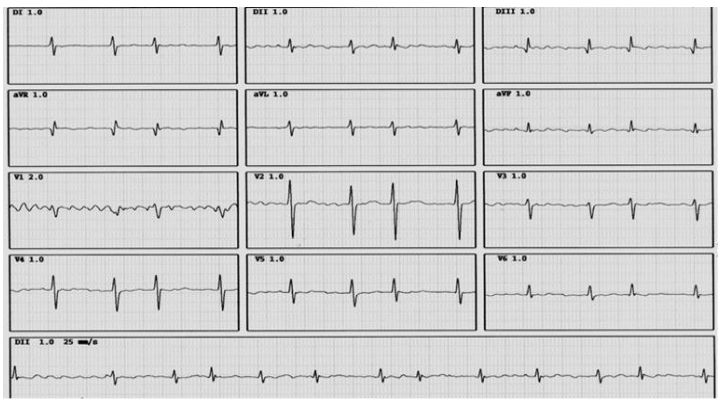
A) somente I está correta

B) opções I e II estão corretas

C) opções I e III estão corretas

D) opções II e III estão corretas

39) Paciente de 80 anos, hipertenso e diabético é admitido com quadro de palpitações intermitentes há 1 semana. Faz uso contínuo de hidroclorotiazida, enalapril, metformina e empagliflozina. Ao exame: FC=130 bpm, PA=130/80 mmHg, pulmões limpos. ECG:



Sobre o caso, analise as afirmativas abaixo:

I- Devemos iniciar um beta bloqueador e um anticoagulante
II- Podemos tentar a reversão para ritmo sinusal com cardioversão elétrica ou química na sala de emergência.
III- Esse paciente deve ser anticoagulado para o resto da vida.

Assinale a alternativa correta:

A) Somente a afirmativa I está correta

B) Somente a afirmativa II está correta

C) As afirmativas II e III estão corretas

D) As afirmativas I e III estão corretas

40) Uma paciente de 28 anos com história prévia de febre reumática procurou a emergência do hospital e foi internada com quadro de edema agudo de pulmão. Sabendo que a paciente é portadora de estenose mitral isolada, analise as informações abaixo que pertencem ao contexto da doença da paciente:

I- O ecocardiograma lhe dará a informação que trata de uma IC com FE <40%

II- Arritmias com perca da contração atrial pode ser causa da piora clínica paciente

III- Metoprolol associado a Furosemida seria uma boa combinação de drogas para estabilizar a descompensação nesse caso.

Estão corretas:

A) II e III

B) I e II

C) I e III

D) Todas

GABARITO 2022.2.1

1. D

2. D

3. C

4. B

5. B

6. C

7. D

8. D

9. C

10. B

11. A
12. D
13. D
14. C
15. A
16. D
17. A
18. A
19. D
20. D
21. A
22. D
23. D
24. A
25. B
26. A
27. C
28. B
29. D
30. A
31. C
32. C
33. C
34. B
35. B
36. A
37. B
38. B
39. D
40. A

PROVA C.M. 2022.2.2

1) Homem de 64 anos, portador de diabetes mellitus não insulinodependente há 20 anos, com tratamento irregular desde o diagnóstico. Sua hemoglobina glicada dos últimos anos esteve sempre em torno de 9,0%. Além disso, o paciente está em tratamento com laser para retinopatia avançada. Hoje durante consulta ambulatorial de rotina, queixou-se que há 3 meses vêm acordando com o "olho inchado" e que sua urina está espumando muito. Ao exame, apresenta importante edema bilateral e simétrico de membros inferiores. A conduta inicial é:

a) Quantificação de proteinúria em 24hs e dosagem de creatinina sérica.

b) EAS e dosagem de creatinina urinária.

c) Pesquisa de microalbuminúria e dosagem de creatinina sérica.

d) Pesquisa de dismorfismo eritrocitário e dosagem de creatinina urinária.

2) Mulher de 45 anos, IMC:36Kg/m2, com pai e mãe portadores de DM tipo 2, procurou atendimento ambulatorial para consulta de rotina. Trouxe exames laboratoriais que revelaram: glicemia de jejum = 115mg/dl; e HbA1c = 6%. Os mesmos exames foram repetidos e revelaram: glicemia de jejum = 118mg/dl; e HbA1c = 6,1%; e TOTG com 75g de glicose anidra = 155mg/dl. Além da mudança no estilo de vida, qual a conduta para esta paciente?

a) Inibidor SGLT2

b) Expectante

c) Glicazida

d) Metformina

3) Homem de 66 anos, tabagista, alcoolista procurou atendimento médico por apresentar febre diária com calafrios, recorrente, não aferida há 3 dias, associada a tosse produtiva com escarro amarelado, hiporexia e redução da capacidade de trabalho. Há um dia, percebeu dispneia não incapacitante e dor em hemitórax direito (HTD), ventilatório-dependente. Ao exame físico: fáscies de doença aguda, acianótico, bulhas rítmicas normofonéticas. Sem abaulamentos nas paredes do tórax. Abolição do frêmito toracovocal, macicez a percussão e abolição do murmúrio vesicular na face lateral e posterior do 1/3 inferior de HTD. FR=32irpm; SatO2 = 94%; Tax= 38,7oC; FC = 118bpm; PA = 90X60mmHg. Foi encaminhado para internação hospitalar. Qual a hipótese diagnóstica?

a) Pneumonia comunitária com condensação extensa à direita

b) Pneumonia comunitária com derrame pleural á direita

c) Pneumonia comunitária com exacerbação aguda de DPOC

d) Pneumonia comunitária com pneumotórax á direita

4) Um paciente está em tratamento para hipertensão arterial com uso de um anti- hipertensivo em monoterapia. Apresenta em seu exame laboratorial dosagem de potássio sérico de 6,1 mEq/L (Normal de 3,5 a 5,5 mEq/L). Qual o fármaco mais provável, dentre os abaixo, que o paciente deve estar usando e qual seria para o caso o medicamento ideal respectivamente.

a) Hidroclorotiazida e Losartana

b) Losartana e Anlodipina

c) Anlodipina e Enalapril

d) Hidralazina e Espironolactona

5) Sobre os objetivos de otimização do controle neuro-hormonal da Insuficiência Cardíaca, assinale a alternativa correta:

a) o bloqueio da aldosterona tem como forte objetivo a redução da pré-carga

b) o bloqueio da angiotensina II tem como objetivo a redução da pré-carga

c) o bloqueio do sistema adrenérgico tem como objetivo o aumento da contratilidade

d) o bloqueio a enzima conversora da angiotensina tem como objetivo a redução da pré-carga

6) Paciente de 60 anos, hipertenso, diabético e tabagista. Procura atendimento médico por apresentar dor precordial em aperto de moderada intensidade, com irradiação para membro superior esquerdo, desencadeada pelo ato de subir morros e que melhora espontaneamente com repouso em 5 minutos. Início do quadro há 6 meses, sem mudança no padrão e sem outros sintomas associados. No momento do atendimento está sem queixas e relata que o último episódio de dor foi há 1 dia.

Sobre o caso clínico analise as afirmativas:

I- O diagnóstico é de angina estável e o paciente deve receber AAS, beta bloqueador, estatina e nitrato sublingual se necessário (caso apresente dor torácica).

II- O paciente tem indicação de cateterismo.

III- Esse paciente pode ser conduzido ambulatorialmente e testes de provocação de aumento do duplo produto devem estar na pauta de sua investigação diagnóstica.

É correto apenas o que se afirma em:

a) I e II

b) I e III

c) somente em III

d) somente em II

7) JBS, 50 anos, procurou o ambulatório de cardiologia do HUV com queixa de dispneia aos esforços (como andar no plano em frente a sua casa), que vem ocorrendo há um ano e que piorou de intensidade há 2 meses. HPP de HAS em tratamento há 20 anos e níveis descontrolados de PA. Relata que faz uso irregular dos seus medicamentos. Apresenta episódios de tosse noturna que apareceu após a piora clínica da dispneia. Ao exame clínico notamos a presença de ictus no sexto espaço intercostal, na linha axilar média com 3 polpas digitais. Ausculta cardíaca com ritmo regular em 3T e presença de B3 de VE e ausculta pulmonar com crepitações nas duas bases pulmonares. Exame de membros com discreto edema bilateral nos tornozelos (perimaleolar), frio, indolor e com sinal de cacifo.

Com relação a um possível diagnóstico de Insuficiência Cardíaca podemos afirmar:

I- Segundo o modelo hemodinâmico temos critérios para insuficiência cardíaca direta e esquerda

II- Em sua avaliação foi detectado a presença de três critérios menores de Framingham

III- Em sua avaliação, o provável modelo de IC encontrado é o com fração de ejeção preservada (ICFEP)

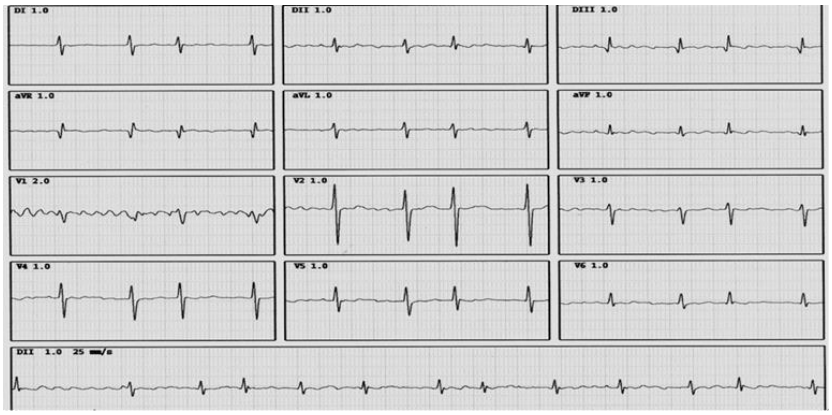
a) somente I está correta

b) opções I e II estão corretas

c) opções I e III estão corretas

d) opções II e III estão corretas

8) Paciente de 80 anos, hipertenso e diabético é admitido com quadro de palpitações intermitentes há 2 semanas. Faz uso contínuo de hidroclorotiazida, enalapril, metformina e empagliflozina. Ao exame: FC=130 bpm, PA=130/80 mmHg, pulmões limpos. ECG:



Sobre o caso analise as afirmativas:

I- Devemos iniciar um Bisoprolol associado a Rivaroxabana

II- Devemos providenciar a reversão para ritmo sinusal com uso de Sotalol na sala de emergência. III- Esse paciente deve ser anticoagulado para o resto da vida.

Assinale a alternativa correta:

a) somente I está correta

b) somente II está correta

c) II e III estão corretas

d) I e III estão corretas

9) Sr. Y, 50 anos, com dispneia mMRC2 há 5 anos, refere no último inverno um episódio de sibilância torácica e dispneia mMRC3 associados a tosse e expectoração mucopurulenta. Nesta ocasião recebeu prescrição de nebulização e antimicrobiano, com melhora do quadro, retornando a dispneia mMRC2. Relatava que a dispneia vinha trazendo desconforto pois o limitava para as caminhadas com sua filha pelas manhãs, o que fazia regularmente até há um ano. HPP: HAS há 7 anos em uso de losartana. Nega alergias, internações ou cirurgias. Nega tuberculose, pneumonia. Nega pneumopatias na família. Tabagista de 30 cigarros/dia há 20 anos.

O médico assistente solicitou uma espirometria que revelou:

Resultados	Pred	LIN	Pre		Post		%Chg
FVC (L)	2,65	2,01	¤1,88	71%	¤1,86	70%	-1%
FEV1 (L)	2,16	1,55	¤1,02	47%	¤1,00	46%	-2%
FEV1/FVC	0,81	0,73	¤0,54	67%	¤0,54	66%	-1%

Neste contexto podemos dizer que:

a) O paciente apresenta quadro clínico e espirométrico compatíveis com asma pois há resposta broncodilatadora na espirometria.

b) O paciente tem o diagnóstico clínico e espirométrico de DPOC.

c) O paciente apresenta somente bronquite tabágica sem espirometria que sugira distúrbio obstrutivo.

d) A espirometria sugere superposição de asma e DPOC.

10) Mulher de 38 anos, procura atendimento com queixa de regurgitação, pirose, tosse não produtiva e disfonia a cerca de 3 meses. Refere que estes sintomas são diurnos e noturnos. Nega febre, disfagia e perda ponderal. Nega uso de medicamentos, comorbidades ou cirurgias prévias. Tabagista 10 anos-maço. Etilista social. Alimentação 3 vezes ao dia e muito estresse durante o dia. Exame físico: bom estado geral, corado e hidratado. Peso=88Kg; Altura=1,60m; PA=110x70mmHg; FC=70bpm. Sem outras alterações. Assinale a alternativa que contenha a conduta terapêutica para esta paciente:

a) Fundoplicatura a Nissen

b) Hidróxido de magnésio ou alumínio 3x ao dia até a melhora dos sintomas

c) Inibidores da bomba de prótons 3x ao dia por 3 meses, em dose plena

d) Perda ponderal e elevação da cabeceira

11) Mulher, 65 anos, com transtorno depressivo maior grave, deu entrada no serviço de emergência sonolenta e hipotensa após tentativa de autoextermínio por ingesta de medicamentos. Ao exame físico: hipertermia, rubor e pupilas dilatadas. Durante o atendimento evoluiu com convulsão, parada cardiopulmonar em ritmo de fibrilação ventricular. O eletrocardiograma de admissão evidenciou QRS largo e intervalo QT prolongado. Que fármaco pode ter desencadeado o quadro clínico?

a) Venlafaxina

b) Fluoxetina

c) Amitriptilina

d) Moclobemida

12) Mulher, 75 anos, sabidamente portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica decorrente de tabagismo, deu entrada na emergência com quadro de dispneia, febre e tosse com secreção purulenta. Ao exame: lúcida e orientada, normocorada, acianótica, Tax: 38,6°C. Roncos pulmonares difusos e estertores em base direita. A gasometria arterial colhida na admissão revelou os seguintes valores: pH: 7,14; PCO2: 35mmHg; PO2: 68mmHg; HCO: 12mEq/L; BE: -8. Qual o distúrbio observado nessa paciente?

a) Acidose metabólica hiperclorêmica

b) Acidose metabólica compensada

c) Acidose metabólica simples

d) Acidose metabólica e respiratória

13) A azotemia pré-renal é a forma mais comum de insuficiência renal aguda, podendo estar associado mais frequentemente:

a) à hemólise

b) à litíase renal

c) à hipovolemia

d) ao contraste iodado

14) Homem de 30 anos de idade, com história de tireoidectomia total e radioablação por carcinoma papilífero de tireoide, chega à consulta emagrecido, com quadro de fadiga, inapetência, sonolência e mucosas hipocoradas. Considerando-se que a medicação de reposição hormonal (levotiroxina 150 mcg/dia) está correta, espera-se que o resultado laboratorial compatível com o diagnóstico presumível seja:

A) T3 diminuído

B) TSH aumentado

C) T4 Livre diminuído

D) tireoglobulina aumentada

15) Ernesto tem 32 anos de idade e iniciou tratamento para tuberculose pulmonar há duas semanas com esquema básico. Há 48 horas percebeu “coceira no corpo todo”, pior à noite, dificultando o sono, sem outros sintomas. Ao exame, seu estado geral é bom e não há lesões cutâneas. A conduta mais adequada ao caso é:

a) informar que não se trata de reação adversa e observar a evolução do quadro.

b) informar que é uma reação potencialmente grave, iniciar corticoterapia oral, suspender tratamento e encaminhar a serviço especializado.

c) informar que trata-se de uma reação adversa ao tratamento, de caráter benigno, prescrever anti- histamínico e manter o esquema terapêutico.

d) informar que é uma reação adversa potencialmente grave, suspender tratamento até a resolução do quadro e reintroduzir as medicações, uma a uma, para identificar a responsável pela reação.

16) Paciente de 27 anos, masculino, com quadro de cefaleia unilateral a esquerda, pulsátil, com náuseas e vômitos desde a adolescência. Os episódios duram em média 6 horas, com melhora parcial em uso de Dipirona. Episodicamente com fotofobia. Nega comorbidades, e os episódios álgicos são em média duas vezes por mês. O exame neurológico é normal. A conduta frente ao quadro:

a) Trocar Dipirona por Sumatriptano

b) Solicitar TC de crânio com contraste

c) Iniciar tratamento diário com Amitriptilina

d) Prescrever O2 inalatório 100% durante as crises

17) Você se encontra no ambulatório de neurologia para acompanhamento de um paciente que sofreu AVC isquêmico há 8 meses. Ele apresenta uma hemiplegia espástica a direita com afasia de Broca. A TC de crânio apresenta uma encefalomalacia frontal a esquerda. Ele está em uso de Captopril 25 mg 1 cp de 12/12 hr e Warfarina 5 mg 1 cp ao dia. Nega uso de AAS e estatinas. O exame e alteração que justifica o uso do anticoagulante ao invés do antiagregante plaquetário, na prevenção secundário do AVC isquêmico é:

a) Ecodoppler de carótidas e vertebrais: Obstrução de 80% na luz da carótida direita

b) Eletroencefalograma: Presença generalizada de ponta-onda a 3 Hz

c) Eletrocardiograma: Ausência de onda P e intervalo QRS irregular em D2

d) Ecocardiograma transesofágico: Aneurisma da artéria Aorta descendente

18) Seu José, 70 anos, apresentou AVC hemorrágico intraparenquimatoso há nove meses. Como sequela, ficou uma hemiparesia a esquerda, onde vem realizando fisioterapia para a reabilitação. Nega cefaleia ou qualquer síndrome álgica e refere controle satisfatório da HAS, em uso de medicamentos. Chama atenção o uso da Nimodipina 30 mg (2 cp de 8/8hr). Seu José, no final da consulta, pergunta se deve continuar com este remédio. A resposta deve ser:

a) Continuar com a Nimodipina, pois previne as complicações do AVC hemorrágico

b) Suspender a Nimodipina, pois nesta forma de AVC hemorrágico não seria necessário o uso

c) Continuar com a Nimodipina, pois ela ajuda a controlar a HAS

d) Suspender a Nimodipina, pois nesta forma de AVC hemorrágico é recomendável o uso, porém apenas por seis meses

19) Adolescente de 17 anos, masculino, com HPP de migrânea sem aura, em investigação para quadros de perda de consciência durando cerca de 5 minutos e com períodos de mialgias e confusão mental após recobrar a consciência. Ao todo, foram 5 episódios e os exames complementares na consulta são: Eletroencefalograma e TC de crânio com contraste, ambos normais. Qual seria a conduta frente a este quadro?

a) Iniciar Valproato de sódio para uso contínuo

b) Não prescrever medicamentos e apenas orientar

c) Encaminhar ao cardiologista para realização de exames complementares

d) Prescrever Diazepam oral SOS, em caso de novos episódios de perda de consciência

20) Homem de 70 anos, vem a consulta de primeira vez acompanhado, e segundo a filha, apresenta perda progressiva da memória e desorientação há 6 meses. Já não consegue mais ser independente nas tarefas cotidianas e já se perdeu na rua. Faz uso de hidroclorotiazida, metformina, omeprazol e diclofenaco de sódio (HAS, DM e Artrite reumatóide). Sem história familiar para doenças neurológicas. No seu exame físico: PA 160 x 90 mmHg, FC 92 bpm, FR 17 irpm e Tax 36c. O miniexame do estado mental é 15/30 (ensino médio completo), marcha de pequenos passos e reflexos tendinosos abolidos globalmente. Força grau 5 em todos os membros, sem alterações na coordenação, sensibilidade e nervos cranianos. A conduta frente ao caso:

a) Iniciar Donepezila uma vez por dia

b) Retirar diclofenaco de sódio e reavaliar em 60 dias

c) Solicitar exame exames (TC de crânio, TSH, T4 livre, VDRL, Vit B12)

d) Internar o paciente para tratar encefalopatia hipertensiva/delirium

21) Homem de 65 anos é trazido em consulta pelos familiares. Estes relatam que há cerca de um ano percebem que o mesmo apresenta dificuldades para realizar tarefas que antes fazia sem problemas, como pagar contas ou ir ao mercado, distante 2 quadras de casa. Notam que ele está muito desatento, mas informam que alguns dias está melhor que em outros. Desde o início do quadro apresenta alucinações visuais e nos últimos meses percebem que caminha com mais dificuldade, com corpo mais duro. Os familiares relatam que o paciente, enquanto dorme, se movimenta muito e fala. Negam histórico de hipertensão arterial e diabetes. No exame clínico apresenta rigidez simétrica nos membros inferiores, sem tremor. Miniexame do estado mental: 29 pontos. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico sugerido a partir do quadro descrito:

a) Demência tipo Binswanger

b) Demência associada à doença de Parkinson

c) Demência por corpúsculos de Lewy

d) Paralisia supranuclear progressiva

22) Homem de 89 anos relata tontura quando fica em pé, sua família relata que quase diariamente, o mesmo se levanta e vai para o quintal, onde fica sob a sombra de uma frondosa mangueira; após poucos minutos, apresenta quedas e precisa ser amparado. Tem hipertensão arterial, incontinência urinária e osteoartrite de joelhos. Utiliza: enalapril 10mg (1-0- 1), hidroclorotiazida 25 mg (1-0-0), oxibutinina 5mg (1-0-1) e analgésicos eventuais para os joelhos. Ao exame físico: PA deitado 160/90 mmHg, FC de 82 bpm em ritmo regular, fica em pé a partir da cadeira com uso de bengala como apoio. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada para avaliar a causa das quedas deste paciente:

a) Realizar tomografia de crânio

b) Mensurar pressão arterial sentado e em pé (esta após 3 minutos)

c) Avaliar equilíbrio com teste de Romberg

d) Avaliar acuidade visual

23) Paciente de 48 anos procura o pronto atendimento com história de perda do sono, dificuldade de concentração, aumento do apetite e angústia, “estando muito preocupada com tudo”, desde há seis meses. A conduta mais adequada para abordar este caso é:

a) Solicitar eletroencefalograma.

b) Prescrever diazepam 10 mg via oral à noite ou equivalente.

c) Introduzir neuroléptico e encaminhar para unidade básica de saúde

d) Iniciar antidepressivo e encaminhá-la para acompanhamento ambulatorial.

24) Paciente de 28 anos, soropositivo para HIV e em uso regular de TARV procura seu médico com história de tosse, expectoração e febre alta, de início há três dias. O exame físico mostra, além da elevação da temperatura axilar, finas crepitações no pulmão direito. A radiografia do tórax mostrou imagem de condensação homogenia no terço inferior deste pulmão. Na última consulta de acompanhamento a carga viral foi indetectável e a contagem de linfócitos T CD4+ foi de 650 células/mm³. O diagnóstico clínico mais provável para este paciente é:

a) Criptococose pulmonar

b) Pneumonia pelo citomegalovírus.

c) Pneumonia bacteriana comunitária.

d) Pneumonia por Pneumocystisjirovecii.

25) Homem de 55 anos gozava de plena saúde até poucas semanas antes da consulta, quando observou o aparecimento de lesões equimóticas nas extremidades e no tronco. Não havia história de trauma e tem se sentido mais fatigado do que o habitual. No exame físico os sinais vitais estavam normais; lúcido e orientado; palidez cutaneomucosa; cavidade oral com edema gengival e petéquias no palato. Ausência de aumento dos linfonodos; aparelho respiratório e aparelho circulatório, assim como o abdome, estão sem alterações; os membros inferiores apresentavam rash petequial bilateral abaixo dos joelhos.

Estudos laboratoriais iniciais: hemoglobina = 7,8 g/dl; hematócrito = 27%; VCM = 85 fl; leucócitos = 17.000/mm³ com 15% de polimorfonucleares, 10% de linfócitos, 5% de monócitos e 70% de blastos; plaquetas = 20.000/mm³.

Considerando as informações apresentadas, o diagnóstico mais provável é:

A) Leucemia mieloide aguda;

B) Leucemia mieloide crônica;

C) Leucemia linfocítica crônica;

D) Leucemia linfoblástica aguda.

26) Assinale o item que apresenta a conduta que melhora a encefalopatia nos portadores de doença hepática crônica.

A) Benzodiazepínico;

B) Acidificação do cólon;

C) Bicarbonato de sódio;

D) Medicação constipante.

27) Paciente de 53 anos, sexo feminino, apresenta história de seis semanas com palpitações, intolerância ao calor e ansiedade. Exame físico: FC = 112bpm; PA = 145/80 mmHg; olhar alerta e com certa proptose; tireoide aumentada e algo nodular; ritmo cardíaco irregular. Exames complementares: TSH = 0,01 um/ml (normal = 0,5 - 4,0); T4 livre = 2,4 ng/dl (normal = 0,8 a 1,8). Ela é referenciada para exame de captação com I-123 que revela captação de 58% em 24 horas (normal = 15 a 30%). O traçado do ECG foi compatível com fibrilação atrial.

Em relação a esta apresentação clínica, assinale o item que se encontra correto.

A) A paciente provavelmente tem um processo hipotalâmico que resultou na produção hipofisária de TSH.

B) A paciente apresenta clássicos sintomas de bócio por deficiência de iodo e deve ser reposta com levotiroxina.

C) Deve ser solicitada dosagem de anticorpos anti- TPO e iniciado tratamento comantitireoidiano e betabloqueador.

D) A alteração tireoidiana não justifica a doença cardíaca subjacente, que provavelmente é de natureza isquêmica, considerando-se a idade da paciente.

28) Paciente de 21 anos, masculino, procura atendimento por causa de febre. Início cinco dias antes com febre, mialgias, cefaleia e dor de garganta. Foi-lhe prescrita ampicilina, após a qual apresentou rash cutâneo. Exame físico: estado geral regular; temperatura axilar = 38,1ºC; mucosas normocoradas; pele apresentando exantema rubeoliforme predominante no tronco. O orofaringe está hiperemiado e coberto por um exsudato claro, com discreto enantema petequial no palato; presença de múltiplos linfonodos cervicais; aparelhos respiratório e cardiovascular normais. No abdome o fígado está a 3cm da reborda costal direita e uma ponta de baço foi sentida sob a reborda esquerda. Assinale o item que apresenta o exame complementar que confirma o diagnóstico deste paciente.

A) Monoteste;

B) Cultura de material de orofaringe;

C) Dosagem da anti-estreptolisina O;

D) Teste rápido para detecção do antígeno estreptocócico.

29) A partir do caso a seguir, selecione a opção com a sequência CORRETA de causas de óbito, para preenchimento da Parte I da Declaração de Óbito, considerando que a primeira causa da lista deve ser a causa imediata e a última será a causa básica. Paciente masculino, 65 anos, sabia ser portador de hipertensão arterial sistêmica desde há 20 anos, sem tratamento. Há cerca de 2 anos iniciou quadro de dispneia aos esforços, quando foi diagnosticada cardiopatia hipertensiva, tendo iniciado tratamento. Desde há 2 meses, evoluiu com insuficiência cardíaca congestiva. Hoje, foi internado com edema agudo de pulmão, indo a óbito após 2 horas.

A) Edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatia hipertensiva, hipertensão arterial sistêmica.

B) Hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatia hipertensiva, edema agudo de pulmão.

C) Edema agudo de pulmão, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatia hipertensiva.

D) Cardiopatia hipertensiva, hipertensão arterial sistêmica, edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva.

30) Mulher de 60 anos, com hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2 de longa data evolui com perda progressiva da função renal. Nos últimos dias, apresentou náuseas, vômitos, asterixis e houve queda do estado geral. Os exames atuais mostram: glicemia= 120mg/dl; uréia=140mg/dl; creatinina= 5,0mg/dl e sódio= 135mEq/L; potássio=5,8 mEq/dl e hemoglobina glicada= 9%. O cálculo do clearance de creatinina (peso=80kg e altura=1,60) e a gasometria arterial mais compatíveis com este quadro, respectivamente, são:

a) 17,7ml/min/pH = 7,32; pO2= 85 mmHg; pCO2 = 39 mmHg; bicarbonato = 21mmol/L; excesso de base = -2mmol/L

b) 17,7ml/min/pH = 7,40; pO2= 85 mmHg; pCO2 = 39 mmHg; bicarbonato = 18mmol/L; excesso de base = -6mmol/L

c) 15,1ml/min/pH = 7,32; pO2= 80 mmHg; pCO2 = 36 mmHg; bicarbonato = 18mmol/L; excesso de base = -6mmol/L

d) 15,1ml/min/pH = 7,40; pO2= 80 mmHg; pCO2 = 36 mmHg; bicarbonato = 21mmol/L; excesso de base = -2mmol/L

31) Assinale a etiologia mais comum da injúria renal aguda que afeta 40-80% dos pacientes:

a) Pré-renal

b) Pós-renal

c) Necrose tubular aguda

d) Nefrite intersticial aguda

32) A causa mais frequente de tireotoxicose é:

A) adenoma tóxico

B) doença de Graves

C) bócio multinodular tóxico

D) Bócio multinodular tóxico

33) Uma paciente idosa portadora de Diabetes mellitus tipo II e hipertensão arterial, em uso de enalapril e atenolol, vinha com sua pressão fora do alvo, variando entre 160 x 110 mmHg e 190 x 120 mmHg, assintomática. Procurou a emergência com sonolência e desorientação dois dias após seu médico acrescentar nova medicação para controle da pressão. Os exames laboratoriais mostravam: glicemia 128 mg%, ureia 15 mg% creatinina 0,6 mg%, sódio 118 mEq/L, potássio 4,1 mEq/L, bicarbonato 25 mEq/L, ácido úrico 2,5 mg%. Entre as drogas citadas abaixo, a que deve ter sido prescrita para essa paciente é a:

A) clonidina

B) furosemida

C) espironolactona

D) hidroclorotiazida

34) Na hipertensão do jaleco branco, o procedimento a ser feito para confirmar o diagnóstico é:

a) MAPA

b) Melhorar a relação médico paciente

c) Prescrever benzodiazepínico

d) ECO cardiograma transtorácico

35) Homem, 58 anos, hipertenso, fumante, com intolerância a glicose e história familiar de DM, tem estenose de cerca de 50% das carótidas internas. Faz uso de 100mg de losartan e sua PA= 150x90mmHg. O médico decide associar outra droga ao esquema anti-hipertensivo. Neste caso, a droga que deve ser evitada pois pode aumentar o risco de mortalidade e de infarto do miocárdio em associação ao losartan é o(a):

a) atenolol

b) enalapril

c) amlodipina

d) hidralazina

36) Homem de 25 anos queixa-se de cefaleia severa na região frontal e que se tornou mais frequente na última semana. Ela ocorre várias vezes ao dia e às vezes é acompanhada de lacrimejamento e congestão nasal. Nega febre e a dor é descrita como “em fisgada”, não melhora com descongestionante nasal e entre as crises o paciente sente-se bem. O exame físico é normal. O diagnóstico mais provável é:

A) enxaqueca;

B) sinusite aguda;

C) tumor cerebral;

D) cefaleia em salvas.

37) Mulher de 66 anos queixa-se com seu médico limitação funcional dos dedos das mãos, estando inclusive com dificuldade de desempenhar seus afazeres domésticos. O médico identifica comprometimento marcante das articulações interfalangeanas distais e pensa, prioritariamente, no diagnóstico de:

A) osteoartrite;

B) artrite séptica;

C) artrite reumatóide;

D) lúpus eritematoso sistêmico.

38) Paciente de 67 anos, sexo feminino, portadora de diabetes mellitus bem controlado com metformina 850mg duas vezes ao dia, procura seu médico com a língua espessa e avermelhada. Ele avalia que este achado se deve provavelmente à carência de:

A) Ferro

B) Folato

C) Vitamina A

D) Vitamina B12

39) Paciente de 18 anos, sexo masculino, apresenta cefaleia, febre e vômitos há cinco dias. Há presença dos sinais de Kernig e Brudzinski e é observada paralisia do terceiro par craniano. A punção lombar dá saída a líquor claro com 140 células/mm³, 70% de mononucleadas; glicose de 60mg/dl e proteínas de 112mg/dl. Dentre os patógenos abaixo, aquele com maior probabilidade de causar esta síndrome liquórica é:

A) Neisseria meningitidis

B) Haemophilus influenzae

C) Streptococcus pneumonae

D) Micobacterum tuberculosis

40. Mulher de 28 anos procura unidade de medicina familiar referindo ganho de peso, queda de cabelos, pele seca e cansaço. O médico suspeita de hipotireoidismo primário. Qual dos seguintes resultados laboratoriais se mostra mais consistente com este diagnóstico?

A) TSH baixo e T4 livre baixo;

B) TSH baixo e T4 livre elevado;

C) TSH elevado e T4 livre baixo;

D) TSH elevado e T4 livre elevado.

GABARITO 2022.2.2

1. A

2. D

3. B

4. B

5. A

6. B

7. B

8. D

9. B

10. D

11. C

12. D

13. C

14. D

15. C

16. A

17. C
18. B
19. A
20. C
21. C
22. B
23. D
24. C
25. A
26. B
27. C
28. A
29. A
30. C
31. A
32. A
33. D
34. A
35. B
36. D
37. A
38. D
39. D
40. C

PROVA C.M. 2023.1.1

1) Paciente de 26 anos, com histórico de uso de drogas ilícitas e abandono de tratamento do HIV, procura atendimento médico pois apresenta cefaleia holocraniana de forte intensidade há mais de 1 semana e febre. Os exames laboratoriais solicitados evidenciaram anemia e linfopenia. A Tomografia computadorizada de crânio com contraste não apresenta lesões. Assinale a alternativa que contenha a principal hipótese diagnóstica e a conduta indicada para confirmar este diagnóstico é:

a) Encefalite herpética – eletroencefalograma

b) Meningite bacteriana – análise do líquor

c) Meningite criptocócica – análise de líquor

d) Neurotoxoplasmose – Ressonância Nuclear Magnética de encéfalo

2) Paciente feminina, 45 anos, em corticoterapia devido á artrite reumatoide. Mantendo níveis de taxa de filtração glomerular entre 35 e 45m/min/1,73m2. Apresentou quadro anterior de disúria e polaciúria. Foi tratada para infecção urinária por Escherichia coli há três semanas. Procura atendimento médico devido a quadro persistente de disúria associada com febre, calafrios, dor lombar, náuseas e vômitos. Estabelecido o diagnóstico de pielonefrite, analise as afirmativas abaixo:

I – A principal causa de pielonefrite é a ascensão ureteral.

II – A pielonefrite pode ocorrer por via hematogênica em pacientes com doença crônica em terapia imunossupressora.

III – Na pielonefrite complicada por doença renal prévia, pode haver redução da função renal.

Quais afirmativas estão corretas:

a) Apenas as afirmativas I e II

b) Apenas as afirmativas II e III

c) Apenas as afirmativas I e III

d) Todas as afirmativas estão corretas

3) Um paciente de 50 anos procura atendimento pois vem apresentando um quadro de evolução insidiosa, com tosse produtiva há 6 semanas, febre baixa e vespertina, sudorese noturna, perda ponderal de 8kg em 30 dias. Apresenta também um quadro diarreico persistente e aumento de volume da cadeia ganglionar á direita, única, cervical e indolor. A ausculta apresentou alteração em segmentos superiores e posteriores á direita. No RX de tórax foi evidenciado derrame pleural moderado e unilateral. Os critérios clínicos apresentados pelo paciente são mais compatíveis com o diagnóstico de:

a) Sarcoidose

b) Tuberculose

c) Doença pulmonar obstrutiva crônica

d) Pneumonia intersticial

4) Paciente de 56 anos, hipertenso (em uso de losartana), procura atendimento médico por aumento de ácido úrico. Ele relata ter um irmão com história de urolitíase. Nega história de litíase renal ou artralgias. Ao exame físico, apresentava-se em bom estado geral, IMC 32Kg/m2, ausência de anormalidades articulares ou presença de tofos. O restante do exame físico estava dentro dos limites de normalidade. Exames trazidos pelo paciente: ácido úrico = 7,3 mg/dl (VN = 2,5 a 7,0); USG do aparelho urinário sem anormalidades. Diante da presença de hiperuricemia assintomática, qual a conduta correta:

a) Tratar com colchicina 1,2mg ao dia por VO

b) Tratar com alopurinol 100mg ao dia por VO

c) Tratar com alopurinol em dose baixa (50mg ao dia por VO)

d) Não tratar

5) Mulher negra de 26 anos procura atendimento com queixa de fraqueza e desânimo há algumas semanas com piora progressiva. Relata febre e emagrecimento. O exame físico mostra mucosas descoradas 2+/4+, sem outras alterações. Os exames laboratoriais mostraram: hemoglobina=7,8g/dl; Hematócrito=22%; VCM=77fl; CHCM=25 pg; leucócitos=10.500/mm3; plaquetas= 550.000/mm3; reticulócitos = 3,0%; ferro sérico = 30□g/dl; (normal de 35 a 150□g/dl) e capacidade de ligação do ferro = 200□g/dl (normal de 200 a 420 □g/dl). Assinale a alternativa que contenha respectivamente a classificação e a causa desta anemia microcítica:

a) Normocrômica/anemia falciforme

b) Hipocrômica/anemia de doença crônica

c) Hipocrômica/anemia por deficiência de ferro

d) Normocrômica/anemia por deficiência de eritropoetina

6) Homem de 70 anos com história de dor lombar progressiva com piora à movimentação e associada a emagrecimento. Apresenta Lasegue positivo á direita, astenia e fraqueza de início há dois meses. Os exames mostraram hemoglobina = 9g/dl; leucócitos = 9.000/mm3, diferencial normal, plaquetas = 200.000/mm3; glicose = 90mg/dl; creatinina = 1,1mg/dl; proteínas totais= 7,5g, albumina = 3,0g/dl; globulina= 4,5g/dl; VHS= 110mm/hora; ácido úrico= 7,5 mg/dl; fosfatase alcalina = 120 U/l; cálcio = 10,5 mg/dl; fósforo = 3,5 mg/dl. O exame de imagem da coluna revela intensa osteopenia sem lesões líticas e PSA total = 9,5 ng/ml. O paciente é tabagista de 40 maços-ano e etilista social. Assinale a alternativa que contenha a principal hipótese diagnóstica para este paciente:

a) Mieloma múltiplo

b) Tumor de próstata metastático

c) Osteoporose secundária a hipogonadismo

d) Metástases na coluna por tumor epidermóide de pulmão

7) Paciente de 55 anos foi internado com quadro de tosse com secreção amarelada, dor tipo pleurítica, febre e queda do estado geral de início há três dias. Foi realizado exame de imagem do tórax que revelou pneumonia bacteriana em lobo inferior direito. Iniciaram amoxacilina-clavulanato e azitromicina que resultaram em melhora inicial do quadro. Após 3 dias de tratamento, a febre e a tosse retornaram e houve mudança na ausculta pulmonar com submacicez e murmúrio vesicular abolido em base de pulmão direito e egofonia. A radiografia de tórax mostrou

consolidação alveolar e velamento de base do pulmão direito com a parábola de Damoiseau. Assinale a alternativa correta em relação á conduta que deverá ser feita:

a) Trocar a prescrição para ceftrizxone, mantendo a azitromicina.

b) Realizar toracocentese e análise do líquido pleural.

c) Realizar pleuroscopia com biópsia pleural.

d) Solicitar TC de tórax e toracotomia.

8) Homem de 45 anos, hígido e sem antecedentes mórbidos procura atendimento médico com queixa de adinamia e fraqueza. Negava febre, emagrecimento ou anemia. Foram solicitados exames que mostraram: Glicose = 85mg/dl; creatinina = 0,8mg/dl; TGO = 87U/dl; TGP = 110U/dl; proteína total = 7,5g/dl; albumina = 3,5g/dl; TAP com INR = 1,4. Sorologias: HBsAg = não reagente; anti HBs = reagente; anti HBc = reagente; anti HCV = reagente e anti HAV IgG = reagente. Levando em consideração o resultado dos exames e visando a definição diagnóstica do quadro, a opção correta é solicitar:

a) USG de fígado e vias biliares

b) Fibroscan hepático

c) PCR para vírus C

d) PCR para vírus B

9) Homem de 60 anos procura atendimento pois relata estar apresentando dor abdominal em barra há dois dias, de forte intensidade, localizada no andar superior do abdômen associada a febre, náuseas e vômitos. Ao ser examinado, verificou-se: distensão abdominal e peristalse débil; PA= 100X60 mmHg; FC= 115 bpm e FR= 18 irpm. Exames laboratoriais: Hb= 12g/dl; leucócitos= 15.000/mm3; bastões= 10%; Glicemia = 140 mg/dl; creatinina= 1,6mg/dl; ureia= 100mg/dl; amilase= 1.500 U/I e lipase= 250 U/I. A TC de abdômen identificou pâncreas aumentado difusamente e coleções peripancreáticas. Nesse momento, a abordagem de maior importância, imediata, é realizar neste paciente:

a) a reposição vigorosa de cristaloides.

b) a nutrição enteral com reforço lipídico.

c) Antibioticoterapia precoce com meropenem

d) A drenagem das coleções pancreáticas

10) Mulher de 22 anos procura atendimento médico em função de cefaleia crônica e recorrente, de forte intensidade. Informa cefaleia unilateral e pulsátil que inicia de forma mais leve e acentua-se com o passar das horas, durando mais de 4 horas na ausência de tratamento adequado. Às vezes, o quadro é precedido por escotomas, caracterizados por falhas periféricas no campo visual. O médico que estava avaliando, afirmou se tratar de migrânea, pois, além dos dados apresentados acima, havia também:

a) Fonofobia e fotofobia durante as crises.

b) Anorexia isolada, sem náuseas e vômitos.

c) Hiperemia conjuntival e miose ipsilateral á dor.

d) Alívio da dor ao subir escadas ou fazer atividade física similar.

11) Um paciente é diagnosticado com trombose venosa profunda (TVP). Sabemos que a principal consequência deste quadro é:

a) Atelectasia pulmonar

b) Embolia pulmonar

c) Insuficiência pulmonar

d) Parada cardíaca

12) Você atende um paciente com diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Pensando em uma terapêutica que poderia reduzir a mortalidade neste caso, você poderia usar:

a) Inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), digoxina ou diurético de alça

b) Diurético de alça, betabloqueador ou IECA

c) IECA, antagonista da aldosterona e betabloqueador

d) Digoxina, antagonista da aldosterona e betabloqueador

13) Em relação ao paciente com diabetes tipo 2, é correto afirmar:

a) Aspirina é a droga de escolha na profilaxia primária de eventos cardiovasculares para todos os pacientes desde o diagnóstico de diabetes.

b) A droga de escolha para o início do tratamento de hipertensão arterial nos pacientes diabéticos é o bloqueador do canal de cálcio.

c) Estatinas devem ser utilizadas para manter o colesterol LDL abaixo de 100mg/dl.

d) O único efeito esperado da metformina é auxiliar no controle dos níveis glicêmicos

14) Um paciente estava em uso de uma determinada medicação e apresentou quadro de necrose tubular aguda. Assinale a alternativa que contenha a medicação usada:

a) Ciclosporina

b) Anfotericina B

c) Aminoglicosídeo

d) Cefalexina

15) Paciente de 65 anos, diabético e hipertenso, realiza consulta ambulatorial para seguimento de suas comorbidades. Faz uso regular de metformina 1,5g/dia, enalapril 10mg/dia e sinvastatina 40mg/dia. Nega episódios de dor torácica, eventos cardiovasculares ou cerebrovasculares. Relata pais falecidos por infarto agudo do miocárdio após 70 anos de idade. Assinale, dentre as alternativas abaixo, a opção mais adequada para triagem de doença aterosclerótica subclínica:

a) Teste ergométrico

b) Cintilografia miocárdica

c) Ultrassonografia (USG) com doppler de carótidas

d) Eletrocardiograma e raio X de tórax

16) Paciente de 35 anos de idade, portador da patologia CID:B24 (AIDS) há 4 anos, sem tratamento específico procura atendimento com queixa de diarreia há 40 dias, 3 a 4 evacuações por dia, com fezes aquosas, sem febre ou dor abdominal. Fez uso de vários medicamentos para verminose, sem sucesso. CD4= 210/mm3 e carga viral= 156.000 cópias. Dos patógenos listados abaixo, assinale aquele que mais comumente causa esta situação descrita acima:

a) Isospora belli

b) Salmonella sp

c) Enterovírus

d) Clostridium difficile

17) Adolescente com quadro de febre moderada, persistente por mais de 15 dias e frequentemente vespertina, acompanhado de irritabilidade, tosse, perda de peso, sudorese noturna, às vezes profusas. Na investigação apresentou duas baciloscopias positivas no escarro. Foi introduzido tratamento com o esquema básico. Assinale a alternativa correta em relação ao tratamento, segundo o Ministério da Saúde:

a) Inicia-se com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Se surgir exantema, suspender o tratamento e reintroduzir o tratamento droga a droga após resolução.

b) Inicia-se com estreptomicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Se aparecer hepatite, suspender o tratamento.

c) Inicia-se com rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Se aparecer rabdomiólise, suspender o tratamento.

d) Inicia-se com rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Se surgir neuropatia periférica, suspender o tratamento e iniciar esquema duplo.

18) Uma mulher de 76 anos com antecedentes de diabetes e hipertensão arterial procurou atendimento pois apresentou quadro súbito de hemiparesia desproporcionada à direita e dificuldade para falar. Um exame neurológico mais detalhado mostrou que ela era capaz de obedecer ao comando simples, mas era incapaz de nomear ou repetir o nome de objetos que lhe foram mostrados. Com base nesses dados, podemos afirmar que a paciente apresentava:

a) Afasia sensitiva

b) Afasia motora

c) Disartria hipocinética

d) Disartria hipofônica

19) Paciente masculino de 36 anos, casado, está em acompanhamento de um quadro de hepatite B aguda. Onze meses após o início da doença, apresenta os seguintes resultados laboratoriais: transaminases normais; HBsAg

positivo; Anti-HBs negativo; HBeAg positivo; anti-HBc positivo; anti-HBc IgM negativo e anti-HBe negativo. Neste caso, o diagnóstico é de hepatite B:

a) Crônica em fase não replicativa

b) Crônica em atividade

c) Aguda em fase de recuperação

d) Aguda em fase replicativa

20) Dentre os fatores abaixo relacionados, assinale aquele que corresponde ao de maior risco para infarto agudo do miocárdio.

a) Diabetes

b) Obesidade

c) Dislipidemia

d) Hipertensão

21) Paciente de 56 anos, sexo masculino, queixa-se de aumento de peso corporal após início de um medicamento para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2. O medicamento que tem maior relação com o aumento de peso corporal e que provavelmente este paciente esteja tomando é:

a) Metformina

b) Liraglutida

c) Glimepirida

d) Saxagliptina

22) Paciente masculino, 57 anos de idade, apresenta queixas de queimação retroesternal, referindo por vezes regurgitação. Com suspeita de doença do refluxo gastroesofageano (DRGE), assinale a alternativa que contenha o nome do exame considerado padrão ouro para a confirmação diagnóstica:

a) Rx de contraste de esôfago

b) pH metria de 24 horas

c) esofagomanometria

d) endoscopia digestiva alta

23) Assinale a alternativa CORRETA em relação à meningite causada por Neisseria meningitidis.

a) O período de transmissibilidade persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe, o que ocorre a partir de 72 horas do início da antibioticoterapia adequada.

b) O regime antibiótico recomendado pelo Ministério da Saúde para adultos não imunocomprometidos é de 2 g de ceftriaxona a cada 24h, por sete dias.

c) O modo de transmissão é o contato direto pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas sintomáticas ou portadores assintomáticos da bactéria.

d) De acordo com o Ministério da Saúde, a quimioprofilaxia está indicada para todos os profissionais da saúde que atenderam o paciente antes do início da antibioticoterapia, sendo a rifampicina o medicamento de escolha.

24) Homem de 54 anos, diabético tipo 2 e hipertenso, vem em uso de metformina, hidroclorotiazida, enalapril e anlodipina. Durante o acompanhamento, desenvolve hiperuricemia e gota. Estas complicações apresentadas podem estar relacionadas ao uso de:

a) Metformina

b) Hidroclorotiazida

c) Enalapril

d) Amlodipina

25) Mulher de 50 anos, apresenta aferições de pressão arterial sistólica na faixa de 160 a 170mmHg e diastólica na faixa de 80 a 95 mmHg. O exame clínico é normal, exceto por B4 como bulha acessória. O ECG indica aumento da amplitude da onda R em precordiais esquerdas, índice de Morris aumentado e padrão do segmento ST tipo “strain”. Além das modificações do estilo de vida e da dieta hipossódica, a melhor conduta será:

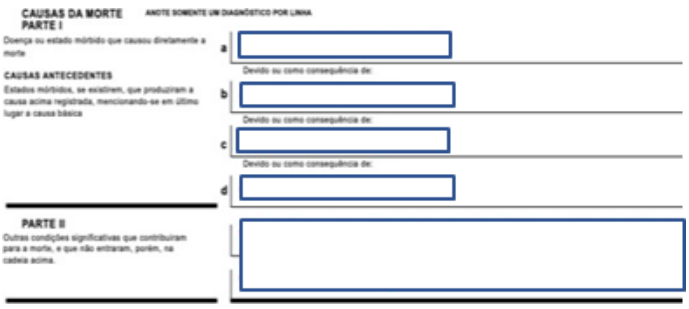
a) Iniciar anti-hipertensivos como a hidralazina com ou sem clonidina

b) Iniciar anti-hipertensivos como inibidor da enzima de conversão com ou sem tiazídico.

c) Aguardar resposta das modificações do estilo de vida, da dieta hipossódica e solicitar MAPA

d) Aguardar resposta das modificações do estilo de vida, da dieta hipossódica e reavaliar em 6 meses

26) Um homem de 75 anos de idade foi levado ao pronto-socorro mais próximo de sua casa com quadro de piora da insuficiência cardíaca congestiva com dispneia súbita. Evoluiu a óbito três dias após a internação, Era tabagista (40 maços ano). Teve diagnóstico de estenose de mitral aos 30 anos de idade e febre reumática na infância. A imagem a seguir mostra parte da declaração de óbito desse homem:



Com base nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o melhor preenchimento dessa declaração de óbito.

a) Parte 1: a, insuficiência cardíaca; b. estenose de valva mitral; c. febre reumática; d. tabagismo.

b) Parte 1: a. dispneia intensa; b. estenose de valva mitral; c. tabagismo. Parte II: febre reumática,

c) Parte 1: a. insuficiência cardíaca; b. estenose de valva mitral; c, febre reumática. Parte II: tabagismo.

d) Parte 1: a. parada cardiorrespiratória; b. estenose de valva mitral, c. febre reumática; d. tabagismo.

27) Uma paciente do sexo feminino, de 89 anos, procura o médico com queixa de edema perimaleolar discreto há 20 dias. É hipertensa de longa data em uso de enalapril 10 mg duas vezes ao dia e nifedipina 20 mg duas vezes por dia, tendo o último medicamento sido iniciado há cerca de um mês. Ao exame físico, apresenta pulso de 84 bpm, pressão arterial de 145 x 95 mmHg, ausculta pulmonar normal e pulsos periféricos normais. Os exames laboratoriais mostravam funções hepática, renal e tiroidiana normais. Qual é a provável causa do edema?

a) Níveis pressóricos ainda inadequadamente controlados.

b) Uso de bloqueador dos canais de cálcio dihidropiridínico.

c) Insuficiência cardíaca congestiva.

d) Envelhecimento do sistema vascular, já que a paciente é muito idosa.

28) Um paciente de 67 anos, do sexo masculino, hipertenso, portador de diabetes mellitus tipo 2, foi levado ao ambulatório de geriatria com queixas de dificuldades de memória e insônia há 6 meses, após cirurgia para revascularização do miocárdio. Refere cansaço fácil, edema de membros inferiores e diz que tem exercido alguma atividade laboral com muito esforço. Enfatiza perda do interesse pela leitura, pelo lazer e tornou-se emotivo nos últimos meses, chorando muito facilmente. Antecedentes familiares: IAM, HAS e DM. O exame físico não mostrou alterações significativas. Exame psíquico: diminuição da atenção e memória de fixação, anedonia importante e apatia. Qual é a hipótese diagnóstica para esse caso?

a) Hipotireoidismo

b) Quadro demencial inicial

c) Depressão maior

d) Insuficiência cardíaca compensada

29) Um paciente de 77 anos, obeso, diabético, queixa- se de tontura quando fica de pé, acompanhada, muitas vezes, de visão turva e sensação de desmaio. Queixa- se, também, de empachamento pós-prandial e de alterações do ritmo intestinal, intercalando obstipação e diarreia. Deitado, sua PA foi 140/90 mmHg. Após 5 min em posição ortostática, sua PA foi 110/70 mmHg e sentiu tontura. A frequência cardíaca não se alterou com a mudança de posição. De acordo com o exposto, qual é a causa das queixas desse paciente?

A) Amiotrofia diabética

B) Microangiopatia diabética

C) Neuropatia autonômica diabética

D)Polineuropatia periférica diabética

30) Paciente do sexo masculino, de 69 anos, oito anos de escolaridade, foi levado à consulta pela filha, que relatou ser o pai uma pessoa tímida e reservada, porém há oito meses estava evoluindo com muita apatia, alternando períodos de agressividade, alterações do juízo crítico como falar alto, dizer inconveniências, andar nu pela casa e comer em demasia. Obteve 28 pontos no MEEM. Nega doenças previas e uso regular de medicamentos. Exame físico sem achados anormais. Foi solicitada ressonância magnética do crânio. Nesse caso, o provável diagnóstico e os achados na ressonância são, respectivamente:

a) Demência vascular e microangiopatia

b) Doença de Alzheimer e atrofia dos hipocampos

c) Demência por corpos de Lewy e atrofia cerebral difusa

d) Demência frontotemporal e atrofia frontal bilateral

31) Um homem de 38 anos deu entrada no hospital trazido pelo SAMU, devido a episodio de perda de consciência durando cerca de 6 minutos. Questionado, informantes afirmaram que o paciente ficou “todo duro” e “roxo” durante o evento. Ao recobrar a consciência se queixa de cefaleia holocraniana, confusão mental e desorientação. Foi medicado, feito TC de crânio (normal) e liberado para acompanhamento ambulatorial.

No ambulatório, ele é atendido e refere episódios semelhantes na adolescência e há 2 anos atras, sem nenhum fator desencadeante. O exame físico é normal e o paciente não apresenta comorbidades.

A medicação feita no hospital e conduta agora no ambulatório, respectivamente:

a) Diazepam EV – Solicitar Eletroencefalograma

b) Diazepam oral – Iniciar Fenitoína oral regular

c) Dipirona EV – Iniciar Valproato de sódio regular

d) Fenitoína EV – Realizar Eletrocardiograma

32) Dona Maria vem a primeira consulta ao ambulatório de neurologia, acompanhada da filha. Apresenta alteração cognitiva progressiva há 9 meses. Os filhos também mencionam há um mês, alteração da marcha e início de incontinência urinária. Conduta frente ao caso:

a) Iniciar Donepezila pensando em se tratar de Doença de Alzheimer em fase intermediária/tardia

b) Iniciar Levodopa/Benserazida e explicar a família se tratar de Doença de Parkinson em fase inicial

c) Solicitar Ressonância magnética de crânio e encaminhar a neurocirurgia para derivação ventrículo- peritoneal

d) Solicitar Tomografia de crânio sem contraste e iniciar AAS + Sinvastatina

33) A.B.C., 27 anos, vem a consulta médica se queixando de cefaleia de forte intensidade. Refere episódio semelhante na adolescência e que voltou há cerca de 4 meses. As cefaleias são em média 2 crises por mês no período menstrual, unilateral, pulsátil a esquerda, durando 24 horas, com náuseas e vômitos. Sem melhora com uso de Dipirona. Piora com a luz e esforço físico. Nega febre ou comorbidades. Exame físico sem alterações.

Levando em consideração o quadro clínico, o medicamento a ser adotado:

a) Sumatriptano

b) Valproato de sódio

c) Propranolol

d) Amitriptilina

34) S.L.J., 70 anos, refere cefaleia há 1 ano com as seguintes características: em pressão, bilateral, de média intensidade, sem náuseas e vômitos, quase diária e durando cerca de 40 minutos. Nega emagrecimento, febre ou perda de consciência. É portadora de HAS em uso regular de Anlodipina. Em relação ao caso:

a) Iniciar tratamento profilático com tricíclico

b) Iniciar tratamento profilático com inibidor da receptação da serotonina

c) Solicitar TC de crânio com contraste

d) Solicitar Eletroencefalograma em vigília

35) Homem de 75 anos é acompanhado no ambulatório de clínica médica por insuficiência cardíaca e hipertensão. Está em uso regular de enalapril e carvedilol em doses máximas, até 4 meses atrás, estava clinicamente estável. Desde então, a dispneia passou dos grandes aos médios esforços, com aparecimento de edema de membros inferiores ao final do dia. Nega febre, alteração do peso ou do padrão de sono. Há quatro dias apresenta palpitação e piora da dispneia, que passou a ocorrer no repouso. No exame clínico, tem frequência cardíaca de 90 bpm (arrítmico), pressão arterial 122x76 mmHg, bulhas arrítmicas e estertores finos em bases pulmonares. O restante do exame clínico é normal. Qual dos exames complementares abaixo deve ser realizado neste momento?

a) Angiotomografia de tórax.

b) Eletrocardiograma.

c) Cineangiocoronariografia.

d) Proteína C-reativa.

36) Adamastor, 55 anos, portador de diabetes mellitus tipo II há 05 anos, iniciou um quadro de hipertensão arterial sistêmica. Diante do cenário clínico, além das recomendações não farmacológicas, compreendeu-se a necessidade do início da seguinte classe medicamentosa, esta, preconizada para tal contexto:

a) Beta bloqueador.

b) Bloqueador dos canais de cálcio.

c) Agente simpatolítico de ação central.

d) Inibidor da enzima de conversão da angiotensina.

37) Carla, 27 anos, procura o serviço de saúde para mostrar exames. Ela vinha com quadro de tosse produtiva há 30 dias, associado a febre, inapetência e perda de peso. A baciloscopia do escarro veio positiva para BAAR. A radiografia de tórax demonstra cavitações em ambos os pulmões. Ela traz também resultado do anti-HIV positivo. Sua médica de família e comunidade faz encaminhamento para infectologia, mas consegue marcar a consulta apenas para o próximo mês. Decide então discutir o caso com a infectologista. Após essa discussão, assinale a alternativa que apresenta a forma mais adequada de tratamento para esse caso.

a) Iniciar o esquema básico de tratamento da tuberculose juntamente com o tratamento antirretroviral, porém modificando a rifampicina por rifabutina para diminuir os riscos de efeitos adversos.

b) Iniciar o tratamento antirretroviral e após 15 dias iniciar o tratamento para tuberculose.

c) Iniciar o tratamento de tuberculose com esquema básico e, após algumas semanas, o tratamento antirretroviral, para evitar síndrome da reconstituição imune.

d) Iniciar os antirretrovirais em conjunto com esquema básico da tuberculose para diminuir o risco de intolerância medicamentosa e efeitos adversos.

38) Marque a opção que contenha respectivamente sinal e sintoma comuns ao quadro de hipotireoidismo:

a) Bócio e diarreia.

b) Pele quente e palpitação.

c) Tremor de extremidades e cansaço.

d) Pele infiltrada e acuidade auditiva diminuída.

39) Considerando um paciente com 3 dias de febre alta, artralgias simétricas intensas e com edema, e que apresentou exantema no 2o / 3o dia de doença, é possível afirmar que:

a) Os diagnósticos mais prováveis são de febre Chikungunya e infecção pelo vírus Zika, pela presença de febre alta e artralgias, devendo as sorologias serem solicitadas.

b) O diagnóstico poderia incluir febre Chikungunya e dengue, sendo útil o exame NS-1 neste momento da investigação.

c) O diagnostico poderia incluir infecção pelo Zika e febre Chikungunya considerando o exantema precoce, devendo o exame NS ser pedido.

d) O diagnóstico inicialmente poderia incluir qualquer arbovirose, mas a ausência de hiperemia conjuntival e do prurido afasta a possibilidade de Chikungunya.

40) Sobre a doença viral Zika é correto afirmar que:

a) Há evidências de complicações neurológicas, como síndrome de Guillain- Barré e microcefalia.

b) É transmitida pelo mesmo vetor que transmite a malária

c) As medidas de combate a transmissão de combate a dengue não são eficazes.

d) Em comparação com a dengue, tem morbidade inferior e mortalidade superior.

GABARITO 2023.1.1

1. C

2. D

3. B

4. D

5. B

6. A

7. B

8. C

9. A

10. A

11. B

12. C

13. C

14. C

15. C

16. A

17. A

18. B

19. B

20. C

21. C

22. B

23. C

24. B

25. B

26. C

27. B

28. C

29. C

30. D

31. C

32. C

33. A

34. C

35. B

36. D

37. C

38. D

39. B

40. A

PROVA C.M. 2023.1.2

1) Paciente 4 anos de idade, em bom estado geral, apresentando múltiplas placas eritemato descamativa com tonsura em couro cabeludo ausência de sinais f logísticos e ou drenagem de material purulento. Sua responsável relata evolução de 10 dias e que este possui 2 irmãos com mesmos sinais e sintomas. Qual tratamento?

a) Cetoconazol

b) Cefalexina

c) Griseofulvina

d) Aciclovir

2) Paciente 42 anos de idade refere que após barbear-se, há 2 dias, iniciou com lesões faciais. Relata que isso nunca havia ocorrido. Ao exame: papulo-pústulas eritematosas foliculares e não foliculares e crostas melicéricas em face (borda mandibular e mentoniana). Nega febre e sensação de ardência/ prurido ocasional.

a) Impetigo

b) Escabiose

c) Dermatite de contato

d) Tinea faciei

3) Paciente 25 anos, sem histórico prévio de doenças pulmonares, com tosse produtiva e emagrecimento há 1 mês. Nega dispneia ou dor torácica. Cursando com hemoptise em pequeno volume nas últimas 24 horas. Presença de cavitação no segmento 6 á direita. Qual é a causa mais provável desta hemoptise?

a) Tuberculose

b) CA de pulmão

c) TEP

d) Bronquectasia

4) Educador físico, 58 anos de idade, queixa-se há um ano de astenia e dor articular dos punhos e articulações metacarpofalangianas com ritmo inflamatório. Ao exame físico apresenta artrite com dor, edema e calor nas articulações citadas. Leucograma normal, 500 mil plaquetas, fator reumatoide negativo, fator antinuclear (FAN) negativo, sorologias para hepatites virais e anti- HIV negativas, velocidade de hemossedimentação = 50 mm, PCR = 3,2 mg/dl (normal até 1,0 mg/dl).

a) Osteoartrite seria um dos principais diagnósticos diferenciais devido à idade e articulações acometidas

b) Levando em conta as características clínico- laboratoriais podemos pensar em artrite reumatoide

c) Devemos pesquisar síndrome de Sjögren devido ao quadro articular muito sugestivo

d) Quadro inflamatório clínico e laboratorial nos faz pensar em doença infecciosa.

5) Geólogo, 38 anos, casado, obeso, hipertenso, refere há dois dias monoartrite associada a derrame articular volumoso no joelho direito, sem história de trauma, febre ou queda do estado geral. Há um ano apresentou quadro semelhante no primeiro pododáctilo a direita, com melhora após uso de anti-inflamatórios não hormonais. Qual provável diagnóstico?

A) Espondiloartrites

B) Lúpus eritematoso sistêmico

C) Febre reumática

D) Gota

6) Analista de Recursos Humanos, feminina, 64 anos de idade, com sobrepeso desde a adolescência, há seis meses apresenta gonalgia bilateral, com crepitação e ritmo mecânico. Nega sintomas sistêmicos. Apresenta fator reumatoide positivo, porém provas de atividade inflamatória negativas. Podemos afirmar que se trata de um caso de:

a) Artrite reumatoide

b) Osteoartrite

c) Tendinite de pata de ganso

d) Sindrome de Sjogren

7) Enfermeira, casada, com 74 anos de idade, queixa-se há 2 meses de poliartralgia de ritmo mecânico, sem alterações cutâneas, cardiovasculares ou renais. Exames laboratoriais: FAN título 1/320 padrão pontilhado fino denso, fator reumatoide positivo, hemograma sem alterações e provas de atividade inflamatória normais. Qual a conduta?

A) Investigação com Anti-DNA dupla hélice e Anti-SM, pois há elevada probabilidade de lúpus eritematoso sistêmico.

B) Como trata-se de quadro compatível com artrite reumatoide, deve ser iniciado o tratamento específico para esta doença

C) Investigação com Anti-CCP para comprovar a hipótese de artrite reumatoide.

D) Acalmar a paciente, pois este padrão de FAN é comumente encontrado em indivíduos saudáveis

8) Historiadora, branca, 62 anos de idade, queixa- se há dois anos de quadro álgico de ritmo mecânico nas articulações interfalangianas proximais (IFP) bilateralmente e gonalgia à esquerda. Ao exame: ausência de calor nas articulações acometidas e nódulos de Bouchard nas IFP. Nega alterações sistêmicas. Qual seria um dos fatores de risco para a doença da paciente acima?

a) Raça branca

b) Envelhecimento

c) Consumo de frutas

d) História familiar de osteoporose

9) Sr. JRM tem uma queixa de tremor em repouso, de alta amplitude e baixa frequência, rigidez muscular, fácies inexpressiva, fala monótona. Em relação ao diagnóstico, assinale a alternativa correta

a) Parkinsonismo

b) Tremor senil

c) Tremor fisiológico

d) Paralisia supranuclear progressiva.

10) Sra. MSG, 91 anos, sexo feminino, branca, solteira. Tem antecedente de hipertensão arterial e tabagismo. É internada com história de queda da própria altura e dor intensa na coxa direta com impossibilidade de deambulação. Foi constatada uma fratura transtrocantérica do fêmur direito. Assinale a alternativa correta a respeito desse caso.

a) Trata-se de fratura por fragilidade, associada à osteoporose.

b) Trata-se de fratura acidental, sem relação com qualquer doença pré-existente.

c) Trata-se de fratura por fragilidade, havendo a necessidade de se realizar a densitometria óssea para confirmação de osteoporose.

d) Trata-se de fratura patológica, associada a doença de Paget.

11) Paciente de 70 anos de idade, aposentado do serviço público (professor universitário) havia cerca de cinco anos, chegou ao ambulatório de geriatria com queixa de esquecimentos. Não havia antecedente familiar (pai, mãe e irmãos) de demência. Relatou incontinência urinária iniciada havia menos de um ano. Negou tontura, rigidez ou bradicinesia. Ao exame físico, apresentou apraxia de marcha e tremores de mãos bilaterais com baixa amplitude e alta frequência. Sua pressão arterial era de 145 mmHg × 86 mmHg. A partir das informações apresentadas, identifique a opção correta:

a) Há critérios clínicos para o diagnóstico de doença de Parkinson.

b) Entre as causas relacionadas ao possível déficit cognitivo, devem-se considerar os diagnósticos de hidrocefalia de pressão normal e demência vascular.

c) Não é necessária a realização de um exame de imagem de crânio (ressonância magnética ou tomografia computadorizada) para o diagnóstico nesse caso

d) O tratamento adequado para este paciente é reabilitação fisioterápica

12) Sra Maria José, 83 anos, viúva, professora aposentada, vem ao serviço com queixa de esquecimento. Queixa-se de esquecer onde coloca objetos e nomes lembrando após alguns minutos. Ela mora sozinha, relata ser capaz de tomar seus remédios, pagar suas compras, fazer as atividades da casa, tendo somente uma pessoa para ajudar uma vez por semana. MiniExame do Estado Mental de 29/30. Sua filha, que a acompanha, diz que não percebe a queixa da mãe e ratifica as informações dadas sobre sua funcionalidade. Sua hipótese à princípio é de:

a) Depressão

b) Esquecimento subjetivo

c) Transtorno neurocognitivo menor

d) Transtorno neurocognitivo maior

13) Idoso, masculino, 81 anos, engenheiro, casado é avaliado no ambulatório. Ele relata ter tido 3 quedas nos últimos meses, dificuldade em subir um lance de escada, pois mora no segundo andar, principalmente quando trazendo compras do mercado, sem dificuldade para andar dentro de casa. Relata perda de peso leve não aferida consequente a redução no seu apetite. Timed get up and go (TGUG) foi de 22 segundos (normal até 12seg), velocidade de marcha 0,6m/s (normal maior ou igual a 0,8m/s), seu perímetro de panturrilha mediu 30 cm (maior de 31 cm) , IMC (índice de massa corpórea) de 22 Kg/m2 (normal entre 22 a 27), MAN (mini avaliação nutricional- triagem) com 12 pontos (maior que 12 sem risco nutricional), MEEM (mini exame do estado mental) 29 pontos (escore esperado para escolaridade de 29 pontos), escala de depressão geriátrica (EDG) 3 pontos (até 5 sem risco). Baseado nestas informações, você sugere a hipótese de:

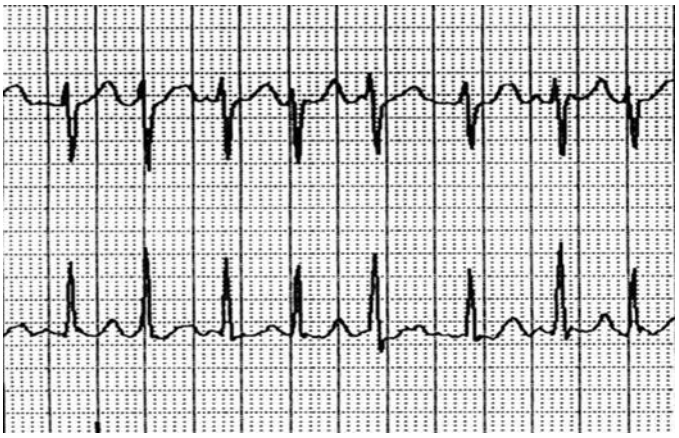
a) Sarcopenia

b) Déficit cognitivo

c) Depressão

d) Desnutrição.

14) Homem de 41 anos, levado por familiares a emergência do HUV devido quadro de Dispneia de início súbito há 2h, associada a palpitações, durante festa de comemoração de aniversário de seu irmão. O paciente havia feito uso de bebida alcoólica em grande quantidade. Negava dor torácica. Sem febre. Nenhum antecedente e nenhuma queixa prévia de doença cardiovascular. Não faz uso de nenhuma medicação. Não é tabagista. PA= 110X70mmHg P=150bpm. Segue o ECG abaixo. Qual a conduta correta:



a) Anticoagulação imediata e betabloqueador

b) Cardioversão elétrica

c) Reversão da fibrilação atrial com amiodarona venosa

d) Reverter a arritmia somente após realizar ecotransesofágico

15) Paciente tem diagnóstico e cardiopatia dilatada e faz tratamento regular com 4 medicamentos: Furosemida, Espironolactona, Sacubitril Valsartana e Carvedilol. Todas estão em doses otimizadas. Na última semana apresentou piora dos sintomas com dispneia aos esforços abaixo dos habituais e edema de MMII. Procurou o ambulatório e apresentava ritmo cardíaco irregular. ECG com fibrilação atrial. Decidimos associar mais um medicamento. A escolha deve ser:

a) Digoxina

b) Hidralazina

c) Amiodarona

d) Losartana

16) O diagnóstico da hipertensão arterial (HA) inclui a confirmação do diagnóstico (medida casual complementada pela MAPA ou MRPA), a identificação de possíveis causas secundárias, avaliação das lesões de órgãos alvo (LOA) além da avaliação do risco cardiovascular (CV). Para iniciar o tratamento devemos classificar o paciente de acordo com o nível da PA e as condições clínicas associadas. Um homem de 55 anos com pressão arterial de 164x98 mmHg e com antecedentes de angioplastia coronariana será classificado como:

a) Estágio I de risco alto

b) Estágio I de risco moderado

c) Estágio II de risco alto

d) Estágio II de risco moderado

17) Um paciente de 70 anos, tabagista de longa data é internado no H.U.V. com quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada e cor pulmonale (insuficiência ventricular direita secundária a doença pulmonar), negou outras patologias. Os achados semiológicos possivelmente presentes, compatíveis com tal condição são:

I- Sopro sistólico em foco de ponta com Rivero Carvallo positivo

II- Edema de membros inferiores simétrico, quente e duro

III- Refluxo hepato jugular patológico

IV- Macicez a percussão e Frêmito tóraco vocal abolido em bases pulmonares

a) As afirmativas I, II , III e IV são verdadeira

b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras

c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras

d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras

18) O Sr. João da Silva, 65 anos, vem se queixando de dor precordial do tipo opressiva, irradiada para o MSE, desencadeada no final de sua caminhada de 3 km, obrigando-lhe a interromper a caminhada para o alívio da dor. Paciente diabético, hipertenso e dislipidêmico. Sinais vitais: FC = 90 bpm PAS= 150/90 mmhg. Com relação aos objetivos terapêuticos desse paciente podemos afirmar:

I- O duplo produto do paciente encontra-se elevado

II- O Carvedilol seria droga de escolha tanto com objetivos hemodinâmicos como redução do risco de arritmias ventriculares

III- O papel do nitrato seria no alívio da dor e redução da mortalidade.

a) somente I está correta

b) somente III está correta

c) I e II estão corretas

d) I e III estão corretas

19) Um homem de 35 anos, diabético tipo II, chega à sala de urgência com quadro de disúria polaciúria, dor perineal, porém sem relato de febre. Exame de urina de jato médio, coletada com técnica asséptica evidencia nitrito positivo, leucocitúria, piúria, hematúria e flora microbiana aumentada. Qual dos antibióticos abaixo deve ser prescrito?

A) Amoxacilina

B) Nitrofurantoína

C) Penicilina cristalina

D) Sulfametoxazol/trimetropima

20) Um paciente com litíase de repetição apresenta litíase hipercalciúrica absortiva. Qual das medicações abaixo é utilizada como prevenção à litíase de repetição?

A) Hidroclorotiazida

B) Dutasterida

C) Tansulosina

D) Vitamina C

21) Uma paciente de 35 anos apresenta-se pela primeira vez com sintomas de disúria, polaciúria, hematúria sem coágulos, odor forte na urina, dor lombar bilateral e febre. Vem a upa pois foi medicada no psf com nitrofurantoína e os sintomas persistiram. Dos sintomas acima qual nos indica que a escolha do antimicrobiano para o tratamento da infecção urinária foi inadequado?

A) Disúria

B) Hematúria

C) Febre

D) Polaciúria

22) Um homem de 35 anos chega à sala de urgência com quadro de disúria polaciúria, dor perineal, porém sem relato de febre. Exame de urina de jato médio, coletada com técnica asséptica evidencia nitrito positivo, leucocitúria, piúria , hematúria e flora microbiana aumentada. Qual o achado doe exame de urina com maior valor preditivo para infecção urinaria?

A) Hematúria

B) Leucocitúria

C) Flora bacteriana aumentada

D) Nitrito positivo

23) Paciente de 22 anos, sexo masculino, procura o HUV com quadro de dor lombar em cólica à esquerda, com irradiação para região de flanco e fossa ilíaca homolateral, de forte intensidade (10/10) e associada à urina avermelhada. Qual o método diagnóstico considerado padrão ouro para o diagnóstico desse paciente?

A) Urotomografia com contraste

B) USG renal sem doppler de artérias renais

C) USG renal com doppler de artérias renais

D) Urotomografia sem constraste

24) Paciente de 30 anos, sexo feminino, procura atendimento médico com quadro de disúria, polaciúria e urgência miccional, compatível com quadro de cistite aguda. Qual dos resultados abaixo é compatível com esse quadro:

A) EAS: nitrito: - estearase leucocitária:- proteína: ausente Hb: ++++ hemácias: incontáveis/campo

B) EAS: proteína: ++++ Hb:++++ hemácias: 30/campo leucócitos: ausentes

C) EAS: proteína: ++++ Hb: ausente leucócitos 1/campo hemácias: ausentes

D) EAS: nitrito: + estearase leucocitária:+ proteína: traços Hb: ausente leucócitos 30/campo

25) Paciente de 25 anos, sexo feminino, sabidamente portadora de lúpus eritematoso sistêmico, procura o posto de saúde do seu bairro com quadro de edema facial e de membros inferiores. É examinada, os exames preliminares são realizados e a paciente é encaminhada ao ambulatório de Nefrologia do HUV. Na primeira consulta com o especialista, são solicitados alguns exames, cujos resultados seguem descritos: EAS: Hb:++ Proteína: +++. Hemácias: 20/campo Microscopia de fase: presença de cilindros hemáticos e acantócitos >5% É possível concluir que:

A) a paciente apresenta hematúria pós- glomerular

B) a paciente apresenta microalbuminúria

C) a paciente apresenta glomerulonefrite

D) a paciente apresenta hematúria isomórfica

26) Paciente de 19 anos dá entrada no pronto- socorro com queda do estado geral, referindo febre e início de diarreia há 3 dias, 5 episódios/dia. Encontra- se taquipneico, taquicárdico, tendendo à hipotensão, apresentando olhos encovados. Realizados 2L de SF0,9% com melhora do estado geral. À gasometria: pH 7,20 | HCO3 10 | pCO2 23 | Cl 120 mEq/L | Na 140 mEq/L Qual o distúrbio apresentado:

A) Acidose respiratória

B) Acidose metabólica hiperclorêmica

C) Acidose metabólica com ânion gap elevado

D) Acidose metabólica e alcalose respiratória

27) Qual alteração eletrocardiográfica esperada em paciente com hipercalemia?

A) Onda U proeminente

B) Taquicardia sinusal

C) Onda T apiculada

D) Infradesnivelamento ST

28) Homem, 54 anos, bombeiro hidráulico, morador de Vassouras, sem história de vacinação para Febre Amarela. Dois dias após regressar de Manaus- AM, apresentou febre alta de 39o, mialgia, cefaleia e hiporexia. No 5o dia de doença foi levado ao hospital com piora do estado geral e manifestação de icterícia e epistaxe. Exames da admissão: Hemograma: anemia, plaquetopenia e leucocitose. Bioquímica: transaminases hepáticas discretamente aumentadas, bilirrubinas aumentadas, ureia e creatinina aumentadas, potássio diminuído. VHS e proteína C reativa muito aumentados. Pesquisa de gota espessa de sangue negativa. Pelos dados apresentados, qual seria sua principal hipótese diagnóstica e o tratamento certo para o caso?

A) Leptospirose. Tratamento com Penicilina cristalina

B) Febre amarela. Tratamento com Ceftriaxona

C) Leptospirose. Tratamento com amoxicilina oral.

D) Febre amarela. Tratamento de suporte e das complicações.

29) Um homem de 59 anos de idade, previamente saudável, com sorologia não reagente para HIV, iniciou quadro de febre, cefaleia e vômitos. No segundo dia de doença, foi levado à emergência muito sonolento com abertura ocular somente ao estímulo doloroso, emitindo palavras incompreensíveis e fazendo movimento de retirada dos membros ao estímulo doloroso (escala de Glasgow=8). Sem história de crise convulsiva, sem comprometimento de pares cranianos, sem sinais neurológicos focais e sem papiledema. Na suspeita de Meningite Bacteriana Aguda, marque a resposta com a ordem cronológica correta para investigar e tratar esse caso:

A) Coleta de hemocultura--»»» Início de

corticoide--»»» Início de antibioticoterapia--»»» Exame de imagem do crânio --»»» Caso no exame de imagem não se verifiquem alterações que contraindiquem a punção lombar: proceder punção lombar para coleta do líquor.

B) Punção lombar para coleta do líquor --»»» coleta de hemoculturas - -»»» Início de corticoide

--»»» Início de antibioticoterapia -- -»»» Exame de imagem do crânio para avaliação de complicações

C) Início de antibioticoterapia--»»» Início de corticoide--»»» Punção lombar para coleta do líquor --»»» Exame de imagem do crânio--»»» Coleta de hemocultura.

D) Punção lombar para coleta do líquor --»»» Coleta de hemoculturas- -»»» Início de antibioticoterapia --»»» Exame de imagem do crânio --»»» Início de corticoide.

30) Homem, 70 anos de idade, com doença pulmonar obstrutiva crônica, comparece à emergência com queixa, de 2 dias de evolução, de febre, tosse produtiva com expectoração amarelada e dispneia aos esforços. Ao exame: frequência respiratória de 28 irpm, ausculta pulmonar com presença de sibilos difusos e estertores creptantes em base de HTE, acordado, orientado no tempo e espaço, frequência cardíaca 100 bpm, pressão arterial: 100 X 62 mmHg, restante do exame físico sem achados significativos. Pelos exames complementares: leucocitose com desvio à

esquerda, aumento de ureia= 70 mg/dl e Rx de tórax com condensação em 1/3 inferior de hemitórax esquerdo. Marque a opção que apresenta a correta classificação pelo CURB 65 e a correta conduta terapêutica.

A) CURB 65= 2, tratamento em enfermaria com Levofloxacina

B) CURB 65=2, tratamento em enfermaria com ceftriaxona +Azitromicina

C) CURB 65= 1, tratamento ambulatorial com Azitromicina.

D) CURB 65= 3, tratamento em enfermaria, com amoxicilina/ ácido clavulânico + azitromicina

31) Um homem de 20 anos de idade sofreu mordedura pelo gato do vizinho em região de coxa direita. Foi, então, realizada limpeza local e início de profilaxia para tétano e raiva. 48h após a mordedura, o paciente apresentaram quadro de celulite cutânea ao redor da lesão (perilesional). Qual o antibiótico correto para o caso?

A) Oxacilina

B) Amoxicilina/ Clavulanato

C) Cefalexina

D) Sulfametoxazol-trimetoprim

32) Em um paciente de 68 anos com suspeita de pneumonia, o exame físico mostrou ausência de confusão mental, uréia de 60 mg/dl, freqüência respiratória de 37 irpm e pressão arterial de 80 x 50 mmHg. Nesse caso, é Possível afirmar:

A) a mortalidade é em torno de 1,5% e deverá ser tratado ambulatorialmente

B) a mortalidade é em torno de 17% e deverá ser tratado em enfermaria

C) a mortalidade é em torno de 9,2% e deverá ser tratado ambulatorialmente

D) a mortalidade é em torno de 41% e deverá ser tratado em UTI

33) Homem, 27 anos, saudável, recebe o diagnósticos de pneumonia comunitária, sendo medicado com azitromicina. No 5° dia é reavaliado,estando afebril há 72 horas com estabilidade respiratória e hemodinâmica, mas sem melhora na radiografia de tórax de controle. Das alternativas a seguir, qual deve ser adotada?

A) Manter azitromicina por 7 a 10 dias

B) Associar antibiótico para enterobacterias

C) Mudar o antibiótico para quinolona

D) Considerar tratamento concluído

34) Uma paciente de 25 anos, admitida na emergência com quadro de dispneia de início súbito, hemoptise em pequeno volume e taquicardia, refere ser portadora de deficiência de proteína S e iniciou uso de contraceptivo oral há 3 meses. Apresentava-se com taquipneia e hemodinamicamente estável. A oximetria de pulso era de 95%. O exame diagnóstico mais indicado de avaliação para trombeombolismo pulmonar neste contexto será:

A) Ecocardiograma de câmaras cardíacas direitas

B) Dímero D por ensaio imunoenzimático

C) Angiotomografia de tórax

D) Angiografia pulmonar

35) M. C., 32 anos, masc, foi medicado há 3 meses com corticosteroides inalados (CI) em baixas doses associadas a beta agonista de longa duração sob demanda. Hoje ele retorna à consulta relatando sibilos respiratórios semanais e dificuldade para as atividades do cotidiano devido à dispneia. A avaliação e a conduta mais adequadas deverão ser:

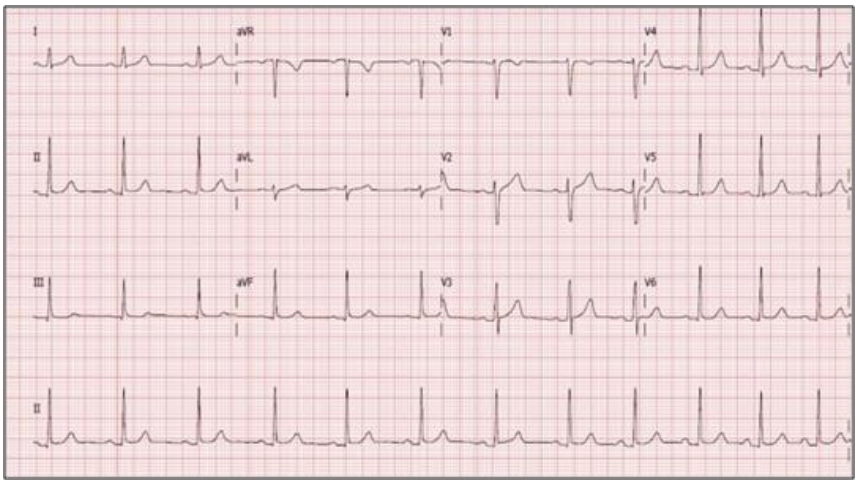
A) Elevar a dose do CI e prescrever o beta agonista de curta duração inalatório de alívio antes de atividades físicas e em exacerbações.

B) Avaliar a adesão a terapia, o uso correto da medicação inalatória e possíveis poluentes ambientais na casa e no trabalho.

C) Introduzir anticolinérgico de longa ação associado a doses moderadas do CI e aos beta agonistas, e reavaliar o paciente em tempo mais curto entre as consultas.

D) Solicitar espirometria e radiografia de tórax para rever diagnóstico e doses de medicação.

36) 13. A.M.B, 66 anos, hipertensa e tabagista, procura atendimento médico devido ao quadro de dor precordial de caráter progressivo, refere que tal dor tinha duração de cerca de 5 minutos e agora apresenta maior duração, nega sintomas associados. Exame físico sem alterações. Feito eletrocardiograma que se encontra abaixo:



Sobre a conduta do quadro clínico acima, o que podemos afirmar:

a) Se trata de um caso de angina estável, que necessita de tratamento ambulatorial.

b) Necessita de solicitação troponina ultrassensível, e se negativa, o tratamento deve ser ambulatorial.

c) Requer solicitação de troponina ultrassensível e novo eletrocardiograma, e o tratamento deve ser em regime de internação hospitalar.

d) Visto que eletrocardiograma apresentava infra de ST, é feito diagnóstico de infarto agudo do miocárdio.

37) Paciente masculino, 60 anos, vem a consulta neurológica de retorno para acompanhamento devido ao uso há 1 ano de Levodopamina/Benserazida 1 cp, 3x/dia. Refere melhora dos sinais e sintomas com o uso da medicação. Levando em consideração a conduta terapêutica e o diagnóstico, esse paciente apresentava no início do quadro:

a) Tremor de ação e quedas

b) Demência e tremor de repouso

c) Bradicinesia e rigidez unilateral

d) Hipocinesia e acatisia

38) Paciente feminina, 65 anos, vem a consulta médica devido a quadro súbito de dificuldade de se comunicar, apresentando uma "voz escandida", desequilíbrio, nistagmo vertical, tremor de ação no dimídio esquerdo e reflexo vestíbulocular presente bilateral. Refere que o quadro iniciou subitamente há 10 dias e permanecendo inalterado desde então. Procurou a emergência, porém foi liberada dias depois sem um diagnóstico definido. Como comorbidades, apresenta HAS e angina estável no passado. Sobre o quadro clínico podemos afirmar:

a) Trata-se de um caso típico de VPPB, sendo necessário realizar a manobra de Dix-Hillpike

b) Ao solicitar TC de crânio, devemos encontrar uma hipodensidade no cerebelo esquerdo

c) Pensando no diagnóstico de AVC, o uso regular de Warfarina será superior ao AAS

d) O quadro clínico é típico de Neurite vestibular, não sendo necessário acompanhamento regular

39) Um homem de 61 anos, hipertenso e diabético, apresenta repentinamente quadro de amaurose fugaz no olho esquerdo. O sintoma durou cerca de 2 horas e no momento está assintomático. Sua PA agora está 180x95 mmHg, FC 98 bpm, FR 19 irpm e Tax 37c. A conduta a ser adotada:

a) Iniciar AAS + Clopidrogrel, prescrever sinvastatina e internar o paciente para novos exames complementares

b) Realizar TC de crânio sem contrate, caso esteja normal, iniciar trombólise endovenosa com Alteplase

c) Normalizar a PA do paciente para 120x80 mmHg, solicitar ecocardiograma e eletrocardiograma

d) Iniciar AAS e liberar o paciente para controle dos fatores de risco cardiovascular no ambulatório nas próximas semanas

40) Mulher de 58 anos, sem histórico médico significativo, apresenta quadro súbito de fraqueza no braço direito e dificuldade na fala. Os sintomas duraram apenas alguns minutos e desapareceram completamente. Questionada não havia outros sinais e sintomas. Levando em consideração a principal hipótese diagnóstica, o medicamento que irá contribuir para evitar novos episódios:

a) Valproato de sódio

b) Amitriptilina

c) Atorvastatina

d) Warfarina

GABARITO 2023.1.2

1. C
2. A
3. A
4. B
5. D
6. B
7. D
8. B
9. A
10. A
11. B
12. B
13. A
14. C
15. A
16. C
17. D
18. C
19. D
20. A
21. C
22. C
23. D
24. D
25. C
26. B
27. C
28. A
29. A
30. A
31. B

32. D

33. D

34. C

35. B

36. C

37. C

38. B

39. A

40. C

PROVA 2023.2.1

1) Mulher de 45 anos, apresenta cefaleia há 6 meses, de forte intensidade, unilateral, latejante e que piora com atividades físicas. Os episódios duram cerca de 48 horas e média de quatro vezes por mês. Há vômitos e náuseas, mas nega fotofobia. Nega aura. Relata na adolescência cefaleias semelhante. Na HPP, é hipertensa e história de angina/IAM, em uso de Losartana e AAS + Clopidrogrel. Os sinais vitais estão dentro dos valores da normalidade e exame físico/neurológico sem alterações. Sobre o caso, a melhor conduta:

a) Iniciar Topiramato diariamente

b) prescrever sumatriptano nas crises

c) solicitar TC de crânio com contraste

d) apenas solicitar diário da dor e retorno em 90 dias

2) Na enfermaria do hospital, encontra-se um homem de 50 anos com quadro de hemiplegia súbita a direita e cefaleia, há 3 dias. No momento, a cefaleia não mais existe, mantendo o déficit motor. No exame físico, não há sinais de irritação meníngea, os reflexos profundos no dimídio direito estão abolidos e com flacidez muscular. O grau da força é 1 neste lado. Sua PA é 120 x 85 mmHg, FC: 98 bpm, FR: 16 irpm, Tax: 37c e SatO2 97%. A TC de crânio sem contraste do dia da internação (figura). Sobre o caso:



a) Devemos aumentar e manter a sua PA para 140 x 90 mmHg com Ringer Lactato

b) A localização mais frequente é exatamente nesta região, sendo a HAS o principal fator de risco

c) Deve se realizar angiografia dos vasos cerebrais para pesquisa de aneurismas cerebrais

d) Na prescrição médica, devem constar AAS + Sinvastatina

3) Adolescente de 15 anos, sexo feminino, vem a consulta devido a episodio de perda de consciência ocorrido há 15 dias, que durou 5 minutos. Segundo testemunha, o episodio foi sem sintomas premonitórios, houve cianose labial e abalos musculares rápidos (clônias). Nega salivação, liberação esfincteriana e mordedura de língua. Houve certa confusão mental pós-evento, durando cerca de 15 minutos. História patológica pregressa e familiar sem doenças. Sobre o caso, a conduta deverá ser:

a) Iniciar Amitriptilina e reavaliar em 30 dias

b) Solicitar ecocardiograma e eletrocardiograma

c) Iniciar Valproato de sódio e reavaliar em 60 dias

d) Solicitar ressonância magnética e eletroencefalograma

4) Homem de 69 anos apresenta quadro de bradicinesia, iniciado há 6 meses, com lentidão dos movimentos e dificuldade para amarrar os sapatos. Ao caminhar, apresenta passos mais curtos e sensação de instabilidade. Concomitantemente, apresenta tremores nas mãos, de repouso, associado a rigidez, além de alteração olfativa, constipação intestinal de 3 dias e alteração do padrão do sono. Nega alterações do humor e cognição. No exame físico, o paciente apresenta bom estado geral, marcha com inclinação anterior lenta e arrastada, diminuição dos movimentos dos braços, tremores assimétricos das mãos e hipertonia em roda dentada. Ressonância magnética realizada há 2 semanas constatou: redução da espessura pars compacta mesencefálica e maior grau de hiposinal nos núcleos da base, com atrofia cerebral difusa.

A principal hipótese diagnóstica nesse caso é:

a) Demência vascular

b) Tremor essencial

c) Doença de Parkinson

d) Hidrocefalia normobárica

5) Um paciente de 60 anos, hipertenso e diabético, assintomático, pretende iniciar atividade física aeróbia e solicitou um atestado médico para frequentar a academia. Em qual das opções abaixo encontramos uma afirmativa ideal sobre como proceder na continuidade da investigação de risco desse paciente.

a) solicitar ecocardiograma de repouso e em caso de disfunção segmentar solicitar um teste de esforço

b) solicitar ecocardiograma de repouso, se normal, solicitar um teste de esforço

c) solicitar ecocardiograma de repouso, se normal, solicitar cateterismo

d) solicitar cateterismo, se normal, solicitar cintilografia miocárdica

6) Sr João, 70 anos, procurou o ESF do Madruga por conta de hipertensão arterial, trouxe consigo cerca de 20 medidas realizadas no período de 30 dias com médias em torno de PAS = 160-170 mmhg e PAD= 100 mmhg. Queixa-se de dor retro esternal opressiva quando realiza esforços como se deslocar do centro até o sombrão; aliviando em 3 minutos ao repousar. Com relação ao quadro descrito podemos afirmar:

a) o seu risco cardiovascular é alto e o estágio da HAS é II

b) o seu risco cardiovascular é moderado e o estágio da HAS é III

c) o risco cardiovascular é alto e o estágio da HAS é III

d) o risco cardiovascular é moderado e o estágio da HAS é II

7) Um paciente portador de insuficiência cardíaca, decorrente de uma insuficiência valvar mitral e acompanhamento regular no ambulatório de cardiologia, apresentava boa evolução clínica em classe funcional I da NYHA. Há uma semana vem queixando-se dispneia aos pequenos esforços como tomar banho. PA= 90/70 mmHg FC=

115 bpm. Ritmo cardíaco irregular em 3T com B3 de VE e VD. No exame laboratorial percebemos a presença de disfunção renal.

Analise as afirmativas abaixo sobre o caso acima:

I- Na diástole houve redução em 30% do enchimento atrial que gerou a queixa de dispneia
II- O fator descompensador do quadro diminuiu o débito renal
III- O pulso arterial desse paciente apresenta características que nos levam a pensar no provável fator etiológico da descompensação cardíaca

Podemos afirmar que:

a) apenas a afirmativa I está correta

b) apenas a afirmativa II está correta

c) As afirmativas I e II estão corretas

d) todas as afirmativas estão corretas

8) Um paciente portador de insuficiência cardíaca, com episódios de dispneia aos mínimos esforços e durante o sono, dormindo com 4 travesseiros, procurou a emergência do hospital para internação. Apresenta-se com edema até terço médio das coxas bilateralmente. Pulso venoso com sinal de Kussmaul. Enchimento capilar de 5s. Precórdio com ictus no sexto espaço intercostal na linha axilar anterior e com 3 polpas digitais. Ritmo cardíaco regular em 3T com B3 de VE. Com relação ao caso avalie as afirmativas abaixo:

I- A classe funcional do paciente é IV da NYHA

II- O paciente hemodinamicamente é do tipo quente e úmido

III- O modelo de IC identificado é esquerda

IV- Ao ecocardiograma provavelmente teremos uma FE < 40%

Podemos afirmar que:

a) apenas as afirmativas I e II estão corretas

b) apenas as afirmativas II e III estão corretas

c) apenas as afirmativas III e IV estão corretas

d) apenas as afirmativas I e IV estão corretas

9) Homem, 61 anos de idade, vem à consulta acompanhado de sua esposa. Há alguns anos, observa-se consumo excessivo de álcool, diminuição do autocuidado e intensa agitação. O paciente envolve-se com frequência em brigas, discussões, não suporta ser corrigido, não consegue adaptar- se a novas tarefas e queixa-se de diminuição da quantidade de sono. Na avaliação cognitiva, apresenta prejuízo na atenção, linguagem, planejamento, organização, na resolução de problemas, na abstração e na memória de trabalho. A memória episódica e as habilidades visuoespaciais estão normais. Qual o diagnóstico mais provável?

a) Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)

b) Demência frontotemporal variante comportamental.

c) Demência de Alzheimer (DA) de início precoce.

d) Demência com corpos de Lewy. (DCL)

10) Em paciente com doença de Alzheimer, estágio moderado a grave, utilizando inibidor de acetilcolinesterase, a conduta mais adequada é:

a) Suspender o inibidor de acetilcolinesterase e introduzir antipsicótico.

b) Suspender o inibidor de acetilcolinesterase e manter paciente sem droga.

c) Manter o inibidor de acetilcolinesterase e associar antidepressivo

d) Manter o inibidor de acetilcolinesterase e associar memantina

11) Homem com 85 anos, professor universitário, casado, sem filhos, após se aposentar ajudava a esposa na casa, cuidava do jardim, fazia reformas na casa e viajavam todos os anos. Há, aproximadamente, 3 anos começou a perder o interesse e prazer nas atividades habituais, apresentava dificuldade em tomar decisões, marcha lentificada, perda de peso. Quando a esposa o chamava para sair ele dizia estar cansado, se sentindo inútil, não dormia bem e passou a ruminar ideias de morte. Continuava independente para todas as atividades básicas e instrumentais de vida diária. Qual é o diagnóstico mais provável?

a) O diagnóstico mais provável é Transtorno Depressivo.

b) Podemos afirmar que o paciente está na fase prodrômica da Doença de Alzheimer.

c) O paciente está com demência instalada e deve ser iniciado o tratamento com medicação.

d) O diagnóstico mais provável é Transtorno Bipolar.

12) Ainda de acordo com o caso acima; assinale a alternativa que apresenta adequadamente a ferramenta de triagem que deve ser utilizada para a avaliação deste paciente com relação ao diagnóstico possível do caso:

a) Fluência Verbal categoria semântica.

b) Escala de Depressão Geriátrica de 15 itens

c) Montreal Cognitive Assessment (MoCa)

d) Teste do relógio

13) Paciente masculino, 90 anos, robusto, apresenta crise de urticária com prurido importante sendo medicado com hidroxizina 25 mg 8/8h. Após alguns dias inicia quadro com dificuldade de atenção, alteração do ciclo sono-vigília, irritabilidade. Retorna para emergência e é internado para investigação. Evolui com piora do quadro, flutuação do nível de consciência, agitação vespertina e alucinação. Assinale a opção que apresenta a hipótese diagnóstica para o quadro.

a) Delirium.

b) Demência com Corpos de Lewy.

c) Doença de Alzheimer.

d) Demência fronto temporal comportamental.

14) Paciente do sexo feminino, 78 anos é levada á consulta com queixa de vertigem e parestesia nos membros superiores. A filha da paciente que a acompanhava na consulta, relatou que sua mãe estava apresentando quadros de confusão mental. Afirma que demais familiares estavam preocupados que a paciente pudesse estar com Alzheimer. Traz exames laboratoriais recentes (08/08/2023): Hematocrito 21,2 % ; Hemoglobina 7 g/dL ; VCM 120 fL.

Após ver esses exames, qual a provável causa do quadro clínico apresentado?

A) Anemia por deficiência de B12

B) Anemia por alcoolismo.

C) Anemia falciforme.

D) Alzheimer.

15) Das alternativas abaixo, assinale aquela que contenha os principais grupos que desenvolvem anemia ferropriva:

A) Adultos jovens, pacientes com traço falcêmico.

B) Crianças, usuários de drogas.

C) Gestantes e alcoolistas

D) Mulheres pós menopausadas, pacientes veganos.

16) Adamastor, 55 anos, portador de diabetes mellitus tipo II há 05 anos, iniciou um quadro de hipertensão arterial sistêmica. Diante do cenário clínico, além das recomendações não farmacológicas, compreendeu-se a necessidade do início da seguinte classe medicamentosa, esta, preconizada para tal contexto:

a) Beta bloqueador.

b) Bloqueador dos canais de cálcio.

c) Agente simpatolítico de ação central.

d) Inibidor da enzima de conversão da angiotensina.

17) Paciente de 74 anos, comparece à consulta, queixando-se dos seguintes sintomas: retenção urinária, polaciúria, hesitação urinária e esforço miccional. Considerando a causa mais frequente de sintomas do trato urinário inferior (STUIs) neste cenário clínico, assinale o provável diagnóstico:

a) Cistite.

b) Prostatite.

c) Câncer de próstata.

d) Aumento benigno da próstata.

18) Assinale a alternativa que contenha um sinal e um sintoma apresentado por uma paciente com quadro de hipotireoidismo:

a) Bócio e diarreia.

b) Pele quente e palpitação.

c) Tremor de extremidades e cansaço.

d) Pele infiltrada e acuidade auditiva diminuída.

19) Esposa leva seu marido de 66 anos para consulta médica devido à perda progressiva da memória, que se iniciou há dois anos. Existe interferência nas atividades de vida diárias, como esquecer nome dos filhos, mas não erra nas contas e não tem dificuldade nas escritas. A apatia é um dado importante, além do hábito de andar sem roupa dentro de casa e procurar a mulher com muita frequência, desejando manter relações sexuais. O apetite mudou e há procura constante por comida. Na consulta o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) foi 22 (escolaridade nível superior), não havia alterações motoras ou sensitivas ao exame físico e os pares cranianos estavam normais. O diagnóstico mais provável deve ser?

A) Demência vascular.

B) Demência de Alzheimer.

C) Demência frontotemporal.

D) Demência por hidrocefalia de pressão normal.

20) Senhor Cristiano Ronaldo da Silva de 75 anos procura atendimento médico acompanhado de sua filha. A queixa principal é “esquecimento”. Na trilha de investigação de possível quadro demencial, qual será a conduta?

A) Anamnese, MEEM, exames complementares, avaliação neuropsicológica e RNM encéfalo.

B) Exame físico, exames complementares, tomografia crânio e vitamina B12.

C) Anamnese, avaliação neuropsicológica e RNM encéfalo.

D) MEEM, exames complementares e RNM encéfalo.

21) Paciente sexo masculino, assintomático, usuário de drogas injetáveis, procurou atendimento para exame de rotina. O médico que o atendeu opta então pela solicitação de alguns exames sorológicos, cujos resultados foram: HBsAg positivo, anti HBs negativo, anti-HBc IgM negativo, anti-HBc IgG positivo. Com base nos resultados disponíveis, o paciente foi diagnosticado com:

A) Indivíduo imune por infecção natural

B) Hepatite crônica pelo vírus C

C) Hepatite aguda pelo vírus B

D) Hepatite crônica pelo Vírus B

22) Paulo, 59 anos, é portador de hipertensão arterial, diabetes tipo 2, dislipidemia e obesidade grau 2. Paulo há um mês sofreu um acidente vascular encefálico isquêmico (AVCI), que na ocasião não foi trombolisado. Traz consigo para a consulta o boletim de alta hospitalar e exames realizados durante a internação: TC de crânio que evidencia hipodensidade em região de capsula interna direita, eletrocardiograma evidenciando fibrilação atrial e doppler de carótidas e vertebrais sem lesões significativas. Ao exame: hemiparesia a esquerda, ausculta pulmonar sem alterações,

ausculta cardiovascular com ritmo irregular. Você, medico assistente do paciente resolve ajustar terapia medicamentosa visando prevenção de um novo episódio de AVCI. Logo você prescreveu para Paulo:

A) AAS 100 mg e Rosuvastatina 40 mg.

B) Varfarina 5 mg, AAS 100 mg e Atorvastatina 80 mg.

C) Rivaroxabana 20 mg, AAS 100 mg e Atorvastatina 80 mg.

D) Rivaroxabana 20 mg e Rosuvastatina 40 mg.

23) Você atende um paciente que é portador de HIV, na forma assintomática, com contagem laboratorial de T-CD4+ de 180 células/mm^3. A melhor conduta para este paciente será:

A) Iniciar terapia antirretroviral.

B) Iniciar terapia antirretroviral e quimioprofilaxia para pneumocistose e toxoplasmose.

C) Iniciar terapia antirretroviral e quimioprofilaxia para pneumocistose.

D) Iniciar quimioprofilaxia contra Pneumocistose e Toxoplasmose.

24) Paciente de 26 anos, com histórico de uso de drogas ilícitas e abandono de tratamento do HIV, procura atendimento médico pois apresenta cefaleia holocraniana de forte intensidade há mais de 1 semana e febre. Os exames laboratoriais solicitados evidenciaram anemia e linfopenia. A Tomografia computadorizada de crânio com contraste não apresenta lesões. Assinale a alternativa que contenha a principal hipótese diagnóstica e a conduta indicada para confirmar este diagnóstico é:

a) Encefalite herpética – eletroencefalograma

b) Meningite bacteriana – análise do líquor

c) Meningite criptocócica – análise de líquor

d) Neurotoxoplasmose – Ressonância Nuclear Magnética de encéfalo

25) Paciente feminina, 45 anos, em corticoterapia devido á artrite reumatoide. Mantendo níveis de taxa de filtração glomerular entre 35 e 45m/min/1,73m2. Apresentou quadro anterior de disúria e polaciúria. Foi tratada para infecção urinária por Escherichia coli há três semanas. Procura atendimento médico devido a quadro persistente de disúria associada com febre, calafrios, dor lombar, náuseas e vômitos. Estabelecido o diagnóstico de pielonefrite, analise as afirmativas abaixo:

I – A principal causa de pielonefrite é a ascensão ureteral.

II – A pielonefrite pode ocorrer por via hematogênica em pacientes com doença crônica em terapia imunossupressora.

III – Na pielonefrite complicada por doença renal prévia, pode haver redução da função renal.

Quais afirmativas estão corretas:

a) Apenas as afirmativas I e II

b) Apenas as afirmativas II e III

c) Apenas as afirmativas I e III

d) Todas as afirmativas estão corretas

26) Um paciente de 50 anos procura atendimento pois vem apresentando um quadro de evolução insidiosa, com tosse produtiva há 6 semanas, febre baixa e vespertina, sudorese noturna, perda ponderal de 8kg em 30 dias. Apresenta também um quadro diarreico persistente e aumento de volume da cadeia ganglionar á direita, única, cervical e indolor. A ausculta apresentou alteração em segmentos superiores e posteriores á direita. No RX de tórax foi evidenciado derrame pleural moderado e unilateral. Os critérios clínicos apresentados pelo paciente são mais compatíveis com o diagnóstico de:

a) Sarcoidose

b) Tuberculose

c) Doença pulmonar obstrutiva crônica

d) Pneumonia intersticial

27) Homem de 70 anos com história de dor lombar progressiva com piora à movimentação e associada a emagrecimento. Apresenta Lasegue positivo á direita, astenia e fraqueza de início há dois meses. Os exames mostraram hemoglobina = 9g/dl; leucócitos = 9.000/mm3, diferencial normal, plaquetas = 200.000/mm3; glicose = 90mg/dl; creatinina = 1,1mg/dl; proteínas totais= 7,5g, albumina = 3,0g/dl; globulina= 4,5g/dl; VHS= 110mm/hora; ácido úrico= 7,5 mg/dl; fosfatase alcalina = 120 U/l; cálcio = 10,5 mg/dl; fósforo = 3,5 mg/dl. O exame de imagem da coluna revela intensa osteopenia sem lesões líticas e PSA total = 9,5 ng/ml. O paciente é tabagista de 40 maços- ano e etilista social. Assinale a alternativa que contenha a principal hipótese diagnóstica para este paciente:

a) Mieloma múltiplo

b) Tumor de próstata metastático

c) Osteoporose secundária a hipogonadismo

d) Metástases na coluna por tumor epidermóide de pulmão

28) Paciente de 55 anos, com sobrepeso, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica controlada com enapril, comparece à consulta referindo que, após início de um remédio para o diabetes, há dois meses, vem tendo diarréria diariamente. O hipoglicerniante oral que mais provavelmente pode ter sido prescrito foi:

a) Gliclazida

b) Acarbose

c) Metformina

d) Pioglitazona

29) Mulher de 25 anos procura médico por cansaço. Está hipocorada com hemoglobina = 9,9g/dL, VGM = 72fl, HGM = 23pg, RDW = 16,5 e ferritina = 6,0µg/L. Cerca de dez dias após iniciar o tratamento correto, é possível acompanhar a sua eficácia, solicitando:

A) ferritina

B) ferro sérico

C) reticulócitos

D) hemoglobina

30) Após a imunização completa para a hepatite B, o perfil sorológico que deve ser observado é:

A) anti-HBc positivo e anti-HBs positivo

B) anti-HBc positivo e anti-HBe positivo

C) anti-HBc negativo e anti-HBs positivo

D) anti-HBc negativo e anti-HBe positivo

31) A partir do caso a seguir, selecione a opção com a sequência CORRETA de causas de óbito, para preenchimento da Parte I da Declaração de Óbito, considerando que a primeira causa da lista deve ser a causa imediata e a última será a causa básica. Paciente masculino, 65 anos, sabia ser portadora de hipertensão arterial sistêmica desde há 20, sem tratamento. Há cerca de 2 anos iniciou quadro de dispneia aos esforços, quando foi diagnosticada cardiopatia hipertensiva, tendo iniciado tratamento. Desde há 2 meses, evoluiu com insuficiência cardíaca congestiva. Hoje, foi internado com edema agudo de pulmão, indo a óbito após 2 horas.

A) Edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatia hipertensiva, hipertensão arterial sistêmica.

B) Hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatia hipertensiva, edema agudo de pulmão.

C) Edema agudo de pulmão, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatia hipertensiva.

D) Cardiopatia hipertensiva, hipertensão arterial sistêmica, edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva.

32) Um jovem procura atendimento devido ao aparecimento, há 3 semanas, de manchas claras na pele localizadas na região cervical e nos braços, bilateralmente. Enquanto espera o atendimento, preocupa-se ao observar um cartaz afixado com os seguintes dizeres: “Que mancha é essa? Você pode estar com hanseníase”.

Nesse caso, a principal informação a ser utilizada pelo médico para diferenciar a hanseníase de outras dermatoses que cursam com lesões semelhantes é:

a) o tempo de aparecimento das lesões.

b) a ausência de alterações de sensibilidade.

c) o fato de as manchas serem hipocrômicas.

d) a faixa etária em que se encontra o paciente.

33) Paciente feminina, de 62 anos de idade, vai à consulta médica, referindo tosse produtiva com expectoração clara de aspecto mucoide. Refere história de dispneia aos médios esforços nos últimos 5 anos, com piora nos últimos

30 dias. Nega febre ou alteração característica da tosse habitual. Tabagista 1 maço/ dia há 40 anos. Nega hipertensão arterial sistêmica e diabetes melito. A radiografia de tórax mostra hiperinsuflação pulmonar, hipertransparência e retificação do diafragma. A hipótese diagnóstica provável é:

A) DPOC

B) bronquiectasia

C) asma agravada por infecção

D) DPOC agravada por pneumonia

34) Um militar de 22 anos de idade apresenta meningite por N. meningitides do tipo B. Ele divide o dormitório com outros cinco militares. Qual a conduta indicada em relação aos colegas de dormitórios?

A) Profilaxia apenas para aqueles cuja cultura de líquor for positiva.

B) Ceftriaxone para todos eles.

C) Profilaxia apenas para aqueles cuja cultura de swab nasal for positiva.

D) Vacinação com vacina conjugada.

35) Paciente de 21 anos, sem comorbidades, apresenta febre alta de início súbito há 2 dias, mialgia, 01 episódio de vômito, cefaleia, hepatomegalia maior que 3cm do rebordo costal. Não apresenta sangramentos, sinais de choque e sinais de comprometimento grave de órgãos. Tratando-se de Dengue, das opções apresentadas nas alternativas abaixo, assinale aquela que seria a conduta correta para este caso?

a) Hidratação oral e acompanhamento ambulatorial

b) Hidratação venosa e internação em enfermaria

c) Hidratação venosa e internação em leito de terapia intensiva

d) Hidratação oral e observação em leito-dia.

36) Mulher de 45 anos, IMC:36Kg/m2, com pai e mãe portadores de DM tipo 2, procurou atendimento ambulatorial para consulta de rotina. Trouxe exames laboratoriais que revelaram: glicemia de jejum = 115mg/dl; e HbA1c = 6%. Os mesmos exames foram repetidos e revelaram: glicemia de jejum = 118mg/dl; e HbA1c = 6,1%; e TOTG com 75g de glicose anidra = 155mg/dl. Além da mudança no estilo de vida, qual a conduta para esta paciente?

a) Inibidor SGLT2

b) Expectante

c) Glicazida

d) Metformina

37) Mulher de 38 anos, procura atendimento com queixa de regurgitação, pirose, tosse não produtiva e disfonia a cerca de 3 meses. Refere que estes sintomas são diurnos e noturnos. Nega febre, disfagia e perda ponderal. Nega uso de medicamentos, comorbidades ou cirurgias prévias. Tabagista 10 anos-maço. Etilista social. Alimentação 3 vezes ao dia e muito estresse durante o dia. Exame físico: bom estado geral, corado e hidratado. Peso=88Kg; Altura=1,60m;

PA=110x70mmHg; FC=70bpm. Sem outras alterações. Assinale a alternativa que contenha a conduta terapêutica para esta paciente:

a) Fundoplicatura a Nissen

b) Hidróxido de magnésio ou alumínio 3x ao dia até a melhora dos sintomas

c) Inibidores da bomba de prótons 3x ao dia por 3 meses, em dose plena

d) Perda ponderal e elevação da cabeceira

38) A azotemia pré-renal é a forma mais comum de insuficiência renal aguda, podendo estar associado mais frequentemente:

a) à hemólise

b) à litíase renal

c) à hipovolemia

d) ao contraste iodado

39) Homem de 55 anos gozava de plena saúde até poucas semanas antes da consulta, quando observou o aparecimento de lesões equimóticas nas extremidades e no tronco. Não havia história de trauma e tem se sentido mais fatigado do que o habitual. No exame físico os sinais vitais estavam normais; lúcido e orientado; palidez cutaneomucosa; cavidade oral com edema gengival e petéquias no palato. Ausência de aumento dos linfonodos; aparelho respiratório e aparelho circulatório, assim como o abdome, estão sem alterações; os membros inferiores apresentavam rash petequial bilateral abaixo dos joelhos.

Estudos laboratoriais iniciais: hemoglobina = 7,8 g/dl; hematócrito = 27%; VCM = 85 fl; leucócitos = 17.000/mm³ com 15% de polimorfonucleares, 10% de linfócitos, 5% de monócitos e 70% de blastos; plaquetas = 20.000/mm³.

Considerando as informações apresentadas, o diagnóstico mais provável é:

A) Leucemia mieloide aguda;

B) Leucemia mieloide crônica;

C) Leucemia linfocítica crônica;

D) Leucemia linfoblástica aguda.

40) Um paciente está em tratamento para hipertensão arterial com uso de um anti-hipertensivo em monoterapia. Apresenta em seu exame laboratorial dosagem de potássio sérico de 6,1 mEq/L (Normal de 3,5 a 5,5 mEq/L). Qual o fármaco mais provável, dentre os abaixo, que o paciente deve estar usando e qual seria para o caso o medicamento ideal respectivamente.

a) Hidroclorotiazida e Losartana

b) Losartana e Anlodipina

c) Anlodipina e Enalapril

d) Hidralazina e Espironolactona

GABARITO 2023.2.1

1. A
2. B
3. D
4. C
5. B
6. A
7. D
8. D
9. B
10. D
11. A
12. B
13. A
14. A
15. C
16. D
17. D
18. D
19. C
20. A
21. D
22. D
23. C
24. C
25. D
26. B
27. A
28. C
29. C
30. C

31. A

32. B

33. A

34. B

35. B

36. D

37. D

38. C

39. A

40. B

PROVA C.M. 2023.2.2

1) A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa que acomete aproximadamente 1% da população idosa. O diagnóstico da DP é essencialmente clínico e envolve, principalmente, o reconhecimento de alterações no exame neurológico e na anamnese. Sendo assim assinale a alternativa que só contenha sinais cardinais da doença de Parkinson:

a) Hipocinesia, tremor postural, hipertonia elástica e estabilidade postural.

b) Hipocinesia, tremor de repouso, hipertonia plástica e instabilidade postural.

c) Bradicinesia, tremor de repouso, hipertonia plástica e instabilidade postural.

d) Bradicinesia, tremor postural, hipertonia elástica e estabilidade postural.

2) Mulher, 28 anos, portadora do vírus HIV assintomática no momento, exames iniciais evidenciando hemoglobina 12 g/dl, leucócitos 5.500/mm³ com linfopenia, creatinina 0,8 mg/dl, PPD 6 mm, carga viral 100.000 cópias/ml, CD4 290 células/mm³, raio x de tórax sem alterações, anticorpo IgG 1:128 para toxoplasmose, VDRL não reagente, FTA-ABS negativo e sorologias para hepatite negativa. Além do início de terapia antirretroviral é necessário associar:

a) Sulfadiazina/pirimetamina por três semanas.

b) Sulfametoxazol + trimetropim três vezes por semana.

c) Esquema RIPE (Rifampicina/Isoniazida/Pirimetamina/Etambutol)

d) Isoniazida por seis meses.

3) Paciente de 38 anos com exames laboratoriais mostrando os seguintes resultados: HBsAg negativo, Anti-HBC IgG positivo, Anti- HBs positivo, HBeAg negativo. Esse perfil sorológico é compatível com:

a) Hepatite B aguda.

b) Hepatite B crônica.

c) Vacinação para hepatite B.

d) Cura funcional da hepatite B.

4) Paciente internado com quadro de Hemorragia Subaracnoide não- traumática (HSA). Na admissão, ele está um pouco sonolento, com discreta hemiparesia a direita. A investigação evidencia um aneurisma de Artéria Cerebral Média esquerda. Após 8 dias, apresenta rebaixamento do nível de consciência e piora da força motora à direita. Qual é a mais provável causa dos seus novos sintomas?

a) Vasoespasmo.

b) Sangramento.

c) Hidrocefalia aguda.

d) Herniação uncal.

5) Paciente sexo masculino, 66 anos, admitido com hemiplegia à direita e afasia motora, pontuava 15 no NIHSS realizado a beira leito. Angiotomografia de crânio evidenciava oclusão de artéria cerebral média a esquerda, segmento M1, sem sinais de sangramento. Administrado trombolítico intravenoso, sem melhora do quadro clínico. Na sequência qual a melhor opção terapêutica seria:

a) Iniciar AAS.

b) Iniciar enoxaparina.

c) Realizar trombectomia mecânica intravascular.

d) Repetir dose de trombolítico.

6) No ambulatório de Neurologia, você está avaliando um paciente com possível síndrome demencial. O paciente é do sexo masculino, 65 anos e aposentado. Vem a consulta acompanhado da filha, pois ele não consegue mais morar sozinho. Apresenta perda de memória frequente para fatos cotidianos. Refere estar mais nervoso e com insônia. O mini mental (ensino médio completo) é de 22/30. A conduta a ser adotada neste momento:

a) Iniciar Donepezila diariamente

b) Prescrever Clonazepam a noite

c) Solicitar exames complementares

d) Orientar retorno em 6 meses para reavaliar

7) Adolescente de 16 anos com história de apagões desde a infância, com acompanhamento irregular e abandono do tratamento há 3 anos. O exame solicitado foi EEG com o seguinte resultado: ponta onda de 3 Hz. Dentre as opções, o melhor medicamento para controle do quadro:

a) Ácido Valpróico

b) Carbamazepina

c) Fenobarbital

d) Fenitoína

8) Luiza, 28 anos, apresenta diagnóstico de migrânea sem aura desde a adolescência, onde fazia uso esporádico de dipirona com alívio em 2 horas. Refere que há 3 meses, progressivamente, sua dor aumentou na intensidade e frequência. Seu companheiro notou mudança no comportamento e déficit de linguagem (parafasias). O exame físico era normal, além de pequena sonolência e confusão mental (Glasgow 14). Sem sinais de irritação meníngea. Em relação ao quadro, a conduta:

a) Solicitar exame de neuroimagem

b) Iniciar Topiramato diariamente

c) Trocar por Sumatriptano SOS

d) Iniciar Ceftriaxona EV

9) Paciente masculino de 65 anos, deu entrada no hospital devido a hemiparesia súbita a esquerda, há 2 horas, sem alterações sensitivas ou da linguagem. Com leve cefaleia e sem história de trauma. Sem vômitos ou rebaixamento do nível de consciência. Nega comorbidades prévias, portanto, sem uso de quaisquer medicamentos. Sua PA: 210x115 mmHg, FC: 110 bpm, FR: 19 irpm, Tax 37c. Sat 02 97%. Levando em consideração o quadro clínico, marque a assertiva correta:

a) Em caso de TC de crânio normal, deve se solicitar pesquisa de xantocromia na punção liquórica

b) Caso houver na TC de crânio, hipodensidade, o diagnóstico de AVC isquêmico se define e a conduta imediata será trombólise com alteplase

c) O diagnóstico de AVC não é descartado, devendo iniciar anticoagulação e estatina

d) Se TC de crânio estiver normal nas primeiras 24 horas, a prevenção secundária se dará nos próximos dias com doppler de carótidas/vertebrais, eletrocardiograma e ecocardiograma transtorácico

10) FRJ, 65 anos, há 6 meses apresenta comportamentos inapropriados em público que chamaram atenção de familiares e vizinhos. Familiares referem que tem tido um comportamento acumulador e apresentado problemas de memória leves e dificuldade de lembrar os nomes de objetos e pessoas. O médico que a atende solicita um exame de ressonância nuclear magnética de crânio. Assinale a opção que apresenta a alteração esperada no exame da paciente em questão.

a) Alterações micorvasculares (fazekas III).

b) Atrofia hipocampal bilateral.

c) Atrofia cerebral difusa e intensa.

d) Atrofia cerebral mais proeminente em região frontal.

11) Mulher de 62 anos procurou atendimento em atenção primária devido piora dos tremores em mãos. Após avaliação com anamnese e exame físico minuciosos, dado diagnóstico de Tremor Essencial e prescrito betabloqueador com previsão de retorno para reavaliação. Considere as características abaixo:

I. Tremor de repouso em “contar de moedas”.

II. Tremor fino e rápido associado à história familiar.

III. Piora com ansiedade e melhora após uso de álcool.

Assinale a alternativa que contenha apenas as características relacionadas ao tremor essencial.

a) I apenas

b) II e III apenas

c) I, II e III

d) II apenas

12) Paciente de 84 anos, feminina, procura auxílio médico com queixas de ter caído 2 vezes no último ano. Na avaliação geriátrica ampla, observa-se queixa de incontinência urinária de início recente e cognitiva, um miniexame do estado mental (Mini- mental) de 22 (esperado 24 pontos para idade e escolaridade), teste do time up and go (TUG)

>20 segundos (esperado < 15 segundos), com apraxia de marcha evidente. Neste caso, a opção que correlaciona a hipótese diagnóstica correta ao exame de imagem correto, é:

a) Demência frontotemporal e cintilografia cerebral

b) Demência por doença de Alzheimer e SPECT

c) Hidrocefalia de pressão normal e ressonância nuclear magnética

d) Doença de Parkinson e PET TRODAT

13) A Síndrome clínica caracterizada por alteração aguda da consciência e cognição, caracterizada por desatenção e pensamento desorganizado, que se desenvolve em horas ou dias, com caráter flutuante no decorrer do dia, comum em idosos e pacientes hospitalizados, principalmente internados em Unidade de Terapia Intensiva é:

a) Intoxicação por álcool

b) Intoxicação por benzodiazepínicos

c) Delirium

d) Transtorno esquizoide

14) Paciente masculino, 75 anos, ex-professor universitário, comparece à consulta de retorno trazendo exames de investigação de queixa cognitiva solicitados por colega externo. Paciente e esposa relatam esquecimentos corriqueiros, com impacto em atividades diárias mais complexas, como dirigir, e no manejo financeiro. Apresenta Mini-exame do estado mental com escore de 25 pontos. Escala de Lawton com prejuízo leve e Escala de Katz com escore normal. Exame físico sem maiores achados. Ressonância de encéfalo mostra atrofia cortical e de hipocampos, sem outros achados de importância. Hemograma, perfil glicêmico, função renal, tireoidiana e hepática normais; dosagens de vitamina B12 e ácido fólico normais e sorologias negativas. Nega comorbidades prévias ou uso de medicamentos. Qual o provável diagnóstico etiológico do paciente?

a) Doença de Alzheimer

b) Doença de Paget

c) Doença de Parkinson

d) Demência por corpos de Lewy

15) (ENADE 2023) Um paciente com 21 anos de idade, previamente hígido, comparece a uma unidade básica de saúde, relatando que descobriu que a ex-parceira, com quem se relacionou por 3 anos, está infectada pelo HIV. Ele afirma que, no início do relacionamento, faziam uso de preservativo em todas as relações, mas que, com o tempo, pararam de usar. Conta que teve outras parceiras ocasionais, mas sempre com uso de preservativo nas relações. Afirma que nunca realizou sorologia para HIV e que doou sangue há 3 anos.

O paciente está muito ansioso e chora durante a consulta, manifesta ter muito medo de estar com AIDS, pois comenta que “todo mundo que tem AIDS morre”, e que tem medo de ser discriminado pelos amigos e familiares. Ao exame físico, não apresenta nenhuma alteração. Após acalmá-lo e fazer o aconselhamento, o médico solicita realização de dois testes rápidos para HIV de fabricantes diferentes – ambos com resultado positivo.

Considerando esse caso, assinale a opção que indica a conduta médica correta a partir dos resultados dos referidos testes.

A) Iniciar tratamento antirretroviral de imediato.

B) Solicitar exames complementares para estadiar a infecção.

C) Realizar genotipagem para orientar o tratamento antirretroviral.

D) Solicitar o exame de Western-Blot para a confirmação diagnóstica.

16) MRTA, 42 anos, sexo masculino, etilista crônico desde os 21 anos. Filha acompanhando o pai na consulta diz que o mesmo bebe todos os dias do momento que acorda até a hora de dormir. Ao exame paciente apresenta palidez muco cutânea, cansaço aos pequenos esforços, perda acentuada de peso. Qual a provável etiologia desta anemia?

A) Anemia por deficiência de ácido fólico.

B) Anemia por sangramento crônico.

C) Anemia devido a síndrome mielodisplásica.

D) Anemia devido a doença de base descompensada.

17) Mulher de 67 anos queixa-se de limitação funcional dos dedos das mãos e dor lombar crônica, com dificuldade em desempenhar seus afazeres domésticos devido a dor. Você identifica comprometimento das articulações interfalangeanas distais, hiperlordose e dor a palpação de coluna lombar e pensa, prioritariamente, no diagnóstico de:

a) Osteoartrite.

b) Lúpus eritematoso sistêmico.

c) Artrite reumatoide

d) Mieloma Múltiplo.

18) Homem de 30 anos, com múltiplos parceiros sexuais recentemente, sem proteção de barreira, apresenta quadro de febre, fadiga e odinofagia há 7 dias. Ao exame físico, nota-se eritema em orofaringe e adenomegalia cervical e axilar. Constitui a próxima conduta correta:

a) Retorno em 6 meses e observação.

b) Obter carga viral para HIV.

c) Prescrever amoxicilina por 7 dias.

d) Tratar de forma empírica doenças sexualmente transmissíveis.

19) Segundo o Ministério da Saúde, um paciente HIV+ com LT-CD4 de 46 células/mm³ e PPD não reator, ainda sem uso de terapia antirretroviral, deve fazer uso de quais profilaxias primárias?

a) Pneumocystis jiroveci e Toxoplasma gondii, com sulfametoxazol + trimetoprima diário.

b) Cryptococcus sp., com fluconazol e complexo Mycobacterium avium, com azitromicina.

c) Pneumocystis jiroveci e Toxoplasma gondii, com sulfametoxazol + trimetoprima, três vezes semana.

d) Pneumocystis jiroveci e Toxoplasma gondii, com sulfametoxazol + trimetoprima, e complexo Mycobacterium avium, com azitromicina .

20) Lucia, 60 anos, é portadora de hipertensão arterial, diabetes tipo 2, dislipidemia e obesidade grau 2. Há um mês sofreu um acidente vascular encefálico isquêmico (AVCI), que na ocasião não foi trombolisado. Traz consigo para a consulta na ESF o boletim de alta hospitalar e exames realizados durante a internação: TC de crânio que evidencia hipodensidade em região de capsula interna direita, eletrocardiograma ritmo sinusal com sinais de hipertrofia ventricular esquerda e doppler decarótidas e vertebrais sem lesões significativas. Ao exame: hemiparesia a esquerda, ausculta pulmonar sem alterações, ausculta cardiovascular com ritmo regular. Você, médico assistente do paciente resolve ajustar terapia medicamentosa visando prevenção de um novo episódio de AVCI. Logo você prescreveu para Lúcia:

a) AAS 100 mg e Rosuvastatina 40 mg.

b) Prasugrel 10 mg, AAS 100 mg e Atorvastatina 80 mg.

c) Rivaroxabana 20 mg, AAS 100 mg e Atorvastatina 80 mg.

d) Rivaroxabana 20 mg e Rosuvastatina 40 mg.

21) Assinale a alternativa que apresenta o exame que poderia excluir lesão de órgão alvo em um paciente com hipertensão arterial sistêmica.

a) Acido úrico

b) Microalbuminuria de 24 hrs

c) LDL

d) Glicemia de jejum

22) (ENADE 2023) Uma paciente com 38 anos de idade chega para consulta com queixa de cefaleia há três semanas, temporal à direita, de caráter contínuo, pulsátil, intensidade de 9 em 10, sem melhora com uso de analgésicos comuns ou opioides. Relata que apresenta despertar noturno devido à dor e que não há fatores de melhora ou de piora da dor. Nega febre, conta que apresenta ciclo menstrual regular e que faz uso regular de anticoncepcional oral combinado há 9 anos. Acrescenta que, há 15 anos, tem migrânea perimenstrual, com alívio da dor com analgésicos simples, que é hipertensa há dois anos, obtendo boa resposta ao tratamento com atenolol 50 mg/dia e hidroclorotiazida 25 mg/dia.

Ao exame físico, registram-se: FC de 76 bpm, FR de 18 irpm, PA de 144 × 96 mmHg. A paciente apresenta fácies de dor, corada, hidratada, eupneica, acianótica e anictérica. Não apresentam alterações os resultados dos exames cardiovascular, respiratório e abdominal, assim como o de pares cranianos e de fundo de olho, registrando-se ainda ausência de rigidez nucal.

Considerando-se esse caso clínico, é correto afirmar que se deve:

A) realizar tomografia de crânio com contraste, pois a paciente apresenta sinais de alerta.

B) introduzir nova medicação anti-hipertensiva, com retorno ambulatorial em duas semanas.

C) substituir a medicação anticoncepcional oral para uma com menor concentração de progesterona.

D) descartar neoplasia intracraniana ou glaucoma, já que o exame de fundo de olho se encontra normal.

23) Paciente de 74 anos, comparece à consulta, queixando-se dos seguintes sintomas: retenção urinária, polaciúria, hesitação urinária e esforço miccional. Considerando a causa mais frequente de sintomas do trato urinário inferior (STUIs) neste cenário clínico, assinale o provável diagnóstico:

a) Cistite.

b) Prostatite.

c) Câncer de próstata.

d) Aumento benigno da próstata.

24) Assinale a alternativa que contenha um sinal e um sintoma apresentado por uma paciente com quadro de hipotireoidismo:

a) Bócio e diarreia.

b) Pele quente e palpitação.

c) Tremor de extremidades e cansaço.

d) Pele infiltrada e acuidade auditiva diminuída.

25) Paciente feminina, 45 anos, em corticoterapia devido á artrite reumatoide. Mantendo níveis de taxa de filtração glomerular entre 35 e 45m/min/1,73m2. Apresentou quadro anterior de disúria e polaciúria. Foi tratada para infecção urinária por Escherichia coli há três semanas. Procura atendimento médico devido a quadro persistente de disúria associada com febre, calafrios, dor lombar, náuseas e vômitos. Estabelecido o diagnóstico de pielonefrite, analise as afirmativas abaixo:

I – A principal causa de pielonefrite é a ascensão ureteral.

II – A pielonefrite pode ocorrer por via hematogênica em pacientes com doença crônica em terapia imunossupressora.

III – Na pielonefrite complicada por doença renal prévia, pode haver redução da função renal.

Quais afirmativas estão corretas:

a) Apenas as afirmativas I e II

b) Apenas as afirmativas II e III

c) Apenas as afirmativas I e III

d) Todas as afirmativas estão corretas

26) Um paciente de 50 anos procura atendimento pois vem apresentando um quadro de evolução insidiosa, com tosse produtiva há 6 semanas, febre baixa e vespertina, sudorese noturna, perda ponderal de 8kg em 30 dias. Apresenta também um quadro diarreico persistente e aumento de volume da cadeia ganglionar á direita, única, cervical e indolor. A ausculta apresentou alteração em segmentos superiores e posteriores á direita. No RX de tórax foi evidenciado derrame pleural moderado e unilateral. Os critérios clínicos apresentados pelo paciente são mais compatíveis com o diagnóstico de:

a) Sarcoidose

b) Tuberculose

c) Doença pulmonar obstrutiva crônica

d) Pneumonia intersticial

27) Homem de 70 anos com história de dor lombar progressiva com piora à movimentação e associada a emagrecimento. Apresenta Lasegue positivo á direita, astenia e fraqueza de início há dois meses. Os exames mostraram hemoglobina = 9g/dl; leucócitos = 9.000/mm3, diferencial normal, plaquetas = 200.000/mm3; glicose = 90mg/dl; creatinina = 1,1mg/dl; proteínas totais= 7,5g, albumina = 3,0g/dl; globulina= 4,5g/dl; VHS= 110mm/hora; ácido úrico= 7,5 mg/dl; fosfatase alcalina = 120 U/l; cálcio = 10,5 mg/dl; fósforo = 3,5 mg/dl. O exame de imagem da coluna revela intensa osteopenia sem lesões líticas e PSA total = 9,5 ng/ml. O paciente é tabagista de 40 maços-ano e etilista social. Assinale a alternativa que contenha a principal hipótese diagnóstica para este paciente:

a) Mieloma múltiplo

b) Tumor de próstata metastático

c) Osteoporose secundária a hipogonadismo

d) Metástases na coluna por tumor epidermóide de pulmão

28) Paciente de 55 anos, com sobrepeso, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica controlada com enapril, comparece à consulta referindo que, após início de um remédio para o diabetes, há dois meses, vem tendo diarréria diariamente. O hipoglicerniante oral que mais provavelmente pode ter sido prescrito foi:

a) Gliclazida

b) Acarbose

c) Metformina

d) Pioglitazona

29) Mulher de 25 anos procura médico por cansaço. Está hipocorada com hemoglobina = 9,9g/dL, VGM = 72fl, HGM = 23pg, RDW = 16,5 e ferritina = 6,0µg/L. Cerca de dez dias após iniciar o tratamento correto, é possível acompanhar a sua eficácia, solicitando:

A) ferritina

B) ferro sérico

C) reticulócitos

D) hemoglobina

30) Após a imunização completa para a hepatite B, o perfil sorológico que deve ser observado é:

A) anti-HBc positivo e anti-HBs positivo

B) anti-HBc positivo e anti-HBe positivo

C) anti-HBc negativo e anti-HBs positivo

D) anti-HBc negativo e anti-HBe positivo

31) Um jovem procura atendimento devido ao aparecimento, há 3 semanas, de manchas claras na pele localizadas na região cervical e nos braços, bilateralmente. Enquanto espera o atendimento, preocupa-se ao observar um cartaz afixado com os seguintes dizeres: “Que mancha é essa? Você pode estar com hanseníase”.

Nesse caso, a principal informação a ser utilizada pelo médico para diferenciar a hanseníase de outras dermatoses que cursam com lesões semelhantes é:

a) o tempo de aparecimento das lesões.

b) a ausência de alterações de sensibilidade.

c) o fato de as manchas serem hipocrômicas.

d) a faixa etária em que se encontra o paciente.

32) Paciente feminina, de 62 anos de idade, vai à consulta médica, referindo tosse produtiva com expectoração clara de aspecto mucoide. Refere história de dispneia aos médios esforços nos últimos 5 anos, com piora nos últimos 30 dias. Nega febre ou alteração característica da tosse habitual. Tabagista 1 maço/ dia há 40 anos. Nega hipertensão arterial sistêmica e diabetes melito. A radiografia de tórax mostra hiperinsuflação pulmonar, hipertransparência e retificação do diafragma. A hipótese diagnóstica provável é:

A) DPOC

B) bronquiectasia

C) asma agravada por infecção

D) DPOC agravada por pneumonia

33) Um militar de 22 anos de idade apresenta meningite por N. meningitides do tipo B. Ele divide o dormitório com outros cinco militares. Qual a conduta indicada em relação aos colegas de dormitórios?

A) Profilaxia apenas para aqueles cuja cultura de líquor for positiva.

B) Ceftriaxone para todos eles.

C) Profilaxia apenas para aqueles cuja cultura de swab nasal for positiva.

D) Vacinação com vacina conjugada.

34) Sr. Y, 50 anos, com dispneia mMRC2 há 5 anos, refere no último inverno um episódio de sibilância torácica e dispneia mMRC3 associados a tosse e expectoração mucopurulenta. Nesta ocasião recebeu prescrição de nebulização e antimicrobiano, com melhora do quadro, retornando a dispneia mMRC2. Relatava que a dispneia vinhatrazendo desconforto pois o limitava para as caminhadas com sua filha pelas manhãs, o que fazia regularmente até há um ano. HPP: HAS há 7 anos em uso de losartana.

Nega alergias, internações ou cirurgias. Nega tuberculose, pneumonia. Nega pneumopatias na família. Tabagista de 30 cigarros/dia há 20 anos.

O médico assistente solicitou uma espirometria que revelou:

Resultados	Pred	LIN	Pre		Post		%Chg
FVC (L)	2,65	2,01	¤1,88	71%	¤1,86	70%	-1%
FEV1 (L)	2,16	1,55	¤1,02	47%	¤1,00	46%	-2%
FEV1/FVC	0,81	0,73	¤0,54	67%	¤0,54	66%	-1%

Neste contexto podemos dizer que:

a) O paciente apresenta quadro clínico e espirométrico compatíveis com asma pois há resposta broncodilatadora na espirometria.

b) O paciente tem o diagnóstico clínico e espirométrico de DPOC.

c) O paciente apresenta somente bronquite tabágica sem espirometria que sugira distúrbio obstrutivo.

d) A espirometria sugere superposição de asma e DPOC.

35) Mulher, 75 anos, sabidamente portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica decorrente de tabagismo, deu entrada na emergência com quadro de dispneia, febre e tosse com secreção purulenta. Ao exame: lúcida e orientada, normocorada, acianótica, Tax: 38,6°C. Roncos pulmonares difusos e estertores em base direita. A gasometria arterial colhida na admissão revelou os seguintes valores: pH: 7,14; PCO2: 35mmHg; PO2: 68mmHg; HCO: 12mEq/L; BE: -8. Qual o distúrbio observado nessa paciente?

a) Acidose metabólica hiperclorêmica

b) Acidose metabólica compensada

c) Acidose metabólica simples

d) Acidose metabólica e respiratória

36) Homem de 64 anos, portador de diabetes mellitus não insulinodependente há 20 anos, com tratamento irregular desde o diagnóstico. Sua hemoglobina glicada dos últimos anos esteve sempre em torno de 9,0%. Além disso, o paciente está em tratamento com laser para retinopatia avançada. Hoje durante consulta ambulatorial de rotina, queixou-se que há 3 meses vêm acordando com o “olho inchado” e que sua urina está espumando muito. Ao exame, apresenta importante edema bilateral e simétrico de membros inferiores. A conduta inicial é:

a) Quantificação de proteinúria em 24hs e dosagem de creatinina sérica.

b) EAS e dosagem de creatinina urinária.

c) Pesquisa de microalbuminúria e dosagem de creatinina sérica.

d) Pesquisa de dismorfismo eritrocitário e dosagem de creatinina urinária.

37) Um paciente está em tratamento para hipertensão arterial com uso de um anti- hipertensivo em monoterapia. Apresenta em seu exame laboratorial dosagem de potássio sérico de 6,1 mEq/L (Normal de 3,5 a 5,5 mEq/L). Qual o fármaco mais provável, dentre os abaixo, que o paciente deve estar usando e qual seria para o caso o medicamento ideal respectivamente.

a) Hidroclorotiazida e Losartana

b) Losartana e Anlodipina

c) Anlodipina e Enalapril

d) Hidralazina e Espironolactona

38) Sobre os objetivos de otimização do controle neuro-hormonal da Insuficiência Cardíaca, assinale a alternativa correta:

a) o bloqueio da aldosterona tem como forte objetivo a redução da pré-carga

b) o bloqueio da angiotensina II tem como objetivo a redução da pré-carga

c) o bloqueio do sistema adrenérgico tem como objetivo o aumento da contratilidade

d) o bloqueio a enzima conversora da angiotensina tem como objetivo a redução da pré-carga

39) Homem de 66 anos, tabagista, alcoolista procurou atendimento médico por apresentar febre diária com calafrios, recorrente, não aferida há 3 dias, associada a tosse produtiva com escarro amarelado, hiporexia e redução da capacidade de trabalho. Há um dia, percebeu dispneia não incapacitante e dor em hemitórax direito (HTD), ventilatório-dependente. Ao exame físico: fáscies de doença aguda, acianótico, bulhas rítmicas normofonéticas. Sem abaulamentos nas paredes do tórax. Abolição do frêmito toracovocal, macicez a percussão e abolição do murmúrio vesicular na face lateral e posterior do 1/3 inferior de HTD. FR=32irpm; SatO2 = 94%; Tax= 38,7oC; FC =

118bpm; PA = 90X60mmHg. Foi encaminhado para internação hospitalar. Qual a hipótese diagnóstica?

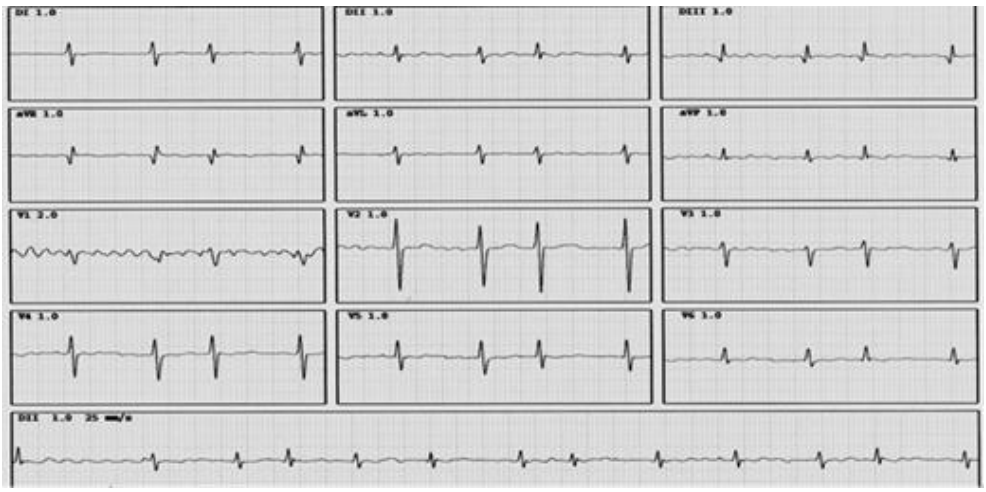
a) Pneumonia comunitária com condensação extensa à direita

b) Pneumonia comunitária com derrame pleural á direita

c) Pneumonia comunitária com exacerbação aguda de DPOC

d) Pneumonia comunitária com pneumotórax á direita

40) Paciente de 80 anos, hipertenso e diabético é admitido com quadro de palpitações intermitentes há 2 semanas. Faz uso contínuo de hidroclorotiazida, enalapril, metformina e empagliflozina. Ao exame: FC=130 bpm, PA=130/80 mmHg, pulmões limpos. ECG:



Sobre o caso analise as afirmativas:

I- Devemos iniciar um Bisoprolol associado a Rivaroxabana

II- Devemos providenciar a reversão para ritmo sinusal com uso de Sotalol na sala de emergência.

III- Esse paciente deve ser anticoagulado para o resto da vida.

Assinale a alternativa correta:

a) somente I está correta

b) somente II está correta

c) II e III estão corretas

d) I e III estão corretas

GABARITO 2023.2.2

1. C
2. D
3. D
4. A
5. C
6. A
7. A
8. A
9. D
10. D
11. B
12. C
13. C
14. A
15. B
16. A
17. A
18. B
19. D
20. A
21. B
22. A

23. D

24. D

25. D

26. B

27. A

28. C

29. C

30. C

31. B

32. A

33. B

34. B

35. D

36. A

37. B

38. A

39. B

40. D

PROVA C.M. 2024.1.1

1) (TEMA: ITU) Uma mulher de 30 anos de idade, no segundo mês de gestação, apresentou disúria e polaciúria há 48h. Hoje, apresentou febre, calafrios e dor lombar e procurou atendimento. Na admissão, ela estava febril e com frequência cardíaca de 108, normotensa, com bom débito urinário, sem outras alterações ao exame físico. Ela apresentava pontuação=0 no escore de SOFA, News2=2 e SIRS=2. Marque a resposta com a conduta diagnóstica e terapêutica mais adequada:

a) Coletar urinocultura e iniciar empiricamente nitrofurantoína

b) Coletar hemocultura e urinocultura e iniciar empiricamente ceftriaxona.

c) Coletar hemocultura e urinocultura e iniciar empiricamente levofloxacina.

d) Coletar lactato, urinocultura e hemocultura. Iniciar empiricamente amoxicilina/ clavulanato. Iniciar reposição volêmica vigorosa e, caso não responda, iniciar vasopressor.

2) (TEMA: ARBOVIROSES) Sobre as arboviroses, marque a resposta correta:

a) Os casos de doenças causadas pelo vírus Zika em adultos são sempre de evolução benigna, não havendo notificação de casos de óbitos no Brasil desde 2015

b) Casos graves de dengue (grupo D) sempre estão relacionados ao aumento da permeabilidade capilar e extravasamento de plasma ou sangramentos abundantes.

c) TGO ≥ 500 U/L ou creatinina ≥ 1,3 mg/dl são critérios de internação em enfermaria na febre amarela

d) Para o manejo da dor (artralgia), na fase aguda da Chikungunya, deve-se utilizar anti-inflamatório não hormonais, quando não há melhora com o uso de analgésicos comuns

3) (TEMA: MENINGITE) Um homem de 20 anos de idade apresenta febre e cefaleia há cerca de 20 dias. Hoje comparece à emergência com piora da cefaleia e apresentado náuseas e vômitos. Na análise do líquor desse paciente, evidenciou-se os seguintes resultados: 200 células, sendo 95% de mononucleares 5% de polimorfonucleares; glicose baixa= 40 mg/dl e proteína muito elevada= 500 mg/dl. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

a) Meningite fúngica

b) Meningite bacteriana

c) Meningite viral

d) Meningite tuberculosa

4) (ARBOVIROSES) Homem, 54 anos, morador de Vassouras, sem história de vacinação para Febre Amarela. Dois dias após regressar de Manaus- AM, apresentou febre alta de 39o, mialgia, cefaleia e hiporexia. No 5o dia de doença foi levado ao hospital com piora do estado geral e manifestação de icterícia e epistaxe. Bioquímica: transaminases hepáticas discretamente aumentadas, bilirrubinas aumentadas, ureia e creatinina aumentadas, potássio diminuído. VHS e proteína C reativa muito aumentados. Pesquisa de gota espessa de sangue negativa. Pelos dados apresentados, qual seria sua principal hipótese diagnóstica?

a) Febre Amarela

b) Leptospirose

c) Zika

d) Malária

5) (TEMA: PNEUMONIA) Homem de 35 anos de idade, sem comorbidades, sem história de uso de antibiótico ou internação no último ano, apresentando a 03 dias febre e tosse produtiva com expectoração amarelada. Hoje deu entrada na emergência acordado, orientado no tempo e espaço, com persistência da febre (39o) e, ao exame, apresentava ainda: FC= 104 bpm e PA: 95x 65 mmHg; FR= 28 irpm, com MV abolido em base D e presença de estertores creptantes em 1/3 inferior de HTD. Pelos exames complementares: ureia normal= 40 mg/dl e Rx de tórax com condensação em 1/3 inferior de HTD e derrame pleural em base esquerda. Marque a opção que apresenta a correta classificação pelo CURB 65 e a correta conduta terapêutica.

A) CURB 65= 0, tratamento ambulatorial com Azitromicina

B) CURB 65= 1, tratamento ambulatorial com Azitromicina

C) CURB 65=2, tratamento em enfermaria com Amoxicilina+ Clavulanato e Azitromicina

D) CURB 65= 3, tratamento em enfermaria, com Moxifloxacina.

6) (TEMA: HIPERGLICEMIA) Mulher de 45 anos, IMC:36Kg/m2, com pai e mãe portadores de DM tipo 2, procurou atendimento ambulatorial para consulta de rotina. Trouxe exames laboratoriais que revelaram: glicemia de jejum = 115mg/dl; e HbA1c = 6%. Os mesmos exames foram repetidos e revelaram: glicemia de jejum = 118mg/dl; e HbA1c = 6,1%; e TOTG com 75g de glicose anidra = 155mg/dl. Além da mudança no estilo de vida, qual a conduta para esta paciente?

a) Inibidor SGLT2

b) Expectante

c) Glicazida

d) Metformina

7) (TEMA: DIABETES MELLITUS) Homem de 64 anos, portador de diabetes mellitus não insulinodependente há 20 anos, com tratamento irregular desde o diagnóstico. Sua hemoglobina glicada dos últimos anos esteve sempre em torno de 9,0%. Além disso, o paciente está em tratamento com laser para retinopatia avançada. Hoje durante consulta ambulatorial de rotina, queixou-se que há 3 meses vêm acordando com o “olho inchado” e que sua urina está espumando muito. Ao exame, apresenta importante edema bilateral e simétrico de membros inferiores. A conduta inicial é:

a) EAS e dosagem de creatinina urinária.

b) Pesquisa de microalbuminúria e dosagem de creatinina sérica.

c) Pesquisa de dismorfismo eritrocitário e dosagem de creatinina urinária.

d) Quantificação de proteinúria em 24hs e dosagem de creatinina sérica.

8) (TEMA: DENGUE) Sobre o diagnóstico da Dengue, é correto afirmar:

A) A pesquisa de antígeno NS1 é mais sensível quando colhido até o 3o dia da doença.

B) A pesquisa de anticorpos IgM é o método de escolha para o diagnóstico da Dengue até o 5o dia da doença.

C) O isolamento viral só é possível após o 5o dia da doença.

D) A pesquisa de anticorpos IgG é mais sensível entre o 4o e 7o dia da doença.

9) (TEMA: CELULITE) Uma mulher de 50 anos de idade, sem comorbidades, sem história de internação ou uso de antibiótico recente, sofreu uma mordedura superficial pelo seu próprio cachorro na perna direita. Como o cachorro era observável, o médico assistente não recomendou nenhuma medicação, soro ou vacina. Nos dias subsequentes, houve o surgimento de uma celulite infecciosas perilesional (ao redor da mordedura do cachorro). Ela não apresenta febre e sinais de sepse. Qual o tratamento antibiótico de escolha para esse caso?

A) Oxacilina

B) Penicilina Cristalina

C) Amoxicilina/ ácido clavulânico

D) Cefalexina

10) (TEMA: MENINGITE) Um homem de 30 anos de idade, vivendo com HIV, sem história de trauma crânio encefálico e neurocirurgia, iniciou quadro de febre de cerca de 39oc, cefaleia e vômitos. Dois dias após o início do quadro, houve piora da cefaleia e do vômito e procurou atendimento. Ao exame, encontrava- se acordado e orientado no tempo e espaço, escala de glasgow=15 (máximo= 15), febril e normotenso. Sem comprometimento de pares cranianos, sem sinais neurológicos focais, sem papiledema e sem história de crise convulsiva. Na suspeita de Meningite Bacteriana Aguda, marque a resposta com a ordem cronológica correta para investigar e tratar esse caso, quando ele deu entrada para o atendimento:

a) Coleta de hemocultura- início de corticoide- início de Vancomicina + Cefepime + ampicilina- exame de imagem do crânio- caso exame de imagem sem contraindicações, punção lombar para coleta do líquor- ajuste da antibioticoterapia de acordo com a análise líquor.

b) Coleta de hemoculturas- punção lombar para coleta do líquor- Início de corticoide- Início de Vancomicina + Ceftriaxone + ampicilina- ajuste da antibioticoterapia de acordo com a análise líquor.

c) Coleta de hemocultura- início de corticoide- início de Vancomicina + Ceftriaxona + ampicilina- exame de imagem do crânio- caso exame de imagem sem contraindicações, punção lombar para coleta do líquor- ajuste da antibioticoterapia de acordo com a análise líquor.

d) Coleta de hemoculturas- punção lombar para coleta do líquor- Início de corticoide- Início de Vancomicina + Cefepime + ampicilina- ajuste da antibioticoterapia de acordo com a análise líquor.

11) (TEMA: OSTEOPOROSE) Economista, aposentada, 82 anos, apresentou fratura do quadril esquerdo e do punho direito após cair da cadeira. Esta paciente fazia uso regular de ácido zoledrônico há dois anos. Laboratório: hemograma, creatinina, fósforo, cálcio e paratormônio – dentro dos limites da normalidade. Qual é o tratamento indicado?

a) Teriparatida.

b) Denosumabe.

c) Alendronato de sódio

d) Raloxifeno.

12) (TEMA: GOTA) Advogado, 58 anos, com insuficiência renal crônica em tratamento conservador, obesidade e ureterolitíase, procura atendimento referindo, há cerca de seis horas, hiperemia e edema, com dor intensa ao toque na 1a articulação metatarsofalangeana esquerda. Nega relações sexuais desprotegidas ou trauma. Ao exame: bom estado geral e afebril, além do quadro articular descrito. Exames laboratoriais colhidos durante a crise: Velocidade de hemossedimentação = 52 mm e ácido úrico = 5,7 mg/dl. Qual é a medicação inicial indicada para tratamento da crise desse paciente?

a) Prednisona.

b) Alopurinol.

c) Benzbromarona

d) Antiinflamatórios não hormonais.

13) (TEMA: GOTA) Engenheiro civil aposentado, viúvo, 74 anos, com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, relata quadro de artrite aguda do tornozelo esquerdo que iniciou há 10 meses e entrou em remissão após uma semana. Nega febre, insuficiência renal, relações sexuais desprotegidas ou outros sintomas. Refere quadros semelhantes algumas outras vezes, sempre monoarticulares, tanto nos tornozelos, bem como nos joelhos e no hálux. A primeira crise ocorreu há 25 anos. Após a resolução do quadro agudo, foi iniciado tratamento com alopurinol e o paciente evoluiu sem crises por dois anos, porém este ano já apresentou duas crises. Laboratório: ácido úrico = 6,4 mg/dl (normal até 7,0 mg/dl). Qual é a conduta indicada nesse caso?

A) Manter a uricemia inferior a 6,0 mg/dl, ajustando regularmente a dose do alopurinol

B) Dosar a uricemia frequentemente, ajustando a dose do alupurinol para atingir alvo inferior a 3,0 mg/dl.

C) Diminuir a dose do alopurinol, pois o paciente já atingiu o alvo da uricemia

D) Associar anti-inflamatório não hormonal para garantir a remissão do quadro.

14) (TEMA: DOENÇA PEPTICA) Senhor de 50 anos, sempre muito ativo, passado de doença ulcerosa péptica e revascularização miocárdica, fazendo uso crônico de aspirina e bloqueador de bomba de prótons para proteção da mucosa gástrica. Relata que há 3 meses apresenta déficit de memória, fadiga e dores musculares. Procurou o cardiologista que descartou problemas cardíacos e o encaminhou ao gastroenterologista pois acredita que os sintomas são secundários ao uso crônico do bloqueador de bomba de prótons (IBP). Quais cuidados devem ser tomados com os pacientes que fazem uso crônico de IBP?

a) Dosagem sérica de vitamina C.

b) Realizar endoscopia digestiva alta anual pelo risco de formação de pólipos de glândulas fúndicas.

c) Dosagem sérica de vitamina B12

d) realizar endoscopia digestiva anual pelo aumento do risco para adenocarcinoma do tipo difuso.

15) (TEMA: DOENÇA PEPTICA) Paciente, 38 anos, queixa-se de queimação retroesternal intermitente há cerca de 6 meses. Relata que a sensação de queimação piora após as refeições copiosas e ao se deitar. Além disso apresenta tosse

crônica, rouquidão e asma leve, que têm sido persistentes nas últimas semanas. Ele tentou alívio com antiácidos, mas os sintomas persistem. De acordo com o caso clínico qual seria a melhor opção diagnóstica para o paciente?

A) Tomografia computadorizada de abdome e tórax e pHmetria de 24h

B) Endoscopia digestiva alta e tomografia computadorizada de tórax

C) Endoscopia digestiva alta e se necessário pHmetria de 24h.

D) Prescrever tratamento empírico com IBP em dose plena durante 4 semanas

16) (TEMA: DOENÇA PEPTICA) Homem, 37 anos, iniciou dor epigástrica de forte intensidade com despertar noturno, há cerca de 72hrs, além de um episódio de hematêmese. Realizou endoscopia na unidade de emergência que evidenciou úlcera localizada em antro, medindo cerca de 12mm, com coágulo aderido no fundo. Teste da urease: positivo. Procedeu-se a terapia endoscópica com plasma de argônio e injeção de adrenalina. Apresenta história de queda de moto há 10 dias com uso, sem prescrição médica, de Cetoprofeno 100mg de 6/6hrs por dor em joelho esquerdo. Recebeu alta após 72hrs, sem novo sangramento e com melhora clínica. Qual a prescrição e o controle de tratamento indicado para esse paciente, após alta hospitalar?

A) Omeprazol 40mg + Claritromicina 500 mg de 12/12hrs + Levofloxacino 500mg uma vez ao dia por 14 dias, seguido por mais 6 semanas de IBP. Suspender AINES. Controle através de teste respiratório C14 em no mínimo 2 semanas após término do tratamento

B) Omeprazol 20 mg + Amoxicilina 500 mg + Claritromicina 1g de 12/12hrs por 10 dias, podendo complementar com mais 6 a 8 semanas de IBP. Suspender AINES. Controle através de nova endoscopia digestiva em no mínimo 2 semanas após término do tratamento.

C) Omeprazol 20 mg + Amoxicilina 1g + Claritromicina 500 mg de 12/12hrs por 14 dias, podendo complementar com 6 a 8 semanas de IBP. Suspender AINES. Controle através de nova endoscopia digestiva após 1 mês do término do tratamento.

D) Omeprazol 40 mg + Amoxicilina 1g + Levofloxacino 500 mg de 12/12hrs por 10 dias, seguido por mais 2 semanas de IBP. Suspender AINES. Controle através de teste respiratório com uréia marcada C14 em no mínimo 4 semanas após término do tratamento.

17) (TEMA: DOENÇA RENAL) Paciente 46 anos, feminina, portadora de obesidade grau II, recebeu diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 durante sua consulta. No momento possui taxa de filtração glomerular estimada por CKD-EPI 89ml/min, EAS sem alterações. Qual exame está indicado para rastreamento de possível doença renal e como deve orientar a coleta do material a ser analisado?

A) Relação albumina/creatinina urinária: colher amostra isolada de urina, colhida pela manhã.

B) Proteinúria de 24h: Colher 2 litros de urina ao longo do dia e levar ao laboratório para análise na manhã seguinte.

C) EAS: Colher 2 litros de urina ao longo do dia e levar ao laboratório para análise na manhã seguinte.

D) Relação proteína/creatinina urinária: colher amostra isolada de urina, colhida em horário aleatório.

18) (TEMA: DOENÇA RENAL) Paciente de 25 anos, sexo masculino, procura atendimento médico com quadro de início súbito de intensa dor lombar direita com irradiação para flanco e fossa ilíaca homolaterais. História pregressa de

nefrolitíase. Ultrassom renal realizado à beira leito evidencia hidronefrose à direita. Quais alterações no exame de urina são compatíveis com o quadro clínico e de imagem desse paciente?

A) Proteína +++ hemácias: 50/campo, cilindros hemáticos

B) Proteína ++++ hemácias: ausentes, partículas gordurosas

C) Hb ++++ hemácias: ausentes

D) Hb +++ hemácias: 50/campo

19) (TEMA: DOENÇA RENAL) Na avaliação da doença renal, qual exame de imagem deve ser empregado de forma preferencial para avaliação quanto à cronicidade da condição oferecendo menor risco ao paciente?

A) Ultrassonografia de rins e vias urinárias

B) Cintilografia renal

C) Urografia excretora

D) Urotomografia

20) (TEMA: FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR) Um paciente masculino, 25 anos, procura espontaneamente o ambulatório de cardiologia, com queixa de "pressão descontrolada". Ele tem 180cm e está pesando 70kg, cursando direito, ele trabalha durante o dia, num escritório de advocacia, e estuda à noite; não faz atividade física há 4 anos (desde seu ingresso na faculdade); não tem vícios; é filho único e seus pais são vivos e saudáveis; na primeira medida, sua PA foi: 150 x 90mmHg e a segunda aferição foi de: 140 x 95mmHg, 7 dias após a primeira, quando trouxe exames laboratoriais, que foram normais. Qual opção traz a classificação e estratégia de tratamento indicado?

a) Baixo risco; Mudança de estilo de vida.

b) Moderado Risco; Mudança de estilo de vida.

c) Moderado Risco; Mudança de estilo de vida e tratamento farmacológico obrigatório.

d) Alto Risco; Mudança de estilo de vida e tratamento farmacológico obrigatório.

21) (TEMA: IC) No arsenal terapêutico para tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER) dispomos de inúmeras drogas. Um grupo age nas alterações hemodinâmicas e são capazes de aliviar sintomas. Outras, além dos efeitos hemodinâmicos, agem na regulação neuro-humoral e são capazes de modificar a história natural da ICFER e reduzem a mortalidade. Dentre as opções abaixo, assinale a que contêm drogas que aliviam sintomas, mas não modificam a mortalidade:

a) Digoxina, furosemida, nitrato e hidralazina

b) Espironolactona, inibidores da enzima de conversão e betabloqueador

c) Furosemida, espironolactona e betabloqueador

d) Espironolactona, bloqueador do receptor de angiotensina e betabloqueador

22) (TEMA: HAS) Qual dos esquemas anti-hipertensivos está mais adequado para tratamento de paciente de 48 anos, masculino, dislipidêmico, com níveis pressóricos de 170x100 mmHg?

A) Enalapril 10 mg 12/12 horas, Indapamida 1,5 mg 1x dia, Amlodipina 5 mg à tarde.

B) Losartan 50 mg 12/12h, Furosemida 40 mg 1x dia, Nifedipina 10 mg 12/12h

C) Valsartan 160 mg ao dia, Hidroclorotiazida 25 mg 1x dia, Metoprolol 50 mg 1x dia

D) Captopril 25 mg 8/8 horas, Clortalidona 25 mg 1x dia, Olmesartana 20 mg 1x dia

23) (TEMA: PARKINSON) Em relação aos sinais cardinais da doença de Parkinson, assinale a alternativa CORRETA:

A) Tremor, rigidez, bradicinesia, instabilidade postural.

B) Tontura, quedas, alteração cognitiva e demência.

C) Quedas, discinesia, rigidez, alucinações visuais complexas.

D) Insônia, bradicinesia, instabilidade postural, quedas.

24) (TEMA: SAÚDE DO IDOSO) O Sr. JRM, 72 anos, tem uma queixa de esquecimentos. Eles se iniciaram há 3 ou 4 anos e vem piorando paulatinamente, encontra-se muito desatento, há necessidade de repetir diversas vezes a mesma coisa, seus familiares dizem que percebem uma variação de sua capacidade cognitiva dentro do mesmo dia. Dorme com muita facilidade durante o final da manhã e tem vocalizações e agitação motora percebida por seus familiares, depois acorda e fica agitado, inquieto. Esquece onde guarda suas coisas, não consegue mais realizar atividades às quais estava acostumado, como trocar as torneiras de sua casa, não consegue entender o que ocorre em um programa de televisão e por vezes é visto conversando com ela, como se fosse uma pessoa na sala. Atualmente não sai mais de casa sozinho, porque já se perdeu no bairro onde mora há 40 anos, além do fato de ter apresentado diversas quedas. Concomitantemente, desenvolveu os sintomas descritos: tremor em repouso, de alta amplitude e baixa frequência, rigidez muscular, fácies inexpressiva, fala monótona. Assinale a alternativa que cita o provável diagnóstico e a manifestação clínica que está fortemente associada a ele:

A) A faixa etária de início da demência está associada a demência frontotemporal comportamental

B) Sr. JRM tem necessidade de altas doses de neuroléptico para controle comportamental, pois trata-se de alteração psiquiátrica

C) Declínio cognitivo de início insidioso e piora progressiva, característico de doença de Parkinson

D) Parkinsonismo tendo início próximo ao início do declínio cognitivo, característico de doença por corpos de Lewy

25) (TEMA: TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO) Paciente feminina de 78 anos, viúva, estudou até a quinta série, trabalhou como dona de casa. Queixa-se de esquecimento, tristeza e perda de vontade em executar suas tarefas habituais. Refere que tem tido sono com muitos despertares, sentindo-se cansada pela manhã, assim como ter perdido peso pois suas roupas estão mais largas. Na sua avaliação o miniexame do estado mental foi de 29 pontos (de 4 a 8 anos de escolaridade ponto de corte em 26 pontos); fluência verbal categoria semântica de 9 animais (até 8 anos de escolaridade mínimo de 8 itens), escala de depressão geriátrica com 9 pontos (ponto de corte 5).

Sua hipótese diagnóstica é a de:

A) esquecimento subjetivo.

B) transtorno neurocognitivo maior.

C) transtorno depressivo.

D) transtorno neurocognitivo menor.

26) (TEMA: DEMÊNCIA) Dona Maria, 82 anos, é encaminhada a um consultório de geriatria por sua família devido a um declínio progressivo nas funções cognitivas e físicas nos últimos seis meses. A filha de Dona Maria relata que sua mãe costumava ser ativa e independente, mas agora ela está cada vez mais confusa, fraca e com dificuldades para caminhar. Dona Maria tem uma dieta restrita, excluindo produtos de origem animal, e raramente sai de casa. Ela se queixa de formigamento nas mãos e pés e sente tonturas ao ficar de pé por um tempo prolongado. Durante o exame físico, você observa palidez da pele e uma língua lisa e avermelhada. Além disso, Dona Maria tem reflexos hiperativos e uma marcha instável. A ressonância magnética do cérebro não revela anormalidades estruturais.

Com base no caso clínico apresentado, qual das seguintes condições é a causa mais provável dos sintomas de Dona Maria?

A) Doença de Alzheimer.

B) Demência vascular.

C) Degeneração combinada subaguda relacionada a deficiência de vitamina B12.

D) Demência frontotemporal

27) (TEMA: ANSIEDADE/PÂNICO) Um homem de 32 anos procura atendimento por ter apresentado nos últimos dois ou três meses três episódios de taquicardia, sensação de forte aperto no peito, taquipneia, sudorese e tremor, além de muito medo de morrer, o que o levou por duas vezes a buscar serviço médico de emergência. Apresenta-se assintomático e bem há quase um mês, mas teme a repetição dos sintomas.

Sua hipótese diagnóstica e conduta são, respectivamente:

A) Ataques de ansiedade aguda recorrentes, requerendo medicação tipo ISRS.

B) Transtorno de ansiedade generalizada necessitando benzodiazepínico de meia-vida longa associado a ISRS.

C) Síndrome de possível insuficiência coronariana requerendo avaliação cardiológica prévia a qualquer tratamento psicofarmacológico.

D) Transtorno de pânico necessitando ISRS associado a BZD constante.

28) (TEMA DEPRESSÃO) A respeito do uso de antidepressivos a afirmação correta é a seguinte:

A) Embora não sejam especificamente ansiolíticos, todos os AD têm efetividade contra a ansiedade.

B) Os AD devem ser evitados em pacientes deprimidos que tenham ideação suicida devido ao risco de potencializar a possibilidade de suicídio.

C) Os ADT são estritamente contraindicados em pacientes idosos e/ou hipertensos.

D) Os ISRS não apresentam absolutamente nenhum efeito sobre os neurotransmissores além da serotonina, sendo, portanto, erradamente chamados de “moléculas sujas”.

29) (TEMA: HAS) Quanto aos efeitos adversos das medicações anti-hipertensivas de primeira linha podemos dizer que:

a) A hidroclorotiazida tem como efeito adverso maior o broncospasmo e astenia.

b) Bloqueadores dos canais de cálcio geralmente cursam com hiperuricemia e intolerância a glicose.

c) A alteração do paladar e tosse seca podem estar associadas ao uso de IECA

d) Os Betabloquadores são responsáveis por efeitos como sonolência e hipotencão postural.

30) (TEMA: TUBERCULOSE) Com relação ao teste rápido molecular para tuberculose (diagnóstico biomolecular) podemos afirmar que:

a) É um teste indicado preferencialmente para controle de pacientes em tratamento para tuberculose.

b) É um teste que além de dar diagnóstico de tuberculose extrapulmonar também indica presença de sensibilidade a rifampicina.

c) É um teste que também indica resistência ou não a Isoniazida.

d) É um teste que amplifica os ácidos nucleicos empregados para detecção de DNA do M. tuberculosis.

31) (TEMA: ARBOVIROSE) Quanto aos sintomas causados pelo Chikungunya, podemos afirmar que:

a) A poliartralgia geralmente é bilateral e simétrica assim como localizada.

b) Sintomas neurológicos como delirium e tontura são frequentes.

c) A febre constitui um sintoma que não tem correlação com a gravidade.

d) Astenia e fadiga são sintomas raros da doença.

32) (TEMA: HIV) Assinale a alternativa correta sobre a terapia antirretroviral (TARV) para HIV:

A) Não é indicada para pacientes com contagem de linfócitos TCD4+ acima de 350 células/mm^3 .

B) Seu início deve ser sempre precedido de exame de genotipagem.

C) Além da redução da morbimortalidade relacionada ao HIV, a TARV também diminui a transmissão da doença.

D) Deve ser iniciada preferencialmente com três drogas: tenofovir, lamivudina e efavirenz.

33) (TEMA: HIV) A Profilaxia Antirretroviral Pós- Exposição de risco à infecção pelo HIV (PEP) é utilizada para acidentes ocupacionais e para situações de violência sexual e de exposição sexual consentida. Sobre a PEP é INCORRETO afirmar que:

A) A PEP é uma medida de prevenção da infecção pelo HIV que consiste no uso de medicamentos antirretrovirais para reduzir o risco de infecção em situações de exposição ao vírus.

B) A condição sorológica da pessoa exposta deve ser investigada e, sempre que possível, da pessoa-fonte da exposição.

C) A duração da PEP é de 30 dias e a pessoa exposta deve ser acompanhada pela equipe de saúde.

D) A profilaxia das situações de exposição ao vírus é uma urgência médica, devendo ser iniciada o mais rápido possível, preferencialmente nas primeiras duas horas após a exposição e, no máximo, em até 72 horas

34) (TEMA: HEPATITE B) Uma paciente com 28 nos de idade, do sexo feminino, que refere soropositividade para hepatite B, em exames de triagem de banco de sangue apresenta os seguintes resultados: AgHBs negativo, anti- HBc total positivo, anti-HBs positivo, AgHBe negativo. Esses perfis sorológicos sugerem:

A) vacinação contra hepatite B.

B) hepatite B soroconvertida.

C) hepatite B crônica com alta replicação viral.

D) hepatite B crônica com baixa replicação viral

35) (TEMA: DIABETES MELITUS) Uma mulher de 59 anos de idade procurou atendimento ambulatorial devido a quadro de polineuropatia diabética. Há 6 meses, ela apresenta ainda dor em queimação e choques em pés, também associada a formigamento, dormência e prurido local. Qual das alternativas a seguir elenca apenas medicações de primeira linha para tratamento da dor desse paciente?

A) Oxicodona, Fenitoína e Gabapentina.

B) Amitriptilina, Metadona e Duloxetina.

C) Duloxetina, Gabapentina e Clorpromazina.

D) Carbamazepina, Gabapentina e Amitriptilina.

36) (TEMA: CEFALEIA) Mulher de 34 anos com cefaleia crônica desde os 15 anos de idade. A cefaleia é unilateral, pulsátil, de forte intensidade, piora com esforço físico e sem fono ou fotofobia. Nega febre ou piora progressiva. Com média de 5 crises por mês, que duram em média 6 horas. A conduta frente ao caso:

a) Prescrever Morfina SOS

b) Realizar uso diário de Topiramato

c) Solicitar Tc de crânio com contraste

d) Iniciar profilaxia com Sumatriptano

37) (TEMA: CRISE CONVULSIVA) Carlos, 40 anos, veio a consulta acompanhado da esposa, em que refere uma “crise” durante o sono no último final de semana. O episódio durou cerca de 5 minutos, com movimentos clônicos nos 4 membros, cianose labial e período pós ictal com cefaleia e desorientação. No dia seguinte pela manhã, já estava totalmente recuperado. Ao ser questionado se já houve outro episódio semelhante, refere que na adolescência já teve, mas não sabe dizer as circunstâncias do fato. Traz um eletroencefalograma e tomografia de crânio normais. Conduta:

a) Prescrever Diazepam 10 mg 1 cp a noite

b) Aguardar um novo episódio para caracterizar melhor

c) Iniciar fenitoína 100 mg 1 cp de 12/12 hr diariamente

d) Solicitar Ecocardiograma transesofágico e Holter de 24 horas

38) (TEMA: AVE) Seu José, 60 anos, apresentou hemiplegia súbita a direita com afasia motora há 1 ano atrás. É hipertenso e diabético, em uso regular atualmente. No momento, melhora parcial com a reabilitação pela fisioterapia. Nega cefaleia, história de trauma ou perda de consciência. Sobre o caso, podemos afirmar:

a) O uso de Clopidogrel é indicado caso ocorra ausência de onda p e presença de QRS em intervalos irregulares no D2 longo (ECG)

b) No dia do evento, se a TC de crânio sem contraste estivesse normal, haveria a possibilidade de trombólise química com estreptoquinase

c) Em caso de etiologia isquêmica, o uso de sinvastatina nos primeiros 90 dias após o evento se justifica mesmo com lipidograma normal

d) Devemos manter uma leve hipertensão arterial (140/90 mmHg) na fase crônica para melhor perfusão cerebral

39) (TEMA: AVE) Paciente masculino de 45 anos, sem comorbidades, com episódio súbito de “pior dor de cabeça da minha vida”. Feito Tc de crânio sem contraste, com hiper densidade intraventricular bilateral e cisternas da base. Nega febre. Apresenta sinal de Brudzinski. Sobre o caso, devemos:

a) Iniciar precocemente o uso de Nimodipina para evitar possível complicação dessa patologia

b) Deixar esse paciente, sem intervir, caso a PA esteja até 180/115 mmHg

c) A principal causa para o evento é angiopatia amiloide

d) O exame do liquor embora imprescindível, não deve atrasar o início do ceftriaxone

40) (TEMA: DOENÇA DA TIREOIDE) Homem de 30 anos de idade, com história de tireoidectomia total e radioablação por carcinoma papilífero de tireoide, chega à consulta emagrecido, com quadro de fadiga, inapetência, sonolência e mucosas hipocoradas. Considerando-se que a medicação de reposição hormonal (levotiroxina 150 mcg/dia) está correta, espera- se que o resultado laboratorial compatível com o diagnóstico presumível seja:

A) T3 diminuído

B) TSH aumentado

C) T4 Livre diminuído

D) Tireoglobulina aumentada

GABARITO 2024.1.1

1. B

2. C

3. D

4. B

5. A

6. D

7. D

8. A

9. C

10. A

11. A

12. A

13. A

14. C

15. C

16. C

17. A

18. D

19. A

20. A

21. A

22. A

23. A

24. D

25. C

26. C

27. A

28. A

29. C

30. D

31. A

32. C

33. C

34. B

35. D

36. B

37. C

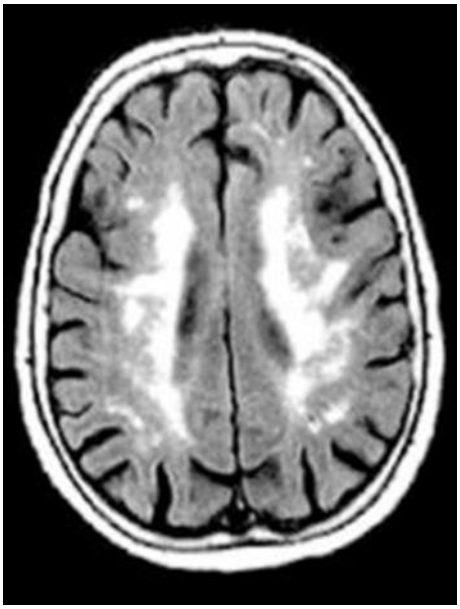
38. C

39. A

40. D

PROVA C.M. 2024.1.2

1) O sr. Joaquim, de 75 anos, hipertenso e diabético, é levado para uma consulta geriátrica. A filha relata que há 2 anos o paciente apresentou um episódio de AVC isquêmico e que antes do evento, o pai era totalmente independente. Há 2 anos, o paciente vem precisando de ajuda para cuidar das finanças e lembrar de compromissos. Nos testes cognitivos, é observado prejuízo importante na memória e na atenção. Ao exame físico, são observadas hemiparesia esquerda e membros superiores com rigidez em roda denteada. O exame de imagem realizado (RNM do encéfalo) apresenta microangiopatia extensa (FAZEKAS III). Sobre a principal hipótese diagnóstica para o sr. Joaquim, assinale a alternativa correta.



a) Doença de Alzheimer

b) Demência por Corpos de Lewy

c) Demência Vascular

d) Demência Mista

2) Assinale a afirmativa que associa as características clínicas com o possível diagnóstico:

a) Declínio cognitivo flutuante, com períodos de confusão e alucinações visuais; quedas frequentes – Demência Frontotemporal.

b) Parkinsonismo; declínio cognitivo flutuante, distúrbios do sono REM – Demência por Corpos de Lewy.

c) Evolução com piora súbita, em degraus, súbito com curso flutuante e gradativo; labilidade emocional associada ao declínio cognitivo – Demência de Alzheimer.

d) Início 10 anos mais cedo que as demências em geral; alterações comportamentais e de linguagem; perda da autocrítica – Atrofia de múltiplos sistemas.

3) Paciente de 67 anos, iniciou quadro de tremor em membro superior direito, em repouso. Apresenta, ainda, queixa de três quedas nos últimos 2 meses. Relata sensação de “perna pesada”. Filho notou que alterações iniciaram há um ano, apresentando marcha lenta, com passos curtos. Em consulta, foi aventada a hipótese de Doença de Parkinson. Considerando o caso acima, assinale a alternativa correta.

A) Na Doença de Parkinson, existem os sinais cardinais: bradicinesia, tremor de repouso, rigidez, no entanto o tremor de repouso é obrigatório

B) Se confirmado o diagnóstico, é frequente haver comprometimento rápido da cognição, apresentando demência pela doença de Parkinson após menos de um ano do diagnóstico

C) Transtornos de humor como depressão e ansiedade são pouco frequentes em pacientes com Parkinson

D) Sintomas não motores da Doença de Parkinson como alteração do sono REM, constipação intestinal e hiposmia são frequentes e podem manifestar-se anos antes dos sintomas motores.

4) Homem de 34 anos relata história de dor abdominal e diarreia com presença sangue há aproximadamente sete meses, associada a febre baixa, perda ponderal e anemia. Apresenta lesões cutâneas compatíveis com eritema nodoso e apresentou recente quadro de uveíte. Levantada hipótese de doença inflamatória intestinal realizou colonoscopia que evidenciou ulcerações em retossigmóide, cólon descendente, cólon ascendente e importante acometimento do íleo terminal. O diagnóstico mais provável e o exame que define a atividade da doença, respectivamente, são:

a) Doença de Crohn / ASCA em altos títulos.

b) Colite ulcerativa / P-Anca em altos títulos.

c) Colite ulcerativa / calprotectina fecal em altos títulos.

d) Doença de Crohn / calprotectina fecal em altos títulos.

5) Homem, 62 anos, hipertenso e diabético, refere há um dia episódio de perda súbita de força muscular nos membros superior e inferior direito, com duração de aproximadamente 20 minutos, desaparecendo de modo completo, sem sequelas. Atendido no pronto atendimento onde se mostrava hipertenso (PA: 160X100 MMHG). Sendo realizada tomografia de crânio sem contraste que se mostrou sem alterações. E eletrocardiograma que se mostrava em ritmo sinusal regular. Sobre o caso assinale a alternativa correta:

a) O diagnóstico é de ataque isquêmico transitório e deve ser iniciado dupla antiagregação com AAS e Clopidogrel por 21 dias.

b) Deve ser iniciado o uso de anticoagulantes e estatinas, orientado o abandono do tabagismo e o controle da hipertensão arterial e do diabetes melito.

c) Caso haja estenose da artéria carótida interna entre 70 e 100% , está indicada endarterectomia ou angioplastia.

d) A normalidade da tomografia de crânio exclui o diagnóstico de ataque isquêmico transitório.

6) Paciente masculino, 29 anos, apresentando quadro de febre, convulsões e hemiplegia à esquerda. Foi realizada Tomografia Computadorizada do Crânio que evidenciou múltiplas lesões com reforço da periferia e edema perilesional após a administração do meio de contraste. Durante a anamnese, antes da paciente ser transferida para a UTI, o mesmo relatou ao médico residente que mantinha relações sexuais desprotegidas com seu atual companheiro e que o mesmo é caminhoneiro e há cerca de 06 meses apresentou um quadro de “cobreiro” na região torácica. Diante das queixas clínicas, dos dados epidemiológicos e do exame de imagem, qual o provável diagnóstico?

a) Infecção pelo HIV + Neurotoxoplasmose.

b) SIDA + Neurotoxoplasmose.

c) SIDA + Neurocriptococcose.

d) Infecção pelo HIV + Linfoma do SNC.

7) Mulher de 21 anos, com múltiplos parceiros sexuais recentemente, sem proteção de barreira, apresenta quadro de febre, fadiga e odinofagia há 7 dias. Ao exame físico, nota-se eritema em orofaringe e adenomegalia cervical e axilar. Pensando em descartar infecção aguda pelo HIV, a combinação de testes que deve ser solicitada para o diagnóstico mais precoce desta infecção (HIV) é:

a) Dois testes rápidos de fabricantes diferentes.

b) Um teste rápido e um molecular.

c) Imunoensaio de 3ª geração e um teste rápido.

d) Imunoensaio de 4ª geração e um teste molecular.

8) Paciente foi encaminhado à Unidade Básica de Saúde após doação de sangue. De acordo com o banco de sangue seus exames vieram alterados: HBsAg negativo / Anti HBc IgG positivo / Anti HBs positivo. Você é o médico que atende este paciente. Qual orientação você deverá dar a ele sobre este resultado?

A) O paciente deverá ser alertado já que ele é portador crônico de hepatite B e precisa iniciar o tratamento.

B) O paciente deverá ser tranquilizado já que ele não tem hepatite B, entrou em contato com o vírus e curou-se.

C) O paciente deverá ser alertado já que ele é portador crônico de hepatite B e precisa ser internado e vacinado contra hepatite B.

D) O paciente devera ser tranquilizado já que ele não tem hepatite B mas precisa ser orientado a receber a vacina contra o vírus B.

9) Paciente sexo masculino, 62 anos, durante investigação etiológica de Cirrose hepática, realiza sorologia que revela hepatite B crônica com alta replicação viral. Qual dos resultados abaixo é compatível com este diagnóstico?

A) HBsAg positivo e HBe Ag positivo

B) anti-HCV positivo e HBs Ag negativo

C) anti_HBe positivo e anti-HBc IgG positivo

D) anti-HBs positivo e HBsAg negativo

10) Mulher, 43 anos, procedente de Manaus, encontra-se internada no CTI, pois evoluiu com quadro de hepatite fulminante pelo vírus da hepatite B, com indicação de transplante hepático. Tem passado de hepatite C tratada com antivirais de ação direta obtendo a resposta virológica sustentada (cura). Assinale a alternativa que apresenta a sorologia atual dessa paciente.

A) HBsAg (-), anti-HBc total (+), anti-HBc IgM (-), anti-HBs (+), Anti-HCV (+)

B) HBsAg (+), anti-HBc total (+), anti-HBc IgM (-), anti-HBs (-), Anti-HCV (-)

C) HBsAg (+), anti-HBc total (-), anti-HBc IgM (+), anti-HBs (-), Anti-HCV (+)

D) HBsAg (-), anti-HBc total (+), anti-HBc IgM (+), anti-HBs (+), Anti-HCV (-)

11) Considere uma pessoa com diagnóstico de infecção pelo HIV/ AIDS recente e contagem de linfócitos TCD4= 180 células/ mm . Em relação às profilaxias primárias para as infecções oportunistas, marque a resposta correta:

A) Iniciar sulfametoxazol- trimetoprim, azitromicina e, caso PPD forte reator, isoniazida.

B) Iniciar sulfametoxazol- trimetoprim, isoniazida e azitromicina .

C) Iniciar sulfametoxazol- trimetoprim e, caso PPD forte reator, isoniazida diariamente

D) Iniciar sulfametoxazol- trimetoprim e isoniazida.

12) Homem, 30 anos de idade, obeso e vivendo com HIV/ AIDS, com boa adesão aos antirretrovirais, procura assistência médica no 6º dia do início dos sintomas de uma síndrome gripal. Apresenta febre de 38º c, congestão nasal com coriza clara, tosse produtiva com expectoração clara, frequência respiratória= 18 irpm, saturação de O2= 97% em ar ambiente e normotenso. Realizado teste rápido para pesquisa de antígeno de SARS COV 2 em swab de nasofaringe que resultou não reagente e reação de polimerase em cadeia (PCR) para influenza positiva. Qual a conduta correta para esse caso?

A) Internação hospitalar. Prescrever dexametasona e anticoagulante profilático

B) Acompanhamento ambulatorial. Prescrever sintomáticos.

C) Acompanhamento ambulatorial. Prescrever sintomáticos e Oseltamivir (Tamiflu®).

D) Acompanhamento ambulatorial. Prescrever sintomáticos e Nirmatrelvir-ritonavir (paxlovid®).

13) Homem de 45 anos de idade, natural do norte de Minas Gerais e morador há 30 anos no Rio de Janeiro, apresenta sinais de insuficiência cardíaca há cerca de 2 anos. Diante de uma cardiopatia crônica em um paciente jovem, natural do norte de Minas Gerais, o médico suspeitou de doença de Chagas e para comprovar sua suspeita, ele solicitou:

A) Sorologia para pesquisa de anticorpos da classe IgM

B) Pesquisa direta do parasita em gota fresca de sangue

C) Sorologia para pesquisa de anticorpos da classe IgG

D) Xenodiagnóstico

14) Adamastor, 55 anos, portador de diabetes mellitus tipo II há 05 anos, iniciou um quadro de hipertensão arterial sistêmica. Diante do cenário clínico, além das recomendações não farmacológicas, compreendeu-se a necessidade do início da seguinte classe medicamentosa, esta, preconizada para tal contexto:

a) Beta bloqueador.

b) Bloqueador dos canais de cálcio.

c) Agente simpatolítico de ação central.

d) Inibidor da enzima de conversão da angiotensina.

15) Um homem de 75 anos, apresenta quadro progressivo de déficit de memória que afeta as atividades diárias e desorientação tempo- espacial (se perde na rua e não é mais capaz de sair sozinho de casa). Possui escolaridade ensino

médio completo e pontuou 22 no miniexame do estado mental. A esposa ao ser questionada, refere início há 8 meses, trazendo exames laboratoriais e TC de crânio sem alterações. A medicação de escolha para essa fase, em monoterapia é:

a) Memantina

b) Galantamina

c) Pregabalina

d) Amitriptilina

16) Uma mulher de 24 anos chama ajuda pois iniciou movimentos clônicos no braço esquerdo, sem perda da consciência (ainda conversava). Após 5 minutos, ela cai no chão, perde a consciência e percebe-se movimentos tônicos-clônicos em ambos os lados. Este evento dura cerca de 10 minutos e a paciente retorna a conciencia com cefaleia holocraniana e confusa. Indagada, a paciente refere ser a terceira crise, sempre do mesmo padrão, e não consegue definir uma causa aparente. Pensando no diagnóstico e com intuito de prevenir futuros eventos, devemos iniciar imediatamente:

a) Diazepam

b) Valproato de sódio

c) Gabapentina

d) Carbamazepina

17) Seu João, 70 anos, deu entrada no hospital com quadro de hemiparesia a direita e afasia motora. Esposa refere início do quadro há 15 minutos atrás quando estavam almoçando. É hipertenso e diabético, em uso regular de medicações. Durante o exame de tomografia de crânio, que veio normal, o paciente apresentou melhora completa do quadro. Sua PA estava 170x106 mmHg, FC: 100 bpm, FR: 16 irpm, HGT 140 mg/dL, Tax 36c. De acordo com o caso, a melhor conduta:

a) Realizar trombólise com Alteplase e manter hospitalizado sem alterar a PA

b) Internar o paciente, iniciar AAS + Clopidogrel, realizar Eletrocardiograma, Ecocardiograma e Doppler de carótidas e vertebrais

c) Liberar o paciente com AAS e realizar Eletrocardiograma, Ecocardiograma e Doppler de carótidas e vertebrais ambulatorialmente

d) Internar o paciente, normalizar a PA com Nitroprussiato de sódio EV e aguardar 48 horas para realizar nova TC de crânio

18) Homem 72 anos, procura atendimento, acompanhado da esposa. Segundo ela, ele já tem diagnóstico estabelecido de Doença de Parkinson. Porém, nos últimos meses, está apresentando lapsos de memória, alucinações e muito repetitivo. Na doença de Parkinson a presença de quadro demencial pode ocorrer, em geral:

A) Precedendo os sintomas motores

B) Após comprometimento motor significativo

C) quando o tremor ainda é leve e esporádico

D) De modo simultâneo aos sintomas motores

19) Cristiane, 25 anos, busca atendimento por apresentar episódios de cefaleia de forte intensidade desde os 16 anos de idade. Localização temporo-parietal esquerda, pulsátil, com duração de 6hs, acompanhada de náuseas, foto e fonofobia. Um dia antes da cefaleia sente sonolência diurna excessiva. A frequência das crises é de, aproximadamente, seis ao mês e apresenta sobrepeso. Traz uma TC de crânio normal, realizada há três meses. Quanto a classificação da cefaleia e o esquema terapêutico mais adequado podemos dizer que:

A) A paciente apresenta enxaqueca hemiplégica familiar e o melhor esquema terapêutico seria Naratriptano + Propranolol + metoclopramida.

B) A paciente apresenta estado de mal enxaquecoso e o melhor esquema terapêutico seria Ergotamina + Divalproato de Sódio + Dexametasona.

C) A paciente apresenta enxaqueca sem aura e o melhor esquema terapêutico seria Triptano + Topiramato.

D) A paciente apresenta enxaqueca com aura e o melhor esquema terapêutico seria dipirona + Cloridrato de Amitriptilina.

20) Paciente de 55 anos de idade, fototipo III, procurou atendimento devido a pinta na perna que está crescendo e se tornando escura, com evolução de 2 anos. Nega dor ou prurido no local. Avó materna com histórico de câncer de pele carcinoma basocelular. Ao exame observa-se mácula hipercrômica, de bordas irregulares, superfície com textura irregular, diferentes tonalidades, variando do castanho- claro ao tom enegrecido, com 1,0 cm, em panturrilha direita. Assinale a principal hipótese diagnóstica do caso.

A) melanoma extensivo superficial

B) ceratoacantoma

C) carcinoma basocelular

D) nevo melanocítico

21) Paciente foi diagnosticado com hanseníase tuberculóide e mostrou preocupação com o diagnóstico, em relação à sua família, uma vez que mora com sua mãe de 80 anos e seus filhos de 7 e 12 anos. Qual a orientação correta a ser passada para o paciente?

A) Não é necessário examinar a família pois a forma de hanseníase que ele apresenta, não é contagiosa.

B) A mãe do paciente deve ser examinada e receber duas doses da BCG, não sendo necessário examinar as crianças.

C) Deve ser realizada a baciloscopia do raspado intradérmico em todos os contatos que habitam com o paciente, independente da forma clínica do paciente.

D) Todos os contatos devem ser examinados e receber uma dose da vacina BCG, de acordo com seu histórico vacinal, caso seja descartada hanseníase.

22) ACRV, 36 anos, residente na cidade do Rio de Janeiro. Queixa-se de mancha na perna há mais de 2 anos e que percebe que o local é menos sensível ao toque. Na história familiar, seus avós tinham lesões semelhantes que foram tratadas na Unidade Básica de Saúde. Ao exame, tinha placa com as bordas nítidas e eritematosas na perna direita,

com centro hipocrômico, medindo 10 x 10 centímetros de diâmetro. A lesão é bem delimitada e a baciloscopia foi negativa. O teste de sensibilidade tátil estava bastante alterado na lesão. Após o seu diagnóstico e classificação desta forma de hanseníase, o tratamento adequado a ser proposto é:

A) Rifampicina + Clofazimina mensal supervisionada e dose diária autoadministrada de Clofazimina + Dapsona: tratamento por 12 meses

B) Rifampicina + Clofazimina + Dapsona mensal supervisionada e dose diária autoadministrada de Clofazimina + Dapsona: tratamento por 12 meses

C) Clofazimina + Dapsona mensal supervisionada e dose diária autoadministrada de Clofazimina

+ Dapsona: tratamento por 6 meses

D) Rifampicina + Clofazimina + Dapsona mensal supervisionada e dose diária autoadministrada de Clofazimina + Dapsona: tratamento por 6 meses.

23) CJA, 27 anos, masculino, com queixa de manchas na pele há 30 dias, assintomáticas. Ao exame dermatológico observou-se máculas eritematosas difusamente distribuídas pelo tronco e acometimento também das palmas das mãos, com lesões eritematosas com descamação periférica em colarete. Ao ser questionado, informou ter múltiplas parceiras e não usar preservativos com frequência. Baseado na história clínica e após o adequado diagnóstico, o tratamento a ser indicado para o paciente é:

A) Benzilpenicilina potássica cristalina 18-24 milhões de UI/dia via IV por 14 dias

B) Benzilpenicilina benzatina 2.400.000 UI por semana, aplicar 2 doses

C) Ceftriaxona 2 g via IV 1 x ao dia por 10 a 14 dias

D) Benzilpenicilina benzatina 2.400.000 UI apenas 1 dose

24) J.C.S, 42 anos, fototipo II, feirante, tabagista, refere apresentar em região central do lábio inferior, área vermelha, ressecada, com frequentes descamações e rachaduras. No decorrer de 4 meses, a lesão tornou-se endurecida, com erosão e sangramentos constantes. Realizada biópsia para confirmar malignização para o câncer de pele:

A) melanoma extensivo superficial

B) carcinoma basocelular

C) carcinoma espinocelular

D) ceratoacantoma

25) Um paciente de 30 anos procura atendimento médico por quadro de erupção cutânea máculo- papulosa no tronco e nas palmas das mãos, além de lesões condilomatosas na área anogenital. Refere ter tido ulceração indolor no pênis há aproximadamente 3 meses e quedesapareceu sem tratamento. Exame laboratorial confirma diagnóstico de Sífilis. Qual estágioda doença ele se encontra atualmente?

A) Sífilis Latente recente

B) Sífilis Secundária

C) Sífilis Primária

D) Sífilis Terciária

26) Quais critérios são utilizados no método ABCDE para avaliação de lesões cutâneas suspeitas de melanoma?

A) Angiogênese, Biópsia, Cicatrização, Diagnóstico precoce e Exame físico.

B) Assimetria, Bordas irregulares, Cores variadas, Diâmetro superior a 5mm e Evolução.

C) Ablação, Borda, Cor, Diagnóstico e Exame.

D) Amostra, Biópsia, Contorno, Diagnóstico e Evolução.

27) Qual é a principal abordagem terapêutica para o tratamento da anemia na doença renal crônica?

A) Administração de eritropoietina

B) Suplementação de ácido fólico

C) Suplementação dietética de ferro

D) Transfusões sanguíneas frequentes

28) Paciente 65 anos, portador de DPOC, dispneia basal mMRC2, há 2 dias evoluindo com dor torácica, piora da dispneia basal mMRC4, hemoptise, nega outros sintomas respiratórios, nega febre. Devido quadro clínico procurou atendimento médico e teve corretamente como hipótese diagnóstica principal:

A) Exacerbação de DPOC

B) Tuberculose

C) Tromboembolismo pulmonar

D) Pneumonia adquirida na comunidade

29) Mulher, 30 anos, diabética, há 2 meses com tosse seca, febre de até 38ºC e emagrecimento de 10Kg neste período. Radiografia de tórax com infiltrado em 1/3 superior do hemitórax direito e cavitação no 1/3 médio ipsilateral.

Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual a alternativa correta para tratamento?

A) Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida por 2 meses e Rifampicina + Isoniazida por 4 meses

B) Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Levofloxacina por 2 meses e Rifampicina + Levofloxacina por 4 meses

C) Rifampicina + Isoniazida por 2 meses + Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol por 4 meses

D) Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol por 2 meses e Rifampicina + Isoniazida por 4 meses

30) Homem, 45 anos, com diagnóstico recente de tuberculose pulmonar. Durante avaliação foram identificados como contactantes intradomiciliar a esposa de 40 anos, uma filha de 20, um filho de 14 e a sogra de 70. Todos assintomáticos. Qual a conduta mais adequada quanto aos contactantes?

A) Orientação quanto ao surgimento de sintomas

B) Teste rápido molecular

C) Prova tuberculínica

D) Pesquisa de BAAR no escarro

31) Paciente 82 anos, portador de Alzheimer, acamado há 6 meses, evoluindo com tosse e engasgos pós alimentares, internado para realização de gastrostomia, durante a admissão o médico identificou que o paciente se apresentava taquipneico e febril, solicitou radiografia de tórax e identificou presença de condensação em lobo inferior direito, iniciado tratamento para pneumonia adquirida na comunidade. Neste caso a forma de penetração do patógeno nas vias inferiores foi por:

A) Aspiração de conteúdo da orofaringe

B) Translocação bacteriana intestinal

C) Aspirações de aerossóis contaminados

D) Via hematogênica

32) Paciente 38 anos, previamente hígida em tratamento de pneumonia, hoje no sétimo dia de antibiótico (betalactâmico) relata melhora da tosse com expectoração, sem episódios de febre, nega dispneia, dor torácica, informa melhora dos sintomas respiratórios. O médico do PSF repetiu a radiografia de tórax e percebeu persistência da opacidade de contornos imprecisos localizada no lobo médio e pensando na melhor conduta para o caso decidiu corretamente:

A) Repetir a radiografia no dia seguinte

B) Encerrar o tratamento diante da melhora clínica

C) Associar outro antibiótico e estender tratamento

D) Solicitar uma tomografia computadorizada de tórax

33) Em pacientes com Diabetes, devemos ter atenção aos sinais precoces da Doença Renal do Diabetes (DRD). Dentre as opções abaixo qual delas mostra os primeiros sinais manifestados:

A) Macroalbuminúria e nefrite intersticial.

B) Hiperfiltração glomerular e microalbuminúria.

C) Hematúria macroscópica e leucocitúria.

D) Hipoaldosteronismo hiporreninêmico e acidose tubular renal.

34) Paciente de 52 anos, com diabetes mellitus tipo 2 há mais de 10 anos, sobrepeso (IMC: 28.5kg/m2) e hipertenso. Refere que nunca fez acompanhamento médico regular, atualmente sedentário e sem acompanhamento nutricional. Relata que vem perdendo peso mesmo sem fazer dieta, emagrecendo 6kgs no último mês, queixa-se também da visão que está muito embaçada. Nega tabagismo, bebe cerveja 4 vezes na semana. Atualmente em uso de Metformina 850mg 3x / dia; Losartana 50mg 2x/ dia e Hidroclorotiazida 1x / dia. Exames laboratoriais: glicose: 292mg/dl; Hba1c: 10.8% TFGe: 57ml/min; Colesterol total: 257; HDL-c: 36; Triglicerídeos: 588mg/dl. No caso descrito, considerando apenas o tratamento do diabetes, dentre as alternativas abaixo qual a conduta CORRETA a ser tomada?

A) Iniciaria Dapagliflozina 10mg 1x / dia; Gliclazida MR 120mg/dia e mudança do estilo de vida.

B) Iniciaria Dapagliflozina 10mg 1x / dia; Gliclazida MR 120mg/dia; reduziria a dose da Metformina e mudança do estilo de vida.

C) Iniciaria Insulina NPH 0.5Ui/kg/dia; reduziria a dose da Metformina e mudança do estilo de vida.

D) Iniciaria Insulina NPH 0.5Ui/kg/dia e mudança do estilo de vida.

35) Paciente de 68 anos deu entrada no ambulatório do cardiologista para seguimento de acompanhamento cardiológico. Paciente refere ser hipertenso, diabético e dislipidêmico. Relata ainda internação hospitalar por IC descompensada há 5 anos e internação hospitalar por pneumonia há 8 anos.No momento, está assintomático e em uso regular de enalapril, carvedilol, espironolactona, rosuvastatina, metformina e gliclazida.Trouxe consigo exames que evidenciavam: Hb 13.7, HT 42.5, leucócitos 5200, plaquetas 248000, ureia 37, creatinina 0.8, hemoglobina glicada 5.5, LDL 57. Trouxe também um ecocardiograma que evidenciava diâmetros cavitários aumentados e fração de ejeção de 38%. De acordo com as classificações da IC, é correto afirmar:

A) Trata-se de uma IC estágio B e, de acordo com a classificação por fração de ejeção, reduzida.

B) Trata-se de uma IC estágio C e, de acordo com a classificação por fração de ejeção, levemente reduzida.

C) Trata-se de uma IC estágio C e, de acordo com a classificação por fração de ejeção, reduzida.

D) Trata-se de uma IC estágio B e, de acordo com a classificação por fração de ejeção, levemente reduzida

36) Está indicada quimioprofilaxia para meningoencefalite aos profissionais de saúde e contactantes diretos de casos com identificação de:

a) Listeria

b) Herpes-virus

c) Pneumococo

d) H.Influenzae B

37) Paciente de 29 anos, sem comorbidades previamente, deu entrada no HUV com quadro de sinusite bacteriana em tratamento com amoxicilina com clavulanato há cerca de 05 dias. No 5° dia de tratamento evoluiu com desorientação temporo-espacial, febre e cefaleia intensa, sendo então trazido ao pronto socorro. Ao exame paciente acordado, desorientado no tempo e no espaço, sonolento e torporoso, estável hemodinamicamente, eupneico em ar ambiente, ausência de rigidez de nuca ao exame.Assinale a alternativa que contém o provável diagnóstico do paciente, o padrão esperado do líquor e o tratamento adequado para a hipótese:

a) Meningite bacteriana -Celularidade aumentada com predomínio neutrofílico, glicose reduzida, proteína aumentada - Ceftriaxona 2 g EV 12/12 horas + dexametasona venosa.

b) Meningite bacteriana -Celularidade aumentada com predomínio neutrofílico, glicose reduzida, proteína aumentada - Ceftriaxona 2 g EV 12/12 horas + ampicilina + dexametasona venosa.

c) Meningoencefalite viral -Celularidade aumentada com predomínio linfocítico, glicose normal, proteína aumentada - Aciclovir 10 mg/kg 8/8 horas.

d) Meningite bacteriana -Celularidade aumentada com predomínio neutrofílico, glicose normal, proteína aumentada - Ceftriaxona 1 g EV 12/12 horas.

38) Uma paciente de 72 anos, com histórico de diabetes mellitus e doença renal crônica estágio 4, é admitida no hospital apresentando febre alta, calafrios, dor lombar intensa, hipotensão arterial com perfusão capilar periférica >3 segundos. Os exames laboratoriais revelam leucocitose com desvio à esquerda e culturas de urina e sangue positivas para Klebsiella pneumoniae produtora de beta-lactamase de espectro estendido (ESBL). Qual é o tratamento antibiótico empírico mais apropriado para esta paciente enquanto se aguarda os resultados de sensibilidade aos antibióticos?

A) Amoxicilina-clavulanato

B) Meropenem

C) Piperacilina-tazobactam.

D) Cefepime

39) Um paciente de 58 anos, com histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), é trazido ao pronto-socorro com queixas de dispneia intensa e sonolência. Os exames laboratoriais apresentam os seguintes resultados:- pH: 7,28- pCO2: 65 mmHg- HCO3-: 30 mEq/L. Qual é o distúrbio ácido-básico presente neste paciente?

A) Acidose metabólica

B) Alcalose metabólica

C) Acidose respiratória

D) Alcalose respiratória

40) Lúcia, 63 anos, com diagnóstico estabelecido de HAS, apresenta PA sistematicamente acima do alvo (155/100 mmHg) apesar de estar em terapia dupla com um diurético tiazídico e um inibidor da ECA. Lúcia é também obesa e sedentária. Qual é a estratégia de tratamento mais adequada para melhorar o controle da PA de Lúcia?

a) Intensificar o regime farmacológico adicionando um beta bloqueador à terapia existente.

b) Substituir o diurético tiazídico por um antagonista dos receptores da angiotensina II para potencializar o efeito anti-hipertensivo.

c) Enfatizar intervenções de estilo de vida, como perda de peso e aumento da atividade física, antes de modificar o regime de medicação.

d) Encaminhar imediatamente para avaliação cardiológica devido ao alto risco de eventos cardiovasculares.

GABARITO 2024.1.2

1. C

2. B

3. D

4. D

5. A

6. ?

7. D

8. B

9. A

10. C

11. D

12. B

13. C

14. D

15. B

16. D

17. B

18. B

19. C

20. A

21. D

22. ?

23. D

24. C

25. B

26. B

27. A

28. C

29. D

30. C

31. A

32. B

33. B

34. D

35. C

36. D

37. A

38. B

39. C

40. C

PROVA 2024.2.1

1) Paciente de 80 anos, com arteriosclerose generalizada, interna com quadro de injúria renal aguda (IRA), dez dias após realização de aortografia. Ao exame físico, notava-se livedo reticulares em membros inferiores, dedos dos pés azulados e eosinofilia. O diagnóstico mais provável é:

a) IRA pós-contraste.

b) IRA por nefrite intersticial.

c) IRA por glomerulonefrite aguda crescêntica.

d) IRA ateroembólica.

2) Mulher, 63a, com diagnóstico de cirrose alcoólica, está internada por descompesação clínica há 3 dias, com piora da ascite, oligúria e início de encefalopatia hepática. Em uso diário de espironolactona 200mg, furosemida 40mg e complexo vitamínico. Creatinina 1,7 mg/dL; (0,8 mg/dL na entrada); Líquido ascítico: hemácias= 1.300/mm³, leucócitos= 420/mm³ (62% de linfócitos, 31% neutrófilos e 7% de monócitos); proteína= 1,4 g/dL, albumina= 0,7 g/dL. O diagnóstico e a conduta são:

a) Peritonite bacteriana espontânea com disfunção renal; prescrever ceftriaxona e albumina.

b) Lesão renal aguda estágio 1; reduzir diuréticos e prescrever ceftriaxona empírico.

c) Lesão renal aguda estágio 2; suspender diuréticos e prescrever albumina humana.

d) Síndrome hepatorrenal; prescrever albumina humana e terlipressina.

3) Funcionária da limpeza de um hospital, ao torcer o esfregão, acidenta-se com agulha que se encontrava de permeio. Vem hoje para avaliação médica, cinco dias após o acidente. Não se sabe se a agulha do acidente havia sido usada em algum paciente. A profilaxia pós-exposição de HIV nesta paciente:

a) Deve ser iniciada imediatamente e mantida por um mês.

b) Deve ser considerada após resultado de sorologia negativa.

c) Deve ser iniciada imediatamente e reavaliada após resultado de sorologia.

d) Não é recomendada.

4) Um homem de 54 anos procura atendimento médico com queixa de dor ao urinar e urgência miccional. O diagnóstico de prostatite é estabelecido e a urocultura mostra crescimento de pseudomonas aeruginosa. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

a) A pseudomonas aeruginosa é responsável pela maioria dos casos de prostatite bacteriana aguda.

b) O quadro clínico geralmente é assintomático.

c) A Nitrofurantoína é o antimicrobiano de escolha nesses casos.

d) O uso de ertapenem está contraindicado.

5) Dentre as medidas de prevenção e controle da doença meningocócica, visando prevenir a ocorrência de casos secundários entre os contatos próximos de um caso suspeito, bem como prevenir casos desta doença em crianças menores de 1 ano, a quimioprofilaxia tem sido considerada uma medida eficaz. Nesta importante ação, o antibiótico de escolha preconizado é a:

a) Doxiciclina

b) Rifampicina

c) Azitromicina

d) Ampicilina

6) Márcio Augusto, 80 anos, é levado pelo filho ao geriatra pois há alguns meses vem apresentando anedonia e esquecimentos. Não lembra o dia da semana ou onde guardou as chaves e outros pertences. Nega outros sintomas, porém relata que não tem mais vontade de sair de casa e fazer coisas que antes lhe davam prazer, porém acha natural já que a idade não permite mais tantas aventuras. É hipertenso e diabético. Era professor de universidade e aposentou-se aos 60 anos. Recusou-se a realizar o miniexame do estado mental quando solicitado pelo médico. Diante desse caso, é CORRETO afirmar:

a) Pode-se afirmar que se trata de demência vascular, sendo necessária a solicitação de exames complementares que descartem causas reversíveis de demência.

b) É importante a realização de ferramenta de avaliação para síndrome depressiva e a recusa da realização do MEEM eleva a suspeição sobre a condição.

c) Trata-se de transtorno cognitivo leve de modo que se deve ajustar o tratamento das doenças crônicas e não há necessidade de outros exames.

d) O paciente apresenta sintomas comuns que antecedem a doença de Parkinson e deve-se iniciar levodopa.

7) Sra Marta, 62 anos, advogada aposentada, procura o seu consultório por queixa de memória. Relata que se distrai facilmente e vem esquecendo onde guarda objetos e panelas no fogão. No momento, está em tratamento de Transtorno de Ansiedade Generalizada com Sertralina 100 mg/dia prescrita por psiquiatra assistente. Nos testes cognitivos, apresentou os seguintes resultados:

- Montreal Cognitive Assessment (MoCA): 30/30

Sobre o caso apresentado, qual o diagnóstico da paciente?

a) Declínio Cognitivo Subjetivo

b) Comprometimento Cognitivo leve

c) Transtorno Neurocognitivo Maior leve

d) Transtorno Neurocognitivo Maior moderado

8) Idosa de 84 anos é atendida em serviço de urgência com relato de sonolência e hiporexia há 4 dias. É portadora de HAS, osteoporose grave de joelhos e asma e vem com tosse seca há 1 semana após relato de contato com animal de estimação da neta. A filha vem usando broncodilatadores de rotina e iniciou por conta própria Prednisona 20mg ao dia há 2 dias, sem melhora clínica. Ao exame, encontra-se desorientada e sonolenta, FR 28ipm, SO2 94%, FC 98bpm, PA 120x60mmHg. Na ausculta respiratória, percebe-se estertores em ⅓ inferior de HTE. Realizado Rx de tórax com

presença de infiltrado/consolidação em terço médio de hemitórax esquerdo. Sobre esse caso, assinale a afirmativa correta:

a) O quadro clínico e a imagem são sugestivos de pneumonia, mesmo que a paciente não apresente sintomas clássicos de tosse produtiva, febre e dor torácica.

b) Como a paciente é portadora de asma e não melhorou com o uso de Prednisona, deve ficar internada para realizar fisioterapia respiratória e corticóide venoso.

c) Deve-se considerar a possibilidade de neoplasia pulmonar devido à imagem que sugere processo expansivo em hemitórax esquerdo.

d) A paciente deve ficar internada para realizar uma tomografia de tórax com protocolo para TEP e iniciar anticoagulação de imediato.

9) Idosa de 76 anos vem para consulta após se recuperar de cirurgia de correção de fratura de fêmur esquerdo. Relata que a fratura ocorreu após queda da própria altura ao sair do banho e escorregar no tapete. O ortopedista orientou a buscar orientação sobre tratamento de osteoporose. Traz Densitometria óssea (DMO) com DP -2,7 em L1-L4 e DP - 2,4 em fêmur total. Baseado no caso, marque a alternativa correta:

a) A paciente tem diagnóstico de Osteoporose de coluna lombar e osteopenia de fêmur, o que indica que a fratura de fêmur não deve ter sido causada por fragilidade óssea.

b) O fato da paciente ter apresentado fratura de fêmur após trauma de baixo impacto já indicaria tratamento farmacológico para osteoporose independente do resultado da DMO.

c) O T score reflete a comparação da massa óssea do idoso com indivíduos da mesma faixa etária

d) Obesidade, tabagismo e uso de corticóide são fatores de risco para osteoporose.

10) Idoso 78 anos vem para consulta por insistência dos filhos, que relatam episódios de dificuldade para realizar atividades habituais, como se perder em caminhos próximos de casa e cuidar de finanças, realizando pagamentos em duplicidade ou esquecendo as datas de vencimento. No restante, mantém uma conversa normal, lembrando dos familiares e amigos e atividades sociais sem prejuízo. O paciente queixa-se apenas de sonolência durante o dia e sua esposa diz que ele vem com o sono muito agitado à noite, por vezes com gritos e movimentos bruscos. Apresentou 2 quedas nos últimos 3 meses, sem causa aparente, por tropeços em trajetos já conhecidos. Em relação ao caso, podemos afirmar:

A) O fato do paciente manter a memória pouco alterada e ter episódios evidentes e flutuantes de prejuízo executivo e de atenção (se perder e manejar finanças), além de quedas e queixas relacionadas ao sono, faz pensar em Demência por corpos de Lewy como diagnóstico mais provável.

B) Como o paciente mantém a memória e linguagem preservadas, não podemos pensar em diagnóstico de demência.

C) O fato do paciente apresentar queixas de sonolência diurna indica a exclusão de apnéia do sono como principal hipótese diagnóstica antes de pensar em quadro demencial.

D) Como o paciente não tem relato de tremor ou rigidez, a hipótese de demência por corpos de Lewy está afastada.

11) Um paciente masculino de 63 anos, com histórico de hipertensão e tabagismo, relata episódios recorrentes de dor torácica nos últimos 8 meses. Ele descreve a dor como uma pressão central no peito, que surge situações do seu dia a dia como caminhar por distâncias superiores a 200 metros ou ao subir escadas; e que melhora completamente após 5 a 10 minutos de repouso. A dor não apresenta irradiação porém vem sempre acompanhada de dispneia. Durante a avaliação na emergência, o exame físico revela um paciente estável, com pressão arterial de 135/85 mmHg e frequência cardíaca de 78 bpm. O eletrocardiograma realizado em repouso não mostra alterações.

Considerando a história clínica do paciente qual é a alternativa correta com relação ao quadro descrito:

A) A dor é do tipo B, trata-se de uma angina estável classe I da CCS, com sinais de congestão venosa sistêmica

B) A dor é do tipo A, trata-se de uma angina estável classe II da CCS, com sinais de congestão atrial esquerda e venocapilar

C) A dor é do tipo B, trata-se de uma angina instável classe II da CCS, com sinais de congestão atrial esquerda e venocapilar

D) A dor é do tipo A, trata-se de uma angina instável classe I da CCS, com sinais de congestão venosa sistêmica

12) Um paciente masculino de 62 anos, tabagista e diabético, comparece à emergência com queixa de dor torácica em aperto, irradiando para o braço esquerdo, iniciada há 3 horas. A dor surgiu em repouso, sem relação com esforço físico, e persistiu sem melhora após uso de nitrato sublingual. O paciente relata episódios similares nas últimas semanas, mas sempre desencadeados por esforço e aliviados pelo repouso. No exame físico, ele apresenta-se ansioso, com pressão arterial de 150/90 mmHg e frequência cardíaca de 100 bpm. O eletrocardiograma mostra inversão de onda T nas derivações inferiores, mas sem supradesnivelamento do segmento ST. A troponina I foi dosada em 0,7 ng/mL (valor de referência: <0,04 ng/mL). Com base no quadro clínico do paciente e nos exames complementares, qual a melhor conduta terapêutica a ser adotada neste momento?

A) Iniciar tratamento com enoxaparina, clopidogrel e betabloqueador, e encaminhar para coronariografia o mais rápido que puder dentro de 24 a 48h

B) Administrar nitroglicerina intravenosa, associada a ácido acetilsalicílico e clopidogrel, e adiar a realização de coronariografia, monitorando o paciente por pelo menos 7 dias.

C) Prescrever heparina não fracionada e iniciar terapia trombolítica devido à elevação de troponina, aguardando resposta antes de considerar angiografia.

D) Iniciar tratamento com ácido acetilsalicílico, betabloqueador e nitrato sublingual, sem necessidade de coronariografia imediata, optando por monitoramento clínico rigoroso.

13) Sr. João, 75 anos, procura a emergência do HUV por conta de súbita elevação da pressão arterial. Hoje, em uma medida de rotina percebeu a PA = 190/120 mmhg e ficou assustado com a medida motivo pelo qual procurou a emergência. HPP: hipertenso há 20 anos. Em uso de Losartana e Metoprolol, refere que está sem usar Metoprolol há 2 dias pois não encontrou o medicamento na farmácia. Exames de rotina: LDL= 50 mg/dl – HDL = 70 mg/dl - Glicemia= 80 mg/dl – Creatinina= 2,5 mg/dl (nornal =1,3 mg/dl). Trouxe consigo uma série de exames anteriores que apresentam o mesmo padrão do exame atual. PA na chegada a emergência= 190/120 mmHg. Avalie as afirmativas abaixo sobre o caso:

I- O paciente apresenta dois fatores de risco associados que permitem o desenvolvimento de crise hipertensiva (CH)

II- A aferição da PA = 160/100 mmhg em uma segunda medida, permite uma alta segura, sem uso de medicamentos dentro da unidade de emergência.

III- O paciente deve ficar internado para segurança e melhor definição do caso.

Marque a afirmativa correta:

a) apenas I está correta

b) apenas II está correta

c) I e II estão corretas

d) I e III estão corretas

14) Um paciente com diagnóstico de insuficiência cardíaca, procura seu ambulatório para retornar acompanhamento cardiológico. Paciente assintomático, porém interrompeu por conta própria todas as medicações que fazia uso. Paciente HAS, DLP. Nega outras comorbidades. Ecocardiograma transtorácico com Fe= 34%.

Qual seria a prescrição inicial visando diminuir a mortalidade deste paciente?

a) Sacobutril Valsartana, Bisoprolol e espironolactona

b) Losartan, furosemida e espironolactona

c) Enalapril , Losartan e espironolactona

d) Furosemida , Propranolol e Enalapril

15) Mulher de 72 anos, advogada, HAS e com artrite gotosa, apresenta queixa de “esquecimentos” há dois anos. Refere que necessita fazer mais anotações que o comum para se lembrar de compromissos e tem a impressão de ter se tornado mais repetitiva. Nega declínio da funcionalidade. Refere dificuldade no seu ofício como advogada e as vezes esquece de tomar alguns remédios. Miniexame do estado mental: 28/30 pontos (errou o dia do mês e esqueceu uma palavra). Pela persistência da queixa, foi realizada avaliação neuropsicológica, que evidenciou comprometimento de memória episódica e demais funções cognitivas com desempenho adequado. Assinale a hipótese diagnóstica mais provável.

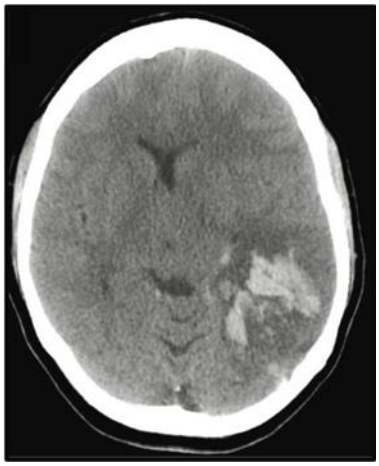
a) Doença de Alzheimer leve

b) Comprometimento cognitivo leve

c) Doença dos corpúsculos de Lewy

d) Hidrocefalia normobárica

16) Você é o plantonista de clínica médica de sobreaviso do hospital municipal. A enfermagem te chama para avaliar de emergência um paciente masculino de 54 anos que “rebaixou”. Possui diagnóstico de acidente vascular encefálico isquêmico há 12 horas, onde foi trombolisado dentro das 4,5h com alteplase sem problemas. No momento, evolui com Glasgow 9 (Glasgow de entrada 15) e piora do NIHSS 22 (NIHSS de entrada 8). Sua PA no momento é 175/95 mmHg, Tax 36,8c, FC:102 bpm, FR: 19 irpm, Sat 02 96% e HGT 75 mg/dL. A TC de crânio sem contraste de entrada foi normal e a TC de crânio sem contraste agora (vide foto)



Conduta imediata:

a) Crioprecipitado

b) Ceftriaxone

c) Nitroprussiato de sódio

d) Clopidrogrel + AAS

17) Mulher de 18 anos, com antecedentes de crise convulsiva febril aos 3 anos de idade, chega ao seu ambulatório com história de que apresentou quadro de sensação de frio na barriga que logo evolui com perda da consciência e movimentos tonico-clonicos generalizados. O paciente não estava em uso de medicamentos, tinha atividades básicas diárias normais, não tinha queixa de outros sintomas precedendo o quadro. Diante do exposto, qual seria a conduta mais apropriada:

a) Solicitar RM de crânio e não iniciar antiepiléptico

b) Solicitar TC de crânio com contraste e iniciar anticonvulsivante

c) Iniciar Ácido valproico

d) Iniciar Amitriptilina

18) Sobre a sífilis secundária, qual das seguintes afirmações é correta?

A) A sífilis secundária pode apresentar uma erupção macular eritematosa no tronco e nas palmas das mãos, além de condilomas planos na área anogenital.

B) A sífilis secundária é caracterizada pela presença de gomas sifilíticas na pele e nas mucosas.

C) Apesar dos sintomas cutâneos, a sífilis secundária não cursa com sintomas sistêmicos.

D) A sífilis secundária ocorre geralmente de um a cinco anos após a cicatrização do cancro duro.

19) Na amostra de secreção traqueal colhida de um paciente com pneumonia associada a ventilação mecânica, houve crescimento de Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. Dos antibióticos listados abaixo, qual seria indicado para esse caso?

A) Daptomicina

B) Cefazolina

C) Piperacilina/tazobactam

D) Linezolida

20) Homem, 70 anos, com história de bronquiectasias e doença pulmonar obstrutiva crônica, procura atendimento com queixa, de 2 dias de evolução, de febre, tosse produtiva com expectoração amarelada e dispneia aos esforços. Ao exame: frequência respiratória de 28 irpm, ausculta pulmonar com presença de sibilos difusos e estertores creptantes em base de HTE, acordado, orientado no tempo e espaço, frequência cardíaca 100 bpm, pressão arterial: 100 X 62 mmHg, restante do exame físico sem achados significativos. Pelos exames complementares: leucocitose com desvio à esquerda, aumento de ureia= 70 mg/dl e Rx de tórax com condensação em 1/3 inferior de hemitórax esquerdo. Marque a opção que apresenta a correta classificação pelo CURB 65 e a correta conduta terapêutica.

A) CURB 65= 1, tratamento ambulatorial com Azitromicina.

B) CURB 65= 2, tratamento em enfermaria com Levofloxacina.

C) CURB 65=2, tratamento em enfermaria com ceftriaxona + Azitromicina

D) CURB 65= 3, tratamento em enfermaria, com amoxicilina/ ácido clavulânico + azitromicina

21) Mulher de 70 anos de idade, em D10 de internação em unidade coronariana, apresenta febre de foco indeterminado com cateter vesical de demora (D10). Hoje, ela evolui com sinais de sepse, porém sem choque. Na urinocultura, houve crescimento de Escherichia coli= 100.000 (105) ufc produtora de beta-lactamase de espectro estendido (ESBL). Pelo uso racional dos antibióticos, qual seria o tratamento mais adequado pera este caso?

A) Ceftriaxona

B) Amoxicilina/ clavulanato

C) Ertapenem

D) Piperacilina/ Tazobactam

22) Na urinocultura de uma mulher de 30 anos de idade, internada na enfermaria de um hospital há 7 dias, em uso de cateter vesical de demora (D7), houve crescimento de Candida albicans. Ela não apresenta sinais e sintomas de infecção. Qual a conduta correta para esse caso?

A) Retirar ou trocar o cateter vesical e tratar com Fluconazol

B) Retirar ou trocar o cateter e repetir a cultura. Se novamente positiva, tratar com fluconazol se ela estiver em pré-operatório de cirurgias urológicas ou grávida.

C) Retirar ou trocar o cateter vesical e tratar com Anfotericina B

D) Manter o cateter vesical e tratar com anfotericina B.

23) Uma mulher vítima de violência sexual com penetração vaginal, sem o uso de preservativo, comparece ao posto de saúde 24h após o abuso. O teste rápido para HIV realizado na vítima foi não reagente (negativo). Além do acolhimento e das condutas referentes à prevenção de gravidez e das infecções pelo HPV e vírus da hepatite B, qual a conduta correta nesse caso?

A) Prescrever Zidovudina (AZT) + Lamivudina (3TC) + Darunavir + Ritonavir (DRV+RTV) para profilaxia pós exposição (PEP) ao HIV, Penicilina Benzatina 2.400.000u para profilaxia de sífilis, Ceftriaxona 1g + azitromicina 1g para profilaxia de uretrites e Metronidazol 2g para profilaxia de tricomoníase.

B) Prescrever Penicilina Benzatina 2.400.000u para profilaxia de sífilis, Ceftriaxona 1g + azitromicina 1g para profilaxia de uretrites e Metronidazol 2g para profilaxia de tricomoníase. Não há necessidade de prescrever profilaxia pós exposição ao HIV, uma vez que o teste rápido para HIV da vítima foi não reagente.

C) Prescrever Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) + Dolutegravir (DTG) para profilaxia pós exposição (PEP) ao HIV, Penicilina Benzatina 2.400.000u para profilaxia de sífilis, Ceftriaxona 1g + azitromicina 1g para profilaxia de uretrites e Metronidazol 2g para profilaxia de tricomoníase.

D) Prescrever Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) + Dolutegravir (DTG) para profilaxia pós exposição (PEP). Em relação à prevenção das outras infecções sexualmente transmissíveis (IST), deve-se fazer o acompanhamento da vítima. Ao longo do acompanhamento, caso ela apresente alguma manifestação clínica ou laboratorial de IST, realizamos o tratamento.

24) Pessoa vivendo com HIV/ AIDS com baixa adesão ao tratamento antirretroviral e contagem de linfócitos TCD4 < 100 células/ ml comparece à emergência com história de cefaleia, náusea e vômitos que se iniciaram há 72h. Hoje apresentou rebaixamento importante do nível de consciência. A tomografia computadorizada de crânio não evidenciou alterações e, pelo exame do líquor, se observou a presença de Cryptococcus neoformans. Qual a conduta terapêutica correta para este caso?

A) Iniciar a terapia antirretroviral com tenofovir (TDF)+ lamivudina (3TC) + dolutegravir (DTG). Cerca de 15 dias após início de terapia antirretroviral, iniciar tratamento para meningite criptocócica com Sulfametoxazol-trimetoprim.

B) Iniciar, ao mesmo tempo, o tratamento para meningite criptocócica com Anfotericina B+ fluconazol e tratamento antirretroviral com tenofovir (TDF)+ lamivudina (3TC) + dolutegravir (DTG).

C) Iniciar o tratamento para meningite criptocócica com Anfotericina B+ fluconazol. Cerca de 4 a 6 semanas após início do tratamento para meningite criptocócica, iniciar terapia antirretroviral com tenofovir (TDF)+ lamivudina (3TC) + dolutegravir (DTG).

D) Iniciar tratamento para meningite criptocócica com Sulfametoxazol-trimetoprim. Cerca de 15 dias após início do tratamento para meningite criptocócica, iniciar terapia antirretroviral com tenofovir (TDF)+ lamivudina (3TC) + dolutegravir (DTG).

25) Homem de 40 anos de idade, em acompanhamento na clínica da família, recebe diagnóstico de tuberculose pulmonar e infecção pelo HIV. Foi, então, iniciado rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol (RIPE) e solicitado carga viral do HIV e contagem de linfócitos TCD4, além de outros exames complementares. Os resultados chegaram 15 dias após o início do RIPE e mostraram carga viral do HIV= 100.000 cópias/ ml e contagem de CD4= 150 células/ ml. Qual a conduta correta neste momento?

A) Início de Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) + dose usual de Dolutegravir (DTG) e início de sulfametoxazol-trimetoprim diário para profilaxia de neurotoxoplasmose

B) Início de Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) + dose dobrada de Dolutegravir (DTG) e início de sulfametoxazol-trimetoprim, três vezes por semana, para profilaxia de pneumocistose.

C) Início de Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) + dose usual de Dolutegravir (DTG) e início de sulfametoxazol-trimetoprim, três vezes por semana, para profilaxia de pneumocistose.

D) Início de Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) + dose dobrada de Dolutegravir (DTG) e início de sulfametoxazol-trimetoprim diário para profilaxia de neurotoxoplasmose

26) Um homem de 30 anos de idade vivendo com HIV/ AIDS faz uso irregular de antirretrovirais e apresenta contagem de carga viral do HIV= 5.000 cópias/ ml. Ele é casado com uma mulher soronegativa para HIV. Qual a melhor conduta para a esposa em relação à prevenção do HIV?

A) Uso de profilaxia pós exposição com Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) + Dolutegravir (DTG)

B) Uso de profilaxia pré exposição com Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) + Dolutegravir (DTG)

C) Uso de profilaxia pré exposição com Tenofovir (TDF) + Emtricitabina (FTC)

D) Uma vez que o marido faz uso de antirretrovirais, não está indicado o uso de profilaxias pré ou pós exposição.

27) Um homem de 30 anos de idade, morador de Vassouras, procura a emergência com história de 3 dias de evolução de febre alta de início súbito, hiporexia, cefaleia e mialgia. Refere que teve contato com água de enchente há aproximadamente 10 dias. Ao exame, queixou de dor principalmente nas panturrilhas. Encontrava-se normotenso e não apresentava sangramentos, icterícia, lesões de pele e nem disfunções de órgãos. No exame de hemograma completo, se observou hematócrito normal, discreta leucocitose sem desvio à esquerda e discreta plaquetopenia. Diante deste quadro de doença febril aguda, qual seria a conduta mais correta?

A) Acompanhamento ambulatorial com prescrição de hidratação oral e sintomáticos.

B) Acompanhamento ambulatorial com prescrição de doxiciclina, hidratação oral e sintomáticos.

C) Internação em enfermaria com prescrição de ceftriaxona, hidratação venosa e sintomáticos

D) Internação em enfermaria com prescrição de hidratação venosa e sintomáticos.

28) Paciente de 21 anos de idade, sem comorbidades, é levado à emergência no 5º dia de evolução da doença, apresentando febre alta de início súbito iniciada há 5 dias, mialgia, cefaleia retro orbital, astenia e 01 episódio de vômito. Exame físico sem alterações significativas. Pelo exame do hemograma completo, observou-se plaquetopenia discreta e aumento do hematócrito. Não apresentava sangramentos, sinais de choque e sinais de comprometimento grave de órgãos. Tratando-se de suspeita de Dengue, qual seria a conduta correta para este caso?

A) Hidratação oral e acompanhamento ambulatorial

B) Hidratação venosa e internação em enfermaria

C) Hidratação venosa e internação em leito de terapia intensiva

D) Hidratação venosa e acompanhamento ambulatorial

29) Homem, 54 anos, bombeiro hidráulico, morador de Vassouras, sem história de vacinação para Febre Amarela, dois dias após regressar de Manaus- AM, apresentou febre alta de 39º, mialgia, cefaleia e hiporexia. No 5º dia de doença foi levado ao hospital com piora do estado geral e manifestação de icterícia e epistaxe. Exames da admissão: Hemograma: anemia, plaquetopenia e leucopenia. Bioquímica: transaminases hepáticas aumentadas em 5 vezes o valor de referência, bilirrubinas aumentadas, ureia e creatinina aumentadas, potássio aumentado. VHS normal. Pesquisa de gota espessa de sangue negativa. Pelos dados apresentados, qual seria sua principal hipótese diagnóstica?

A) Leptospirose

B) Febre Amarela

C) Zika

D) Malária

30) Um paciente permanece com artralgia crônica três meses após ter tido febre por Chikungunya. Na crise atual, ele está em uso de anti-inflamatório não hormonal por 10 dias, porém não houve melhora da dor. Qual medicação deve ser prescrita para alívio da dor do paciente neste momento?

A) Manter anti-inflamatório não hormonal até completar 30 dias

B) Substituir por um corticoide

C) Não se deve prescrever anti-inflamatórios para artralgia por Chikungunya. Deve-se substituir para analgésicos comuns e, caso não melhore, prescrever opioides.

D) Substituir por hidroxicloroquina

31) Um paciente de 30 anos procura atendimento médico por quadro de erupção cutânea máculo-papulosa no tronco e nas palmas das mãos, além de lesões condilomatosas na área anogenital. Refere ter tido ulceração indolor no pênis há aproximadamente 3 meses e que desapareceu sem tratamento. Exame laboratorial confirma diagnóstico de Sífilis. Qual estágio da doença ele se encontra atualmente?

A) Sífilis Secundária

B) Sífilis Primária

C) Sífilis Terciária

D) Sífilis Latente recente

32) Paciente foi diagnosticado com hanseníase tuberculóide e mostrou preocupação com o diagnóstico, em relação à sua família, uma vez que mora com sua mãe de 80 anos e seus filhos de 7 e 12 anos. Qual a orientação correta a ser passada para o paciente?

A) Todos os contatos devem ser examinados e receber uma dose da vacina BCG, de acordo com seu histórico vacinal, caso seja descartada hanseníase.

B) Não é necessário examinar a família pois a forma de hanseníase que ele apresenta, não é contagiosa.

C) A mãe do paciente deve ser examinada e receber duas doses da BCG, não sendo necessário examinar as crianças.

D) Deve ser realizada a baciloscopia do raspado intradérmico em todos os contatos que habitam com o paciente, independente da forma clínica do paciente.

33) ACRV, 36 anos. Residente na cidade do Rio de Janeiro. Queixa de mancha na perna há mais de 2 anos, e que percebe que o local é menos sensível ao toque. Na história familiar, seus avós tinham lesões semelhantes que foram tratadas no posto de saúde. Ao exame, tinha placa, com as bordas nítidas e eritematosas na perna direita, com centro

hipocrômico, medindo 10 x 10 centímetros de diâmetro. A lesão é bem delimitada e a baciloscopia foi negativa. O teste de sensibilidade tátil estava bastante alterado na lesão. Após o seu diagnóstico e classificação desta forma de hanseníase, o tratamento adequado a ser proposto é:

A) Rifampicina + Clofazimina + Dapsona mensal supervisionada e dose diária autoadministrada de Clofazimina + Dapsona: tratamento por 6 meses.

B) Rifampicina + Clofazimina mensal supervisionada e dose diária autoadministrada de Clofazimina + Dapsona: tratamento por 12 meses

C) Rifampicina + Clofazimina + Dapsona mensal supervisionada e dose diária autoadministrada de Clofazimina + Dapsona: tratamento por 12 meses

D) Clofazimina + Dapsona mensal supervisionada e dose diária autoadministrada de Clofazimina + Dapsona: tratamento por 6 meses

34) Paciente de 55 anos de idade, fototipo III, procurou atendimento devido a pinta na perna que está crescendo e se tornando escura, com evolução de 2 anos. Nega dor ou prurido no local. Avó materna com histórico de câncer de pele carcinoma basocelular. Ao exame observa-se mácula hipercrômica, de bordas irregulares, superfície com textura irregular, diferentes tonalidades, variando do castanho-claro ao tom enegrecido, com 1,0 cm, em panturrilha direita. Assinale a principal hipótese diagnóstica do caso.

A) ceratoacantoma

B) melanoma extensivo superficial

C) carcinoma basocelular

D) nevo melanocítico

35) Paciente de 60 anos vem ao consultório do urologista acompanhado de sua esposa, refere diminuição do jato urinário, noctúria e esforço miccional. O paciente é hipertenso e diabético controlado com medicação. Quais os exames complementares indicados para este paciente?

A) USG de vias urinárias e ressonância prostática multi paramétrica

B) Psa (antígeno prostático específico) e ultrassom de próstata

C) Psa e ressonância prostática multi paramétrica

D) Ultrassom (USG) de próstata e creatinina

36) Paciente 58 anos, masculino, portador de hipertensão arterial de longa data (>20 anos), retinopatia hipertensiva grau 2 e hipertrofia do ventrículo esquerdo, está em acompanhamento no ambulatório de nefrologia após detectar albuminúria moderadamente aumentada e queda da taxa de filtração glomerular. TFGe (CKE-EPI) 38ml/min/1,73m2. Em consulta possui níveis tensionais de 160 x 90 mmHg, assintomático. Sem edema. Potássio controlado.Uso atual de: losartana 50mg 12/12h, anlodipino 10mg/dia, clortalidona 25mg/dia e dapagliflozina 10mg/dia.Qual ajuste devemos fazer considerando que todas as medidas não farmacológicas estão sendo seguidas?

A) Adicionar espironolactona ao esquema

B) Aumentar a dose de losartana

C) Adicionar enalapril

D) Adicionar furosemida

37) Qual é a principal abordagem terapêutica para o tratamento da anemia na doença renal crônica?

A) Suplementação dietética de ferro

B) Suplementação de ácido fólico

C) Administração de eritropoietina

D) Transfusões sanguíneas frequentes

38) JBT, masculino, 11 anos, trazido para acompanhamento após diagnóstico de glomerulonefrite pós-estreptocócica há 3 semanas. No momento já se encontra normotenso para idade, sem edema, bom estado geral. Qual dos parâmetros a seguir deve ser mantido sob vigilância pelas próximas 5 semanas, eem caso de queda sustentada além desse período deverá levar à realização de biópsia renal?

A) ASLO

B) C3

C) C4

D) CH50

39) J.A.D., 35 anos, proveniente de São Luiz no Maranhão, foi encaminhado ao serviço de hepatologia da UFRJ por ter sido diagnosticado como portador do vírus da hepatite B, por provável via de transmissão materno-fetal. Realizou provas de função hepática e sorologia que mostraram: HBsAg positivo, HBeAg positivo, anti-HBc IgG positivo, PCR-DNA quantitativo com carga viral de 3.000.000 UI/mL e enzimas hepáticas discretamente e continuamente aumentadas (3x o valor normal). Assinale a alternativa correta com relação ao caso.

A) portador de hepatite crônica B sem replicação viral, com indicaçãode tratamento antiviral

B) portador de hepatite crônica B replicativa, com indicação de tratamento antiviral

C) portador de cicatriz vacinal para hepatite B, sem indicação de tratamento

D) portador de cicatriz sorológica, porém pela presença de carga viral detectável tem indicação de tratamento

40) Mulher de 45 anos, IMC:36Kg/m2, com pai e mãe portadores de DM tipo 2, procurou atendimento ambulatorial para consulta de rotina. Trouxe exames laboratoriais que revelaram: glicemia de jejum = 115mg/dl; e HbA1c = 6%. Os mesmos exames foram repetidos e revelaram: glicemia de jejum = 118mg/dl; e HbA1c = 6,1%; e TOTG com 75g de glicose anidra = 155mg/dl. Além da mudança no estilo de vida, qual a conduta para esta paciente?

a) Inibidor SGLT2

b) Expectante

c) Glicazida

d) Metformina

GABARITO 2024.2.1

1. D
2. C
3. D
4. D
5. B
6. B
7. A
8. A
9. B
10. A
11. B
12. A
13. B
14. A
15. B
16. A
17. A
18. A
19. D
20. B
21. C
22. B
23. C
24. C
25. B
26. C
27. B
28. B
29. B
30. B

31. A

32. A

33. A

34. B

35. B

36. A

37. C

38. B

39. B

40. D

PROVA C.M. 2024.2.2

1. Mulher, 68 anos, apresentando quadro de limitação funcional dos dedos das mãos e dor lombar crônica, com dificuldade em desempenhar seus afazeres domésticos devido a dor. Você identifica comprometimento das articulações interfalangianas distais, hiperlordose e dor a palpação de coluna lombar e pensa, prioritariamente, no diagnóstico de:

a) Osteoartrite.

b) Lúpus eritematoso sistêmico.

c) Artrite reumatoide

d) Mieloma Múltiplo.

2. Paciente de 68 anos com diagnóstico de Insuficiência cardíaca (no eco fração de ejeção de 38%) apresentado melhora clínica e não tem congestão nem pulmonar e nem sistêmica. Qual das seguintes opções representa o tratamento medicamentoso adequado para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, buscando prolongar a estabilização e o aumento da sobrevida do paciente, segundo as diretrizes recomendadas?

a) Betabloqueador, diurético tiazídico, inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA) e digoxina.

b) Betabloqueador, antagonista do receptor de angiotensina e neprilisina (ARNI), antagonista dos receptores mineralocorticoides (ARM) e inibidor de SGLT2.

c) Inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA), antagonista dos receptores mineralocorticoides (ARM), inibidor de SGLT2 e bloqueador do canal de cálcio.

d) Diurético de alça, antagonista do receptor de angiotensina e neprilisina (ARNI), betabloqueador e nitrato.

3) Adolescente de 15 anos, sexo feminino, vem a consulta devido a episodio de perda de consciência ocorrido há 15 dias, que durou 5 minutos. Segundo testemunha, o episodio foi sem sintomas premonitórios, houve cianose labial e abalos musculares rápidos (clônias). Nega salivação, liberação esfincteriana e mordedura de língua. Houve certa confusão mental pós-evento, durando cerca de 15 minutos. História patológica pregressa e familiar sem doenças. Sobre o caso, a conduta deverá ser:

a) Iniciar Amitriptilina e reavaliar em 30 dias

b) Solicitar ecocardiograma e eletrocardiograma

c) Iniciar Valproato de sódio e reavaliar em 60 dias

d) Solicitar ressonância magnética e eletroencefalograma

4) Homem de 69 anos apresenta quadro de bradicinesia, iniciado há 6 meses, com lentidão dos movimentos e dificuldade para amarrar os sapatos. Ao caminhar, apresenta passos mais curtos e sensação de instabilidade. Concomitantemente, apresenta tremores nas mãos, de repouso, associado a rigidez, além de alteração olfativa, constipação intestinal de 3 dias e alteração do padrão do sono. Nega alterações do humor e cognição. No exame físico, o paciente apresenta bom estado geral, marcha com inclinação anterior lenta e arrastada, diminuição dos movimentos dos braços, tremores assimétricos das mãos e hipertonia em roda dentada. Ressonância magnética realizada há 2 semanas constatou: redução da espessura pars compacta mesencefálica e maior grau de hiposinal nos núcleos da base, com atrofia cerebral difusa.

A principal hipótese diagnóstica nesse caso é:

a) Demência vascular

b) Tremor essencial

c) Doença de Parkinson

d) Hidrocefalia normobárica

5) Um paciente de 60 anos, hipertenso e diabético, assintomático, pretende iniciar atividade física aeróbia e solicitou um atestado médico para frequentar a academia. Em qual das opções abaixo encontramos uma afirmativa ideal sobre como proceder na continuidade da investigação de risco desse paciente.

a) solicitar ecocardiograma de repouso e em caso de disfunção segmentar solicitar um teste de esforço

b) solicitar ecocardiograma de repouso, se normal, solicitar um teste de esforço

c) solicitar ecocardiograma de repouso, se normal, solicitar cateterismo

d) solicitar cateterismo, se normal, solicitar cintilografia miocárdica

6) Um paciente masculino de 63 anos, com histórico de hipertensão e tabagismo, relata episódios recorrentes de dor torácica nos últimos 8 meses. Ele descreve a dor como uma pressão central no peito, que surge situações do seu dia a dia como caminhar por distâncias superiores a 200 metros ou ao subir escadas; e que melhora completamente após 5 a 10 minutos de repouso. A dor não apresenta irradiação porém vem sempre acompanhada de dispneia. Durante a avaliação na emergência, o exame físico revela um paciente estável, com pressão arterial de 135/85 mmHg e frequência cardíaca de 78 bpm. O eletrocardiograma realizado em repouso não mostra alterações.

Considerando a história clínica do paciente qual é a alternativa correta com relação ao quadro descrito:

a) A dor é do tipo B, trata-se de uma angina estável classe I da CCS, com sinais de congestão venosa sistêmica

b) A dor é do tipo A, trata-se de uma angina estável classe II da CCS, com sinais de congestão atrial esquerda e venocapilar

c) A dor é do tipo B, trata-se de uma angina instável classe II da CCS, com sinais de congestão atrial esquerda e venocapilar

d) A dor é do tipo A, trata-se de uma angina instável classe I da CCS, com sinais de congestão venosa sistêmica

7) Um paciente portador de insuficiência cardíaca, decorrente de uma insuficiência valvar mitral e acompanhamento regular no ambulatório de cardiologia, apresentava boa evolução clínica em classe funcional I da NYHA. Há uma semana vem queixando-se dispneia aos pequenos esforços como tomar banho. PA= 90/70 mmHg FC= 115 bpm. Ritmo cardíaco irregular em 3T com B3 de VE e VD. No exame laboratorial percebemos a presença de disfunção renal

Analise as afirmativas abaixo sobre o caso acima:

I- Na diástole houve redução em 30% do enchimento atrial que gerou a queixa de dispneia
II- O fator descompensador do quadro diminuiu o débito renal
III- O pulso arterial desse paciente apresenta características que nos levam a pensar no provável fator etiológico da descompensação cardíaca

Podemos afirmar que:

a) Apenas a afirmativa I está correta

b) Apenas a afirmativa II está correta

c) As afirmativas I e II estão corretas

d) Todas as afirmativas estão corretas

8) Um paciente portador de insuficiência cardíaca, com episódios de dispneia aos mínimos esforços e durante o sono, dormindo com 4 travesseiros, procurou a emergência do hospital para internação. Apresenta-se com edema até terço médio das coxas bilateralmente. Pulso venoso com sinal de Kussmaul. Enchimento capilar de 5s. Precórdio com ictus no sexto espaço intercostal na linha axilar anterior e com 3 polpas digitais. Ritmo cardíaco regular em 3T com B3 de VE.

Com relação ao caso avalie as afirmativas abaixo:

I- A classe funcional do paciente é IV da NYHA
II- O paciente hemodinamicamente é do tipo quente e úmido
III- O modelo de IC identificado é esquerda
IV- Ao ecocardiograma provavelmente teremos uma FE < 40% Podemos afirmar que:

a) apenas as afirmativas I e II estão corretas

b) apenas as afirmativas II e III estão corretas

c) apenas as afirmativas III e IV estão corretas

d) apenas as afirmativas I e IV estão corretas

9) Uma mulher de 72 anos há 6 meses anda mais devagar e seu tom de voz está mais baixo. Seu marido reclama que ela está falando enquanto dorme e o chuta várias vezes. Alguns dias, ela fica mais distraída e apresentou duas quedas nos últimos 2 meses. Há 4 semanas tem dito que uma criança fica entrando na sua casa e correndo na sala. No MEEM, o desempenho na cópia dos pentágonos entrelaçados foi particularmente ruim em comparação aos outros domínios cognitivos. Assinale a hipótese diagnóstica para o caso descrito.

A) Demência vascular

B) Demência de Alzheimer

C) Demência frontotemporal

D) Demência de corpo de Lewy

10) Em paciente com doença de Alzheimer, estágio moderado a grave, utilizando inibidor de acetilcolinesterase, a conduta mais adequada é:

a) Suspender o inibidor de acetilcolinesterase e introduzir antipsicótico.

b) Suspender o inibidor de acetilcolinesterase e manter paciente sem droga.

c) Manter o inibidor de acetilcolinesterase e associar antidepressivo

d) Manter o inibidor de acetilcolinesterase e associar memantina

11) Homem com 85 anos, professor universitário, casado, sem filhos, após se aposentar ajudava a esposa na casa, cuidava do jardim, fazia reformas na casa e viajavam todos os anos. Há, aproximadamente, 3 anos começou a perder o interesse e prazer nas atividades habituais, apresentava dificuldade em tomar decisões, marcha lentificada, perda de peso. Quando a esposa o chamava para sair ele dizia estar cansado, se sentindo inútil, não dormia bem e passou a ruminar ideias de morte. Continuava independente para todas as atividades básicas e instrumentais de vida diária. Qual é o diagnóstico mais provável?

a) O diagnóstico mais provável é Transtorno Depressivo.

b) Podemos afirmar que o paciente está na fase prodrômica da Doença de Alzheimer.

c) O paciente está com demência instalada e deve ser iniciado o tratamento com medicação.

d) O diagnóstico mais provável é Transtorno Bipolar.

12) Ainda de acordo com o caso acima; assinale a alternativa que apresenta adequadamente a ferramenta de triagem que deve ser utilizada para a avaliação deste paciente com relação ao diagnóstico possível do caso:

a) Fluência Verbal categoria semântica.

b) Escala de Depressão Geriátrica de 15 itens

c) Montreal Cognitive Assessment (MoCa)

d) Teste do relógio

13) Paciente masculino, 90 anos, robusto, apresenta crise de urticária com prurido importante sendo medicado com hidroxizina 25 mg 8/8h. Após alguns dias inicia quadro com dificuldade de atenção, alteração do ciclo sono-vigília, irritabilidade. Retorna para emergência e é internado para investigação. Evolui com piora do quadro, flutuação do nível de consciência, agitação vespertina e alucinação. Assinale a opção que apresenta a hipótese diagnóstica para o quadro.

a) Delirium.

b) Demência com Corpos de Lewy.

c) Doença de Alzheimer.

d) Demência fronto temporal comportamental.

14) Paciente do sexo feminino, 78 anos é levada á consulta com queixa de vertigem e parestesia nos membros superiores. A filha da paciente que a acompanhava na consulta, relatou que sua mãe estava apresentando quadros de confusão mental. Afirma que demais familiares estavam preocupados que a paciente pudesse estar com Alzheimer. Traz exames laboratoriais recentes (08/08/2023): Hematocrito 21,2 % ; Hemoglobina 7 g/dL ; VCM 120 fL.

Após ver esses exames, qual a provável causa do quadro clínico apresentado?

A) Anemia por deficiência de B12

B) Anemia por alcoolismo.

C) Anemia falciforme.

D) Alzheimer.

15) Das alternativas abaixo, assinale aquela que contenha os principais grupos que desenvolvem anemia ferropriva:

A) Adultos jovens, pacientes com traço falcêmico.

B) Crianças, usuários de drogas.

C) Gestantes e alcoolistas

D) Mulheres pós menopausadas, pacientes veganos.

16) Adamastor, 55 anos, portador de diabetes mellitus tipo II há 05 anos, iniciou um quadro de hipertensão arterial sistêmica. Diante do cenário clínico, além das recomendações não farmacológicas, compreendeu-se a necessidade do início da seguinte classe medicamentosa, esta, preconizada para tal contexto:

a) Beta bloqueador.

b) Bloqueador dos canais de cálcio.

c) Agente simpatolítico de ação central.

d) Inibidor da enzima de conversão da angiotensina.

17) Paciente de 74 anos, comparece à consulta, queixando-se dos seguintes sintomas: retenção urinária, polaciúria, hesitação urinária e esforço miccional. Considerando a causa mais frequente de sintomas do trato urinário inferior (STUIs) neste cenário clínico, assinale o provável diagnóstico:

a) Cistite.

b) Prostatite.

c) Câncer de próstata.

d) Aumento benigno da próstata.

18) Assinale a alternativa que contenha um sinal e um sintoma apresentado por uma paciente com quadro de hipotireoidismo:

a) Bócio e diarreia.

b) Pele quente e palpitação.

c) Tremor de extremidades e cansaço.

d) Pele infiltrada e acuidade auditiva diminuída.

19) Esposa leva seu marido de 66 anos para consulta médica devido à perda progressiva da memória, que se iniciou há dois anos. Existe interferência nas atividades de vida diárias, como esquecer nome dos filhos, mas não erra nas contas e não tem dificuldade nas escritas. A apatia é um dado importante, além do hábito de andar sem roupa dentro de casa e procurar a mulher com muita frequência, desejando manter relações sexuais. O apetite mudou e há procura

constante por comida. Na consulta o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) foi 22 (escolaridade nível superior), não havia alterações motoras ou sensitivas ao exame físico e os pares cranianos estavam normais. O diagnóstico mais provável deve ser?

A) Demência vascular.

B) Demência de Alzheimer.

C) Demência frontotemporal.

D) Demência por hidrocefalia de pressão normal.

20) Senhor Cristiano Ronaldo da Silva de 75 anos procura atendimento médico acompanhado de sua filha. A queixa principal é “esquecimento”. Na trilha de investigação de possível quadro demencial, qual será a conduta?

A) Anamnese, MEEM, exames complementares, avaliação neuropsicológica e RNM encéfalo.

B) Exame físico, exames complementares, tomografia crânio e vitamina B12.

C) Anamnese, avaliação neuropsicológica e RNM encéfalo.

D) MEEM, exames complementares e RNM encéfalo.

21) Paciente sexo masculino, assintomático, usuário de drogas injetáveis, procurou atendimento para exame de rotina. O médico que o atendeu opta então pela solicitação de alguns exames sorológicos, cujos resultados foram: HBsAg positivo, anti HBs negativo, anti-HBc IgM negativo, anti-HBc IgG positivo. Com base nos resultados disponíveis, o paciente foi diagnosticado com:

A) Indivíduo imune por infecção natural

B) Hepatite crônica pelo vírus C

C) Hepatite aguda pelo vírus B

D) Hepatite crônica pelo Vírus B

22) Paulo, 59 anos, é portador de hipertensão arterial, diabetes tipo 2, dislipidemia e obesidade grau 2. Paulo há um mês sofreu um acidente vascular encefálico isquêmico (AVCI), que na ocasião não foi trombolisado. Traz consigo para a consulta o boletim de alta hospitalar e exames realizados durante a internação: TC de crânio que evidencia hipodensidade em região de capsula interna direita, eletrocardiograma evidenciando fibrilação atrial e doppler de carótidas e vertebrais sem lesões significativas. Ao exame: hemiparesia a esquerda, ausculta pulmonar sem alterações, ausculta cardiovascular com ritmo irregular. Você, medico assistente do paciente resolve ajustar terapia medicamentosa visando prevenção de um novo episódio de AVCI. Logo você prescreveu para Paulo:

A) AAS 100 mg e Rosuvastatina 40 mg.

B) Varfarina 5 mg, AAS 100 mg e Atorvastatina 80 mg.

C) Rivaroxabana 20 mg, AAS 100 mg e Atorvastatina 80 mg.

D) Rivaroxabana 20 mg e Rosuvastatina 40 mg.

23) Uma paciente de 15 anos experimenta crises iniciadas por uma sensação de mal-estar na região epigástrica, descrita como uma sensação local de vazio/náusea, de forma ascendente, a seguir testemunhas das crises relatam que a sua consciência fica prejudicada, ela então fixa o olhar, tem automatismos orais e manuais à direita, além de distonia de membro superior contralateral, com duração entre 1 a 2 minutos. Marque a opção abaixo que indica o lobo do cérebro provavelmente responsável por essa manifestação referida acima e a medicação de escolha, respectivamente:

A) Lobo temporal direito, Ácido Valpróico.

B) Lobo frontal esquerdo, Fenobarbital.

C) Lobo temporal esquerdo, Carbamazepina.

D) Lobo frontal direito, Fenitoína.

24) Um paciente de 67 anos, hipertenso e diabético, apresenta quadro agudo de hemiparesia direita e afasia percebido ao despertar. Foi visto a última vez assintomático há 5 horas. TC de crânio não mostra alterações relevantes. A angio- TC dos vasos cranianos evidencia oclusão do segmento M2 da artéria cerebral média esquerda. Assinale a opção abaixo que apresenta a melhor conduta terapêutica a ser implementada.

A) Trombólise venosa com rt-PA.

B) Trombectomia mecânica.

C) Trombólise intra-arterial com rt-PA.

D) Anticoagulação plena com enoxa

25) Paciente MMS, 88 anos de idade, possui diagnóstico de demência de Alzheimer, em uso de donepezil 10 mg por dia há cinco anos. Trazida a consulta por estar apresentando quadro de agitação psicomotora, mais frequente no final da tarde, há 2 meses. Filha relata que paciente fica irritada e com falas agressivas e já chegou a apresentar agressividade física com a cuidadora. Durante episódios, passa a perambular e perguntar quando irá para sua casa, repetindo várias vezes a pergunta. Apesar desse quadro, a filha afirma que o sono e o apetite estão preservados, mantém peso estável e nega outras alterações comportamentais ou de humor.

a) Síndrome do pânico; prescrever clonazepam 0,5mg no horário da crise

b) Progressão da doença de Alzheimer; início de tratamento com olanzapina

c) Alteração comportamental da demência; tentar inicialmente medidas não farmacológicas.

d) Delirium misto; encaminhar a emergência hospitalar para realização de exames.

26) Mulher, 66 anos de idade, professora universitária aposentada há 01 ano, com queixa de perda de memória de início nos últimos seis meses. Refere ter se perdido uma vez enquanto estava dirigindo, e relata esquecimentos de questões do dia a dia, como lembrar-se de datas de vencimento de contas; porém, ainda segue fazendo as atividades básica e instrumentais de vida diária sem auxílio. Veio à consulta e acompanhada do esposo que diz que tem achado a esposa mais esquecida, mas acha normal para a idade. Discurso coerente, demonstra-se ansiosa diante da queixa atual. Caso a paciente apresente alteração na triagem cognitiva, é correto afirmar:

a) Paciente tem síndrome demencial, visto que a desorientação que apresentou ao dirigir é um sinal grave de alerta para o quadro.

b) Como não há perda de atividades diárias, a paciente apresenta um declínio cognitivo subjetivo, e apenas terapia cognitivo-comportamental está indicada

c) Deve-se rastrear causas de disfunção cognitiva potencialmente tratáveis, ainda que seja um comprometimento cognitivo leve.

d) Já há indicação de iniciar terapia com anticolinesterásico pelo maior benefício na fase precoce.

27) Uma idosa de 82 anos, com história de hipertensão arterial controlada com losartana 50 mg/dia e diabetes mellitus tipo 2 em uso de metformina 850 mg duas vezes ao dia, foi trazida ao pronto-socorro por seus familiares devido a um quadro de confusão mental aguda, iniciado há dois dias. A paciente, que até então era independente para as atividades diárias, passou a apresentar desorientação no tempo e no espaço, inquietação, e períodos de sonolência excessiva, alternados com momentos de agitação psicomotora. A alimentação está prejudicada, bem como a ingesta hídrica. Seus familiares relatam que, há três dias, começou a se queixar de dor ao urinar mas não conseguiram levá-la ao seu médico para avaliação. No exame físico, encontra-se desatenta, desorientada em tempo e espaço, corada, desidratada 1+/4, eupneica, afebril com FC 98 bpm, pressão arterial de 110/70 mmHg. O exame neurológico não revela déficits focais, e a ausculta pulmonar está sem alterações. A glicemia capilar está em 230 mg/dL. Com base no caso clínico, assinale a alternativa correta.

a) Suspender imediatamente todos os medicamentos da paciente, e realizar internação em unidade de terapia intensiva para monitoramento.

b) Como paciente sem se alimentar e ingerir líquidos, deve- se passar sonda nasoenteral para evitar desnutrição.

c) Iniciar antibioticoterapia empírica para tratar uma possível infecção urinária, hidratação venosa e monitorar parâmetros glicêmicos, além de vigilância do nível de consciência.

d) Administrar um antipsicótico de baixa dose, como haloperidol, para controlar a agitação, e aguardar melhora do quadro de delirium para realizar a anamnese adequada com a paciente.

28) Um homem de 62 anos de idade, advogado aposentado, previamente saudável, é trazido à consulta por sua esposa, que relata que vem percebendo mudanças comportamentais nos últimos dois anos. Segundo a esposa, ele começou a ter dificuldade em fazer atividades do seu dia a dia, eventualmente demonstrando insatisfação excessiva e agressividade verbal. Além disso, ele se tornou mais reservado, apresentando uma redução no interesse por atividades sociais e mostrando pouca preocupação com as emoções dos outros. Em casa, ele tem demonstrado comportamentos repetitivos, como reorganizar objetos sem razão aparente, e se fixou em certos alimentos, recusando-se a comer outros.

- MEEM 25/30 (esperado para o paciente é 29)
- Fluência verbal: 7 animais (esperado para o paciente é maior ou igual a 13)
- Escala de depressão geriátrica 1/15 (ausência de depressão)
- Escala de Katz (ABCD): 6/6 - independente
- Escala de Lawton (AIVD): 15/27 - dependente parcial

Exames laboratoriais de rastreio cognitivo estão normais e a Ressonância magnética de crânio mostrou aumento de sulcos e fissuras em lobos frontotemporais. Diante do caso, qual é a hipótese diagnóstica?

a) Demência frontotemporal - variante comportamental.

b) Demência vascular

c) Afasia Progressiva Primária variante semântica

d) Demência de Alzheimer de inicio precoce

29) Sobre a doença de Parkinson, analise as afirmativas a seguir.

I. Instabilidade postural e disautonomia tendem a aparecer mais tardiamente no curso da doença, diferente de outras sinucleinopatias.

II. O tremor de repouso geralmente é assimétrico, acometendo um ou mais membros, e tende a piorar com o estresse e a desaparecer durante o sono.

III. Entre manifestações não-motoras, hiposmia e distúrbios de sono REM tendem a ser precoces, enquanto depressão e declínio cognitivo, tendem a ser tardias.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

a) I e II, apenas.

b) I e III, apenas.

c) II, apenas.

d) I, II e III.

30) Após a imunização completa para a hepatite B, o perfil sorológico que deve ser observado é:

A) anti-HBc positivo e anti-HBs positivo

B) anti-HBc positivo e anti-HBe positivo

C) anti-HBc negativo e anti-HBs positivo

D) anti-HBc negativo e anti-HBe positivo

31) A partir do caso a seguir, selecione a opção com a sequência CORRETA de causas de óbito, para preenchimento da Parte I da Declaração de Óbito, considerando que a primeira causa da lista deve ser a causa imediata e a última será a causa básica. Paciente masculino, 65 anos, sabia ser portadora de hipertensão arterial sistêmica desde há 20, sem tratamento. Há cerca de 2 anos iniciou quadro de dispneia aos esforços, quando foi diagnosticada cardiopatia hipertensiva, tendo iniciado tratamento. Desde há 2 meses, evoluiu com insuficiência cardíaca congestiva. Hoje, foi internado com edema agudo de pulmão, indo a óbito após 2 horas.

A) Edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatia hipertensiva, hipertensão arterial sistêmica.

B) Hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatia hipertensiva, edema agudo de pulmão.

C) Edema agudo de pulmão, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatia hipertensiva.

D) Cardiopatia hipertensiva, hipertensão arterial sistêmica, edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva.

32) Um jovem procura atendimento devido ao aparecimento, há 3 semanas, de manchas claras na pele localizadas na região cervical e nos braços, bilateralmente. Enquanto espera o atendimento, preocupa-se ao observar um cartaz afixado com os seguintes dizeres: “Que mancha é essa? Você pode estar com hanseníase”.

Nesse caso, a principal informação a ser utilizada pelo médico para diferenciar a hanseníase de outras dermatoses que cursam com lesões semelhantes é:

a) O tempo de aparecimento das lesões.

b) A ausência de alterações de sensibilidade.

c) O fato de as manchas serem hipocrômicas.

d) A faixa etária em que se encontra o paciente.

33) Paciente feminina, de 62 anos de idade, vai à consulta médica, referindo tosse produtiva com expectoração clara de aspecto mucoide. Refere história de dispneia aos médios esforços nos últimos 5 anos, com piora nos últimos 30 dias. Nega febre ou alteração característica da tosse habitual. Tabagista 1 maço/ dia há 40 anos. Nega hipertensão arterial sistêmica e diabetes melito. A radiografia de tórax mostra hiperinsuflação pulmonar, hipertransparência e retificação do diafragma. A hipótese diagnóstica provável é:

A) DPOC

B) bronquiectasia

C) asma agravada por infecção

D) DPOC agravada por pneumonia

34) Um militar de 22 anos de idade apresenta meningite por N. meningitides do tipo B. Ele divide o dormitório com outros cinco militares. Qual a conduta indicada em relação aos colegas de dormitórios?

A) Profilaxia apenas para aqueles cuja cultura de líquor for positiva.

B) Ceftriaxone para todos eles.

C) Profilaxia apenas para aqueles cuja cultura de swab nasal for positiva.

D) Vacinação com vacina conjugada.

35) Paciente de 21 anos, sem comorbidades, apresenta febre alta de início súbito há 2 dias, mialgia, 01 episódio de vômito, cefaleia, hepatomegalia maior que 3cm do rebordo costal. Não apresenta sangramentos, sinais de choque e sinais de comprometimento grave de órgãos. Tratando-se de Dengue, das opções apresentadas nas alternativas abaixo, assinale aquela que seria a conduta correta para este caso?

a) Hidratação oral e acompanhamento ambulatorial

b) Hidratação venosa e internação em enfermaria

c) Hidratação venosa e internação em leito de terapia intensiva

d) Hidratação oral e observação em leito-dia.

36) Mulher de 45 anos, IMC:36Kg/m2, com pai e mãe portadores de DM tipo 2, procurou atendimento ambulatorial para consulta de rotina. Trouxe exames laboratoriais que revelaram: glicemia de jejum = 115mg/dl; e HbA1c = 6%. Os mesmos exames foram repetidos e revelaram: glicemia de jejum = 118mg/dl; e HbA1c = 6,1%; e TOTG com 75g de glicose anidra = 155mg/dl. Além da mudança no estilo de vida, qual a conduta para esta paciente?

a) Inibidor SGLT2

b) Expectante

c) Glicazida

d) Metformina

37) Uma paciente de 23 anos de idade, sem antecedentes conhecidos, foi encaminhada pelo SAMU para o pronto-socorro, com relato de crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas há sete minutos. No local do chamado, identificou-se glicemia capilar de 92 mg/dL e realizou-se 20 mg de diazepam endovenoso durante o transporte. A paciente foi admitida na sala de emergência com persistência da crise convulsiva. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a próxima medicação a ser administrada.

a) midazolam 10 mg, intramuscular.

b) fentanil 20 mcg/kg, endovenoso.

c) fenitoína 20 mg/kg, endovenosa.

d) fenobarbital 200 mg/kg, intramuscular.

38) Paciente 60 anos apresentando quadro de dor torácica típica há 3 horas. Paciente hipertenso e diabético. Realizado ECG de 12 derivações onde não foi evidenciando supra desnivelamento de ST. Ao exame paciente com fácies de dor apesar do tratamento inicial instituído, taquipneico. Enchimento capilar lentificado PA 80x40 mmHg, FC 120 Bpm, ACV RCR em 3 tempos, AR: Crepitações até ápice durante monitorização é evidenciado períodos de taquicardia ventricular não sustentada. Troponina Ultrassensível solicitada ainda sem resultado. De acordo com o caso acima descrito, qual seria a sua conduta:

a) Indicaria internação e caso troponina positiva cateterismo de urgência (até 72 horas)

b) Indicaria cateterismo de emergência (até 2 horas).

c) Aguardaria a troponina para definição do caso. Caso negativa internaria paciente na enfermaria para seguir investigação.

d) Iniciaria beta bloqueador pois paciente mantém dor devido a FC elevada e solicitaria internação em CTI.

39) Há uma semana, atendemos no Ambulatório Docente um homem de 48 anos com queixa de dor esternal em opressão desencadeada pelo esforço e aliviada pelo repouso. Relata que a dor tem duração média de 10 minutos e não irradia. O ECG realizado revelou ondas “T” positivas, apiculadas e simétricas nas derivações V1, V2, V3 e V4. Qual o diagnóstico eletrocardiográfico?

a) Isquemia subepicárdica de parede anterior.

b) Isquemia subepicárdica de parede ântero-septal.

c) Isquemia subendocárdica de parede ântero-septal.

d) Isquemia subendocárdica de parede apical.

40) Uma paciente de 58 anos é encaminhada ao ambulatório de cardiologia para melhor controle de sua pressão arterial, já em uso de BRA + beta bloqueador. Tem IMC de 29 e sua PA: 145 x 90mmHg. Seu exame físico é normal. Qual seria a melhor estratégia, nesse momento?

a) Aumentar as doses dos medicamentos em uso.

b) Iniciar tiazídico.

c) Iniciar bloqueador de canal de cálcio.

d) Suspender o beta bloqueador e substituí-lo por um tiazídico ou bloqueador de canal de cálcio.

GABARITO 2024.2.2

1. A
2. B
3. D
4. C
5. B
6. B
7. D
8. D
9. D
10. D
11. A
12. B
13. A
14. A
15. C
16. D
17. D
18. D
19. C
20. A
21. D

22. D

23. C

24. B

25. C

26. C

27. C

28. A

29. D

30. C

31. A

32. B

33. A

34. B

35. B

36. D

37. C

38. B

39. C

40. D

PROVA C.M. 2025.1.1

1) Paciente, 59 anos, é admitido no Serviço de emergência de um hospital de grande porte, acompanhado do irmão que refere quadro súbito de perda da força no braço direito, além de dificuldade para comunicar-se. O quadro iniciou-se há 35 minutos, durante atividade física com alteres, na academia. Antecedentes: hipertensão arterial e tabagismo. Exame físico: sonolento, despertável, obedece a comandos simples, com hemiparesia direita completa com predomínio braquiofacial (força muscular grau II). Apresenta ainda afasia de condução. A nuca está livre. Pupilas isocóricas. PA = 190x110mmHg; FC = 88bpm; FR = 14irpm. Realiza tomografia de crânio sem contraste que evidencia lesão hiperdensatálamo-capsular de 2,1x2,5x1,7cm, sem desvio da linha média. Tendo em vista esse quadro, assinale a alternativa com o diagnóstico mais provável e a conduta imediata mais apropriada:

A) Acidente vascular encefálico isquêmico transitório, descartando-se, diante do intervalo de tempo decorrido, terapia trombolítica de reperfusão.

B) Hemorragia subaracnoide, devendo-se manter observação atenta da evolução, com realização de arteriografia cerebral assim que possível.

C) Acidente vascular encefálico hemorrágico recomendando-se um adequado controle pressórico, tratamento de suporte clínico e repetir a tomografia nas primeiras 24 horas.

D) Acidente vascular encefálico isquêmico, tratando- se, diante do intervalo de tempo decorrido, de um candidato à terapia trombolítica de reperfusão com r- tPA, sendo, porém, necessário um adequado controle pressórico e certificação da ausência das demais contraindicações.

2) Mulher, 66 anos, advogada aposentada, queixa-se de problemas de memória, embora sem muito impacto em suas atividades de vida diária, uma vez que mantem o trabalho em seu escritório de advocacia com regular desempenho e ajuda do filho. Este preocupado com a situação vem acompanhado da mãe na consulta e refere início dos sintomas 2 semanas após uso de um certo remédio. A paciente está em suo de hidroclotiazida, carbonato de cálcio, amitriptilina e levotiroxina. O mini mental foi 22/30 e o restante normal. A medicação que pode justificar a queixa da paciente é:

a) Amitriptilina

b) Levotiroxina

c) Hidroclotiazida

d) Carbonato de cálcio

3) As epilepsias devem ser controladas com medicamentos que previnem futuros episódios, para tal se recomenda antiepilépticos de acordo com o subtipo clínico. O tratamento de escolha para as síndromes epilépticas generalizadas como a do tipo Ausência e Mioclônia juvenil:

a) Valproato de sódio

b) Carbamazepina

c) Fenitoína

d) Clonazepam

4) Uma mulher de 83 anos com histórico de esquecimentos progressivos é trazida pelos filhos ao ambulatório. Relatam que ela tem dificuldade para cozinhar, administrar suas finanças, vestir-se sozinha e reconhecer familiares em

visitas recentes. Apresenta desorientação espacial e necessita de supervisão constante. Com base nas aulas teóricas e no estadiamento clínico da doença de Alzheimer, qual é o estágio mais provável da paciente?

A) Comprometimento cognitivo leve.

B) Estágio leve.

C) Estágio moderado.

D) Estágio grave.

5) Durante uma visita domiciliar supervisionada, um interno atende uma paciente de 75 anos que apresenta desorganização no pensamento, comportamento inadequado, impulsividade e linguagem empobrecida. A filha relata que os sintomas iniciaram há pouco menos de um ano, com progressão relativamente rápida. Exame físico com presença do sinal do aplauso. Com base nas características clínicas, qual é o diagnóstico mais provável?

A) Demência com corpos de Lewy.

B) Demência frontotemporal.

C) Demência vascular.

D) Doença de Alzheimer.

6) Durante um ambulatório supervisionado, um interno acompanha uma paciente de 78 anos com diagnóstico recente de doença de Alzheimer em fase leve. Ela ainda é independente para suas atividades básicas, mas apresenta esquecimentos frequentes, dificuldade para manter o foco e dificuldade para resolver tarefas que antes fazia com facilidade. Qual das opções abaixo representa a conduta farmacológica inicial mais adequada?

A) Memantina.

B) Inibidores da acetilcolinesterase.

C) Benzodiazepínico noturno.

D) Antipsicótico atípico.

7) Durante atendimento em enfermaria geriátrica, um interno acompanha um paciente de 76 anos com histórico de dificuldade progressiva de marcha, incontinência urinária e prejuízo cognitivo. Há seis meses foi aventada a hipótese de hidrocefalia de pressão normal, mas o paciente não realizou investigação complementar nem foi encaminhado para avaliação neurocirúrgica. Atualmente, apresenta dependência funcional importante e quedas recorrentes. Considerando o quadro clínico e a evolução, qual é a principal consequência da ausência de tratamento adequado nessa condição?

A) A progressão do quadro com perda funcional pode se tornar irreversível.

B) O paciente evolui com atrofia cortical difusa característica do Alzheimer.

C) A melhora espontânea é esperada com o controle da pressão arterial.

D) O tratamento medicamentoso com anticolinesterásicos pode reverter o quadro.

8) Sra Luíza, 68 anos, portadora de hipotireoidismo, vem apresentando lentificação cognitiva, sonolência excessiva, desatenção e perda de memória recente. Durante a visita questiona se pode tratar-se de um quadro demencial. Qual é a conduta mais adequada?

A) Iniciar donepezila para melhora cognitiva.

B) Iniciar antipsicótico em dose baixa.

C) Investigação laboratorial com HC, Glicemia de jejum, HbA1c, Ur, Cr, sódio, cálcio, TGO, TGP, GGT, FAL, TSH e T4 livre, vitamina B12, ácido fólico, VDRL, anti-HIV 1 e 2 e PCR.

D) Solicitar ressonância nuclear magnética do encéfalo.

9) Paciente de 20 anos, em tratamento para linfoma de Hodgkin, recebeu quimioterapia em altas doses há 10 dias. Apresenta-se ao pronto-socorro com febre de 38,5ºC há 2 horas, sem outras queixas e sem outras alterações ao exame físico. O hemograma revela Hb: 7,5 g/dl, Ht: 20%, leucócitos totais: 1.000/mm³, neutrófilos: 450/mm³, plaquetas: 50.000/mm³. A conduta mais adequada no caso é:

a) Observação clínica e tratamento com antitérmicos, dada a ausência de sintomas clínicos e estado geral preservado.

b) Internação hospitalar, coleta de hemoculturas e início imediato de antibioticoterapia com cefepime.

c) Internação, coleta de hemocultura e início imediato de antibioticoterapia de largo espectro com carbapenêmico, vancomicina e antifúngico.

d) Coleta de hemocultura e alta para tratamento ambulatorial com combinação de amoxicilina + clavulanato e ciprofloxacino.

10) Paciente do sexo masculino, 60 anos, hipertenso bem controlado com losartana e hidroclorotiazida, chega à emergência com quadro de confusão mental. Os exames de admissão evidenciam: Creatinina de 6,0 mg/d, Uréia 150 mg/dl, Leucócitos de 7.900,Hb de 9,0g/dL, Potássio 5,1 mEq/L, Sódio 145 mEq/L e Cálcio total de 15 mg/dL. Assinale a alternativa que representa o resultado do exame que se adequa ao quadro apresentado.

a) Eletroforese da hemoglobina com aumento de hemoglobina A2.

b) Cariótipo da medula óssea com translocação t(9;22).

c) Plasmocitose na medula (>10%).

d) Blastos na medula em número maior que 20%.

11) Mulher, 45 anos, comparece para avaliação médica devido quadro de fraqueza e inapetência intensa. De antecedentes patológicos, refere gastrite. Avaliada por seu médico assistente que solicitou certos exames laboratoriais na suspeita de anemia. Os exames evidenciam: hematócrito 20%; hemoglobina 7,7 g/dl; volume corpuscular médio 110 fl; leucócitos 1.980 mm3; plaquetas 100.000 mm3; desidrogenase lática LDH 200 UI/L (normal até 190). Aumento de homocisteína com níveis normais de ácido metilmalônico. Diante do quadro clínico e dos exames laboratoriais, qual das hipóteses diagnósticas abaixo é a mais provável como etiologia da anemia:

a) Deficiência de ferro

b) Deficiência de vitamina B12

c) Síndrome mielodisplásica

d) Deficiência de folato

12) Mulher, 30 anos, com história de fraqueza muscular, dispneia, dificuldade de deglutição e discreta ptose palpebral ao final do dia. TC de tórax evidenciando lesão expansiva em mediastino anterior. O diagnóstico mais provável para essa lesão seria:

a) timoma

b) linfoma

c) teratoma

d) bócio tireoideano

13) Um estudante de biologia de 24 anos de idade é trazido por sua mãe e seu irmão ao pronto-socorro. Nas últimas duas semanas, o estudante tem ficado progressivamente mais agitado, inquieto, dormindo menos e falando rápido, às vezes difícil de entender. Há dois dias começou a falar que descobriu a cura para a covid-19, tendo enviado várias mensagens eletrônicas para diferentes jornais, instituições públicas e embaixadas. Diz agora que aguarda a ligação de ministros da saúde de vários países para conversar sobre sua descoberta. Quando questionado pelo irmão sobre esses fatos, ficou muito irritado e tentou agredi-lo fisicamente. A família diz que o paciente sempre foi estudioso, trabalhador, carinhoso com os pais e amigo do irmão. Aos 20 anos de idade, apresentou quadro depressivo e foi tratado com medicamento, cujo nome os familiares não se recordam. Não há antecedentes familiares mórbidos relevantes. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

a) Transtorno Obsessivo Compulsivo.

b) Esquizofrenia Hebefrênica.

c) Transtorno Afetivo Bipolar.

d) Transtorno de Personalidade.

14) Um homem de 90 anos de idade, morador de casa de apoio, estava em seu estado usual de saúde, sem sintomas urinários, quando realizou uma série de exames laboratoriais, solicitados pelo seu médico assistente, como parte de uma rotina de avaliação anual de saúde. Os exames estavam todos dentro da normalidade para sua idade, exceto a urinocultura, na qual houve crescimento de Pseudomonas aeruginosas > 100.000 unidades formadoras de colônia, sensível à fosfomicina, ciprofloxacina, levofloxacina, amicacina e aos carbapenêmicos. Qual seria sua conduta terapêutica para este caso?

A) Ciprofloxacina

B) Fosfomicina

C)Meropenem

D)Não tratar

15) Mulher de 80 anos de idade, em D10 de internação em leito de terapia intensiva, apresenta sepse de origem pulmonar associada a ventilação mecânica, sem choque. Na cultura do aspirado traqueal da paciente, houve

crescimento de Escherichia coli= 100.000 (105) unidades formadoras de colônia, resistente aos seguintes antibióticos: ampicilina, amoxicilina, amoxicilina/ clavulanato, cefuroxima, ceftriaxona, cefepime e aztreonam e sensível aos seguintes antibióticos: piperacilina/ tazobactam, amicacina, gentamicina, ertapenem, imipenem e meropenem. Pelo uso racional dos antibióticos, qual seria o tratamento mais adequado pera este caso?

A) Vancomicina + amicacina

B) Piperacilina/ Tazobactam + gentamicina

C)Ertapenem

D)Piperacilina/ Tazobactam

16) Em determinadas infecções relacionadas à assistência à saúde é necessário o tratamento empírico de bactérias anaeróbias, como em algumas infecções de sítio cirúrgico, pneumonias aspirativas, infecções intra-abdominais, abcessos cerebrais etc. Qual o antibiótico listado abaixo apresenta eficaz ação para tratamento de bactérias anaeróbias?

A) Cefepime

B) Vancomicina

C)Ciprofloxacina

D)Meropenem

17) Homem de 40 anos de idade foi internado com história de cefaleia, náusea e vômitos e emagrecimento que se iniciaram há 30 dias. Hoje, houve piora do nível de consciência e foi levado à emergência. A tomografia computadorizada de crânio foi normal e a análise do líquor evidenciou aumento de celularidade, com predomínio de células mononucleares, diminuição de glicose e importante aumento da proteína. Foram realizados dois testes rápidos de marcas diferentes para diagnóstico de infecção pelo HIV que resultaram REAGENTES e coletada amostra de sangue para a realização da carga viral do HIV.O teste de fluxo lateral para detecção de lipoarabinomanano em amostra de urina (LF- LAM) foi reagente. Qual seria a conduta correta para este caso?

A) Iniciar tratamento para meningite criptocócica com anfotericina B. Cerca 4 a 6 semanas após início do tratamento da meningite criptocócica, iniciar a terapia antirretroviral com tenofovir (TDF)+ lamivudina (3TC) + dose usual de dolutegravir (DTG).

B) Iniciar, ao mesmo tempo, o tratamento para meningite tuberculosa com rifampicina+ isoniazida+ pirazinamida+ etambutol, corticoide e tratamento antirretroviral com tenofovir (TDF)+ lamivudina (3TC) + dose dobrada de dolutegravir (DTG).

C) Iniciar o tratamento para meningite tuberculosa com rifampicina+ isoniazida+ pirazinamida+ etambutol e corticoide. Cerca de 4 a 6 semanas após início do tratamento para meningite tuberculosa, iniciar terapia antirretroviral com tenofovir (TDF)+ lamivudina (3TC) + dose dobrada de dolutegravir (DTG).

D) Iniciar tratamento para meningite tuberculosa com rifampicina+ isoniazida+ pirazinamida+ etambutol. Cerca de 4 a 6 semanas após início do tratamento para meningite tuberculsa, iniciar terapia antirretroviral com tenofovir (TDF)+ lamivudina (3TC) + dose usual de dolutegravir (DTG).

18) Um estudante de medicina sofreu um acidente perfurocortante com uma seringa contaminada com sague de um paciente desconhecido, ao tentar descartar o material na caixa coletora, há 4 horas. O teste rápido para HIV desse

estudante foi não reagente (negativo). Ele apresenta vacinação completa para hepatite B e anti- Hbs reagente. Em relação à profilaxia para infecção pelo HIV para esse estudante, qual seria a conduta correta?

A) Iniciar imediatamente: emtricitabina (FTC) + Tenofovir (TDF) por 28 dias.

B) Não iniciar profilaxia pós exposição, pois a PEP não é eficaz após 2h da exposição

C) Iniciar imediatamente: Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) + Dolutegravir (DTG) por 28 dias

D) Não iniciar profilaxia pós exposição, pois como o teste rápido para HIV do estudante foi não reagente (negativo), não há necessidade de PEP.

19) Dois pacientes vizinhos e de mesma idade, sabidamente portadores de angina pectoris apresentam dor ao realizarem atividades diferentes. O Sr. A – ao chegar a padaria que dista 500m de sua casa, o Sr. B- ao chegar no supermercado, que fica a 300m no mesmo trajeto em direção a padaria.

Sobre o caso avalie as afirmativas:

1- O Sr. B apresenta dor em um duplo produto mais baixo que o Sr. A
2- O Sr. A apresenta uma obstrução coronariana maior que o Sr. B

Qual das alternativas abaixo é a correta:

A) as afirmativas 1 e 2 estão incorretas

B) somente a afirmativa 1 está correta

C) somente a afirmativa 2 está correta

D) as afirmativas 1 e 2 estão corretas

20) Um paciente portador de doença coronariana crônica com terapêutica atingindo FC de 50 bpm, PA = 110/70 mmHg e em uso de nitrato regular, permanece sentindo dor mesmo em atividades pequenas como tomar banho. Qual a melhor opção para o quadro:

A) solicitado cateterismo e em caso de lesão de coronária direita e circunflexa indicaríamos cirurgia de revascularização miocárdica.

B) solicitado cateterismo e em caso de lesão de tronco de coronária esquerda indicaríamos cirurgia de revascularização miocárdica.

C) solicitado cateterismo e em caso de lesão de coronária descendente anterior indicaríamos cirurgia de revascularização miocárdica.

D) solicitado cateterismo e em caso de lesão de tronco de coronária descendente anterior, circunflexa e direita indicaríamos angioplastia das coronárias.

21) Uma jovem de 28 anos, portadora de estenose mitral, sem queixas até então, encontra-se na trigésima quarta semana de gestação quando começou a apresentar, ortopneia e alguns episódios de dispneia paroxística noturna. Na ausculta cardíaca notamos um pulso arterial irregular e um ritmo cardíaco irregular

Qual das opções abaixo é a correta com relação ao caso:

A) a piora clínica deve-se a perda da contração ventricular e o uso de digital estabilizaria a queixa clínica

B) a piora clínica deve-se a perda da contração atrial e o uso de BRA estabilizaria a queixa clínica

C) a piora clínica deve-se a perda da contração ventricular e o uso de IECA estabilizaria a queixa clínica

D) a piora deve-se a perda da contração atrial e o uso de Furosemida estabilizaria a queixa clínica

22) Um paciente portador de insuficiência cardíaca , classe funcional III em uso de Enalapril 20 mg de 12/12h, Furosemida 40 mg 02 cp ao dia e Propranolol 40 mg ao dia. Analisando a receita previamente usada, o que você mudaria para o caso visando a redução de mortalidade:

A) Trocaria Propranolol por Atenolol, acresceria Hidroclorotiazida 25 mg ao dia e caso tenha condição trocaria Enalapril por Sacubutril-Valsartana

B) Trocaria Propranolol por Carvedilol, acresceria Espironolactona 25 mg ao dia e caso tenha condição trocaria Enalapril por Sacubutril- Valsartana

C) Trocaria Propranolol por Meto

prolol, Trocaria o Enalapril por Losartana e caso tenha condição acresceria Sacubutril-Valsartana

D) Trocaria Propranolol por Atenolol, acresceria Espironolatona caso tenha condição e acresceria Sacubutril-Valsartana

23) Homem de 58 anos comparece à unidade básica de saúde para consulta de revisão. Refere ser tabagista há 35 anos (cerca de 20 cigarros/dia), com cessação há 1 ano. Tem histórico familiar de pai com infarto agudo do miocárdio aos 54 anos. Nega diabetes mellitus, dislipidemia ou doença renal crônica. Há quatro meses, iniciou seguimento por hipertensão arterial sistêmica, com valores persistentes de pressão arterial em torno de 148/92 mmHg em medidas fora do consultório (média confirmada por MAPA). Encontra- se atualmente assintomático, com exame físico inalterado, exceto por pressão arterial de 146/90 mmHg. Usa atualmente monoterapia com hidroclorotiazida 25 mg/dia, com boa adesão. Exames laboratoriais recentes demonstram função renal preservada, potássio sérico normal, e ausência de microalbuminúria.

Qual é a melhor conduta terapêutica para otimizar o controle pressórico desse paciente, considerando seu nível de risco cardiovascular?

a) Manter o tratamento atual e reavaliar em 3 meses.

b) Iniciar associação com inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA).

c) Substituir o diurético atual por bloqueador dos canais de cálcio.

d) Associar betabloqueador ao tratamento atual.

24) Um paciente previamente hígido é admitido à enfermaria hospitalar com febre, tosse e queda do estado geral apresenta opacidade consolidativa em terço superior do hemitórax direito. No terceiro dia de internação e de antibioticoterapia com amoxicilina e clavulanatoassociados a claritromicina persiste com febre elevada e vem evoluindo com hipotensão. Nova radiografia de tórax é solicitada e observa-se derrame pleural ipsilateral à consolidação. Após toracocentese obtém-se o resultado de:Proteína sérica -4,5g/dL Proteína do líquido pleural - 3g/dLLDH sérica - 276 U/L LDH do líquido pleural – 1475 U/LGlicose sérica - 86mg/dL Glicose do líquido pleural – 57mg/dLADA – 75 U/lCitometria global - 13000 cel/dL , 84% de neutrófilos pH do líquido pleural – 7,17Com base nos resultados acima, a melhor conduta será:

A) Solicitar que o paciente seja submetido a drenagem intercostal fechada pela cirurgia torácica considerando o diagnóstico de derrame pleural com evolução para empiema pleural.

B) Realizar tomografia de tórax com contraste venoso e avaliar a possíveis complicações de processos pneumônicos.

C) Solicitar tomografia de tórax para avaliar diagnósticos diferenciais ao adotado na admissão do paciente, tendo em vista o esquema antimicrobiano adequado e amplo já adotado.

D) Associar vancomicina ao esquema antimicrobiano e colher hemoculturas para avaliar germens não cobertos pelo esquema antimicrobiano adotado

25) Homem, 25 anos, há cerca de 3 meses com relato de tosse produtiva, emagrecimento de aproximadamente 10Kg, febre não aferida, sudorese noturna, astenia e adinamia. Sem comorbidades prévias. Fumante de 10 maços.ano, etilista social aos finais de semana e usuário freqüente de canabis e ocasional de cocaína. Ao exame clínico: eupneico, descorado 1+/4+, anictérico, SatO2 = 96%, FC = 120bpm, Tax = 36,5°C, PA = 110x70mmHg, MVUA sem RA. Peso = 55Kg. Relato de diagnóstico de tuberculose pulmonar há 2 anos, com tratamento irregular e abandono por volta do 4º mês.Diante da situação relatada, além da radiografia de tórax, qual a alternativa mais adequada para o diagnóstico da doença atual? (TRM- TB = Teste rápido molecular para tuberculose; Mtb = Mycobacterium tuberculosis)

A) Tomografia de tórax (avaliar seqüelas do episódio prévio) e TRM-TB do escarro.

B) Pesquisa de BAAR no escarro (2 amostras), TRM-TB para avaliar resistência à Rifampicina e cultura para Mtb, todos por análise do escarro

C) Prova tuberculínica e pesquisa de BAAR no escarro (2 amostras)

D) TRM-TB e cultura para Mtb, ambos com análise do escarro.

26) Homem de 28 anos, com história de diabetes mellitus tipo 2 e alcoolismo crônico, é admitido no serviço de urgência com queixas de febre intermitente (38ºC), tosse seca, dispneia, iniciados há 35 dias. Há 7 dias apresentou surgimento de dor torácica intensa à inspiração profunda, prostração e hiporexia. Relata piora significativa da dispneia nas últimas 48 horas, além de calafrios, sudorese noturna e picos febris mais intensos. Exame Físico: Pressão arterial: 100/65 mmHg. Frequência respiratória: 28 irpm. Saturação de O_2: 88% em ar ambiente. Ausculta pulmonar: murmúrio vesicular abolido no terço inferior direito, ausculta pulmonar pulmão esquerdo sem alterações. Percussão: submacicez na base pulmonar direita. Exames complementares: radiograma de tórax: opacificação homogênea na base direita, presença da parábola de Damoiseau. USG torácico: imagem anecoica e presença do sinal da coluna (spine sign) e do sinal da água viva (Jellyfish sign). Toracocentese: Líquido amarelo citrino. Bioquímica do líquido pleural: Proteínas: 4,0 g/dL, LDH:650 U/L, glicose: 35 mg/dL, adenosina deaminase: 100 U/L. Exames séricos: Proteínas: 3,0 g/dL, LDH: 200 U/L, glicose: 75 mg/dL. Citometria do líquido revelando predomínio de linfócitos.Cultura do líquido pleural: em processamento. BAAR do líquido pleural negativo. Diante do quadro clínico e da etiologia mais provável para o derrame pleural, qual a conduta mais adequada?

A) Iniciar diurético e solicitar avaliação da cirurgia para drenagem torácica em selo d'água

B) Iniciar antibioticoterapia e solicitar avaliação da cirurgia para drenagem torácica em selo d'água

C) Iniciar antibioticoterapia e manter seguimento com radiografias de tórax diariamente

D) Iniciar esquema RHZE (rifampicina+isoniazida+pirazinamida+etambutol)

27) O tratamento da tuberculose pulmonar, em sua maioria de casos, é feito com o esquema básico. Após os primeiros dois meses do tratamento, fase denominada fase de ataque, mais 4 meses de tratamento são realizados. Dentre os objetivos da segunda fase podemos considerar:

A) Redução da infecciosidade

B) Redução da recidiva da tuberculose

C) Redução da morbidade da doença

D) Redução do surgimento de cepas resistentes

28) Paciente de 45 anos deu entrada no HMLG, com história de tosse com presença de secreção associado a febre, prostração e inapetência com evolução de cerca de 5 dias. Há 02 dia iniciou quadro de dispneia com edema de membros inferiores bilateralmente. Relata história prévia de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, hipertensão arterial sistêmica e diabetes melitus. Ao exame admissão apresentava-se taquidispneica, dessaturando em ar ambiente 91%. Radiografia de tórax com presença de consolidação e derrame pleural ocupando mais da metade do hemitórax direito. Foi realizada toracocentese diagnóstica com seguinte resultado. Citologia com predomínio celular de polimorfonucleares, proteínas do líquido pleural 3,5 g/dl, LDH 350 u/ml, glicose 30 mg/dl, Ph 7,0. No sangue proteínas de 4,5 g/dl, LDH 450 U/DL, glicose 90 mg/dl.Diante do quadroassinale a alternativa contendo conduta adequada diante do caso.

A) Trata-se de quadro de pneumonia bacteriana complicado com derrame pleural, sendo a conduta mais adequada o início de antibioticoterapia venosa com cobertura para germes típicos e atípicos, suporte de oxigênio se necessário e acompanhamento radiológico do derrame pleural.

B) Trata-se de pneumonia adquirida na comunidade grave complicada com derrame pleural, a conduta mais adequada é iniciar antibioticoterapia, suporte de oxigênio e realização de drenagem tóracica.

C) Trata- se de descompensação de insuficiência cardíaca e o tratamento deve ser realizado com restrição hídrica, diureticoterapia e suporte com oxigênio suplementar conforme necessidade.

D) Trata- se de quadro de provável de tuberculose pleural, sendo necessário para confirmação do diagnóstica, cultura específica para M.tuberculosis. O tratamento consiste em esquema RIPE.

29) Paciente de 45 anos relata início de quadro de aumento do volume abdominal associado a edema de membros inferiores e periorbitário de início há cerca de 10 dias. Ao exame paciente estável hemodinamicamente, taquipneico em ar ambiente sem sinais de esforço respiratório. Ao exame físico abdominal presença de sinal da macicez móvel. Exame do aparelho respiratório evidencia redução dos murmúrios vesiculares em bases bilateralmente. Realizada paracentese diagnóstica para realização de GASA com os seguintes resultados. Líquido ascítico: albumina 1,0 mg/dL // Albumina plasmática 1,9 mg/dLDiante do quadro clínico qual das opções abaixo é um possível diagnóstico deste paciente?

A) Síndrome nefrótica.

B) Cirrose hepática.

C) Insuficiência cardíaca descompensada.

D) Trombose de veia porta.

30) Uma mulher de 65 anos com doença renal crônica em estágio 5 apresenta acidose metabólica refratária ao uso de bicarbonato, hipercalemia persistente e sintomas urêmicos (fadiga extrema, inapetência, náuseas). Qual é a conduta apropriada?

A) Iniciar diálise peritoneal ou hemodiálise.

B) Aumentar a dose de bicarbonato oral e monitorar.

C) Aguardar piora dos sintomas para transplante renal.

D) Prescrever resinas de troca iônica para tratar a hipercalemia.

31) Uma paciente de 25 anos, previamente saudável, apresenta disúria, polaciúria e dor suprapúbica há dois dias. Não há febre ou sinais sistêmicos. É a primeira vez que apresenta esse quadro. Não usou qualquer antibiótico, não viajou, nem esteve internada há mais de um ano. Qual é o tratamento empírico inicial mais indicado para esta paciente?

A) Nitrofurantoína 100 mg VO, 6/6h, por 5 dias

B) Amoxicilina 500 mg VO, 3 vezes ao dia, por 7 dias

C) Levofloxacina 750m mg VO, 1 vez ao dia, por 5 dias

D) Sulfametoxazol-trimetoprima 400/80 mg VO, 12/12h, por 3 dias.

32) A prevalência de pacientes portadores de doença renal crônica em hemodiálise apresenta crescimento importante no Brasil. A etiologia mais frequente segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia é:

A) Doença renal policística do adulto

B) Diabetes mellitus

C) Glomerulonefrite crônica

D) Hipertensão arterial

33) Um paciente de 64 anos com diabetes mellitus tipo 2 e doença renal crônica estágio 3b (TFGe de 38 mL/min/1,73 m²) apresenta albuminúria de 550 mg/g e HbA1c de 9%. Qual é o tratamento inicial indicado para controle glicêmico e nefroproteção neste caso?

A) Insulina e glibenclamida para reduzir rapidamente a glicemia.

B) Metformina em dose ajustada para a função renal e inibidor de SGL T2.

C) Análogo do GLP1 para controle glicêmico e redução da albuminúria.

D) Sulfonilureia associada a estatinas para controle glicêmico e cardiovascular.

34) Paciente, feminina, leucodérmica, 60 anos, apresenta há 1 ano lesões infiltradas com bordos internos precisos e externos imprecisos, anestésicas, disseminadas, infiltração em um único lóbulo da orelha e anestesia no pé esquerdo e mão direita. Assinale a alternativa correta relacionada às medicações utilizadas no tratamento:

A) Rifampicina, Clofazimina, Amoxicilina

B) Rifampicina, Clofazimina, Dapsona

C) Azitromicina, Ceftriaxona, Clofazimina

D) Dapsona, Azitromicina, Clofazimina

35) Paciente do sexo masculino, 45 anos, procurou atendimento médico devido a cansaço generalizado, dor abdominal no quadrante superior direito e perda de apetite. Refere história de consumo de álcool em quantidades moderadas e realizou transfusão de sangue há 10 anos após um acidente. Exame físico revela icterícia leve e hepatomegalia. Os exames laboratoriais iniciais mostram elevação das transaminases (AST e AL T) e bilirrubinas totais e diretas. Com base nesse quadro clínico, o médico suspeita de infecção crônica por hepatite C. Qual dos seguintes exames seria o mais adequado para confirmar o diagnóstico?

A) Genotipagem do vírus C

B) PCR-RNA qualitativo do vírus C

C) PCR-DNA quantitativo do vírus C

D) Anti HCV

36) Homem, 40 anos, sabidamente portador de hepatite B crônica, morador de área de assentamento recentemente ocupada, sem saneamento básico, procura a Unidade Básica de Saúde por apresentar há 4 dias dor abdominal de leve intensidade em hipocôndrio direito, náuseas, astenia, mialgia e febre de 38ºC. Seu filho apresentou quadro similar há cerca de 15 dias. Baseada nas informações do paciente e na hipótese diagnóstica, qual o resultado da sorologia é esperado nesse caso?

A) HBsAg negativo, anti-HBc IgG positivo, antiHBe positivo, anti-HAV IgG positivo

B) HBsAg positivo, anti-HBs negativo, anti-HBc IgM positivo, anti-HAV IgG positivo

C) HBsAg negativo, anti-HBs positivo, anti HBc IgG negativo, anti-HAV IgM positivo

D) HBsAg positivo, anti HBs negativo, anti-HBc IgG positivo, anti-HAV IgM positivo

37) Mulher, 49 anos, iniciou quadro de dor epigástrica tipo cólica, de forte intensidade, iniciada há 4 horas associada a vômitos e sudorese. A crise foi desencadeada pela ingestão de alimentação gordurosa. Relata uso de analgésicos com melhora da dor. Nega febre ou outros sintomas associados. Ao exame físico: Lúcida, orientada, eupneica, anictérica, acianótica, afebril. Abdome: flácido, indolor a palpação, sem defesa, sem massas palpáveis. Relata leve desconforto à palpação profunda de hipocôndrio direito. De acordo com sua hipótese diagnóstica, qual exame de imagem deve ser solicitado?

A) Ressonância nuclear magnética de abdome superior

B) Endoscopia digestiva alta

C) Tomografia computadorizada de abdome superior

D) Ultrassonografia de abdome total

38) Paciente 20 anos deu entrada no pronto socorro queixando-se de “fraqueza, dor na barriga, diarreia e olho amarelo”. Não sabe informar sobre seu calendário vacinal. Os sintomas iniciaram-se há mais ou menos 15 dias após

sua chegada da praia. Ao exame: lúcido e orientado, ictérico (3+/4), acianótico, eupneico, febril (37,8 C). Abdome: flácido doloroso difusamente a palpação superficial e profunda, sem irritação peritoneal, peristalse aumentada, fígado com limite superior no 7º EICD , com borda palpável a 7 cm do RCD sob a LHCD. Demais sistemas sem alterações.Exames laboratoriais: TGO= 1000 (20-30)/ TGP= 1500 (20- 35), FA= 180 (40-125) GGT= 55 (30-50) / Sorologias: HbsAg negativo /anti HBc IgG positivo / anti HBs positivo /anti HAV IgM positivo.De acordo com o caso clínico qual a hipótese diagnóstica?

A) Hepatite A crônica

B) Hepatite B aguda

C) Hepatite A aguda

D) Hepatite B crônica

39) Homem, 60 anos, é internado com confusão mental e aumento do volume abdominal. A esposa refere que o paciente é etilista de longa data, com consumo de cerca de 7-10 doses de whisky diariamente. Nega hemotransfusões. A hipótese diagnóstica é cirrose alcoólica com hipertensão portal. Qual exame complementar confirmaria esse diagnóstico?

A) Ultrassonografia abdominal com doppler do sistema porta

B) Endoscopia digestiva alta

C) Elastografia hepática ultrassônica

D) Provas de função hepática

40) Homem, 46 anos, dá entrada com dor torácica esternal de inicio há cerca de 8 horas. O ECG está alterado. Em relação ao diagnóstico diferencial entre pericardite e síndrome coronariana aguda (SCA) em um paciente com dor torácica na unidade de emergência, qual das seguintes opções representa o achado mais característico para pericardite?

A) Dor torácica associada a sudorese intensa e padrão de supradesnivelamento do ST em derivações contínuas.

B) Dor torácica em aperto irradiando para o braço esquerdo e padrão de elevação do segmento ST em derivações específicas.

C) Dor torácica que piora com a inspiração profunda e com o decúbito dorsal, associada à elevação difusa do segmento ST e à depressão do PR no eletrocardiograma.

D) Dor torácica que melhora com nitratos e presença de inversão de onda T nas derivações precordiais.

GABARITO 2025.1.1

1. C

2. A

3. A

4. C

5. B

6. B

7. A

8. C

9. B

10. C

11. D

12. A

13. C

14. D

15. C

16. D

17. C

18. C

19. B

20. B

21. D

22. B

23. B

24. A

25. B

26. D

27. B

28. B

29. A

30. A

31. A

32. D

33. B

34. B

35. B

36. D

37. D

38. C

39. A

40. C

PROVA C.M. 2025.1.2

1) Lito, 63 anos, etilista crônico, é admitido com quadro de ascite. Ao exame: abdome globoso com macicez móvel à percussão. Exames laboratoriais mostram albumina sérica de 2,4 g/dL. Realiza-se paracentese diagnóstica com os seguintes dados do líquido ascítico: Albumina do líquido ascítico: 0,8 g/dL. Contagem de polimorfonucleares: 90 células/mm³. Aspecto: claro; Cultura: negativa. Com base nesses dados, qual das condições abaixo é a causa mais provável da ascite?

A) Pancreatite

B) Tuberculose peritoneal

C) Carcinomatose peritoneal

D) Cirrose hepática

2) Paciente do sexo feminino, 50 anos, com histórico de dispepsia há cerca de 6 meses, refere dor epigástrica em queimação, sensação de plenitude gástrica e episódios de náuseas. Relata que os sintomas pioram com a ingestão de bebidas alcoólicas e aliviam temporariamente com uso de antiácidos. Durante a investigação, foi realizada endoscopia digestiva alta, que revelou úlcera duodenal em atividade (A1 de Sakita) e o histopatológico demonstrou gastrite crônica leve do antro sem atividade, com presença de bacilos compatíveis com Helicobacter pylori. Além do bloqueador de bomba de prótons, qual a terapêutica antimicrobiana de eleição indicada para essa paciente?

A) Clindamicina 500mg + Metronidazol 400ng+ Tetraciclina 500mg – 2 vezes ao dia por 10 dias

B) Tetraciclina 500mg + Bismuto 120mg+ Metronidazol 400mg - 2 vezes ao dia por 14 dias

C) Amoxicilina + Levofloxacino 500mg – 2 vezes ao dia por 10 dias

D) Amoxicilina 1g + Claritromicina 500mg - 2 vezes ao dia por 14 dias

3) L.M.S, 45 anos, procedente de Tombos-MG, é admitida na UTI com quadro de hepatite fulminante pelo vírus da hepatite B, com indicação de transplante hepático. Tem antecedente de hepatite C tratada com resposta virológica sustentada (cura). Assinale a alternativa que melhor reflete seu estado sorológico atual:

A) HBsAg (+), Anti-HBc IgG (+), Anti-HBc IgM (-), Anti-HBs (-), Anti-HCV (-)

B) HBsAg (+), Anti -HBc IgG (-), Anti-HBc IgM (+), Anti-HBs (-), Anti-HCV(+)

C) HBsAg (-), Anti-HBc IgG (-), Anti-HBc IgM (+), Anti-HBs (+), Anti-HCV (+)

D) HBsAg (-), Anti-HBc IgG (+), Anti-HBc IgM (-), Anti-HBs (+), Anti-HCV (-)

4) Paciente de 53 anos, sem comorbidades, trabalhador de lavoura de café na região Serrana do Espírito Santo, apresenta, na região posterior da orelha esquerda, uma pápula eritematosa com brilho perolado, observada ao iluminar a lesão com uma lanterna. Há pigmentação acinzentada na região superior e a lesão tem cerca de 2 cm de diâmetro. Refere evolução de 3 anos e sangramento ao banho nos últimos meses. Ao exame físico geral, observa-se importante dano solar cutâneo e múltiplas lesões de ceratoses actínicas em áreas foto expostas. Qual a hipótese diagnóstica e conduta?

A) Nevo melanocítico / biópsia excisional.

B) Ceratoacantoma / conduta expectante.

C) Carcinoma Basocelular / biópsia excisional.

D) Melanose solar / usar filtro solar.

5) Um paciente masculino de 54 anos, morador de rua e com histórico de alcoolismo crônico, é admitido no serviço de emergência com quadro de febre, tosse produtiva com expectoração fétida, emagrecimento progressivo e hemoptise. Ao exame físico, apresenta crepitações e diminuição do murmúrio vesicular na base pulmonar direita. A radiografia de tórax revela uma imagem sugestiva de abscesso pulmonar no lobo inferior direito. Considerando o quadro clínico e os fatores de risco do paciente, qual é o agente etiológico mais provável e qual o tratamento empírico mais adequado?

A) Mycoplasma pneumoniae —macrolídeo (Azitromicina)

B) Streptococcus pneumoniae — beta lactâmico + inibidor de betalactamase (Amoxicilina-clavulanato)

C) Anaeróbios orais — beta lactâmico+ inibidor de beta lactamase (Amoxicilina-clavulanato)

D) Klebsiella pneumoniae — beta lactâmico (Ceftriaxona ou cefuroxima)

6) Um adolescente de 17 anos, previamente saudável, é admitido com febre alta, tosse com secreção purulenta e dor torácica. Apresenta extensa lesão purulenta na perna direita, com sinais de celulite e abscesso em resolução espontânea. Está taquipneico, com SatO□ 92% em ar ambiente. Radiografia de tórax mostra múltiplas opacidades nodulares com áreas de cavitação, especialmente nos lobos superiores. Assinale a alternativa que contenha o diagnóstico mais provável para o caso e o exame complementar que deverá ser solicitado?

A) Pneumonia por Pseudomonas aeruginosa + Hemocultura

B) Pneumonia aspirativa por anaeróbios + culturas da secreção

C) Pneumonia viral + RX de tórax

D) Pneumonia por Staphylococcus aureus + hemocultura e culturas da secreção

7) Homem de 45 anos, assintomático, sem alterações ao exame físico, teve contato domiciliar recente com caso confirmado de tuberculose pulmonar bacilífera. Seu teste tuberculínico (PPD) foi de 8 mm e a radiografia de tórax é normal. Qual a conduta mais apropriada?

A) Iniciar tratamento com esquema RHZE completo por 6 meses.

B) Não é necessário tratamento, pois o PPD é inferior a 10 mm e o paciente é assintomático.

C) Repetir o PPD em 3 meses e só tratar se houver aumento do diâmetro.

D) Iniciar tratamento com isoniazida + rifapentina por 12 semanas (1x/semana)

8) Um homem de 70 anos, previamente saudável, procura a unidade de pronto atendimento com queixa de febre alta, tosse produtiva com expectoração amarelada, dispneia e dor torácica pleurítica há 3 dias. Ao exame: PA 92/66 mmHg, FC 110 bpm, FR 32 irpm, temperatura 38,5ºC, SatO□ 90% em ar ambiente. A ausculta revela estertores crepitantes no hemitórax direito. Radiografia de tórax mostraconsolidação em lobo inferior direito. O paciente está consciente e orientado. Com base no quadro clínico e nos critérios de gravidade, qual a classificação da pneumonia e qual o local mais adequado para o tratamento inicial?

A) Pneumonia hospitalar – Internação em UTI

B) Pneumonia comunitária – Tratamento ambulatorial

C) Pneumonia hospitalar – Tratamento ambulatorial

D) Pneumonia comunitária – Internação hospitalar em enfermaria

9) Um homem de 48 anos, previamente saudável, é admitido com dispneia súbita, dor torácica ventilatório-dependente e hemoptise. Está taquicárdico (FC 115 bpm), taquipneico (FR 28 irpm), saturando 88% em ar ambiente. ECG mostra taquicardia sinusal e padrão S1Q3T3. D-dímero elevado (2500 ng/ml) O médico decide confirmar o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Qual é o exame padrão-ouro para confirmação diagnóstica de TEP neste caso?

A) Angiotomografia computadorizada de tórax com contraste (angioTC)

B) Ultrassonografia de membros inferiores

C) Radiografia de tórax

D) Cintilografia ventilação/perfusão (V/Q)

10) J.A.S., 35 anos, masculino, procura atendimento médico devido a sintomas respiratórios recorrentes e diários. Ele relata episódios diários de tosse seca, sibilos torácicos e dispneia. Os sintomas pioram com exposição a poeira, mudanças climáticas. Nas últimas semanas acordou duas a três vezes no período noturno por crise de dispneia e sibilos torácicos. Ao Exame PA 120/80 mmHg, FC 88bpm, FR 20 irpm, SpO2 96% em ar ambiente. Ausculta pulmonar: MV preservado e simétrico com sibilos difusos, principalmente em bases pulmonares. Exames Complementares: Espirometria: VEF1 pré-broncodilatador 65% do previsto; relação VEF1/CVF reduzida. Há normalização da relação VEF1/CVF após a broncodilatação. Considerando o quadro clínico do paciente e a principal hipótese diagnóstica, qual dos itens abaixo contém o tratamento mais adequado para o paciente?

A) Corticosteroide inalatório em dose baixa + LABA (β2-agonista de longa ação) em caráter de resgate, sem necessidade de uso de manutenção

B) LABA (β2-agonista de longa ação) + LAMA (antagonista colinérgico de longa ação) regular e Corticosteroide inalatório em dose baixa + LABA (β2-agonista de longa ação) de resgate

C) LABA (β2-agonista de longa ação) + LAMA (antagonista colinérgico delonga ação) regular e SABA (β2- agonista de curta ação) em caráter de resgate

D) Corticosteroide Inalatório em dose média + LABA (β2-agonista de longa ação) regular e Corticosteroide inalatório em dose baixa + LABA (β2-agonista de longa ação) de resgate

11) Homem, 68 anos, com diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER), apresenta dispneia aos mínimos esforços e edema de membros inferiores. Seu médico ajustou o tratamento e incluiu medicamento para melhorar os sintomas, entretanto, sem impacto na mortalidade. Qual dos seguintes fármacos se encaixa nesse perfil terapêutico?

A) Sacubitril/valsartana

B) Furosemida

C) Carvedilol

D) Espironolactona

12) Homem, 60 anos, com diagnóstico de hipertensão arterial, relata episódios de dor torácica aos esforços moderados, aliviados com repouso. Seu médico prescreve um medicamento de primeira linha para reduzir a demanda miocárdica de oxigênio e controlar os sintomas. Qual dos seguintes fármacos é considerado de primeira linha para o tratamento da angina estável?

A) Trimetazidina

B) Metoprolol

C) Ivabradina

D) Verapamil

13) Ao iniciarmos tratamento para uma paciente de 56 anos, apresentando diagnóstico de HAS estágio 2, com risco cardiovascular alto, foi optado por terapia tripla, combinando: IECA + BCC + diurético tiazídico. Em 7 dias a paciente retorna, queixando-se de edema importante nos membros inferiores, perimaleolar, doloroso. Qual dos fármacos prescritos está associado ao efeito adverso apresentado pela paciente?

A) Nenhum dos fármacos está associado ao sinal.

B) IECA (inibidor da enzima conversora da angiotensina)

C) Diurético tiazídico

D) BCC (bloqueador de canal de cálcio diidroperidínico)

14) M.O., 65 anos, feminina, portadora de hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia. Vem em uso de: Metformina 1000 mg/dia, Atorvastatina 20 mg/dia, AAS 100 mg/dia, Enalapril 20mg/dia e Anlodipino 5mg/dia. Maria compareceu à consulta ambulatorial queixando-se de dor torácica intermitente há cerca de 6 meses, descrita como opressiva, localizada no centro do peito, irradiando para o braço esquerdo, ocorrendo principalmente durante esforços físicos intensos e aliviada com repouso. Ela vem fazendo caminhada diária de 1 hora e pilates 2x na semana. Sinais Vitais: PA: 125/80 mmHg, FC: 88 bpm, FR: 18 rpm, Temp: 36,5°C; Cardiovascular: bulhas rítmicas, em 2 tempos, normofonéticas, sem sopros; Respiratório: Murmúrio vesicular audível bilateralmente, sem ruídos adventícios; Exames Laboratoriais: Hemoglobina A1c: 6,7%; LDL 140 mg/dL, HDL 40mg/dL, triglicerídeos 180 mg/dL; Creatinina 1,0 mg/dL; Ecocardiograma transtorácico mostra fração de ejeção de 65%, sem disfunção segmentar, diâmetros e espessuras cavitárias sem alterações. Qual seria a conduta mais apropriada neste caso?

A) Dobrar a dose do IECA.

B) Dobrar a dose da estatina.

C) Iniciar betabloqueador, dobrar a dose da estatina e associar ezetimiba (inibidor da absorção intestinal de colesterol).

D) Iniciar nitrato.

15) Joana, 42 anos, obesa, etilista, com dor abdominal difusa e exames com triglicerídeos de 850 mg/dL. Qual a conduta prioritária?

a) Iniciar fibrato, dieta pobre em gordura e suspender álcool.

b) Iniciar estatina e dieta rica em carboidratos.

c) Iniciar insulina e suspender fibrato.

d) Apenas controle glicêmico e perda de peso. Resposta correta: a

16) Qual das alternativas abaixo descreve uma característica típica da polineuropatia diabética?

A) Comprometimento exclusivo dos nervos cranianos, especialmente o facial

B) Fraqueza muscular distal aguda grave nos quatro membros associada a perda sensitiva em padrão “luva e bota”

C) Dor neuropática com perda da noção de posição segmentar e preservação da sensibilidade superficial

D) Perda sensitiva em padrão "luva e bota", com predomínio distal e simétrico

17) João, 68 anos, hipertenso, diabético e portador de insuficiência renal crônica estágio 3 (TFG: 45 ml/min), faz acompanhamento regular na Atenção Primária. Está em uso de losartana 50 mg/dia e apresenta PA média de 158x96 mmHg. Qual deve ser a melhor escolha terapêutica para controle pressórico neste paciente?

a) Aumentar a losartana para 100 mg/dia e associar anlodipino.

b) Manter a losartana e associar hidroclorotiazida.

c) Suspender losartana e iniciar enalapril isoladamente.

d) Iniciar beta-bloqueador para proteção cardiovascular.

18) João, 60 anos, hipertenso com histórico de asma brônquica controlada, comparece para revisão. Sua pressão arterial permanece elevada (150x92 mmHg) apesar do uso de losartana 50 mg/dia. Considerando sua comorbidade, qual anti-hipertensivo deve ser evitado?

a) Amlodipino

b) Hidroclorotiazida

c) Atenolol

d) Espironolactona Comentários:

19) Senhor Antônio, 78 anos, com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 há mais de 10 anos, comparece à Unidade de Saúde da Família para consulta de acompanhamento. Faz uso de aspirina 100 mg/dia, atorvastatina 20 mg/dia, metformina 2550 mg/dia e glibenclamida 20 mg/dia. Relata episódios frequentes de hipoglicemia (2 a 3 vezes por semana), geralmente no final da tarde, antes do jantar. Nega internações recentes ou quedas. Ao exame físico, encontra-se com sinais vitais dentro dos limites da normalidade e IMC de 32 kg/m². Exames laboratoriais recentes mostram: Hemoglobina glicada (HbA1c): 6,3%; Taxa de filtração glomerular estimada (TFG): 50 mL/min/1,73 m². Diante do quadro apresentado, qual deve ser a conduta mais adequada?

A) Orientar aumento da ingestão de carboidratos no almoço.

B) Prescrever glucagon para uso domiciliar em caso de hipoglicemia.

C) Suspender a glibenclamida.

D) Suspender a metformina.

20) Paciente diabético comparece a consulta de acompanhamento trazendo seus exames nos quais verifica-se microalbuminúria. Sendo assim, qual deverá ser a conduta?

a) Não há necessidade de intervenção.

b) Introduzir IECA ou BRA.

c) Iniciar estatina.

d) Prescrever metformina isolada. Resposta: b

21) Paciente diabético com IMC 32, hipertenso, PA 142x88 mmHg, HbA1c 7,1%. Não tem DAC. Qual droga antidiabética tem benefício adicional comprovado em proteção cardiovascular?

a) Glibenclamida.

b) Metformina.

c) Inibidor de SGLT2.

d) DPP-4.

22) José, 65 anos, portador de Diabetes Mellitus tipo 2 e insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr), apresenta HbA1c de 8,2% e relata cansaço progressivo. Está em uso de metformina 850 mg/dia. Qual antidiabético oral não deve ser utilizado neste caso?

a) Empagliflozina (SGLT2).

b) Pioglitazona (Glitazona).

c) Linagliptina (DPP-4).

d) Insulina NPH.

23) Um paciente de 67 anos, diabético e sedentário, apresenta quadro insidioso e progressivo de perda de memória há 5 anos e, nos últimos 6 meses, vinha evoluindo com dificuldade de realizar suas atividades diárias, por prejuízo na linguagem (fluência e articulação das palavras), e cálculos simples. O exame neurológico não demonstrava déficits motores, rigidez de nuca ou alterações de pares cranianos. Quais seriam os achados histopatológicos no sistema nervoso central mais característicos em relação ao provável diagnostico?

a) Necrose liquefativa

b) Placas amiloides

c) Degeneração espongiforme

d) Corpúsculos de Lewy

24) Dona Matilde, 78 anos, é acompanhada há 3 anos por declínio progressivo de memória, já com dependência para suas atividades do dia-a-dia. A filha relata que ela passou a ter dificuldade para lembrar eventos recentes, apresenta problemas para se orientar dentro de casa e não reconheceu um neto em visita recente. Qual combinação de domínios cognitivos está mais comprometida e qual hipótese diagnóstica se confirma?

a) Déficit exclusivo de linguagem e raciocínio lógico; depressão maior.

b) Déficit de memória episódica e funções visuoespaciais; Doença de Alzheimer.

c) Déficit de atenção seletiva e cálculo; transtorno neurocognitivo leve.

d) Déficit apenas executivo; demência frontotemporal.

25) Seu Benedito, 81 anos, agricultor aposentado, com 3 anos de escolaridade, comparece para avaliação de "esquecimentos" progressivos. O médico deseja usar instrumentos de rastreio cognitivo adaptados ao seu perfil e também instrumentos de avaliação funcional para investigar o grau de dependência. Qual combinação de testes é mais adequada neste caso?

a) Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Teste do Relógio, Índice de Katz e Escala de Lawton.

b) Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Trail Making Test B, Índice de Barthel e Escala de Pfeffer.

c) Teste de Stroop, Escala de Cornell, Índice de Barthel e Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey.

d) Escala de Hachinski, Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15), Escala de Yesavage e Escala de Hamilton.

26) Um homem de 70 anos relata dificuldade crescente para realizar tarefas manuais finas, como abotoar camisas, além de passos curtos e lentos. Ao exame, observa-se postura discretamente curvada, expressão facial hipomímica e lentidão na execução de movimentos. Qual hipótese diagnóstica é mais provável e qual conduta inicial é adequada?

a) Tremor essencial; indicar propranolol.

b) Parkinsonismo secundário a medicamentos; suspender antipsicóticos.

c) Demência com corpos de Lewy; iniciar inibidor de acetilcolinesterase.

d) Doença de Parkinson idiopática; iniciar levodopa.

27) Homem de 35 anos, vem ao ambulatório referindo cefaleia desde a adolescência, tendo piorado na intensidade e frequência nos últimos 6 meses. A cefaleia é unilateral alternante, latejante, de forte intensidade, com náuseas e vômitos e costuma durar 10 horas. Nega fono e fotofobia. Há piora da dor com exercícios físicos. Menciona uma média de 4 crises por mês. Nega comorbidades na HPP. A melhor conduta frente a condição neurológica neste caso:

a) Morfina

b) Prednisona

c) Propranolol

d) Fluoxetina

28) Mulher de 25 anos da entrada na emergência do hospital devido a cefaleia de forte intensidade holocraniana, com náuseas e vômitos. Apresenta PA 180x110 mmHg, Tax 36.9c, Glasgow de 12 e sinal de Brudzinski presente. Feito

TC de crânio sem contraste que confirmou a hipótese diagnóstica. No CTI, 5 dias após a internação, evolui para hemiplegia no lado esquerdo. De acordo com esse novo quadro clínico, podemos considerar que essa complicação poderia ter sido evitada se tivesse usado a seguinte medicação desde o início:

a) AAS

b) Nimodipina

c) Corticóide

d) Nitroglicerina

29) Considerando os princípios de saúde pública e a eficiência do sistema de emergência, qual das seguintes estratégias seria a mais eficaz para reduzir o tempo entre o início dos sintomas de AVC e o atendimento médico adequado?

a) Promover campanhas de conscientização com foco em identificar os fatores de risco, como hipertensão e diabetes, recomendando consultas médicas anuais.

b) Realizar campanhas educativas massivas sobre a mnemônica FAST, enfatizando a importância de ligar imediatamente para os serviços de emergência (192) ao detectar sinais de AVC.

c) Implementar programas para aumentar o número de ambulâncias e reduzir o tempo de resposta dos serviços de emergência.

d) Treinar os profissionais da saúde em unidades de pronto atendimento para reconhecer precocemente sinais de AVC e realizar exames de imagem avançados mais rapidamente.

30) Paciente apresentou AVC isquêmico com NIHSS calculado em 14 pontos. Quadro inciado há 5 horas. Tomografia de crânio com ASPECTS de 7. Angiotomografia da entrada, estenose de características ateroscleróticas de carótida interna esquerda de 90%. Qual deve ser a conduta?

a) Dupla antiagregação.

b) Anticoagulação.

c) Trombólise.

d) Trombectomia mecânica

31) Manifestações de doença renal, em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico, ocorrem em cerca de 50% dos pacientes, sendo hematúria e proteinúria, persistentes os achados mais observados. Nefrite lúpica pode cursar com síndrome nefrítica ou nefrótica, consumo de complementos e positivação de qual exame (relacionado a atividade da nefrite lúpica), dos apresentados abaixo?

a) FAN

b) anti-DNA nativo

c) Anti-ccp

d) Anti-SM

32) Paciente 24 anos, HIV positivo, CD4 < 100, com história de 20 dias de evolução, caracterizada por febre, cefaleia, distúrbios visuais e alteração do nível de consciência. Foi realizado punção lombar com pressão inicial: 55cmH2O, glicose: 60mg/dl, proteínas: 38mg/dl, celularidade: 4 células (linfócitos: 3, monócitos: 1) e tinta da China positiva. Qual o diagnóstico mais provável:

a) Meningoencefalite pelo cytomegalovirus.

b) Meningite criptocócica.

c) Neurotoxoplasmose.

d) Leucoencefalopatia multifocal progressiva

33) Considere os casos a seguir:

Caso 1: Um homem de 30 anos de idade comparece à clínica da família porque apresenta, há cerca de 7 dias, lesões eritemato- violáceas, descamativas, disseminas por todo o corpo, incluindo as palmas das mãos e as plantas dos pés, associadas a adenomegalia generalizada e alopecia em clareiras. Ele apresenta teste rápido para sífilis reagente e o VDRL reagente= 1/1024. Ele refere tratamento prévio para sífilis há 2 anos.

Caso 2: Um homem de 30 anos de idade comparece à clínica da família, assintomático, porque apresentou teste rápido para sífilis reagente quando foi doar sangue. Na clínica da família, foi realizado o exame de VDRL que resultou reagente= 1/16. Ele relata que nunca havia feito exames e nem tratamento para sífilis anteriormente. Qual seria o tratamento indicado para cada caso, descrito acima?

A) Caso 1: Penicilina Benzatina 2.400.000u, 1 vez por semana por 3 semanas e caso 2: Penicilina Benzatina 2.400.000u, dose única.

B) Caso 1: Penicilina Benzatina 2.400.000u, dose única e caso 2: Penicilina Benzatina 2.400.000u 1 vez por semana por 3 semanas.

C) Caso 1: não tratar porque é um caso de cicatriz sorológica e caso 2: Penicilina Benzatina 2.400.000u 1 vez por semana por 3 semanas.

D) Caso 1: Penicilina Benzatina 2.400.000u 1 vez por semana por 2 semanas, e caso 2: Penicilina Benzatina 2.400.000u, dose única.

34) Um homem de 25 anos de idade apresentou crise convulsiva e foi levado à emergência, onde se realizou uma tomografia computadorizada de crânio com observação de duas lesões hipodensas com captação anelar do contraste em lobo temporal esquerdo. Durante a internação, ele recebeu o diagnóstico de infecção pelo HIV e foi iniciado fenitoína que ele permanecerá em uso com dose de manutenção. Qual seria a conduta correta para esse caso?

A) Iniciar sulfadiazina+ pirimetamina + ácido folíco para neurotoxoplasmose e, 4 a 6 semanas depois, iniciar e Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) + dose usual de Dolutegravir (DTG) para o HIV.

B) Iniciar sulfadiazina+ pirimetamina + ácido folíco para neurotoxoplasmose e iniciar e Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) + dose usual de Dolutegravir (DTG) para o HIV, ao mesmo tempo.

C) Iniciar sulfametoxazol+ trimatoprim para neurotoxoplasmose e, 4 a 6 semanas depois, iniciar e Tenofovir (TDF)

+ Lamivudina (3TC) + dose dobrada de Dolutegravir (DTG) para o HIV.

D) Iniciar Sulfametoxazol + trimetoprim para neurotoxoplasmose e iniciar e Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC)

+ dose dobrada de Dolutegravir (DTG) para o HIV, ao mesmo tempo.

35) Um homem de 25 anos procura a unidade de saúde com febre há 3 dias, mialgia intensa, cefaleia e dor retroorbital. No terceiro dia de sintomas, apresenta vômitos persistentes e dor abdominal intensa em cólica. Ao exame físico: PA 100/70 mmHg, pulso fino, extremidades frias e presença de petéquias em membros inferiores. Teste rápido para dengue (NS1) é positivo.

Com base nas diretrizes do Ministério da Saúde para manejo da dengue, assinale a alternativa correta:

A) Trata-se de um caso de dengue clássica (sem sinais de alarme), com indicação de hidratação oral e seguimento ambulatorial

B) O paciente apresenta sinais de alarme para dengue, devendo ser classificado como dengue com sinais de alarme e indicado para internação para hidratação venosa e monitorização

C) A presença de febre e petéquias, por si só, caracteriza caso grave de dengue hemorrágica, com indicação de UTI imediata

D) A positividade do NS1 após o terceiro dia de febre indica provável coinfecção viral, sendo necessário iniciar antibióticos de largo espectro

36) A Injúria Renal Aguda (IRA) é uma das mais importantes complicações observadas em pacientes na UTI com diagnóstico de sepse. Devido a alta mortalidade e morbidade da IRA, a hemodiálise deve ser corretamente indicada. Assinale a alternativa que apresenta causas plausíveis para indicação do início da diálise;

a) Encefalopatia urêmica, acidose metabólica severa e hipovolemia

b) Hipovolemia, acidose metabólica severa e hipernatremia

c) Encefalopatia urêmica, hipercalemia e acidose metabólica severa

d) Acidose metabólica severa, anemia hemolítica e hipervolemia

37) Um paciente de 80 anos, previamente independente, apresenta confusão mental e déficit cognitivo progressivo há 8 meses. Não usa álcool nem medicações psicotrópicas. A família relata perda de peso não intencional. Quais exames devem obrigatoriamente fazer parte da investigação etiológica inicial?

a) TSH, vitamina B12, eletrólitos séricos.

b) Hemograma, coagulograma, PSA total.

c) Eletrocardiograma, dosagem de creatina quinase, VDRL.

d) Sorologias virais, glicemia capilar, radiografia de tórax.

38) Uma senhora de 80 anos relata duas quedas em casa no último semestre. Mora sozinha, relata que costuma se levantar rápido da cama à noite para ir ao banheiro, já sentiu “escurecimento” na visão ao levantar e toma medicação para dormir. Sua casa não possui corrimãos nos corredores nem barras de apoio no banheiro. Qual conjunto de fatores contribui mais para o risco de queda?

a) Uso de sedativo, hipotensão ortostática, ausência de adaptações ambientais.

b) Idade isolada, piso de cerâmica e uso de diurético.

c) Catarata bilateral sem indicação cirúrgica.

d) Osteoporose não tratada, sem alterações posturais.

39) Uma mulher de 42 anos apresenta febre, disúria e dor lombar há três dias. No exame de urina, há nitrito+ ; leucocitúria abundante e cilindros leucocitários. Qual é o diagnóstico compatível?

A) Síndrome nefrítica

B) Cistite não complicada

C) Nefropatia por poliomavírus BK

D) Pielonefrite aguda

40) Uma mulher de 38 anos procura atendimento ambulatorial relatando episódios recorrentes de infecção do trato urinário (ITU) nos últimos 12 meses. Ela apresenta boa saúde geral, sem comorbidades conhecidas, e relata três episódios de ITU confirmados por urocultura no último ano, todos tratados com sucesso. Atualmente, está assintomática. Exames físicos e laboratoriais, incluindo ultrassonografia renal e vesical, não revelam anormalidades. Qual é a conduta inicial apropriada para prevenir futuras recorrências de ITU nesta paciente?

A) Encaminhar para avaliação urológica imediata visando investigação de anomalias estruturais.

B) Prescrever curso prolongado de antibióticos por 14 dias para erradicação de possível foco persistente.

C) Iniciar profilaxia antibiótica contínua com nitrofurantoína por tempo indeterminado.

D) Orientar medidas como aumento da ingestão de líquidos, micção após relações sexuais e higiene adequada.

GABARITO 2025.1.2

1. D

2. D

3. B

4. C

5. C

6. D

7. D

8. D

9. A

10. D

11. B

12. B

13. D
14. C
15. A
16. D
17. A
18. C
19. C
20. B
21. C
22. B
23. B
24. B
25. A
26. D
27. C
28. B
29. B
30. D
31. B
32. B
33. B
34. D
35. B
36. C
37. A
38. A
39. D
40. D

PROVA C.M. 2025.2.1

1 - Sr. José Batisita 62 anos, morador de Vassouras, procurou a ESF do Greco com dor tipo opressiva irradiada para o MSE, ocorrendo há 1 mês, sempre quando vai a padaria que fica 1 km de sua casa; trajeto rotineiro em seu dia a dia. No momento assintomático. HPP: Hipertenso, dislipidêmico H.Social: tabagista. Ao exame: PA = 160/100 mmhg , FC= 100 bpm FR = 20 IRPM.

Exame físico cardiovascular: apresenta Ritmo cardíaco regular em 3T com presença de B4 de VE.

Com relação ao caso anterior, em qual das opções abaixo encontraremos drogas que apresentam ação objetiva na fisiopatologia da doença e com consequente melhora da capacidade do Sr. Carlos fazer o seu trajeto até a padaria sem dor. Escolha a opção em que as drogas sejam passíveis de utilização porém, a primeira droga é mais eficiente que a segunda droga:

A) Atenolol e Losartana

B) Nifedipina e Atenolol

C) Metoprolol e Verapamil

D) Verapamil e Losartana

2- Homem de 58 anos, tabagista crônico, portador de diabetes mellitus tipo 2, comparece à consulta com queixas de cefaleia matinal e turvação visual esporádica. Relata uso irregular de metformina. Ao exame físico, apresenta pressão arterial de 192/122 mmHg em mais de uma aferição, sopro sistólico suave em foco mitral, fundoscopia com sinais de retinopatia hipertensiva e eletrocardiograma evidenciando sinais de hipertrofia ventricular esquerda. Proteinúria de 350 mg/24h foi confirmada. Qual associação de fármacos representa a conduta inicial mais adequada para este paciente, considerando o cenário descrito?

A) Inibidor da ECA + Bloqueador do receptor de angiotensina II (BRA)

B) Betabloqueador + Diurético tiazídico

C) Inibidor da ECA + Bloqueador do canal de cálcio de longa ação

D) Bloqueador do canal de cálcio + BRA

3- Homem de 64 anos, com antecedente de hipertensão arterial sistêmica e infarto agudo do miocárdio há 5 anos, encontra-se em acompanhamento ambulatorial. Refere dispneia aos mínimos esforços, ortopneia e dois episódios de dispneia paroxística noturna na última semana. Ao exame físico: pressão arterial de 104/68 mmHg, frequência cardíaca de 88 bpm, turgência jugular a 45º, crepitações bibasais e edema de membros inferiores ++/4+. Classificação funcional: NYHA III. Ecocardiograma prévio mostra fração de ejeção de 32% com dilatação ventricular esquerda. Considerando o perfil hemodinâmico mais provável e a terapêutica otimizada recomendada, qual a melhor conduta para este paciente?

A) Perfil quente e úmido; IECA + betabloqueador + antagonista de aldosterona + Furosemida

B) Perfil frio e seco; iniciar betabloqueador em monoterapia

C) Perfil frio e úmido; utilizar apenas diurético de alça em dose plena

D) Perfil quente e úmido; betabloqueador e furosemida até estabilização

4- Mulher de 72 anos, hipertensa e diabética, comparece ao pronto atendimento por palpitações associadas a dispneia progressiva há 3 dias. Relata episódios prévios autolimitados de palpitação, mas nunca investigados. Ao exame físico: frequência cardíaca de 134 bpm, pressão arterial de 126/78 mmHg, turgência jugular discreta, estertores em bases pulmonares. ECG: fibrilação atrial com resposta ventricular rápida. Ecocardiograma prévio mostra fração de ejeção preservada. CHA_2DS_2- VASc = 4. Qual é a conduta farmacológica mais adequada para este caso, considerando a duração do quadro e o risco embólico?

A) Amiodarona venosa em infusão contínua para reversão do ritmo e anticoagulação profilática com AAS

B) Digoxina oral para controle da frequência cardíaca e anticoagulação com varfarina

C) Betabloqueador ou bloqueador de canal de cálcio não diidropiridínico para controle da frequência e anticoagulação oral plena com DOAC ou varfarina

D) Cardioversão elétrica imediata, seguida de anticoagulação profilática com heparina de baixo peso molecular por 48h.

5- Paciente masculino, 68 anos, hipertenso e diabético, é admitido no serviço de emergência com quadro de hemiparesia esquerda e disartria de início súbito há 2 horas. A Tomografia Computadorizada (TC) de crânio realizada na admissão não evidenciou sinais de sangramento. A glicemia capilar é de 140 mg/dL e a Pressão Arterial (PA) de 195x110 mmHg. Qual a conduta mais apropriada neste momento?

A) Administrar AAS 300mg e iniciar heparina de baixo peso molecular, aguardando parecer da neurologia.

B) Realizar trombólise venosa com alteplase (rt-PA) imediatamente, pois o paciente está na janela terapêutica.

C) Iniciar anti-hipertensivo venoso para reduzir a PA para níveis inferiores a 140x90 mmHg e, após, considerar a trombólise.

D) Iniciar anti-hipertensivo venoso para controle pressórico (meta < 185x110 mmHg) e, se atingida a meta, proceder com a trombólise venosa.

6- Uma paciente de 75 anos, com histórico de Fibrilação Atrial crônica em uso irregular de anticoagulante, é diagnosticada com AVC isquêmico extenso. Qual a principal hipótese etiológica e a medida de prevenção secundária mais indicada a longo prazo?

A) Etiologia aterotrombótica; iniciar estatina de alta potência e clopidogrel.

B) Etiologia cardioembólica; prescrever anticoagulação oral plena com um novo anticoagulante (DOAC) ou varfarina.

C) Etiologia lacunar; controlar rigorosamente a pressão arterial e iniciar AAS.

D) Etiologia indeterminada; manter dupla antiagregação plaquetária com AAS e clopidogrel por 90 dias.

7- Um homem de 66 anos, com hipertensão arterial sistêmica e sem outros antecedentes pessoais ou familiares, comparece a um ambulatório de pneumologia de um hospital terciário referindo ser tabagista (39 anos/maço) e estar com medo de ter câncer de pulmão. Ele apresentou o resultado de uma tomografia de tórax, sem contraste, realizada há 2 semanas, que revelou um nódulo sólido, único, medindo 18 mm, em parênquima de lobo inferior de pulmão esquerdo. Diante desse quadro, o paciente foi encaminhado pelo médico para investigação. Nesse caso, a conduta médica mais adequada é solicitar que o paciente realize

A) controle anual por tomografia de tórax.

B) broncoscopia com lavado brônquico.

C) tomografia de tórax com contraste.

D) biópsia guiada por ultrassonografia.

8- Paciente em tratamento para epilepsia com crises focais vem apresentando episódios de diplopia, ataxia e tontura. Exames laboratoriais revelam hiponatremia. Qual dos seguintes fármacos é mais provavelmente o responsável por este quadro?

A) Ácido valpróico.

B) Lamotrigina.

C) Carbamazepina.

D) Levetiracetam.

9- Mulher de 35 anos procura atendimento com queixa de cefaleia unilateral, pulsátil, de forte intensidade, associada a fotofobia, fonofobia e náuseas. Os episódios duram cerca de 24 horas. Nega sinais de alarme. Qual o diagnóstico mais provável e a classe de medicação de primeira linha para o tratamento agudo (abortivo)?

A) Cefaleia tensional; analgésicos simples.

B) Enxaqueca (migrânea) sem aura; triptanos ou AINEs.

C) Cefaleia em salvas; oxigênio a 100%.

D) Hemicrania contínua; indometacina.

10- Homem, 40 anos, refere cefaleia de início súbito, descrita como "a pior dor da vida". Apresenta-se sonolento e com discreta rigidez de nuca. A TC de crânio inicial não mostrou alterações. Qual o próximo passo na investigação diagnóstica?

A) Realizar uma Angio-TC de crânio para descartar trombose venosa.

B) Realizar uma punção lombar para pesquisa de xantocromia.

C) Iniciar tratamento empírico para meningite.

D) Repetir a TC de crânio com contraste.

11- Uma mulher de 33 anos vai a uma consulta com um clínico geral por se sentir muito deprimida, referindo tristeza e desânimo, que começaram há 6 meses. Ela conta que é natural e procedente de São Paulo, programadora de computadores, católica não praticante, casada há 6 anos, com dois filhos, e que é sedentária. Refere sentir muita fadiga, cansaço, indisposição e sono e que ganhou 7 kg nesse período. Nega ter pensamentos de morte, de culpa ou de menos-valia. Conta, também, que recebeu diagnóstico de depressão e, por isso, usou fluoxetina durante 2 meses, até 60 mg por dia, sem apresentar melhora significativa. Por fim, referiu ter irregularidade menstrual e constipação. Ao exame, apresenta-se hidratada, corada, afebril, sem edemas, anictérica. Seus sinais vitais estão sem alterações, exceto a

frequência cardíaca que está 48 batimentos por minuto em repouso. À ausculta cardíaca, notam-se bulhas normofonéticas, sem sopros. Diante desse quadro, o principal diagnóstico diferencial a ser investigado é?

A) transtorno depressivo persistente.

B) transtorno depressivo secundário.

C) transtorno de somatização.

D) síndrome de Burnout.

12- Paciente com diagnóstico de demência apresenta alucinações visuais bem estruturadas, flutuação do nível de atenção ao longo do dia e sinais de parkinsonismo que surgiram concomitantemente ao quadro cognitivo. Qual o diagnóstico mais provável?

A) Doença de Alzheimer com sintomas psicóticos.

B) Demência com Corpos de Lewy.

C) Demência associada à Doença de Parkinson.

D) Demência Vascular.

13- Um homem de 39 anos, morador de rua, procura espontaneamente a unidade básica de saúde para atendimento. Ele relata sentir dores de cabeça há 3 dias. Afirma que é etilista, tabagista e nega uso de drogas ilícitas. Seus exames físico, neurológico e psíquico apresentam-se sem alterações e sem critérios para enxaqueca. O paciente está com tosse pouco produtiva há 8 dias, não sabe relatar perda de peso e apresenta pápulas com escoriações em membros superiores e abdome. Nesse caso, qual exame deverá ser solicitado com prioridade para investigação diagnóstica?

A. Tomografia computadorizada de tórax.

B. Dosagem de Tiamina sérica.

C. Teste do escarro (BAAR).

D. Teste rápido de sífilis.

14- Qual das seguintes opções descreve uma complicação motora tardia comum do uso crônico da Levodopa no tratamento da Doença de Parkinson?

A) Crises oculogíricas e distonia aguda.

B) Discinesias e flutuações motoras (período "off").

C) Ataxia cerebelar e nistagmo.

D) Piora da rigidez e acatisia.

15- Homem de 72 anos de idade, ex- tabagista 60 anos- maço, com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica grave há mais de 10 anos, referindo uso contínuo de broncodilatadores de longa ação e oxigenoterapia domiciliar (2 L/min em repouso). História de três internações nos últimos 12 meses por exacerbações infecciosas, na última, há 60 dias, utilizou levofloxacino. Há 4 dias iniciou febre (38,5°C), aumento da dispneia habitual, tosse produtiva

com expectoração purulenta e hipoxemia crescente. Radiografia de tórax com insuflação pulmonar e área de consolidação em lobo inferior direito. Pelos exames complementares: leucócitos: 16.000/mm³ (neutrófilos: 85%) e proteína C reativa= 110 mg/L. Qual seria o tratamento antimicrobiano mais indicado para este caso:

A) Amoxicilina/ Clavulanato + Azitromicina

B) Ceftriaxona + claritromicina

C) Cefepima + Azitromicina

D) Moxifloxacina

16- Homem de 70 anos de idade, com diabetes mellitus tipo 2 de difícil controle, apresenta úlcera em pé direito de difícil cicatrização, acometendo até o tecido celular subcutâneo, com calor, dor, edema e presença de secreção purulenta. Eritema ao redor da lesão= 3 cm, sem sinais de sepse. Classificação PEDIS= 3, lesão moderada de origem comunitária. Qual o melhor tratamento para o caso?

A) Cefalexina

B) Cefazolina

C) Piperacilina/ tazobactam

D) Clindamicina+ ciprofloxacina

17- Um homem de 25 anos de idade, vivendo com HIV/ AIDS, imunossuprimido com contagem de linfócitos T CD4= 180 células; mm3, sem história de trauma crânio encefálico e neurocirurgia, iniciou quadro de febre de cerca de 39ºc, cefaleia e vômitos. Dois dias após o início do quadro, houve piora da cefaleia e do vômito e procurou a emergência. Ao exame, encontrava- se acordado e orientado no tempo e espaço, escala de glasgow=15 (máximo= 15), febril e normotenso. Sem comprometimento de pares cranianos, sem sinais neurológicos focais, sem papiledema e sem história de crise convulsiva. Na suspeita de Meningite Bacteriana Aguda, marque a resposta com a ordem cronológica correta para investigar e tratar esse caso, quando ele deu entrada na emergência:

A) Coleta de hemocultura- início de corticoide- início de Vancomicina + Ceftriaxona + ampicilina- exame de imagem do crânio- caso exame de imagem sem contraindicações, punção lombar para coleta do líquor- ajuste da antibioticoterapia de acordo com a análise líquor.

B) Coleta de hemoculturas- punção lombar para coleta do líquor- Início de corticoide- Início de Vancomicina + Cefepime + ampicilina- ajuste da antibioticoterapia de acordo com a análise líquor

C) Coleta de hemocultura- início de corticoide- início de Vancomicina + Cefepime + ampicilina- exame de imagem do crânio- caso exame de imagem sem contraindicações, punção lombar para coleta do líquor- ajuste da antibioticoterapia de acordo com a análise líquor.

D) Coleta de hemoculturas- punção lombar para coleta do líquor- Início de corticoide- Início de Vancomicina + Ceftriaxone + ampicilina- ajuste da antibioticoterapia de acordo com a análise líquor.

18- Mulher de 40 anos de idade comparece à clínica da família com história de violência sexual (estupro) sofrida há 15h, com penetração vaginal sem uso de preservativo, por homem desconhecido usuário de droga. Ela negava alergia medicamentosa e relata que não havia sido vacinada para hepatite B e nem para HPV. Os testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C foram negativos na admissão da paciente. Ela já fez uso de anticoncepcional de emergência. Qual a conduta correta para o caso?

A) Iniciar profilaxia pós exposição (PEP) para HIV com Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) + Dolutegravir (DTG) e profilaxias para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) com Penicilina Benzatina, ceftriaxona, azitromicina e metronidazol. Iniciar vacinação para hepatite B e HPV Encaminhar para a realização imediata de imunoglobulina para hepatite B (IGHAHB).

B) Iniciar profilaxias para ISTs com Penicilina Benzatina, ceftriaxona, azitromicina e metronidazol. Como o teste para HIV foi negativo, não há necessidade para realizar PEP. Iniciar vacinação para hepatite B e HPV Encaminhar para a realização imediata de imunoglobulina para hepatite B (IGHAHB).

C) Iniciar profilaxias para ISTs com Penicilina Benzatina, ceftriaxona, azitromicina e metronidazol e profilaxia pós exposição (PEP) para HIV com Tenofovir (TDF) + Emtricitambina (FTC). Como já havia passado mais de 24h do episódio de violência, não há mais necessidade de profilaxia para hepatite B. A vacina para HPV só está indicada até os 14 anos de idade, portanto não deve ser indiada para esta paciente.

D) Iniciar somente profilaxia pós exposição (PEP) para HIV com Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) + Dolutegravir (DTG). Tratar as outras Ists, caso apresente sintomas. Iniciar vacinação para hepatite B, sem necessidade de imunoglobulina para hepatite B. A vacina para HPV só está indicada até os 14 anos de idade, portanto não deve ser indiada para esta paciente.

19- Homem, 30 anos de idade, nascido e morador do Rio de Janeiro compareceu à unidade de pronto atendimento, em março de 2025, época de forte calor e chuvas constantes, com história de 48h de evolução caracterizada por febre alta, intermitente e de início subido, cefaleia, mialgia intensa e generalizada e hiporexia. Ele negava sintomas respiratórios, urinários, náusea, vômitos, diarreia e dor abdominal. Ele encontrava-se em regular estado geral, corado, anictérico, acordado e orientado, normotenso, sem lesões de pele, sem sopro ou arritmia cardíaca, sem sinais de sangramentos e de disfunção orgânica. Bioquímica sanguínea evidenciando função renal, hepática e eletrólitos normais e hemograma com leucocitose (13.000/ mm3) e série vermelha e plaquetas normais. Qual seria a conduta terapêutica correta para esse caso?

A) Acompanhamento ambulatorial com prescrição de hidratação oral com 60 ml/ kg/ dia, sendo 1/3 com soro de reidratação oral e dipirona para dor ou febre.

B) Acompanhamento ambulatorial com prescrição de doxiciclina 100mg de 12/12h por 5 dias, prescrição de hidratação oral com 60 ml/ kg/ dia, sendo 1/3 com soro de reidratação oral e dipirona para dor ou febre.

C) Internação hospitalar com prescrição de ringer lactato 20 ml/Kg em 2h e dipirona para dor ou febre.

D) Acompanhamento ambulatorial com prescrição de Amoxicilina 500mg de 8/8h por 5 dias, prednisona 0,5 mg/ Kg/ dia por 3 dias para artralgia, dipirona para febre e orientação de hidratação oral conforme sentir sede.

20- J.M.N, 52 anos, admitido no pronto- socorro de sua cidade com história de aumento progressivo do volume abdominal e edema em membros inferiores há duas semanas. Relata ainda dispneia aos pequenos esforços e episódios de confusão mental nos últimos dias. Ele tem diagnóstico prévio de cirrose hepática secundária à hepatite C, com história de ascite de repetição.

Ao exame físico:

PA: 100/60mmHg; FC: 92bpm; FR:

22irpm e SatO2: 95% em ar ambiente.

Há edema de membros inferiores bilateral ++/4+, turgência jugular aumentada, abdome distendido com circulação colateral e macicez móvel à percussão.

Os exames laboratoriais mostram

Albumina sérica: 2,4 g/dL (ref: 3,5- 5,5g/dL);

RNI (Razão Normalizada Internacional): 2,1;

Sódio sérico: 128mEq/L (ref: 135- 145mEq/L);

Creatinina sérica: 1,6mg/dL (ref: 0,6- 1,2mg/dL).

Ultrassonografia abdominal confirma ascite volumosa sem sinais de trombose de veia porta.

Qual é o mecanismo fisiopatológico mais provável para o edema em membros inferiores e ascite no paciente do caso clínico?

A) Redução da pressão oncótica devido à hipoalbuminemia.

B) Aumento da pressão hidrostática por IC congestiva.

C) Hipervolemia secundária à IRA.

D) Aumento da permeabilidade capilar por processo inflamatório.

21- Qual das alternativas a seguir está corretamente associada à provável etiologia do edema, considerando os achados clínicos descritos em cada uma das opções?

A) Edema de membros inferiores bilateral, ausência de varizes visíveis e ascite importante sugerem IC.

B) Edema unilateral não compressível, associado a histórico de radioterapia, é mais compatível com IVC.

C) Edema periorbitário associado a infecções de repetição e anasarca sugere síndrome nefrótica.

D) Presença de edema pulmonar e edema de membros inferiores com ginecomastia sugere linfedema.

22- A.H.L, mulher de 35 anos, apresenta-se à emergência com queixa de edema progressivo há um mês, inicialmente nos tornozelos, agora acometendo pernas e face. Relata também cansaço e urina espumosa, mas nega febre, dor lombar ou outras queixas. Ela tem histórico de hipertensão leve, controlada com dieta, e não possui outras comorbidades. Ao exame físico, está afebril, com pressão arterial de 130/85mmHg, frequência cardíaca de 84bpm e frequência respiratória de 18irpm. Há edema ++/4+ em membros inferiores e discreto edema palpebral. Abdome sem sinais de ascite.

Exames laboratoriais mostram

Albumina sérica: 2,0g/dL (ref: 3,5- 5,5g/dL);

Proteinúria de 24 horas: 6,0g/24h (ref: <150mg/24h);

Colesterol total: 310mg/Dl (ref: <200mg/dL);

Creatinina sérica: 0,9mg/dL (ref: 0,6- 1,2mg/dL).

Qual das alternativas abaixo demonstra o exame adicional mais indicado para investigar a causa primária da síndrome nefrótica no caso desta paciente?

I. Biópsia renal.

II. Dosagem de autoanticorpos e hemograma completo.

III. Ultrassonografia abdominal e proteinograma.

A) Apenas a alternativa I.

B) Apenas a alternativa II.

C) Apenas a alternativa III.

D) As alternativas I, II e III.

23- A médica do Departamento de Emergência é chamada por equipe por resultado crítico em exame laboratorial de paciente que está sendo atendido no PS. O resultado é Potássio sérico 7,5. Qual a primeira conduta a ser tomada?

A) Solicitar à equipe um eletrocardiograma e checar quando possível.

B) Monitorizar paciente em leito de emergência e realizar medidas farmacológicas para redução do potássio sérico.

C) Monitorizar paciente em leito de emergência, solicitar eletrocardiograma.

D) Monitorizar paciente em leito de emergência solicitar eletrocardiograma e realização de gluconato de cálcio agora.

24- Paciente de 54 anos, hipertenso, tabagista com 30 anos/maço, é admitido no pronto-socorro com pressão arterial de 185x100mmHg, apresentando hemiplegia facio-braquio-crural à esquerda e desvio da rima bucal para a direita. Qual a conduta mais apropriada, de acordo com as diretrizes internacionais, para manejo do AVC agudo?

A) Aguardar 24 horas para a estabilização da pressão arterial antes de realizar exames de imagem.

B) Iniciar trombólise IV com alteplase imediatamente após a realização de TC de crânio sem contraste descartando hemorragia.

C) Administrar anti-hipertensivos IVs para reduzir a pressão arterial para menos de 140x90mmHg rapidamente antes de qualquer intervenção.

D) Solicitar exames laboratoriais e monitorar o paciente por 24 horas antes de iniciar qualquer intervenção terapêutica.

25- Dona Alice, 76 anos, é trazida à consulta pela filha, que relata que há aproximadamente dois anos a mãe começou a esquecer onde guarda objetos e a repetir perguntas. Nos últimos meses, passou a confundir datas, esquecer nomes de parentes próximos, e recentemente se mostrou desorientada ao tentar retornar da padaria. Também abandonou atividades que antes gostava, como bordado e leitura. A filha ainda refere que Dona Alice tem deixado o fogão aceso por descuido. Qual é o diagnóstico sindrômico mais compatível e os domínios cognitivos mais provavelmente afetados?

A) Transtorno neurocognitivo leve – prejuízo de atenção dividida e função executiva.

B) Transtorno neurocognitivo maior – prejuízo de memória episódica e orientação visuespacial.

C) Delirium – prejuízo atencional agudo com flutuação cognitiva.

D) Depressão – prejuízo de linguagem e interesse por atividades prazerosas.

26- Um paciente de 80 anos com diagnóstico prévio de transtorno neurocognitivo maior vem apresentando piora progressiva do quadro nos últimos anos. Está acamado, usa fralda, apresenta rigidez muscular, episódios de agitação noturna e dificuldade para se alimentar. A família está exausta e questiona sobre continuidade do tratamento farmacológico e cuidados de fim de vida. Qual é a conduta mais adequada neste estágio da doença?

A) Iniciar antipsicótico típico para controle de agitação noturna.

B) Suspender anticolinesterásicos e discutir plano de cuidados paliativos.

C) Encaminhar para internação psiquiátrica por risco de heteroagressividade.

D) Aumentar a dose dos anticolinesterásicos e associar memantina.

27- Paciente de 72 anos é avaliado por declínio cognitivo há cerca de 6 meses. A esposa relata piora da memória recente, trocas de palavras e dificuldade para se organizar no dia a dia. Ao exame, está orientado no tempo e espaço, mas com atenção dispersa e dificuldade para lembrar três palavras após cinco minutos. Não há antecedentes psiquiátricos relevantes. Qual é o conjunto mínimo de exames laboratoriais indicado na investigação inicial?

A) Hemograma, glicemia, TSH, vitamina B12, eletrólitos, função renal e hepática.

B) Gasometria arterial, VHS, FAN, CK total e eletrólitos.

C) Ureia, creatinina, PCR, EAS e hormônio luteinizante.

D) TGO, TGP, INR, ureia e bilirrubina total.

28- Durante avaliação em UBS, uma paciente de 84 anos, com 3 anos de escolaridade, é atendida por queixas de esquecimento. Relata perda de interesse pelas atividades do grupo da igreja, esquecimento de nomes de vizinhos e dificuldade para fazer compras. A filha complementa dizendo que ela "anda mais lenta" e "não quer mais cozinhar". O médico quer investigar cognição e função. Quais os testes mais adequados para esse perfil de paciente?

A) Teste do relógio e Addenbrooke’s Cognitive Examination (ACE-R).

B) Mini exame do estado mental (MEEM) com ajuste de escolaridade, e escalas de Katz e Lawton

C) Escala de Montreal (MoCA) e Boston Naming Test.

D) Teste de fluência verbal e Escala de Depressão Geriátrica.

29- Um homem de 67 anos é trazido ao pronto atendimento por confusão mental, inversão do ciclo sono-vigília, e relato de alucinações visuais há três dias. A esposa relata que ele vinha se automedicando com omeprazol, difenidramina e complexo B. Ao exame, está desatento, com fala desconexa, sem rigidez ou alterações neurológicas focais. Qual deve ser a primeira conduta frente a esse quadro?

A) Iniciar antipsicótico para contenção comportamental.

B) Solicitar neuroimagem para rastreio de lesão expansiva.

C) Suspender medicações, investigar causas orgânicas e iniciar suporte clínico.

D) Realizar avaliação psiquiátrica de urgência para exclusão de psicose primária.

30- Um homem de 67 anos comparece à consulta de rotina. Diagnosticado com diabetes mellitus tipo 2 há cerca de 12 meses, em uso regular de metformina 500 mg de 12 em 12 horas. Possui história prévia de infarto agudo do miocárdio há 5 anos. Comparece à consulta de acompanhamento com exames laboratoriais de controle recentes, que apresentam resultados semelhantes aos exames anteriores, realizados há 3 e há 6 meses.

Exame	Resultado	Valor d
Ureia	28 mg/dL	13 a 43 m
Creatinina	1,04 mg/dL	0,60 a 1,3
taxa de filtração glomerular (TFG – CKP - EPI)	74,99 mL/min/1,73 m^2	> 90 mL/m
Glicemia de jejum	144 mg/dL	< 100 mg/
Hemoglobina glicada	7,2%	4,5 a 5,6%
Albuminúria em amostra isolada de urina	234 mg/L	< 30 mg/L

Observação: TFG – CKD - EPI corresponde à estimativa da taxa de filtração glomerul proposta pela *ChronicKidneyDiseaseEpidemiologyCollaboration*.

A conduta recomendada para esse paciente é?

A) manter a medicação em uso e solicitar exame de dosagem de proteinúria em amostra de urina de 24 horas.

B) manter a medicação em uso e agendar consulta de retorno solicitando a realização dos exames habituais.

C) trocar o tratamento para um esquema à base de insulina e solicitar exame de dosagem de proteinúria em amostra de urina de 24 horas.

D) associar um medicamento inibidor do receptor SGLT2 (cotransportador sódio-glicose 2) e manter acompanhamento habitual.

31- Uma mulher com 25 anos, solteira, sem comorbidades prévias, é atendida em uma unidade de pronto-socorro devido a queixas de algúria, polaciúria, dor hipogástrica e urgência miccional há 2 dias. Ela nega corrimento vaginal e relata que a menstruação está regular e que não tem relações sexuais há mais de 1 mês. A paciente nega: febre, uso de antimicrobianos nos últimos 3 meses e outros sintomas sistêmicos. Nesse caso, quais são, respectivamente, a hipótese diagnóstica mais provável e a melhor conduta terapêutica?

A) ITU baixa; iniciar nitrofurantoína.

B) ITU alta não complicada; iniciar norfloxacino.

C) ITU por Staphylococcus aureus; iniciar antibiótico de amploespectro.

D) Nefrolitíase complicada com ITU; iniciar antibiótico após resultado de urocultura.

32- Uma paciente com 24 anos procura atendimento médico com relato de sudorese excessiva, palpitações, irritação ocular, nervosismo, fadiga e perda de peso apesar do aumento do apetite, com achado de edema ocular e aumento difuso da tireoide ao exame físico. O médico levanta a suspeita de Doença de Graves. Durante a propedêutica laboratorial, são resultados compatíveis com a hipótese diagnóstica apresentada

A) níveis séricos reduzidos de anticorpos contra o receptor de TSH (TRAb) e de anticorpos antitireoperoxidase (anti-TPO).

B) aumento do tamanho e da ecogenicidade do parênquima da tireoide e presença de nódulos císticos difusos à ultrassonografia.

C) elevação dos níveis séricos do hormônio tireoestimulante (TSH) e supressão dos níveis da fração livre de tiroxina (T4 livre) e da tri- iodotironina (T3).

D) teste de iodo radioativo mostrando elevada captação pela tireoide e cintilografia mostrando distribuição difusa de radiomarcador no parênquima da glândula.

33- Um homem com 38 anos relata, em consulta, exantema, prurido, febre e artralgia que se resolveu em 72 horas com o uso de sintomáticos. O paciente conta que, após 10 dias, passou a apresentar parestesia em membros inferiores, que evoluiu para membros superiores em 24 horas. Ele conta que não buscou ajuda médica por julgar tratar-se de câimbras devido à falta de atividade física regular. Narra, ainda, que, após 3 dias, o quadro evoluiu com fraqueza nos membros inferiores, impedindo a deambulação, queixando- se também de cefaleia holocraniana e obstipação intestinal. Ao exame neurológico, apresenta-se vigil, orientado em tempo e espaço, com pupilas isocóricas e fotorreagentes, mobilidade ocular extrínseca preservada e demais pares cranianos sem alteração. Verificam-se, ainda: força muscular grau V/V em membros superiores e grau III/V em membros inferiores; reflexos bicipital, tricipital e estilorradial grau II/IV; reflexos patelar e aquileu abolidos; hipoestesia tátil e dolorosa nos quatro membros, com padrão de bota e luva; hipopalestesia em membros inferiores, até o tornozelo. O resultado do exame de líquido cefalorraquidiano (LCR) mostrou:

EXAME	RESULTADO	UNIDADES CONVENCIONAIS	UNIDADES SI
Contagem de células	0 a 2 mm^3	0 a 5 linfócitos/mcL	0 a 5×10^6 linfócitos/L
Glicose	74 mg/dL	40 a 80 mg/dL (< 40% do nível plasmático medido simultaneamente se esse nível plasmático está anormal)	2,2 a 4,4 mmol/L (< 40% do nível plasmático medido simultaneamente estão alterados)
Proteína total	103 mg/dL	15 a 60 mg/dL	150 a 600 mg/L

Diante desse quadro clínico, qual é a principal suspeita diagnóstica?

A) Miastenia Gravis.

B) Síndrome de Guillain-Barré.

C) Acidente Vascular Cerebral.

D) Esclerose Lateral Amiotrófica.

34- Um homem com 50 anos, casado, trabalhador de indústria de reciclagem de baterias, é encaminhado, acompanhado de familiares, a um ambulatório de hematologia para investigação de anemia hipocrômica e microcítica e astenia. Ele fez uso de 180 mg/dia de ferro elementar por 6 meses, sem melhora das alterações do hemograma. Relata que, recentemente, começou a apresentar confusão mental. Os familiares negam história de sangramentos evidentes ou restrições alimentares e afirmam que, na unidade básica de saúde, após realização de uma investigação inicial e dos exames de triagem recomendados para sua faixa etária, não havia sido constatada evidência de quaisquer outras doenças. Diante da situação apresentada, qual exame deve ser solicitado para esse paciente?

A) Mielograma.

B) Haptoglobina.

C) Chumbo sérico.

D) Teste de Coombs

35- Um homem com 40 anos, apresentando queixa de perda constante de interesse e de prazer nas atividades das quais costumava gostar, relata: “não tenho vontade sequer de sair de casa”. Afirma que isso vem se mantendo nos últimos 2 meses, de forma constante e diária, mas que piorou no último mês. Conta que seus amigos e familiares também perceberam e vêm cobrando dele uma mudança de atitude. Além disso, diz que tem se sentido mais ansioso e inquieto e que apresentou 2 “crises” súbitas, há um mês, de duração de alguns minutos, em que sentiu medo intenso, taquicardia, sufocação, tontura, sudorese e sensação de que algo ruim iria acontecer e de que iria morrer. Não relaciona as crises a fatores desencadeantes ou a situações pelas quais esteja passando. Relata que, quando teve as crises, foi a um pronto- socorro, onde foram descartadas causas orgânicas para o quadro. Refere também que apresentou perda de peso considerável no último mês, mas não sabe de quanto, tendo percebido apenas por suas roupas. Diz ainda que está sem fome e que tem tido muito sono todos os dias e se sente sempre cansado, está sem concentração e tem dificuldade de pensar. Nega etilismo, tabagismo ou uso de drogas ilícitas, negando também doenças conhecidas. Ao exame físico, o paciente apresenta- se sem alterações, assim como não mostram alterações os exames recentes de hemograma, TSH, T4 livre que ele traz. Ao exame psíquico, apresenta-se colaborativo, atenção preservada, com memória e orientação sem alterações; humor deprimido e ansioso; pensamento de forma, curso e conteúdo sem alterações, assim como juízo e crítica. Não se verificam alterações senso perceptivas, observando-se discreta agitação psicomotora. Considerando-se a situação descrita, qual é diagnóstico para o caso desse paciente?

A) Transtorno de pânico com agorafobia.

B) Transtorno bipolar em fase depressiva.

C) Transtorno de ansiedade generalizada.

D) Transtorno depressivo com ataques de pânico.

36- Uma paciente de 34 anos, obesa e com diabetes do tipo II queixa-se de manchas escuras nas axilas e nas virilhas. Ao exame, observam-se placas hipercrômicas, de superfície aveludada localizada nas áreas relatadas. Assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico.

A) Dermopatia diabética

B) Intertrigo

C) Hidradenite supurativa

D) Acantose nigricans

37- Homem, 53 anos, tabagista e obeso, com diagnóstico de doença do refluxo há mais de 5 anos, em uso irregular de omeprazol, queixando se de pirose intermitente. Realiza endoscopia digestiva alta, que revela esofagite péptica moderada e área circunferencial de metaplasia intestinal sem displasia. Qual é a orientação mais adequada para esse paciente?

A) Indicar, neste momento, a fundoplicatura total de Nissen.

B) Indicar esofagectomia distal.

C) Orientar o uso contínuo de omeprazol, além de medidas não farmacológicas, como abandonar o tabagismo e perder peso. O controle endoscópico não está indicado.

D) Orientar o uso contínuo de omeprazol, além de medidas não farmacológicas, como abandonar o tabagismo e perder peso. O controle endoscópico está indicado.

38- Mulher, 65 anos, comparece à consulta na unidade básica de saúde referindo dor em quadril e joelho há 6 meses. Refere que as dores pioram ao longo do dia, principalmente em dias em que o trabalho como empregada doméstica é mais pesado. Relata melhora durante pausas no trabalho e durante à noite, quando se deita para dormir. Pela manhã, nota rigidez nessas articulações com duração de 20 minutos. Foi orientada pela vizinha a tomar ibuprofeno e apresentou melhora da dor. Como as dores estão piorando progressivamente e interferindo diretamente em seu trabalho, gostaria de um tratamento que a fizesse melhorar. Antecedentes pessoais: hipertensão, dislipidemia. Em uso: hidroclorotiazida, 25 mg, enalapril, 10 mg de 12/12 horas, e sinvastatina, 20 mg. Ao exame físico: IMC de 31 kg/m², PA = 130 x 80 mmHg, dor e limitação de amplitude de movimento em quadril direito, especialmente com a abdução e rotação interna, dor e aumento de volume em joelho esquerdo com crepitações e limitação parcial à flexoextensão, hipotrofia de quadríceps bilateral. Tendo em vista a principal hipótese diagnóstica, que medida não está indicada para essa paciente?

A) Prescrição de prednisona via oral.

B) Perda de peso e fortalecimento muscular.

C) Prescrição de anti-inflamatório não esteroidal tópico.

D) Prescrição de dipirona via oral.

39- Mulher de 27 anos procura atendimento por queixas de inchaço, febre, mal-estar e dores nas mãos e nos punhos. Relata que o inchaço se iniciou nesta semana e que os demais sinais e sintomas, há cerca de 2 meses. Ao exame físico, apresenta úlcera indolor em palato duro, artrite de punhos e metacarpofalangeanas, pressão arterial = 150 x 100 mmHg e edema compressível de membros inferiores 3+/4+ até as coxas. Solicitados exames complementares que mostraram hemoglobina = 9,5 g/dL; leucócitos = 3.200/mm³; plaquetas = 110.000/mm³ ; creatinina = 2,8 mg/dL; ureia = 90 mg/dL; FAN = 1/640 padrão nuclear homogêneo; urina 1 com eritrócitos 10.000/campo; leucócitos 20.000/campo; presença de cilindros hemáticos e albumina 3+/4+; relação proteína/creatinina urina amostra isolada = 2 (VR < 0,2). Tendo em vista a principal hipótese diagnóstica, qual é o melhor tratamento para a paciente nesse momento?

A) Pulsoterapia com metilprednisolona 1 g/dia por 3 dias consecutivos e micofenolato de mofetila.

B) Prednisona 1 mg/kg via oral associada à ciclofosfamida endovenosa.

C) Pulsoterapia com metilprednisolona 1 g/dia por 3 dias consecutivos e metotrexato.

D) Solicitar biópsia renal e, após, definir o melhor tratamento baseado em seus achados.

40- Paciente de 7 anos de idade vem ao pronto-socorro com mialgia, artralgia, obstrução nasal e secreção anterior, associadas a febre alta, dor de garganta, tosse e desconforto abdominal há 3 dias. Ao exame, apresenta hipertrofia de tonsilas com exsudado acinzentado, edema de úvula, petéquias em palato, linfonodomegalia cervical anterior e posterior, edema bipalpebral e temperatura de 38,5 graus. Apresenta-se eupneico, consciente, orientado, normotenso. Com base no caso acima, assinale a hipótese diagnóstica e a conduta correta.

A) Influenza; analgésico, antitérmico e aumento de hidratação oral.

B) Amigdalite bacteriana por S. pyogenes; amoxicilina ou penicilina benzatina associada a analgésico.

C) Mononucleose infecciosa; analgésico e antitérmico.

D) Faringite por adenovírus; prednisona, analgésico e antitérmico.

GABARITO 2025.2.1

1. C
2. C
3. A
4. C
5. D
6. B
7. C
8. C
9. B
10. B
11. B
12. B
13. C
14. D
15. C
16. D
17. C
18. A
19. B
20. A
21. C
22. A
23. D
24. B
25. B
26. B

27. A

28. B

29. C

30. D

31. A

32. D

33. B

34. C

35. D

36. D

37. D

38. A

39. A

40. C